KHIDI
한국보건산업진흥원

회복/퇴원계획수립

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

종사자 훈련도구

프로그램 가이드북

세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한
치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 훈련 도구

아주대학교병원 Ajou University Hospital

이음병원

회복/퇴원계획수립

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

종사자 훈련도구

프로그램 가이드북

세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한
치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 훈련 도구

연구 책임자의 글

치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 5종을 소개하며

아주대학교병원과 이음병원 연구팀은 '세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한 치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 개발' 사업의 결과물을 기쁜 마음으로 소개합니다.

2012년부터 세계보건기구(WHO)는 정신건강 서비스를 사람중심, 권리기반, 회복 지향적으로 변화시키기 위해 퀄리티라이츠(QualityRights) 프로젝트를 진행해 왔습니다. 또한 대한민국 정부는 제 2차 정신건강복지 기본계획을 통해 정신장애 당사자의 권익 증진과 인권 강화에 힘써왔습니다. 특히 이후의 정신건강복지법 개정과 정신건강정책 혁신안을 통해 비강압치료, 절차조력, 동료지원 등 인권과 회복 기반의 서비스 조항이 추가되었고 최근에는 급성기치료환경 개선을 위한 논의가 이어지는 등, 현재는 새로운 돌봄의 구체적 적용을 위한 준비가 필요한 시점입니다.

그 일환으로 한국보건산업진흥원이 '세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한 치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 개발' 연구과제를 제안하여 본 연구팀이 지난 3년 동안 수행하였습니다. 이를 위해 정신건강 분야의 다학제 전문가들과 다분야 이해관계자들이 협력하여 한국의 문화와 의료환경에 맞도록 고안된 결과물을 개발했습니다. 구체적으로, WHO가 적극 권장하는 위기대응 서비스인 오픈 다이얼로그를 지역사회와 병원에서 실천하기 위한 각각의 훈련지침, 또한 당사자, 가족, 종사자가 함께 참여하여 회복을 논의하고 퇴원 계획을 수립하는 '퀄리티라이츠 회복 퇴원 계획', 정신 응급 환자에게 강압적 처치가 아닌 대안적 방식의 돌봄을 제공할 수 있는 '고조완화기법', 그리고 산 경험을 지닌 동료지원가가 당사자의 법적 역량 발휘를 도울 수 있는 '동료지원 지원의사결정' 훈련도구를 동시에 개발하여 시험 운영이 이루어졌습니다.

저희 연구팀은 개발과 시험운영에 그치지 않고 2024년 11월 공청회를 개최하여 워크숍과 발제, 밀도 있는 토론을 통하여 전국에서 참석하신 당사자, 보호자, 그리고 전문가들의 다양한 목소리를 경청하였고 이를 반영한 수정보완 작업을 완료하였습니다. 그리고 이들 훈련도구의 도입과 실천을 위한 가이드라인을 첨부하였습니다. 한편 연구개발이 진행되는 3년 동안 국내의 정신건강 서비스 환경은 이전보다 훨씬 인권/회복 중심의 지역사회 서비스, 그리고 서비스 제공자와 이용자간의 협업을 통한 거버넌스를 강화하는 방향으로 급속도의 변화가 이루어지고 있습니다. 그러므로 이번 결과물이 이러한 시대적 요구에 부응하는 서비스 혁신을 위한 유용한 수단이 되리라 기대합니다.

연구 개발의 모든 과정을 지원하고 참여해 주신 전국의 당사자와 가족, 전문가 여러분, 보건복지부, 보건산업진흥원, 중앙정신건강복지사업지원단, 세계보건기구(WHO)를 비롯한 해외 전문가들께 깊은 감사를 드립니다. 이들 인권중심 중재기술 5종이 널리 보급되어 정신건강 분야의 모든 분이 영감과 희망을 얻고, 그것이 동력이 되어 사회 포용과 통합을 지향하는 정신건강 증진으로 나아가기 위한 가치 있는 마중물이 되기를 바라며 기쁜 마음으로 여러분께 전달드립니다.

주관연구기관 책임자 **아주대학교 노재성**
공동연구기관 책임자 **이음병원 정성권**
연구 코디네이터 **다원정신건강의학과 김성수**

WHO 퀄리티라이츠의 인문학적 의의

질병상황과 인간다움

인간이 질병을 경험한다는 것에는 적어도 세가지의 차원이 있고 영어로는 이것을 1) disease 2) illness 3) sickness 의 세가지 용어로 표현한다. Disease 는 의학적, 특히 병리학적 관점에서 질병을 보는 분류적 차원이다. Illness 는 병을 경험하는 환자의 주관성을 중심으로 개인이 겪는 아픔과 불편함을 말하는 차원이다. Sickness는 사회적, 문화적 측면에서 바라보는 질병인데 아픈 사람이 사회적으로 질병에 관하여 특정한 역할을 부여 받게 되는 차원을 의미한다.

인간이 아프다는 것은 주관적인 경험인 동시에 본질적으로 관계의 문제이고 사회적인 사건이며 이를 표현하거나 이해하기 위해서는 보다 복잡하고 다면적인 시각이 필요하다. 특히 질병 상황은 사람들이 살면서 겪게 되는 비일상적인 상황이다. 일상을 살아나가고 있는 사람이 어쩌다 아파서 의사를 만난다고 하는 것은 어느 누구도 겪고 싶지 않은 부정적인 비일상의 상황인 것이다. 이렇게 복잡한 차원의 비일상적인 질병 상황은 필연적으로 사람이 일상적으로 누리고 있었던 인간다움(humanness)의 위기 상황이기도 하다. 아픈 사람은 질병을 겪고 치료에 임하는 모든 과정에서 육체적인 고통 뿐 아니라 인간으로서의 존엄성과 가치에 대한 위기를 함께 느끼게 된다. 그러나 역설적으로 이러한 위기상황이야말로 인간다움을 가진다는 것이 얼마나 중요한 일이고 인간다움을 지켜나간다는 것이 얼마나 쉽지 않은 것인지를 잘 보여주는 기회가 된다. 특히 정신 건강에 심각한 위기를 맞이하게 되었을 때 모든 사람은 인간다움에 대한 중대한 도전에 직면하게 된다. 이런 도전에 응답하기 위해서 인간은 인간 사이의 관계를 통해 인간다움을 확인할 뿐 아니라 이를 지키기 위해서 더 많은 노력을 기울인다.

WHO 가 제시한 QualityRights를 이해하는 여러가지 관점이 있을 수 있다. 정신 질병에 대한 치료 과정에서 나타나는 인권 존중의 문제로 볼 수도 있고, 정신 건강을 회복 중심에서 바라보는 새로운 관점이 될 수도 있다. 그러나 그 가운데서 간과되어서는 안되는 중요한 한가지가 있다. 결국 QR 이라는 것은 질병을 겪는 인간이 비일상적 위기 상황에서도 인간다움을 지키고 인간으로 살아가는 방법에 대한 하나의 제안이라는 사실이다. 인간은 살아있을 때도, 아플 때도, 혹은 죽은 다음에도 인간다움을 잃지 않아야 한다. 만약에 그렇다면, QR은 단지 의사, 당사자, 가족들에게만 의미 있는 것은 아니다. 비일상적 질병상황의 가장 취약한 인간에게 인간다움이 지켜질 수 있다면 일상을 누리는 건강한 인간들의 인간다움 또한 언제나 존중받고 유지될 수 있다는 의미이기 때문이다.

물론 QR 은 정책적 제안이다. 그러나 이것은 법이나 규정의 차원에서만 이해되어서는 안된다. 동아시아적 관점에서 윤리는 인간이라는 종이 가지고 있는 보편적인 원칙, 즉 우리가 인간으로 살아가는 방법, 인간답게 살아가는 방법인 것이지 윤리의 최저선인 법으로 환원될 수 있는 것은 아니기 때문이다. QR을 인간이 질병상황에서 인간다움을 유지하면서 그 상황을 극복하는 방법에 대한 새로운 제안으로 본다면 이는 윤리적 차원의 문제이며 의료 제도나 치료 방법에서 흔히 회자되는 “효과성이나 비용절감 혹은 적용 가능성”보다 더 우선적이어야 한다는 것이다. 우리가 인간답게 일상을 살기 위해서는 심지어 비일상의 위기상황에서 조차 아무리 효과가 없고, 비용이 많이 들고, 적용이 어려워도 반드시 해야 하는 일들이 있다.

하나의 오해는 바로잡을 필요가 있다. QR의 목적은 당사자나 가족들의 건강이 위험해지는 질병 상황에서 어떠한 개입도 하지 말자는 뜻이 아니다. 인간답게 아플 수 있는 권리는 인간의 주체성을 바탕으로 하는 선택의 문제를 존중하자는 것이지 역설적으로 치료적인 개입을 모두 제한하는 방식으로 작동해서는 안된다는 점이다. 그래서, 만약 QR에 원칙이 있다면 그것은 질병상황에서 " 개인의 자유에 대한 최소한의 개입"이어야 한다. 다시 말해서, 당사자나 치료진이나 가족들 모두 최선을 다해 서로의 인간다움을 존중하면서 적절하게 혹은 최소한으로 개입하고 당사자가 결국 일상으로 돌아가도록 돕자는 것이 핵심이다.

QR을 한국적인 상황에 적용하고 보급하기 위한 이 연구는 다음과 같은 다섯가지 방향에서 전개 되었다.

1. 지역기반 네트워크 미팅
2. 병원기반 네트워크 미팅
3. 고조완화기법 : 안정화 치료
4. 동료지원 지원의사결정 서비스
5. 회복/퇴원 계획수립(퀄리티라이츠 리커버리 프로그램)

각각의 연구는 의학이 질병 중심에서 건강중심으로 바뀌고 의학의 비일상화를 극복하는 의학의 일상화라는 패러다임의 전환을 바탕으로 진행되었다. 다시 말해서, 질병이라는 특수상황을 극복하려는 노력은 특수상황을 제거하는 것이 아니라 일상을 회복하는 데서 가능할 수 있다는 사고적 전환을 의미한다.

인간다움이라는 관점에서 볼 때, Open Dialogue 는 인간의 고통(suffering)에 대한 가장 인간적인 대답인 대화를 중심으로 비일상적 상황을 극복하려는 노력이다. 고조완화 기법 혹은 안정화 치료는 인간의 원초적 본능인 폭력성(violence)조차도 가장 인간적인 방식으로 개입할 수 있다는 가능성을 보여주는 시도이다. 동료지원을 통한 절차조력은 고통 속에 있는 인간들이 서로의 연대(solidarity)를 확인하는 과정을 강조하며 결국 인간다움이 공동체를 통해 지지되고 실현될 수 있다는 점을 보여준다. 회복중심의 퇴원계획을 만들어 나가면서 치료진과 비일상 상황에 있는 당사자, 가족들 모두가 인간다움은 결국 일상에서 실현된다는 것을 인정하고 함께 만드는 노력의 방향을 설정할 수 있게 된다.

이런 연구를 통해서 우리는 QR 에 대한 연구가 단순히 정신건강과 치료의 의학적 차원을 넘어서서 보다 중요한 의미가 있음을 알게 되었다. 왜냐하면 인간다움의 문제는 인간학의 문제이고 공동체의 문제이고 문화의 문제이기 때문이다. 그렇다면 OD 를 통한 대화적 방법론은 사회전반의 문제에 이르기까지 여러가지 측면에서 다양하게 이해되고 적용되고 활용될 수 있을 것이고, 같은 생각을 가지고 같은 상황에 있는 사람들 뿐 아니라 전혀 다른 처지에 있는 사람들과도 인간다움을 바탕으로, 같은 목적을 위해 연대하고 협력하는 것이 가능해질 것이다.

아주대학교 의과대학 인문사회의학 교수 **김신권**

치료친화적 환경 조성을 위한

인권중심 중재기술 도입 가이드라인

훈련 도입에 대한 실용적 제언

본 가이드라인에 대하여

본 지침서를 포함하는 총 5종의 인권기반 중재기술 훈련도구/지침은 실제 정신건강 서비스 현장에 효과적으로 도입 및 실천되기 위한 목적으로 개발되었습니다 그러므로 기술을 교육하고 실천하고자 하는 기관이나 단체를 위한 실무적 가이드라인의 필요성이 존재합니다.

또한 정신건강서비스가 공적 자원을 기반으로 진행되므로 거시적 수준의 정책 또는 사업 지침과 맞물려 진행될 필요가 있다는 면에서, 이러한 교육훈련이 어떻게 정부 정책과 연동하며 그 구현을 촉진할 수 있는지에 대한 당위성이 제시되어야 합니다. 또한, 이 훈련도구의 핵심 기반이 인권/회복 기반의 정신건강 서비스 변혁을 지향하는 WHO 퀄리티라이츠이므로, 첫 실천단계부터 그 기본 철학에 따른 방향 설정이 필요합니다. 그리고 5종의 도구가 정신의료, 지역정신보건, 당사자/가족 운동 등 다양한 현장에서 적재적소에 효율적으로 도입되기 위해서는 각 훈련도구들의 단계적 도입 전략과 활용 방안이 마련될 필요가 있습니다. 나아가 이 교육훈련이 서비스 현장에서 지속적으로 작동하기 위해 필요한 자원과 정책이 무엇인지에 대한 제안도 필요합니다.

이 가이드라인은 위의 필요성에 부응하기 위하여 저희 연구 결과물의 시험 운영 경험, 연구 논문을 통해 획득된 지식, 워크숍과 공청회를 통하여 많은 이해관계자 분들로부터 얻은 피드백, 중앙/지방 정부의 정책 수립과 실천에 관여한 경험 등을 바탕으로 하여, 실제 현장에서 이 도구를 도입하고자 하시는 분들께 유용한 참고자료가 되는 것을 목표로 작성되었습니다.

1. 국가 정신건강정책과의 연동

2021년 보건복지부는 제2차 정신건강복지 기본계획을 발표하였습니다.

제 2차 정신건강복지 기본계획과의 연동



비전	마음이 건강한 사회, 함께 사는 나라
정책 목표	Ⅰ. 코로나19 심리방역을 통한 대국민 회복탄력성 증진 Ⅱ. 전 국민이 언제든 필요한 정신건강서비스를 이용할 수 있는 환경조성 Ⅲ. 정신질환자의 중증도와 경과에 따른 맞춤형 치료환경 제공 Ⅳ. 정신질환자가 차별 경험 없이 지역사회 내 자립할 수 있도록 지원 Ⅴ. 약물중독, 이용장애 등에 대한 선제적 관리체계 마련 Ⅵ. 자살 충동, 자살 수단, 재시도 등 자살로부터 안전한 사회 구현

정책목표	전 략
전 국민 정신건강증진	1. 적극적 정신건강증진 분위기 조성 2. 대상자별 예방 접근성 제고 3. 트라우마 극복을 위한 대응역량 강화
정신의료 서비스 / 인프라 선진화	1. 정신질환 조기인지 및 개입 강화 2. 지역 기반 정신 응급 대응체계 구축 3. 치료 친화적 환경 조성 4. 집중 치료 및 지속 지원 등 치료 효과성 제고
지역사회 기반 정신질환자의 사회통합	1. 지역사회 기반 재활 프로그램 및 인프라 개선 2. 지역사회 내 자립 지원 3. 정신질환자 권익 신장 및 인권 강화
중독 및 디지털기기 이용장애 대응 강화	1. 알코올 중독자 치료 및 재활서비스 강화 2. 마약 등 약물중독 관리체계 구축 3. 디지털기기 등 이용장애 대응 강화
자살로부터 안전한 사회구현	1. 자살 고위험군 발굴과 위험요인 관리 2. 고위험군 지원 및 사후관리 3. 서비스 지원체계 개선
정신건강정책 발전을 위한 기반 구축	1. 정책 추진 거버넌스 강화 2. 정신건강관리 전문인력 양성 3. 공공자원 역량 강화 4. 통계 생산체계 정비 및 고도화 5. 정신건강분야 전략적 R&D 투자 강화

이 기본 계획에서는 정신질환자의 권익/인권 강화와 그에 따라 지역기반의 정신응급 대응체계를 구축하고, 치료친화적 환경을 조성하며 필요한 집중치료와 지속 지원을 제공할 것을 명시했습니다. 이러한 정책 방향은 보다 세부적인 실천계획으로 분류되는데, 본 연구개발에 기반하는 WHO 퀄리티라이츠 훈련도구와 모범사례에서 제시된 컨텐츠들은 각각의 실천이 효과적으로 이루어지기 위한 구체적 내용으로 이루어져 있습니다.

보건복지부 정책 및 적용 가능한 WHO QualityRights 컨텐츠

		2-2. 지역기반 정신응급체계 구축	2-3. 치료 친화적 환경조성	2-4. 집중치료 및 지속 지원 등 치료효과성 제고	3-3. 권익신장 및 인권 강화
보건복지부	2021~2025 정신건강복지 기본 계획	• 정신응급의료기관 확보	• 환자 · 의료진 안전	• 초발 및 급성기 환자 집중 지원 • 완치회복률 제고	• 정신질환자 권익보호 • 자기결정권 강화
		• 정신응급의료기관 지정 수가 시범사업('22)* • 기관별 특화, 정신응급환자 진료지침 제정('22)	• 정신의료기관 시설기준 강화('21. 3. 5. 시행) • 중증도 분류기준 마련 - 급성기 병동 - 회복기 병동 - 만성 재활병동 - 병동별 운영지침('22)	• 급성기치료 보상체계 시범 사업('22)* - 폐쇄병동 집중관리료 - 퇴원 전 사례관리 - 다학제 사례관리팀 - 집중사례관리	• 국공립정신병원 중심 - 동료 · 가족 지원가활동 우선 제공('22)
WHO	QualityRights 훈련도구		• 비강압치료 훈련모듈	• 회복치료 모듈	• 지적의사결정 (자기결정권) 모듈 • 동료지원 모듈
	지역정신 건강서비스 지침 모범사례	• 정신건강위기대응 모범사례 - 쉼터(Crisis center) - 오픈 다이얼로그	• 병원기반 서비스 모범 사례 - 비강압 / 오픈 다이얼로그 / 동료지원 적용 - 단기 집중치료 - 지역사회연결		• 동료지원 모범 사례

보건복지부 정책의 방향성 + WHO QR의 방향성

↓

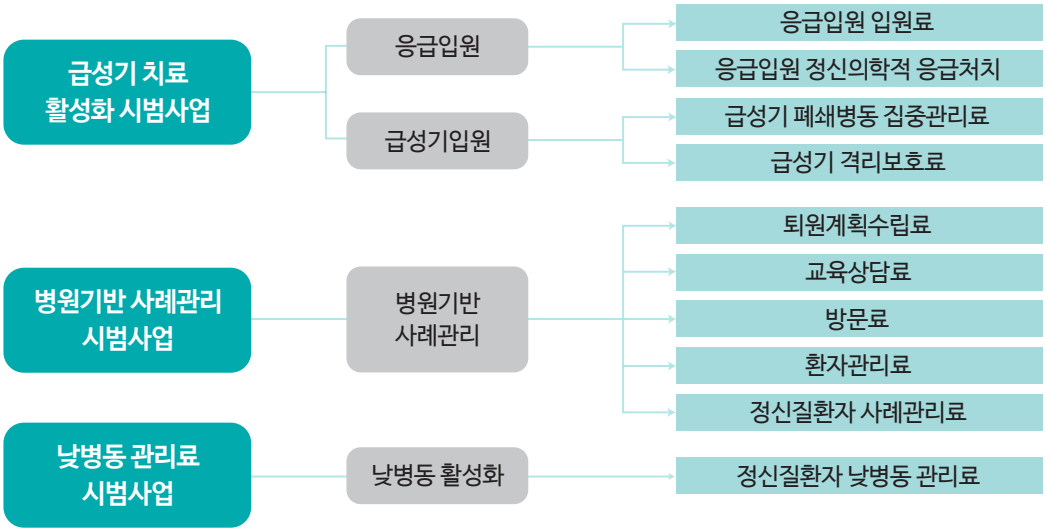
1) 오픈 다이얼로그
2) 비강압치료
3) 회복치료
4) 동료지원
5) 지원의사결정

본 연구개발의 결과물은 이러한 컨텐츠들을 시험 운영 등을 통한 번안 및 보완 과정을 거쳐 한국 서비스 환경에서 실용적으로 적용될 수 있도록 개발된 것으로서 정책이 현장에서 바로 구현될 수 있도록 하는 도구로서의 가치를 지닙니다.

또한 2023년의 정신건강복지법 일부 개정안에 절차조력과 동료지원 등의 항목이 포함되어 전국적 시행을 앞두고 있고, 같은 해에 발표된 정신건강정책 혁신방안에 비강압적 치료 도입이 명시되어 있는 점 등은 본 훈련도구의 신속한 보급이 필요하다는 당위성을 뒷받침합니다.

다른 한 편, 위의 정책과 병행하여 정신의료기관의 급성기 치료역량과 지역사회 연계를 강화하기 위한 정신질환자 지속치료 지원 시범사업이 진행되어 오면서 그 중 일부를 본 사업으로 확대하는 것에 대한 검토가 이루어지고 있습니다. 또한 급성기 병동 서비스를 어떻게 강화할 것인가에 대한 논의도 진행되고 있습니다.

급성기치료 활성화 / 병원기반 사례관리 정책을 위한 효과적 컨텐츠
: 구체적 치료행위(오픈 다이얼로그/비강압치료/회복 프로그램)**로 기능 가능**



정신질환자 중증도 분류기준 및 중증도별 병동 표준운영지침 마련 연구

	행위 관련 수가
표준운영병동	• 주당 정신치료 및 작업 및 오락 요법 회수 현실화
급성기 병동	• '급성기 정신질환 개인면담료(현재의 개인 정신치료 대체)', '급성기 입원 초기 평가료', '급성기 정신질환 간호 관리료' 등 정신과의사, 간호사 등의 인적 투입에 대한 보상 수가 신설 • 소그룹 대상으로 운영되는 전문화 집단 프로그램 및 새로 개발되는 비약물적 중재 프로그램에 대한 현실적인 신규 수가 개발 및 도입 • 지역사회 연계 서비스 수가 개발 (정신건강복지센터 의뢰 회송료, 재활시설 연개료, 퇴원사리관리료 등)

이 모든 변화는 급성기 정신의료 서비스의 질을 강화하는 방향으로 나아가고 있습니다.그러므로 이러한 정책이 실제로 임상을 개선시키며 지속 가능하도록 하기 위한 가장 효과적으로 실천가능한 서비스 행위들을 본 연구의 결과물이 제안하고 있습니다.

그러므로 정신의료기관, 정신건강복지센터 등의 정신건강증진시설에서 종사자 교육을 기획할 때에 위에 기술된 내용을 바탕으로 사업계획의 필요성을 강조하는 것이 도움이 될 것으로 판단됩니다.

2. 도입의 두 가지 핵심 지침

"여러 서비스는 동시에 서로 연동하여 실천되어야 한다"

본 5종의 도구 도입에 있어 가장 강조하고자 하는 첫 지침은 '여러 서비스가 동시에 이루어지고 서로 연동하여 실천되어야 한다'는 점입니다. 오픈 다이얼로그, 비강압(안정화)치료, 퀄리티라이츠 회복퇴원계획, 그리고 동료지원가에 의한 절차 조력은 각각 독립된 별도의 서비스가 아니라, 각 항목 하나 하나가 모두 당사자의 회복을 위해 필수적인 요소들입니다. 그리고 심리사회적 위기 상황에서 이 모든 것들이 동시에 서로 연동하면서 제공되어야 제 기능을 할 수 있습니다.

위기 당사자와 그를 돕는 가족과 종사자들이 개별 사례에서 필요한 요소를 도출하고 협력하기 위해서는 오픈 다이얼로그를 통한 연대 형성이 필수적입니다. 그러나 정신응급상황에서 안전 확보의 목적으로 강압적인 조치가 손쉽게 선택된다면 그러한 연대는 순식간에 와해될 것입니다. 그러므로 비강압치료를 지향하는 정중한 급성기입원 치료가 병행되어야 합니다. 또한 의학적 치료와 심리사회적 회복을 포함하는 모든 치료계획 수립과 실천이 일상적 진료와 지역사회 서비스에서 지속되도록 하는 퀄리티라이츠 회복퇴원계획 프로그램이 구체적인 실천 과정을 뒷받침합니다. 또한 회복의 산 경험을 가진 동료지원가들이 법적 역량 발휘와 회복 과정을 조력함으로써 공동체와의 연결이 완성되게 됩니다.

"여럿이 함께 익히고 협력한다"

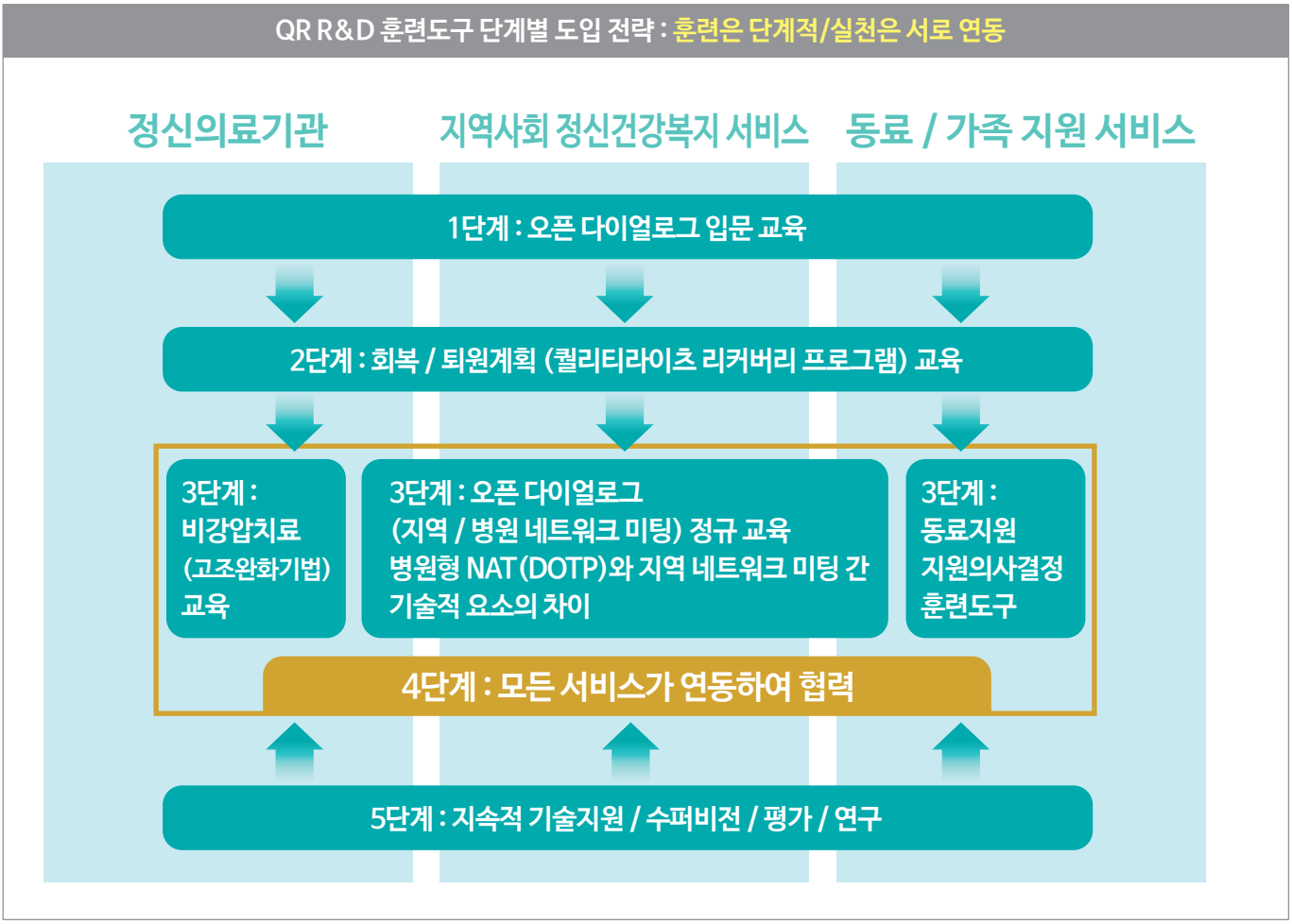
강조되어야 하는 또 하나의 지침은 '여럿이 함께 익히고 협력하여 실천한다'는 것입니다. WHO는 퀄리티라이츠 개발의 첫 단계부터 정신건강서비스 시스템 안에 있는 당사자와 가족, 정신건강 전문가와 공직자, 시민사회 등 관련한 모든 이해관계자들이 함께 하는 공동의 학습 과정을 권장해왔습니다. 또한 본 연구개발 과정을 통해서도 이러한 형태의 혼합 집단이 참여하는 교육훈련이 대단히 효과적인 것으로 밝혀졌습니다.

교육훈련 참여자의 입장에서 이러한 혼합 집단은 다양한 관점을 통한 폭넓은 이해를 가능하게 하는 경험적 학습을 제공하며, 자연스럽게 사람들 간의 연대가 형성되는 것으로 보고되었습니다. 그리고 이것은 이후의 다학제, 다분야 협력을 위한 귀한 자원으로 기능하게 됩니다. 심리사회적 위기를 겪으며 정신건강 서비스를 이용하는 당사자와 가족의 입장에서도 서비스 제공자들 간의 이러한 협력은 그 자체로 대단히 지지적인 네트워크로 작용할 수 있습니다.

예를 들어, 병원에서 안정화(비강압) 치료를 도입할 때에 이른바 보호사 등의 안전인력만을 따로 분리하여 교육하지 않고, 의사와 간호사, 사회복지사들의 다학제 팀과 함께 훈련이 이루어지는 것이 바람직합니다. 그렇게 함으로써 치료진간의 협력이 강화되고 치료 조직 안의 모든 직역 구성원들이 자신들의 업무에 대한 자부심을 가지고 동기 부여될 수 있습니다. 또한 여럿이 함께 하는 교육훈련에는 해당 조직의 최고 또는 고위관리자가 참석할 것을 권장합니다. 이러한 새로운 인권/회복 기반의 서비스가 실천되기 위해서는 임상을 뒷받침하는 행정적 지원이 필요하며 권위적이지 않은 조직내 협력 문화가 필수적이므로 관리자의 참여가 오픈 다이얼로그와 퀄리티라이츠 교육 훈련 모두에서 강조되고 있습니다.

3. 교육훈련 도입의 단계

정신의료기관, 지역사회 정신건강복지 서비스, 동료/가족지원 서비스의 세 분야에 걸쳐 본 도구가 도입되기 위한 세부 단계의 모식을 아래 그림에 요약했습니다.



1단계 : 오픈 다이얼로그 입문교육

모든 범주에 걸쳐 오픈 다이얼로그 입문 교육이 본 연구 5종 훈련도구의 첫 단계로 이루어지는 것이 바람직합니다. 오픈 다이얼로그 입문 교육은 참석자로 하여금 관습적 정신건강 서비스에서의 위계를 벗어나 서로 평등하고 창조적으로 토론하고 협력하는 기초를 제공하는 탁월한 경험적 학습입니다. 입문교육은 1-3일의 전일 교육이 적당하며 기관과 자원의 상황에 따라 융통성 있게 조정 가능하지만 최소 2일 이상 소요되는 것이 효과적입니다. 한 교육의 참석자는 25명 이내가 바람직하며 최소 2인의 교육자가 함께 진행하는 것이 바람직합니다.

2단계 : 회복/퇴원 계획(퀄리티라이츠 리커버리 프로그램)

2단계 훈련은 회복/퇴원계획(퀄리티라이츠 리커버리 프로그램) 교육을 모든 범주의 서비스에서 제공하는 것이 바람직합니다.

이 교육은 참여자들로 하여금 정신건강 서비스에서의 회복(Recovery) 관점 적용과 인권의 중요성을 이해하고 종사자들과 서비스 이용자들이 협력하여 구체적 목표를 설정하여 추진하기 위한 유용한 구조와 토론 주제를 포함합니다. 또한 이 컨텐츠는 병원과 지역사회 사례관리, 동료지원 과정에서 곧바로 사용할 수 있는 실천 도구로 적용될 수 있으며, 정신사회재활 프로그램으로서 임상적 도입이 용이하다는 장점을 가지고 있습니다. 그러므로 2단계로서 모든 범주에서 적용할 것을 권합니다. 이 훈련은 최소 30시간 이상, 바람직하게는 54시간의 교육이 약 15주에 걸쳐 진행되는 것을 권장합니다. 피교육생 참석 인원은 16-25명(4-5명 씩의 분임조)으로, 주강사 1명, 보조강사 1-2명이 진행하는 것이 바람직합니다.

3단계 : 현장에 맞춘 교육훈련

3단계의 교육은 위에 언급된 정신의료기관, 지역사회 정신건강복지 서비스, 동료/가족지원의 세 현장에서 각각 다른 내용으로 진행되도록 고안되었습니다.

-고조완화기법(안정화치료)

정신의료기관을 위한 비강압적 안정화 치료 교육으로서 기관 내의 모든 직역 종사자가 함께 참여하는 것이 바람직합니다. 1회 참석인원은 30명 이내가 바람직하며 약 3일간의 교육을 필요로 합니다. 1명의 주교육자와 2명 정도의 보조교육자가 함께 진행하게 됩니다.

-오픈 다이얼로그(지역/병원 네트워크 미팅) 정규훈련

이 교육은 정신의료기관, 지역정신보건복지 서비스, 동료/가족 지원 서비스 모든 분야에서 적용될 수 있습니다.
국제적으로 오픈 다이얼로그 실천을 위한 정규교육은 20일간의 전일교육이 필요한 것으로 합의되어 있습니다. 장기간의 교육을 위한 자원이 제한적인 관계로 정규 교육은 2-3일부터 5일 간의 교육단위(Block)으로 나누어 진행될 수 있습니다. 그리고 각 교육단위를 단계 또는 주제에 따라 분리하여 진행할 수 있으나 총 교육 기간은 단축시키지 않고 장기간에 걸쳐 나누어 하는 방식을 통해서라도 달성하는 것을 목표로 하는 것이 바람직합니다. 피교육인 인원은 20명 이내로 최소 2인 이상의 훈련자가 진행하는 것이 바람직하고 효율적입니다.

정신의료기관의 경우 한국의 입원 병상 특성에 맞추어 오픈 다이얼로그를 응용한 병원형 필요맞춤치료(DOTP) 훈련도구를 권장하며, 그 성공적인 도입을 위해서는 해당 의료기관의 치료 문화가 중요한 변수가 될 수 있습니다. 치료공동체에 기반한 다학제 접근이 정착되어 있는 기관의 경우 훈련과 실천을 받아들이기가 더 용이하지만 그렇지 않은 경우에는 치료공동체의 기본 원리와 다학제 문화 발전을 위한 프로그램이 추가될 필요가 있으므로 그에 맞추어 훈련 기간이 유연하게 설정되는 것이 바람직합니다.

병원형 필요맞춤치료(DOTP) 기초 훈련은 총 16시간을 2일에 걸쳐 진행되는 워크숍이 실제 이 서비스를 시행중인 강사진에 의해 진행되며, 지속적인 수퍼비전이 사례 중심으로 이루어지는 것이 필요합니다. 또한 이 훈련은 오픈 다이얼로그 정규 훈련과 연동되어 진행되어야 하며 관련한 심화 훈련이 이어질 수 있습니다. 지역사회 정신건강복지 서비스와 동료/가족지원 서비스에서 오픈 다이얼로그를 적용하는 경우는 종사자와 동료/가족지원가가 함께 참여하는 것이 권장되므로 교육 단계부터 실천에 이르는 모든 과정에서 다같이 하도록 진행되는 것이 바람직합니다.

-동료지원 지원의사결정

이 훈련도구는 현재까지 시범사업 형태로 진행되어왔고 향후 전국 도입을 앞두고 있는 절차조력 서비스에 참여하는 동료지원가를 위해 고안된 도구입니다. 절차조력인 양성 과정과 보수교육의 일부로서 대단히 유용하게 적용될 것을 기대합니다. 총 21시간의 교육을 약 2주에 걸쳐 진행하는 것을 권장합니다. 피교육 인원은 약 20명이 4-5명씩 조를 이루어 1명의 주교육자와 1-2명의 보조 교육자에 의해 진행됩니다.

4단계 : 모든 서비스의 협력적 연동

3단계 훈련을 통한 서비스가 효과적으로 운영되기 위해서는 각 도구들이 서로 협력적으로 연동되어야 합니다. 그리고 병원과 지역사회, 동료가족지원 서비스 간의 협력 역시 대단히 중요합니다. WHO퀄리티라이츠의 핵심가치는 정신건강분야의 모든 이들 간의 협력이 서비스 이용자 중심으로 이루어지는 것이기 때문입니다. 그것을 위해 훈련 시행 기관에서는 기관내에서의 다학제 협력에 추가하여 기관간의 다분야 협력 체계도 마련하는 것을 권장합니다.

5단계 : 지속적 기술지원, 수퍼비전, 평가, 연구

모든 교육훈련 이후에는 각 기관에서 실천해 가는 과정을 기술적으로 조력하기 위한 수퍼비전이 지속되는 것이 바람직하며 교육훈련을 시행한 훈련자에 의해 이루어지는 것을 권장합니다. 더불어 도입 및 실천 과정에 대한 평가 및 연구를 통해 서비스를 보완해 가는 것이 필요합니다.

4. 교육훈련의 플랫폼과 실행기관

-교육훈련 플랫폼과 방식

교육훈련은 정신보건복지 분야의 공공 교육 플랫폼과 예산에 의해 진행되는 것이 바람직합니다. 구체적으로 소집 교육과 기관내 교육의 두 가지 방식이 가능합니다. 소집교육은 여러 기관에서 온 참석자들을 한 곳에 소집하여 일정기간 이루어지는 형태입니다. 현재 국내 정신건강복지 시스템에는 다양한 공적 소집 교육 플랫폼이 존재합니다. 대표적으로 한국보건복지인재원에 의해 진행되는 다양한 교육, 공공병원에 의해 진행되는 정신건강전문요원 보수교육, 국가인권위원회에 의해 진행되는 인권교육 등이 있습니다. 본 훈련도구가 이러한 기관들의 교육 컨텐츠로 선정되어 진행된다면, 기존의 교육 시설과 예산을 활용하여 널리 보급될 수 있다는 이점을 얻게 됩니다.

본 훈련도구의 서비스를 실천하기를 원하는 정신의료기관, 지역정신건강복지 서비스 기관, 당사자 가족 단체 등에서 강사진을 초청하여 기관 내의 종사자들을 대상으로 시행하는 기관내 교육(in-house training) 역시 가능한 방법이 될 수 있습니다. 위 두 경우 모두 교육훈련 계획 단계부터 위에 제시한 단계와 구조에 따른 도입을 할 것을 권장합니다. 또한 본 훈련도구의 모든 교육은 단순한 지식 전달이 아닌, 참석자들 간의 상호작용과 소통을 통한 경험적 학습이므로, 온라인이 아닌 대면 교육으로 진행되는 것이 바람직합니다.

-교육훈련 실행 기관

모든 교육은 본 연구개발에 참여했으며 실제로 그 내용을 전문적으로 장기간 실천해 온 기관에서 시행하는 것이 바람직합니다. 그러므로 각각의 훈련도구를 교육할 수 있는 기관의 리스트와 문의를 위한 연락처를 아래에 명시했습니다.

훈련도구	교육기관	문의처
지역기반 네트워크 미팅 (오픈 다이얼로그)	한국 오픈 다이얼로그 학회	mindtrek@hanmail.net
병원기반 네트워크 미팅 (필요맞춤치료; DOTP)	이음병원	eumhospital@naver.com
퀄리티라이츠 리커버리 회복/퇴원계획	아주대학교병원	brainist.cho@gmail.com
고조완화기법(안정화치료)	천주의성요한병원	nearlord1209@gmail.com
동료지원 지원의사결정	사회적협동조합 우리다움 절차조력사업단	hayosa@naver.com

또한 추후에 이 교육훈련을 시행할 수 있는 훈련자를 전국적으로 양성할 필요가 있습니다. 그러므로 장기적으로는 각 훈련도구에 대한 훈련자 양성과정이 개발되어야 합니다.

5. 지속적 보급을 위해 필요한 조치

본 훈련도구가 전국적으로 보급되어 지속가능한 서비스로서 시스템에 기여하기 위해서는 몇 가지 제도적 뒷받침이 필요합니다. 구체적으로 지침 개정, 시범운영기관 또는 지역 확산, 서비스 수가 및 보상 개발 등을 예로 들 수 있습니다.

-지침개정

현행 정신건강증진시설 인권교육 지침이 글로벌 정신건강서비스 인권 기준에 맞추어 전면적으로 개정되어야 공공 교육 기관에서 그에 맞추어 WHO 퀄리티라이츠와 관련한 본격적인 교육 계획을 수립할 근거가 마련됩니다. 또한 지역정신건강복지 서비스의 가이드가 되는 정신건강사업안내에 종사자들의 교육훈련과 다학제/다부문 협력을 권장하는 지침이 포함되는 것이 실질적인 사업 추진의 근거가 될 수 있습니다. 또한 정신의료기관에서도 관련한 서비스를 위한 교육훈련에 대한 보상이 마련된 지침 개정이 필요합니다.

-시범운영 기관 / 지역

본 훈련도구가 지향하는 서비스는 상당한 인적, 물적 자원 투입과 정신의료기관과 지역정신건강복지 기관, 당사자/가족간의 다부문 협력을 필요로 합니다. 그러므로 전국적 보급 이전에, 새로운 서비스를 본격적으로 실천할 수 있는 시범 기관 또는 지역을 선정하여 자원을 지원하는 것이 현실적인 방법이 될 수 있습니다. 예를 들어 본 연구개발사업에서는 경기도 수원시가 시험운영 지역으로 선정되어 아주대학교병원, 이음병원, 수원시행복정신건강복지센터, 수원시성인정신건강복지센터, 수원시자살예방센터, 당사자단체 마음사랑, 경기도절차조력사업지원단, 수원시정신건강가족학교 등이 참여하는 다부문 협력이 병원과 지역 서비스 전체에서 집중적으로 이루어졌고, 그 효과가 드러났습니다.

-서비스 수가 및 보상 개발

본 연구개발의 결과물로 실천될 서비스가 지속가능하기 위해서 각각의 서비스에 대한 수가가 마련되어야 합니다. 그리고 이들 서비스는 보다 넓은 정책 실천 안에 포함되는 것이 바람직합니다. 현재 진행중인 정신질환자 지속치료지원사업에 포함된 급성기치료 활성화, 병원기반 사례관리, 낮병원 시범 사업 등에 요구되는 치료 행위들에 본 훈련도구에 바탕한 각각의 서비스가 포함되고 적정한 수가가 책정될 필요가 있습니다. 또한 지역정신건강복지 서비스 기관 역시 평가 및 운영 지침에 새로운 인권/회복 기반 서비스와 다부문 협력에 대한 보상이 마련되어야 합니다. 이러한 정책적 조치가 향후 지속적인 보급을 위한 기초가 될 것입니다.

맺음말

본 훈련도구의 도입을 위해 세계보건기구(WHO)가 선택한 세부 전략이 좋은 참고가 됩니다. WHO는 우선 평가도구와 훈련도구를 제일 먼저 개발하고, 이어서 실제 모범사례들을 소개한 가이던스, 법령 개정 지침, 정책 실천 가이던스의 세밀한 단계를 거쳐 이 프로젝트를 진행해왔습니다. 그 중 특히 훈련도구를 첫 단계로 도입한 것은 그것이 서비스 변혁을 위한 변화의 첫 단추이기 때문입니다. 그런 면에서 이번 훈련도구 개발이 큰 의미를 가집니다.

또한 WHO가 그간 가장 강조해 온 것은 이 프로젝트에 참여한 모든 이들이 '변화가 가능하다는 것을 믿게 되었다'는 것입니다. 모든 이해관계자들이 다함께 '이전과는 다른' 방식으로 협업하게 되었을 때 '실제로 다른 결과'가 구현되었다는 것을, WHO는 지난 십여 년 동안 증명해오고 있습니다. 본 연구개발에서의 경험 역시 동일합니다.

정책의 변화는 현장의 변화를 촉진합니다. 그리고 현장의 변화는 최종적으로 심리사회적 약자와 가족들의 삶과 공동체를 변화시키게 됩니다. 본 연구 결과물이 이러한 변화를 통해 우리 사회가 통합과 포용으로 나아기는 데에 작은 마중물이 되기를 기대합니다.

발 간 사

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램 가이드북을 펴내며

회복의 여정 중에 있는 당신에게

'회복'이라는 단어는 이제 정신건강 영역에서도 낯설지 않은 개념이 되었습니다. 다양한 지면과 강연, 실천 현장에서 회복이라는 말을 자주 접하게 되지만, 막상 '회복이란 무엇인가?'라는 질문 앞에서는 쉽게 답하기 어렵습니다. 회복이 단순히 긍정적인 변화나 증상의 호전을 의미하는 것은 아닐 텐데, 정작 우리가 회복이라는 말을 쓸 때 그 안에 어떤 의미를 담고 있는지 되묻게 됩니다. 정신건강 영역에서 회복에 대한 관심이 높아졌다는 것은 분명 반가운 변화입니다. 그러나 그 관심이 깊은 성찰 없는 구호처럼 회자될 때, 회복이라는 말은 당사자와 보호자, 종사자 모두에게 공허한 울림이 될 수 있습니다.

이 연구를 시작하면서 저는 회복의 의미를 명확히 정의하고, 그것을 임상 현장에서 실천 가능한 형태로 제시하고 싶었습니다. 회복이 증상 관리 이상의 개념이라는 확신은 있었지만, 그 출발점은 여전히 전문가가 당사자와 보호자에게 회복을 '가르치는' 방식, 즉 정신교육의 연장선에 가까웠습니다. 회복은 결핍된 당사자를 위한 보완적 개입이며, 보호자의 역할은 복약과 진료 참석을 독려하는 것으로 한정되어 있다고 여겼습니다. 하지만 프로그램을 개발하고, 운영하고, 함께 걸어가는 과정에서 이 생각은 근본적으로 바뀌게 되었습니다. 회복은 누군가가 누군가에게 일방적으로 제공하거나 가르칠 수 있는 것이 아니라, 함께 나누고 실현해 가야 할 여정이라는 걸 알게 되었습니다. 회복은 당사자만의 몫도, 보호자만의 과업도, 종사자만의 책임도 아니었습니다. 회복은 누구에게나 필요한 것이며, 그 누구도 예외일 수 없었습니다.

용인정신병원이 WHO의 『Recovery Practices for Mental Health and Well-being』을 회복에 대한 열정으로 정식 번역하기 이전, 아주대학교병원 낮병원에서는 이미 2019년부터 이 프로그램을 운영해 오고 있었습니다. 시작은 어색함의 연속이었습니다. '회복'이라는 막연한 주제로 몇 개월 동안 이야기를 나눈다는 것이 과연 가능할까 하는 걱정이 먼저 앞섰습니다. 당사자, 보호자, 종사자가 한 조에 속해 평등하게 의견을 나눈다는 취지는 말처럼 쉽지 않았습니다. 가운을 입은 종사자의 한 마디에 조 전체의 분위기가 자연스레 쏠리는 현실 속에서 낯설고 어색한 공기가 흐르기도 했습니다. 또한 미구엘, 수라야, 하산, 메리 등 우리 정서와는 다소 거리감이 있는 사례 속 인물들의 이름이 헷갈려 집중이 흐트러지는 일도 자주 있었습니다. 그럼에도 불구하고 시작했기에, 끝까지 해내고 싶었습니다. 당사자에게만 설명하고 권유하는 것이 아니라, 보호자에게도 더 많은 정성과 노력을 들여 참여를 독려했습니다. 종사자는 모두 사복을 입고 참여했고, '조현병 환자', '어머니', '선생님'이라는 호칭 대신 이름이나 별명을 부르며 평등한 대화를 시도했습니다. 회복은 그렇게, 서툴고 어설프지만 진심을 담은 시도 속에서 조금씩 자리를 잡아갔습니다.

그리고 3개월 뒤, 우리는 놀라운 장면들을 마주하게 되었습니다. 당사자는 병동에서도, 진료실에서도 들려주지 않던 이야기를 꺼냈습니다. 자신이 사랑했던 것들, 꿈꿨던 삶, 혼란과 두려움, 그리고 신뢰하고 싶지만 쉽게 다가갈 수 없었던 보호자와 종사자에 대한 솔직한 감정을 털어놓았습니다. 보호자는 누구보다도 치열하게 당사자의 곁을 지켜온, 그래서

때로는 누구보다 복합적인 감정을 가진 존재였습니다. 실망과 희망 사이에서 흔들려온 시간들이 보호자를 더욱 섬세한 치유의 동반자로 단련시키고 있었습니다. 하지만 한편으로는 아쉬움도 컸습니다. WHO가 제시한 프로그램 속 회복은 기존의 치료 시스템과 대비되는 구조 안에서 설명되곤 했고, 그로 인해 종사자가 프로그램 속에서 자신을 소외된 존재로 느끼는 일이 종종 있었습니다. '내가 이 자리에 있어도 되는가?'라는 질문을 품은 채 멀찍이 참여자의 회복을 바라보는 이들이 있었습니다.

그래서 우리는 '회복'이라는 단어가 특정 집단의 전유물이 아니라, 우리 모두가 함께 이야기하고 함께 만들어가야 할 삶의 태도이자 방향임을 어떻게 더 진정성 있게 전달할 수 있을지 깊이 고민했습니다. 그 결과, 한국의 임상 현실과 문화적 맥락에 맞도록 프로그램을 세심하게 수정하고, 우리 정서에 맞는 한국어 사례들을 추가했으며, 당사자·보호자·종사자 모두가 자신의 회복을 주체적으로 이야기할 수 있도록 구성의 균형을 다시 조율했습니다. 그 결과, 종사자도 점점 자신의 삶 속 회복을 이야기하게 되었습니다. 회복은 더 이상 당사자나 보호자에게만 필요한 것이 아니었습니다. 누군가의 이야기를 들으며 서로의 삶을 돌아보고, 또 누군가의 슬픔에 공감하며 오히려 내 마음이 치유되는 시간을 가질 수 있었습니다. 그리고 프로그램에 참여한 종사자들은 한결같이 이렇게 말했습니다.

"이 프로그램의 가장 큰 수혜자는 바로 저였던 것 같습니다."

우리는 이 프로그램을 통해 '회복'을 '자기감의 회복'이라 정의하고자 했습니다. 온전한 나를 회복하고, 온전한 너를 만나 동행하는 것이야말로 회복의 본질이라 믿었습니다. 하지만 동시에 우리는 회복이라는 개념이 결코 하나의 정의로 고정될 수 없다는 것도 압니다. 회복은 유동적이고, 살아 있는 이야기입니다. 논의는 계속되어야 하고, 그 속에서 우리는 매번 새로운 회복을 만나게 될 것입니다. 정신질환이라는 상황에서 출발했지만, 결국 우리가 바라는 회복은 인간다움의 회복이었습니다. 이 프로그램이 당사자, 보호자, 종사자 모두에게 개인의 회복을 넘어, 사회와 공동체의 회복으로 이어지는 첫걸음이 되기를 소원합니다.

끝으로, 이 여정에 함께 해주신 모든 분들께 감사의 인사를 전합니다.

선구자처럼 앞서 걸어주신 김성수 선생님과 이숙희 선생님, 그리고 회복을 매일같이 실천해 오신 이음병원의 김영희, 양명화, 조순이 선생님께 깊은 감사를 드립니다. 프로그램의 운영과 개발에 함께해 주신 아주대학교병원의 유안나, 정수인, 김진, 김봉채 선생님과 여러 자원봉사자들, 지역사회 정신건강의 회복을 위해 애써주신 김유라, 이찬란, 최지원, 박시진 선생님께도 마음 깊이 감사드립니다. 또한, 언제나 따뜻한 지지로 함께해 주신 사회적협동조합 우리다움의 동료지원가 여러분, 섬세한 번역으로 힘을 보태주신 신성만 교수님과 임한나, 박은수 선생님, 김시언 학생, 그리고 따뜻한 감성을 더해주신 신민하 디자이너님께도 고개 숙여 감사드립니다.

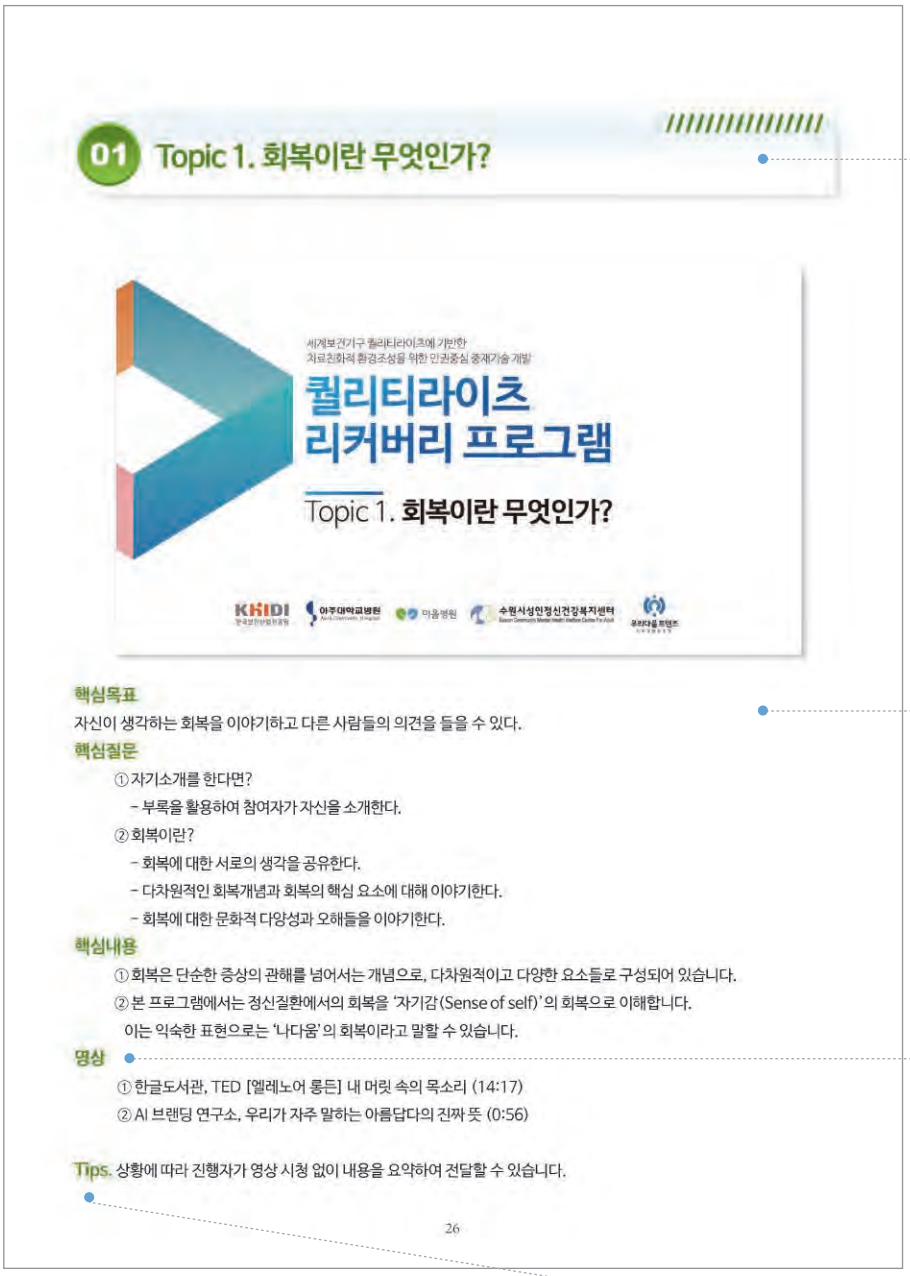
마지막으로, 이 연구의 총괄 책임자로서 든든한 버팀목이 되어주신 노재성 교수님, 아낌없는 지원을 보내주신 홍창형 교수님, 그리고 모든 개발 과정에서 가장 큰 힘이 되어주신 허은실 선생님께 진심으로 감사의 마음을 전합니다.

회복의 여정 중에 있는 당신에게, 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램이
어두운 밤 하늘에 은은하고도 따듯하게 길을 비춰주는 자그마한 별이 되길 바랍니다.

아주대학교병원 정신건강의학과 교수 / 수원시성인정신건강복지센터 센터장 **조용혁**

00 | Topic 0. 오리엔테이션 ---- 26
01 | Topic 1. 회복이란 무엇인가? ---- 36
02 | Topic 2. 회복 지향적 접근 ---- 49
03 | Topic 3. 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진 ---- 58
04 | Topic 4. 회복의 여정에 함께 한다는 것 ---- 70
05 | Topic 5. 회복의 여정에서의 경계 ---- 84
06 | Topic 6. 회복을 위한 긍정적 위험감수 ---- 93
07 | Topic 7. 공동체로의 재연결 ---- 106
08 | Topic 8. 회복 의사소통 기술 1 ---- 118
09 | Topic 9. 회복 의사소통 기술 2 ---- 135
10 | Topic 10. 회복의 별 ---- 148
11 | Topic 11. 회복 계획 1 ---- 155
12 | Topic 12. 회복 계획 2 ---- 167
13 | 수료식 ---- 175
14 | 참고문헌 ---- 186
15 | 부록 ---- 189

가이드북의 구성과 특징



01 Topic 1. 회복이란 무엇인가?

세계보건기구 퀄리티라이즈에 기반한
치료친화적 환경조성을 위한 민관중심 중재기술 개발

퀄리티라이즈
리커버리 프로그램

Topic 1. 회복이란 무엇인가?

KHIDI 아주대학교병원 마음병원 수원시성인정신건강복지센터

핵심목표

자신이 생각하는 회복을 이야기하고 다른 사람들의 의견을 들을 수 있다.

핵심질문

① 자기소개를 한다면?
- 부록을 활용하여 참여자가 자신을 소개한다.

② 회복이란?
- 회복에 대한 서로의 생각을 공유한다.
- 다차원적인 회복개념과 회복의 핵심 요소에 대해 이야기한다.
- 회복에 대한 문화적 다양성과 오해들을 이야기한다.

핵심내용

① 회복은 단순한 증상의 관해를 넘어서는 개념으로, 다차원적이고 다양한 요소들로 구성되어 있습니다.
② 본 프로그램에서는 정신질환에서의 회복을 '자기감(Sense of self)'의 회복으로 이해합니다.
이는 익숙한 표현으로는 '나다움'의 회복이라고 말할 수 있습니다.

영상

① 한글도서관, TED [엘레노어 롱든] 내 머릿 속의 목소리 (14:17)
② AI 브랜딩 연구소, 우리가 자주 말하는 아름답다의 진짜 뜻 (0:56)

Tips. 상황에 따라 진행자가 영상 시청 없이 내용을 요약하여 전달할 수 있습니다.

26

Topic별 구조

총 12개의 주제(Topic)로 구성되어 있으며, 각 Topic은 1회기 단위로 구성되어 있습니다.

핵심요소 요약

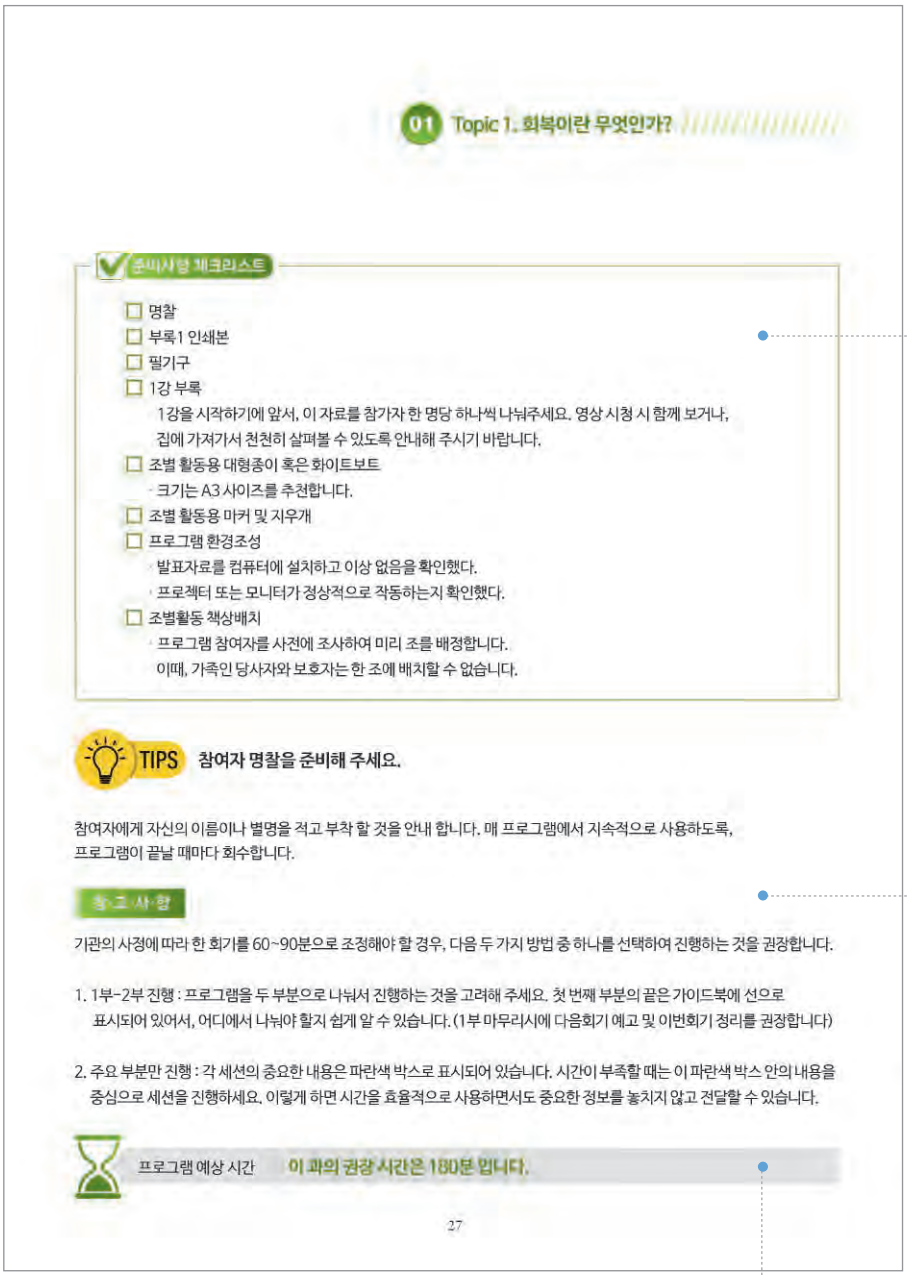
각 Topic 시작 부분에는 '핵심목표', '핵심질문', '핵심내용'이 정리되어 있어, 당일 회기에서 무엇에 집중해야 하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

영상

각 Topic에 사용될 영상의 출처와 영상의 길이를 파악할 수 있습니다.

Tips

실제 현장에서 경험한 어려움이나 유용한 팁이 곳곳에 포함되어 있어, 처음 진행하는 분들도 쉽게 참고할 수 있습니다.



01 Topic 1. 회복이란 무엇인가?

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록1 인쇄본
- ☐ 필기구
- ☐ 1강 부록
  1강을 시작하기에 앞서, 이 자료를 참가자 한 명당 하나씩 나눠주세요. 영상 시청 시 함께 보거나, 집에 가져가서 천천히 살펴볼 수 있도록 안내해 주시기 바랍니다.
- ☐ 조별 활동용 대형종이 혹은 화이트보드
  - 크기는 A3 사이즈를 추천합니다.
- ☐ 조별 활동용 마커 및 지우개
- ☐ 프로그램 환경조성
  - 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다.
- ☐ 조별활동 책상배치
  - 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다.
  이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

TIPS 참여자 명찰을 준비해 주세요.

참여자에게 자신의 이름이나 별명을 적고 부착 할 것을 안내 합니다. 매 프로그램에서 지속적으로 사용하도록, 프로그램이 끝날 때마다 회수합니다.

참고사항

기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부~2부 진행 : 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

2. 주요 부분만 진행 : 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 이 파란색 박스 안의 내용을 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 이 과의 권장 시간은 180분 입니다.

27

준비사항 체크리스트

각 회차마다 필요한 물품이 체크리스트 형식으로 제공되어 실수 없이 준비할 수 있습니다.

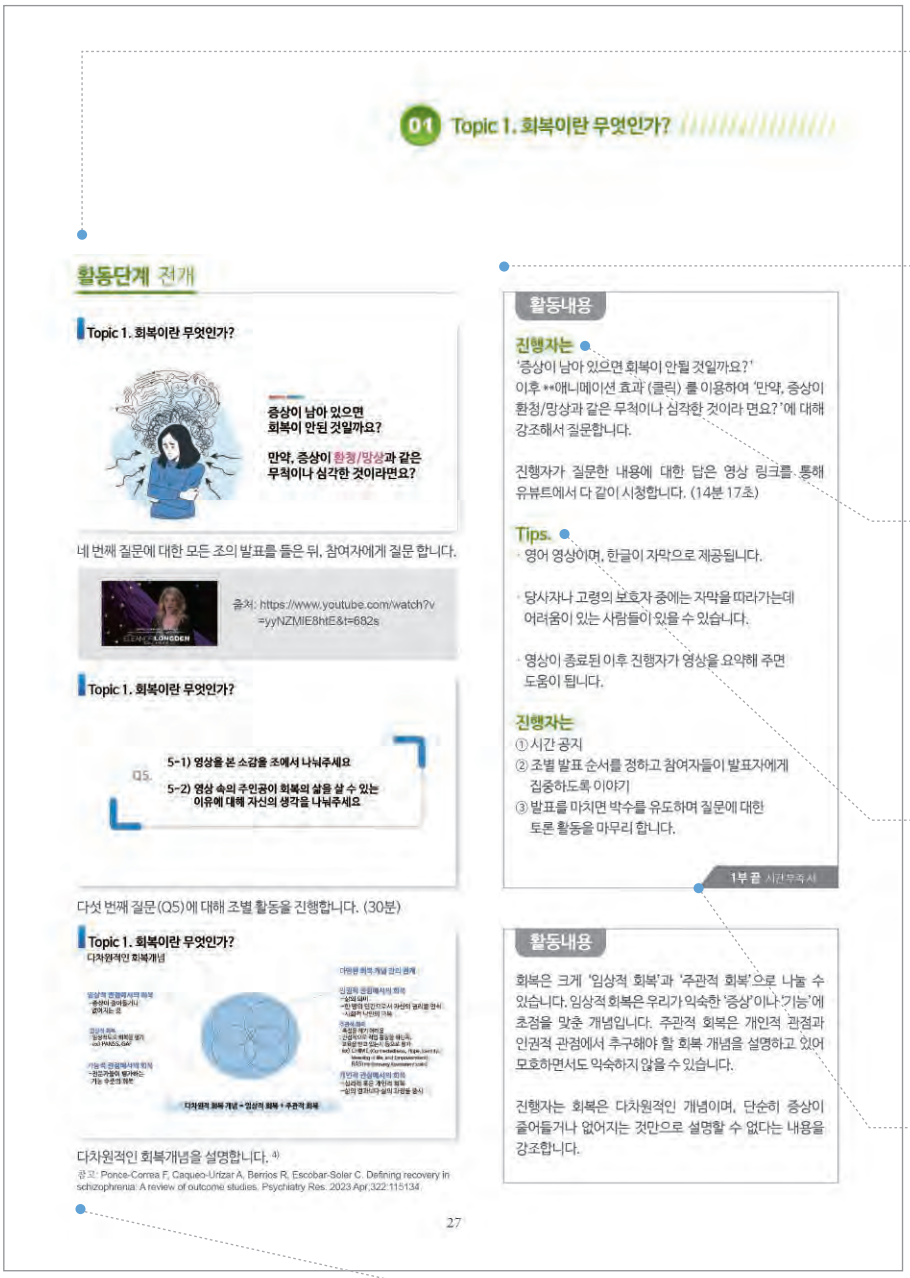
참고사항

제한된 시간 내에서도 핵심 내용을 놓치지 않고 진행할 수 있도록, 회기 분할 기준과 주요 내용 선별 기준이 함께 안내되어 있습니다.

프로그램 예상 시간

각 회기에는 주제와 활동의 성격에 따라 권장 시간이 제시되어 있으며, 이는 참여자 간 충분한 나눔과 활동 진행을 위한 기준 시간입니다.

가이드북의 구성과 특징


01 Topic 1. 회복이란 무엇인가?

활동단계 전개

Topic 1. 회복이란 무엇인가?

증상이 남아 있으면 회복이 안된 것일까요?

만약, 증상이 환청/망상과 같은 무척이나 심각한 것이라면요?

네 번째 질문에 대한 모든 조의 발표를 들은 뒤, 참여자에게 질문 합니다.

출처: https://www.youtube.com/watch?v=yyNZMIE8htE&t=682s

Topic 1. 회복이란 무엇인가?

Q5. 5-1) 영상을 본 소감을 조에서 나눠주세요
5-2) 영상 속의 주인공이 회복의 삶을 살 수 있는 이유에 대해 자신의 생각을 나눠주세요

다섯 번째 질문(Q5)에 대해 조별 활동을 진행합니다. (30분)

Topic 1. 회복이란 무엇인가?
다차원적인 회복개념

다차원적인 회복개념을 설명합니다. 4)

출처: Ponce-Correa F, Caqueo-Urizar A, Berrios R, Escobar-Soler C. Defining recovery in schizophrenia: A review of outcome studies. Psychiatry Res. 2023 Apr;322:115134.

27

활동내용

진행자는
'증상이 남아 있으면 회복이 안될 것일까요?'
이후 **애니메이션 효과 (클릭) 를 이용하여 '만약, 증상이 환청/망상과 같은 무척이나 심각한 것이라 면요?'에 대해 강조해서 질문합니다.

진행자가 질문한 내용에 대한 답은 영상 링크를 통해 유튜브에서 다 같이 시청합니다. (14분 17초)

Tips.
· 영어 영상이며, 한글이 자막으로 제공됩니다.
· 당사자나 고령의 보호자 중에는 자막을 따라가는데 어려움이 있는 사람들이 있을 수 있습니다.
· 영상이 종료된 이후 진행자가 영상을 요약해 주면 도움이 됩니다.

진행자는
① 시간 공지
② 조별 발표 순서를 정하고 참여자들이 발표자에게 집중하도록 이야기
③ 발표를 마치면 박수를 유도하며 질문에 대한 토론 활동을 마무리 합니다.

1부 끝 시간 무족 시

활동내용

회복은 크게 '임상적 회복'과 '주관적 회복'으로 나눌 수 있습니다. 임상적 회복은 우리가 익숙한 '증상'이나 '기능'에 초점을 맞춘 개념입니다. 주관적 회복은 개인적 관점과 인권적 관점에서 추구해야 할 회복 개념을 설명하고 있어 모호하면서도 익숙하지 않을 수 있습니다.

진행자는 회복은 다차원적인 개념이며, 단순히 증상이 줄어들거나 없어지는 것만으로 설명할 수 없다는 내용을 강조합니다.

좌측 페이지

활동 단계별 흐름과 함께,
참고할 슬라이드가 안내됩니다.

우측 페이지

해당 슬라이드의 해설과 진행자 대본, 질문 예시가 포함되어 있어 실제 진행에 바로 활용할 수 있습니다.

회기 흐름 이해하기

각 Topic은 도입 - 전개 - 정리의 세 단계로 구성되며, 각 단계별 활동 흐름과 내용이 양쪽 페이지(좌우)에 나뉘어 안내됩니다.

Tips

실제 현장에서 경험한 어려움이나 유용한 팁이 곳곳에 포함되어 있어, 처음 진행하는 분들도 쉽게 참고할 수 있습니다.

분할 기준선

제한된 시간 내에서도 핵심 내용을 놓치지 않고 진행할 수 있도록, 회기 분할 기준선을 표시해두었습니다.

참고문헌

해당 내용에서 사용된 참고문헌 및 출처가 표시되어 있습니다.

가이드북 활용법

효과적으로 프로그램을 운영하기 위해 아래와 같이 활용해 주세요.

사전 준비

· 준비물 체크리스트를 바탕으로, 환경(프로젝터, 조 배치, 출력물 등)과 물품을 미리 준비합니다.
· 각 회차마다 필요한 물품은 체크리스트 형식으로 제공되어, 실수 없이 준비할 수 있습니다.
또한 영상 시청, 발표자료 송출 등 진행 환경 점검 항목도 포함되어 있어, 사전 리허설에 활용하면 좋습니다.

진행 시 유의사항

· 활동단계는 좌측에서 흐름을 파악하고, 활동내용은 우측에서 설명과 해설을 확인합니다.
· 슬라이드 클릭 순서나 애니메이션 효과가 필요한 경우, 미리 연습해 보고 타이밍을 체크해 두면 좋습니다.
· 대본은 참고용으로, 자신의 말로 자연스럽게 재구성해 참여자와 소통하는 것이 중요합니다.
· 토론 진행 시 참여자의 발언을 경청하고, 교정하거나 정답을 유도하지 않습니다.
· 조장/서기/발표자 역할은 매 회기마다 새롭게 선출되며, 참여자의 자발성을 존중하되 필요시 지원이 필요합니다.

프로그램의 핵심 철학 기억하기

· 이 프로그램은 '증상의 관해'를 넘어서 '나다움'의 회복, 즉 자기감 회복을 목표로 합니다.
· 참여자(당사자), 보호자, 종사자가 수평적인 관계에서 서로를 이해하고 존중하는 것이 회복의 출발점입니다.
· 각자의 목소리가 '하나의 의견'으로 존중받을 수 있도록 진행자의 촉진자 역할이 매우 중요합니다.

조별활동 진행방법



토론 내용 작성방법

1. 화이트 보드 시트지 사용

· 장점 : 지울 수 있으므로 여러 번 사용하기 용이함

· 단점 : 하나의 토론 주제에 대해서는 기록 후 지워야 하기 때문에, 토론이 이어지는 주제일 경우에는 지우기 전에 사진을 찍어 두어야 함.





← 화이트 보드 시트지 예시

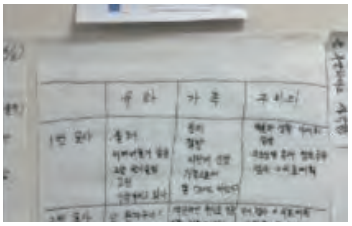


2. 포스트잇 563 테이블탑 2in1 이젤 패드 사용

· 장점 : 내용을 기록한 후, 이동이 용이하여 다른 곳에 쉽게 붙여둘 수 있음.

· 단점 : 한 번 기록한 내용은 지울 수 없으며, 포스트잇을 모두 사용하면 재구매해야 함.





← 이젤 패드 사용 예시

조별활동 진행방법

토론 내용 발표방법

1. 조별 발표자가 일어서서 발표 (규모가 작은 경우)

1) 진행자는 각 조의 발표자가 발표할 때,
① 발표자가 앞으로 나와서 발표하도록 안내할 수도 있고,
② 자리에서 일어나 발표하도록 할 수도 있습니다.

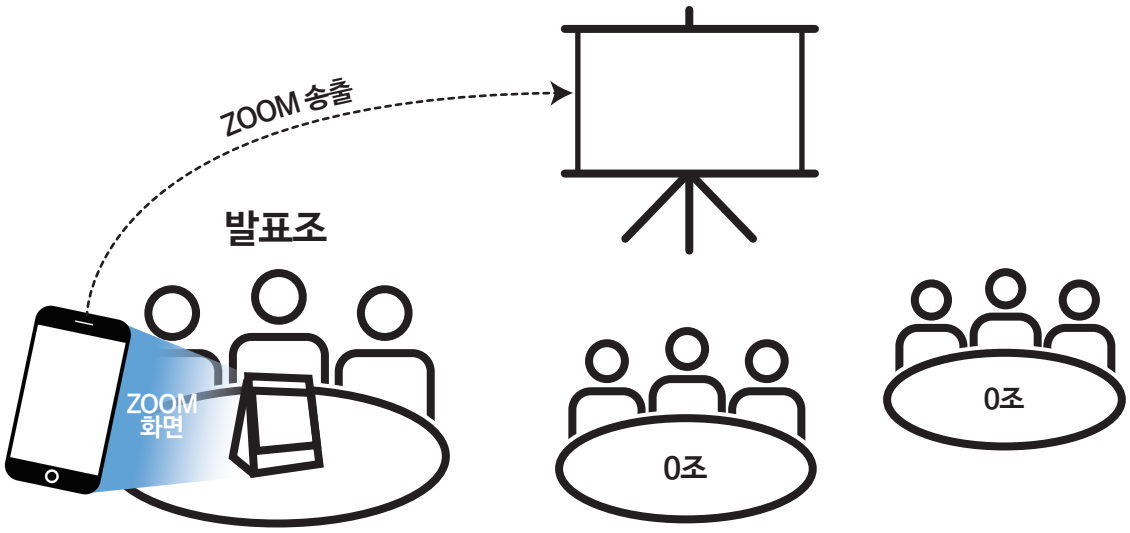
2) 발표가 진행되는 동안 모든 참여자들이 발표자 쪽으로 의자를 돌려 발표 내용에 집중할 수 있도록 유도합니다.
또한 발표자 외의 조원들은 화이트 보드 시트지나 대형 포스트잇을 전체 참여자들이 잘 볼 수 있도록 방향을 맞춰 들고 있도록 안내할 수 있습니다.

2. Zoom을 활용한 발표 (규모가 커질 경우)

1) 진행자는 PC에 진행용 PPT를 미리 준비해 두듯, Zoom 회의를 생성하여 화면(또는 스크린)에 띄울 수 있도록 사전에 설정해 둡니다.

2) 보조 진행자는 자신의 휴대폰으로, 진행자가 생성한 Zoom 회의에 입장합니다. 입장이 완료되면, 진행자는 보조 진행자에게 화면 공유 권한을 부여합니다.

3) 각 조가 발표할 때, 보조 진행자가 화면 공유 기능을 이용해 자신의 휴대폰으로 발표 내용을 비추고, 모든 참여자가 발표 내용을 함께 볼 수 있도록 합니다.



00 Topic 0. 오리엔테이션



핵심목표

참여자가 자신의 치료 목표를 '자기감의 회복'이라고 다른 사람에게 말로 표현할 수 있다.

핵심질문

① 자아의 경계란?

- 자아의 경계에 관한 도식으로 정신질환을 이해한다.

② 치료의 목표란?

- 증상회복을 넘어선 회복의 개념을 이해하고, 이를 자기감의 회복으로 정의할 수 있다.

③ 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램이란?

④ 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 특징은?

- 당사자, 보호자, 종사자가 함께 하는 그룹 치료 프로그램
- 실질적인 사례에 대한 토의를 통해 당사자, 보호자, 종사자 간의 상호 이해를 증진시키는 프로그램
- 정답을 배우는 것이 아닌, 모두의 이야기가 경청되고 존중되는 프로그램

⑤ 추후 계획은?

- 퀄리티라이츠 리커버리 전체 토픽 소개 및 개요를 제시한다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 프로그램 동의서
- ☐ 설문지 (사전검사지)
- ☐ 필기구
- ☐ 프로그램 환경조성
  - · 발표자료를 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - · 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다.
- ☐ 책상 배치

TIPS 프로그램 동의서 및 설문지

1. 본 프로그램은 회복과 삶에 대한 명확한 목적이 있습니다.
시작과 끝에 진행하는 설문을 통해 얼마나 좋아졌는지 격려할 수 있습니다.

2. 작성된 동의서와 설문지는 치료진만 확인하며 안전하게 보관되고 일정 기간 이후 파기됩니다.

3. 당사자 중 설문지와 동의서 작성에 도움이 필요할 수 있습니다.
   → 보호자도 자신의 설문지에 집중하도록 직원이 작성을 보조해주십시오.
   미리 담당자를 선정하여 역할을 나누어 두시는 것이 진행에 도움이 됩니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 90분 입니다.**

활동단계 사전 작성



활동내용

진행자는

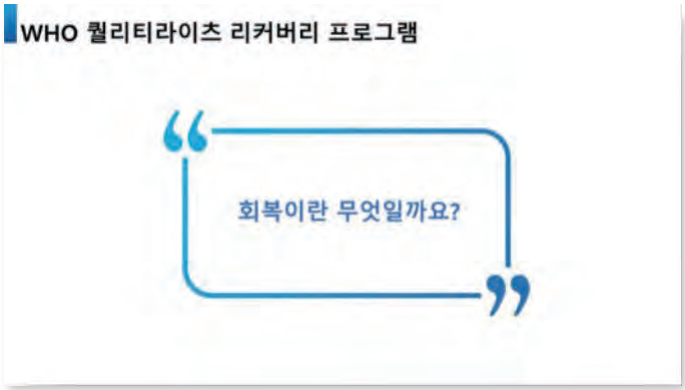
동의서와 설문지를 모든 참여자가 작성하도록 공지합니다. 아래의 내용을 작성 전 또는 중에 설명합니다.

① 개인별 프로그램의 효과를 확인하기 위해 종료 시에도 설문지를 한번 더 작성합니다.
② 당사자 뿐만 아니라 보호자, 종사자도 함께 참여하는 프로그램이므로 모두 각자 자신의 동의서와 설문지를 작성해야 합니다.
③ 동의서와 설문지는 비밀이 보장되며, 안전하게 보관되고 일정 기간 후에 파기됩니다.

Tips.

진행자는 미리 필요한 물품과 도움을 줄 수 있는 직원을 확인해 두십시오. 진행 중에 도움을 받지 못하는 당사자를 발견 시 연계를 해주십시오.

활동단계 도입





본 프로그램에서 핵심인 세 질문으로 오리엔테이션을 시작합니다.

활동내용

진행자는

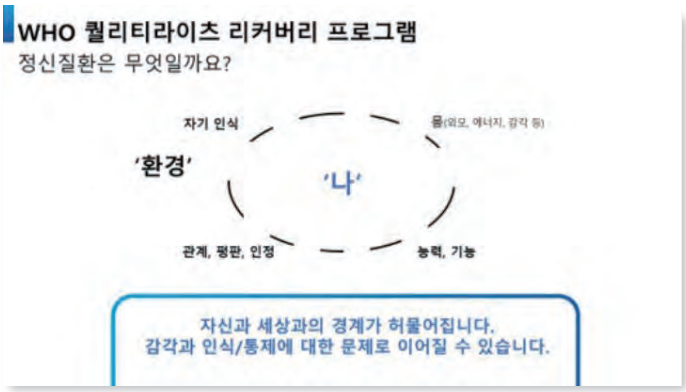
'회복이란 무엇일까요?',
'나의 삶엔 회복이 필요한가요?',
'정신질환은 무엇이고 무엇을 회복해야 하나요?'
라는 세 가지 질문을 합니다.

시간이 허락된다면 자유롭게 참여자들의 이야기를 들으면 좋습니다.

Tips.

진행자는 미리 필요한 물품과 도움을 줄 수 있는 직원을 확인해 두십시오. 진행 중에 도움을 받지 못하는 당사자를 발견 시 연계를 해주십시오.

활동단계 전개



'자아의 경계' 개념을 설명합니다.[1)]

애니메이션 효과 1~4번 (클릭4차례)까지 자아의 경계에 대해 소개를 진행합니다.

애니메이션 효과 5번~7번 (클릭 3차례)은 자아의 경계가 무너지는 것을 표현합니다.

활동내용

애니메이션 효과 1 ~ 4번

인간은 평생 동안 '나'와 '내가 아닌 것'을 구별하며 살아갑니다. 나와 내가 아닌 것을 구별하는 경계를 '자아의 경계'라고 부릅니다.

'자아의 경계'는 크게 네 가지로 이루어져 있습니다.
첫째, 몸에 대한 자아의 경계입니다. 갓난아이는 자신의 몸을 탐색하고 알아가는 과정에서 크게 발달하게 됩니다. 이는 나를 인식할 때 외모, 힘과 에너지, 감각 등을 통해 자신을 알아가는 것을 의미합니다.

둘째, 기능에 대한 자아의 경계입니다. "엄마, 엄마, 이리 와 요것 보셔요"라는 가사를 떠올려 보세요. 이는 자신의 능력이나 기능을 알고 남에게 이야기하려는 모습을 나타냅니다. 이 부분은 유치원 시절에 크게 발달하게 됩니다. 우리는 자신을 남에게 소개할 때, "저는 ~~일을 하는 사람입니다."라고 표현하는데, 이 부분이 바로 기능에 대한 자아입니다.

셋째, 관계에 대한 자아의 경계입니다. 이 부분은 청소년기에 크게 발달합니다. 타인과의 관계 속에서 자신을 발견하는 것이며, 관계 안에서 내가 다른 사람에게 어떻게 인식되는지를 고민하는 중요한 부분입니다.

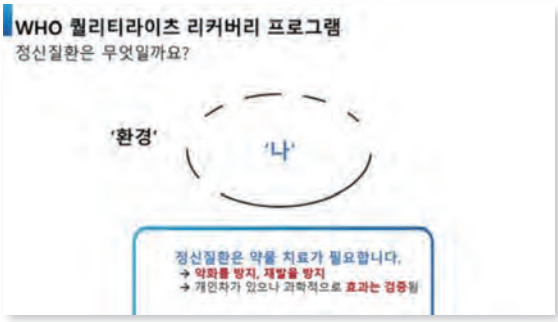
넷째, 자기인식에 대한 자아의 경계입니다. 이는 나를 조금 더 객관적으로 인식하려고 하는 과정입니다. 자신이 경험한 것들을 당연하게 받아들이는 것에서 나아가, 어떤 경험을 하는 자신을 한 발자국 뒤에서 관찰하는 데 중요한 역할을 합니다.

우리는 자아의 경계가 잘 형성된 사람을 '정체성이 뚜렷한 사람'이라고 이야기합니다.

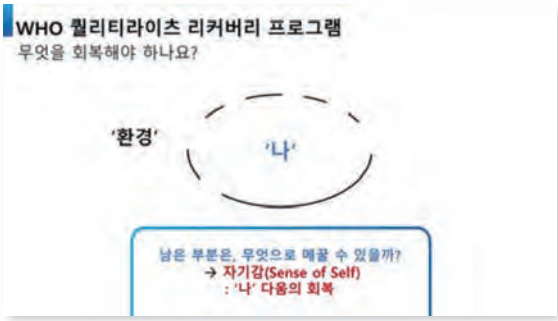
애니메이션 효과 5번 ~ 7번

자아의 경계는 시기와 환경에 따라 변화무쌍하게 변할 수 있으며, 때로는 무너지기도 하고 다시 회복되기도 합니다. 자아의 경계에 위협을 주는 여러 요인이 있습니다. 예를 들어, 술이나 마약과 같은 약물, 심리적으로 극심한 스트레스, 그리고 유전적 취약성이 그 요인입니다. 정신질환은 위에서 언급한 여러 이유로 인해 자신과 세상의 경계가 허물어지는 특징이 있습니다. 치료를 받지 않는 기간이 길어질수록, 그리고 재발할수록 그 경계는 더욱 무너질 수 있습니다. 특히, 자신과 세상의 경계가 허물어진다는 점을 뇌과학적 관점에서 설명하면, 나와 세상에 대한 감각과 인식의 변화, 그리고 이로 인해 발생하는 통제 문제로 이어진다고 할 수 있습니다.

활동단계 전개

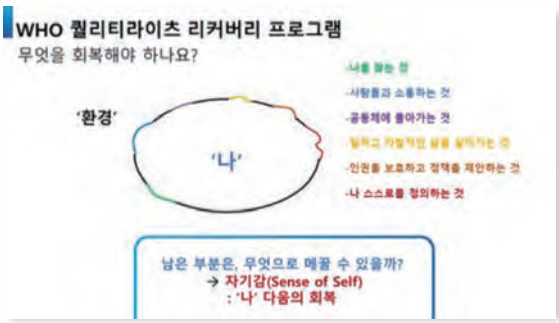


약물 치료와 한계를 설명합니다.
회복, 특히 '자기감의 회복'을 설명합니다. [2)]





치료의 목표가 '증상의 관해(Remission)'를 넘어 회복에 도달해야 한다는 개념을 설명합니다.



'나'다움의 회복을 위한 구체적인 예시를 시각화 자료를 통해 설명합니다.

활동내용

애니메이션 효과 활용, 한 번 클릭

무너진 자아의 경계를 회복하기 위해 약물을 사용할 수 있습니다. 정신과 약물은 과학적으로 효과가 검증된 방법이며, 정신질환의 악화와 재발을 방지합니다. 하지만, 약물만으로 무너진 자아의 경계를 모두 회복할 수 없습니다.

남은 부분을 회복하기 위해서 필요한 것이 바로 '자기감의 회복' 입니다. 자기감의 회복 이라는 단어가 어렵게 느껴진다면 '나'다움의 회복이라고 생각할 수 있습니다.

Tips

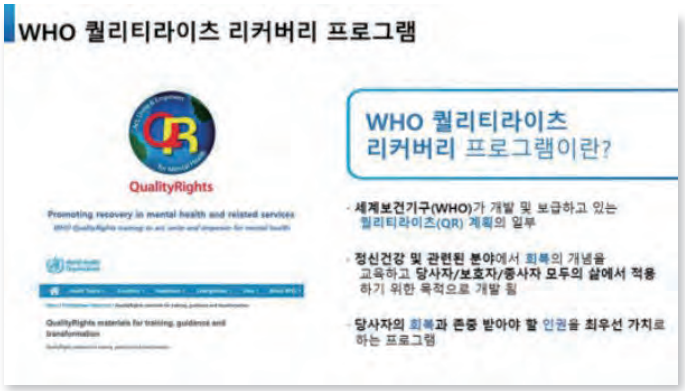
약물 치료는 중요하지 않다고 오해하지 않도록 주의가 필요합니다. 약물 치료는 자기감의 회복에 중요한 첫 시작이며, 회복의 과정 전반에 걸쳐 필요한 치료입니다!

애니메이션 효과 활용, 무너진 자아의 경계 회복

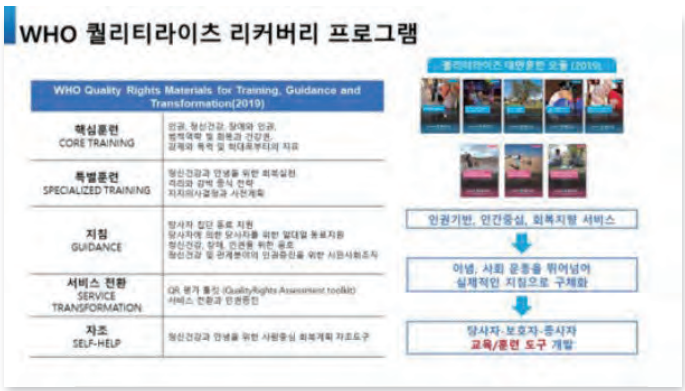
무너진 자아의 경계는 나를 찾고, 사람들과 소통하고, 공동체로 돌아가고, 직업 생활을 하고, 나와 타인의 인권에 관심을 가지고, 나 스스로를 정의 함으로써 회복될 수 있습니다.

무너지기 전의 자아의 경계와 비교 했을 때, 색깔이 다르고, 매끄럽지 않은 경계일 수 있지만, 이는 유일무이한 '나' 다움의 회복을 나타냅니다. 우리가 앞으로 함께할 프로그램에서는 '나'다움의 회복에 대한 다양한 토론이 진행될 것입니다.

활동단계 전개



퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에 대해 설명합니다.





활동내용

퀄리티라이츠는 일종의 운동(Movement)로 WHO(세계보건기구)에서 개발하고 운영하고 있습니다.

당사자의 회복과 인권을 최우선 가치로 한다는 것을 강조합니다.

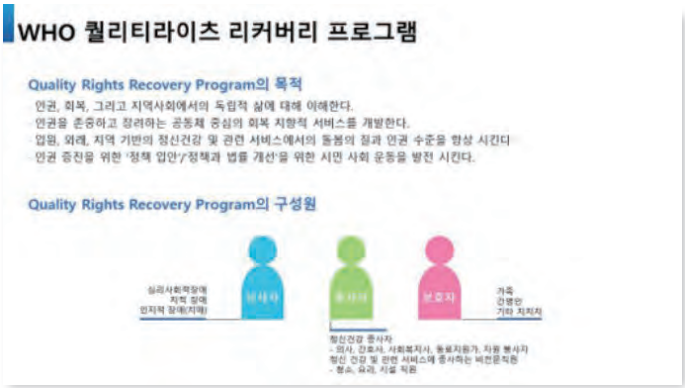
진행자는 아래의 내용을 시간과 이해도에 따라서 설명해주십시오.

이 프로그램은 WHO에서 2019년 개발하고 배포한 대면훈련 모듈 중 '전문화 훈련'도구 중 하나입니다. 이념, 사회 운동을 뛰어넘어 실제적인 지침으로 구체화 한 교육/훈련 도구입니다.

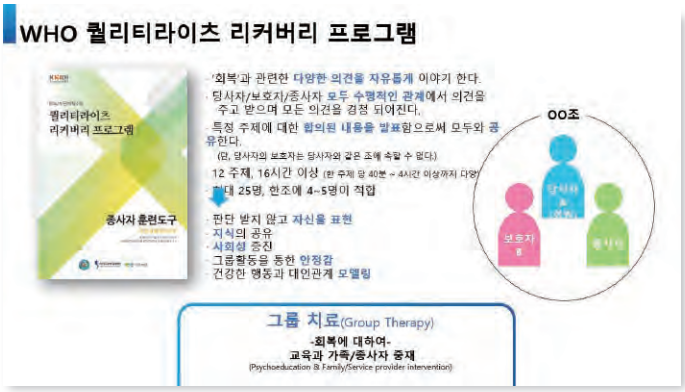
본 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 시초는 2019년에 WHO가 개발한 '전문화 훈련' 도구 중 하나인 'Recovery practices for mental health and well-being' 이며 한국에는 용인정신병원에서 번역한 번역본이 2022년에 소개 되었습니다.

본 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램은 WHO에서 개발한 'Recovery practices for mental health and well-being'의 내용을 기반으로 한국어 번안을 하였으며, 한국 상황을 반영한 사례를 개발하고 활동을 추가했습니다.

활동단계 전개



퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 목적과 구성원을 소개합니다.



퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 진행 규칙을 설명합니다.



퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에 대해 설명합니다

활동내용

진행자는 목적과 구성원에 대해 각각 소개하고 설명해 주십시오.

앞으로 우리가 참여할 프로그램의 진행 규칙입니다.

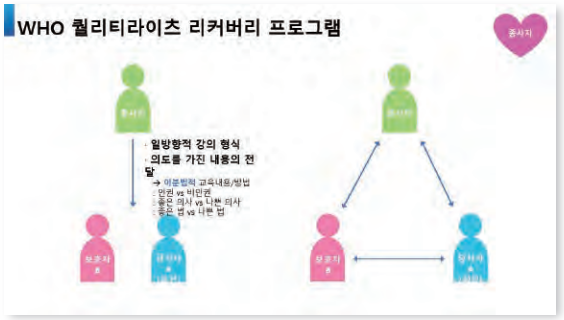
당사자, 보호자, 종사자 모두 수평적인 관계라는 점이 중요합니다. 즉, 조에서 토론을 할 때에는 충분히 그리고 자유롭게 자신을 표현할 수 있도록 중간에 이야기를 끊거나 교정하려고 하지 않습니다.

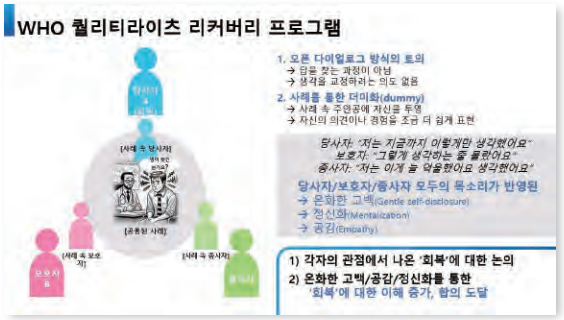
정리하자면, 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램은 회복에 대한 그룹 치료입니다. 이에 대해 설명해 주십시오.

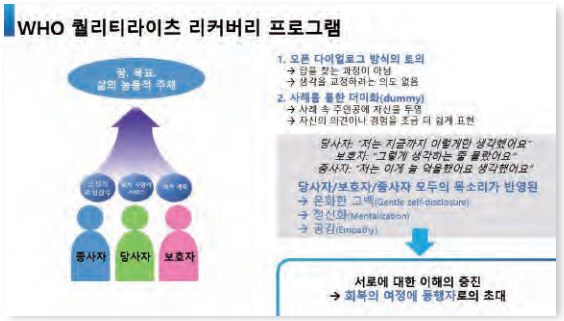
앞으로 각 토픽마다 임상 현장에서 마주칠 수 있는 '사례'가 소개 됩니다.

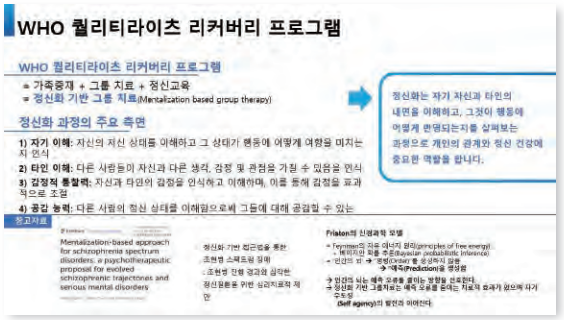
그리고 이 사례를 중심으로 토론 활동을 할 수 있도록 돕는 질문들이 주어집니다.

활동단계 전개









정신화 그룹치료: 자기 및 환경 이해 증진을 통한 예측 오류 감소와 치료 효과 [3)]

활동내용

가이드북에만 소개되는 PPT 슬라이드 입니다.
2019년에 배포된 대면 훈련도구는 회복에 대한 개념을 설명할 때 이분법적인 접근 방법을 사용합니다.

이러한 방식은 오히려 회복에 대한 오해를 불러 일으킬 소지가 있습니다. 또한, 당사자/보호자/종사자 간의 오해와 분열을 일으킬 수 있습니다.

진행자는 사례를 중심으로 토론 활동이 진행되는 방식의 특징을 설명합니다.

우선, 오픈다이얼로그 방식의 토의 태도가 필요합니다. 사례에 등장하는 주인공들에게 자신을 투영함으로써 자기 표현이 쉬워질 수 있습니다.

이 과정을 통해 당사자, 보호자, 종사자 모두 자신의 마음을 온화하게 고백할 수 있으며, 서로에 대한 이해와 공감을 향상시킬 수 있습니다.

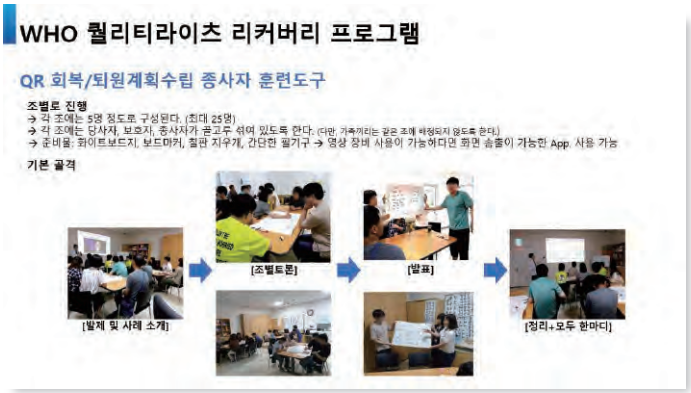
궁극적으로 함께 회복에 대한 정의를 내릴 수 있습니다.

우리가 하는 프로그램의 특징은 가족 중재 성격을 띕니다.
그룹 치료 형식입니다.
회복에 대한 교육적인 측면이 포함되어 있습니다.
사례 중심의 토의 형식을 통해 '정신화'를 지향합니다.

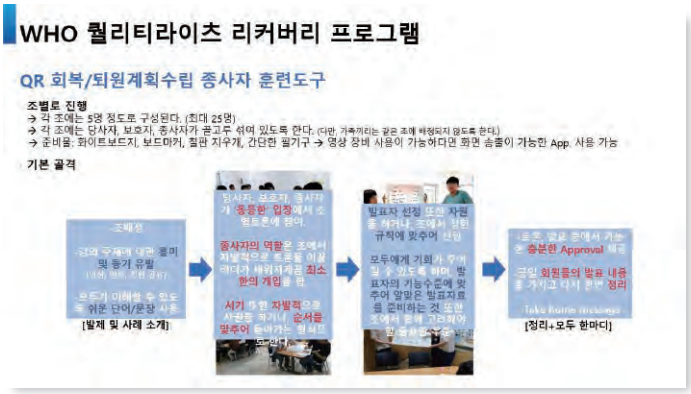
진행자의 판단에 따라 정신화에 대한 설명을 제공 할 수 있습니다.

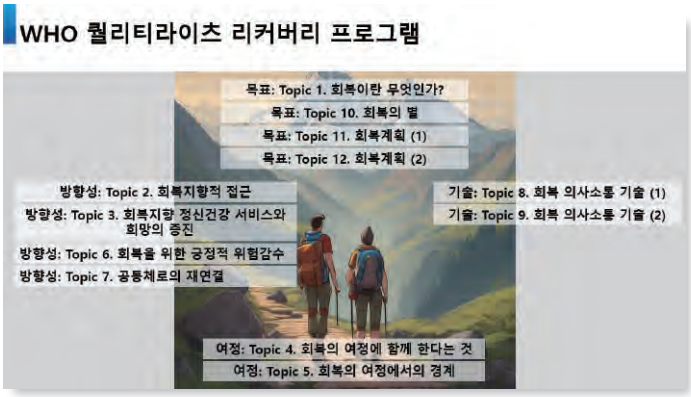
〈참고 자료〉 정신화 작용이 당사자가 자신 외의 환경에 대한 이해를 높여 예측 오류를 줄이기 때문에 치료 효과가 있다는 내용을 담고 있는 논문을 소개합니다.

활동단계 정리



앞으로 진행될 프로그램의 기본 골격을 설명합니다.





퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 개요를 설명합니다.

활동내용

진행자는 청중의 이해도에 따라 자세히 설명해주십시오.

조별로 진행되며, 매 시간마다 조장과 서기를 뽑고, 함께 토론한 내용을 돌아가며 모든 참여자에게 발표한다는 내용을 설명합니다.

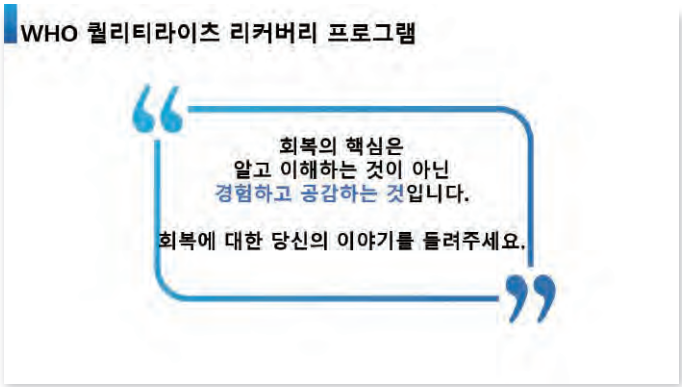
Tips.
기본 골격을 설명하며, 진행자는 자신의 역할이 '촉진자'임을 명확히 인지하고 설명하는 것이 중요합니다.

진행자는 앞으로 진행할 프로그램이 크게 목표, 방향성, 기술, 여정으로 나누어짐을 설명합니다.

각 제목을 다같이 함께 읽습니다.

오리엔테이션 참여자들에게 마지막까지 성실히 참여하여 자신만의 회복에 대한 정의를 내리도록 격려를 합니다.

활동단계 정리



마무리 슬라이드입니다.



활동내용

참여한 모든 사람에게 오리엔테이션에 대한 소감을 들어봅니다. 첫 시간인 만큼 참여한 모든 사람의 이야기를 충분히 듣고, 이후에 진행자가 규칙을 설명하면 좋습니다. 예로 1분 이내로 자신의 소감을 이야기해보자고 할 수 있습니다.

앞으로의 시간에도 늘 끝날 때는 그날의 소감을 참여자 모두가 이야기 하고 마친다는 사실을 전달합니다.

Tips.

소감을 이야기할 때, 질문을 하거나 우려가 되는 사안에 대해 언급한다면, 우선 화자의 이야기를 다 듣고 진행자가 질문에 답을 하거나 우려에 대한 안심을 제공하는 형식으로 그때 그때 피드백을 드립니다.

01 Topic 1. 회복이란 무엇인가?



핵심목표

자신이 생각하는 회복을 이야기하고 다른 사람들의 의견을 들을 수 있다.

핵심질문

① 자기소개를 한다면?

- 부록을 활용하여 참여자가 자신을 소개한다.

② 회복이란?

- 회복에 대한 서로의 생각을 공유한다.
- 다차원적인 회복개념과 회복의 핵심 요소에 대해 이야기한다.
- 회복에 대한 문화적 다양성과 오해들을 이야기한다.

핵심내용

① 회복은 단순한 증상의 관해를 넘어서는 개념으로, 다차원적이고 다양한 요소들로 구성되어 있습니다.

② 본 프로그램에서는 정신질환에서의 회복을 '자기감(Sense of self)'의 회복으로 이해합니다.
이는 익숙한 표현으로는 '나다움'의 회복이라고 말할 수 있습니다.

영상

① 한글도서관, TED [엘레노어 롱든] 내 머릿 속의 목소리 (14:17)

② AI 브랜딩 연구소, 우리가 자주 말하는 아름답다의 진짜 뜻 (0:56)

Tips. 상황에 따라 진행자가 영상 시청 없이 내용을 요약하여 전달할 수 있습니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록1 인쇄본
- ☐ 필기구
- ☐ 1강 부록
  - · 1강을 시작하기에 앞서, 이 자료를 참가자 한 명당 하나씩 나눠주세요. 영상 시청 시 함께 보거나, 집에 가져가서 천천히 살펴볼 수 있도록 안내해 주시기 바랍니다.
- ☐ 조별 활동용 대형종이 혹은 화이트보트
  - · 크기는 A3 사이즈를 추천합니다.
- ☐ 조별 활동용 마커 및 지우개
- ☐ 프로그램 환경조성
  - · 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - · 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다.
- ☐ 조별활동 책상배치
  - · 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다. 이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

TIPS 참여자 명찰을 준비해 주세요.

참여자에게 자신의 이름이나 별명을 적고 부착 할 것을 안내 합니다. 매 프로그램에서 지속적으로 사용하도록, 프로그램이 끝날 때마다 회수합니다.

참·고·사·항

기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행 : 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

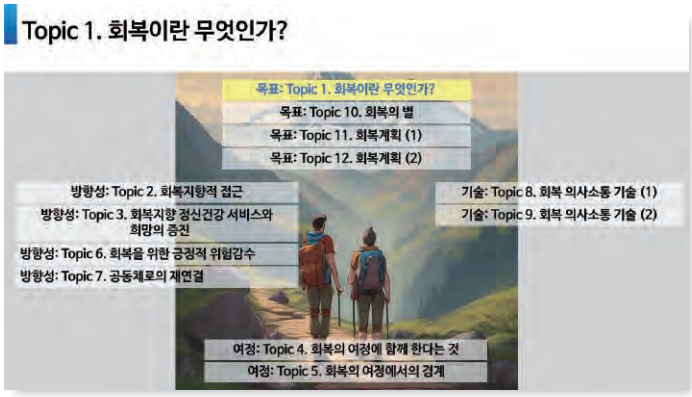
2. 주요 부분만 진행 : 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 180분 입니다.**

활동단계 도입









매 번 조장과 서기 선출 시간이 있습니다.

활동내용

지난 시간에는

① 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램이란?
② 자아의 경계와 회복에 대하여
③ 프로그램의 기본 골격
세 가지에 관해 살펴보았습니다.

Tips.

오리엔테이션에 참석하지 못하고, 이번 시간에 처음 온 참여자가 있을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

지난 시간의 내용을 상기시킬 때, PPT 상의 내용을 참여자들이 함께 소리 내어 읽거나, 한 명씩 돌아가면서 읽으며 참여를 유도할 수 있습니다.

진행자는

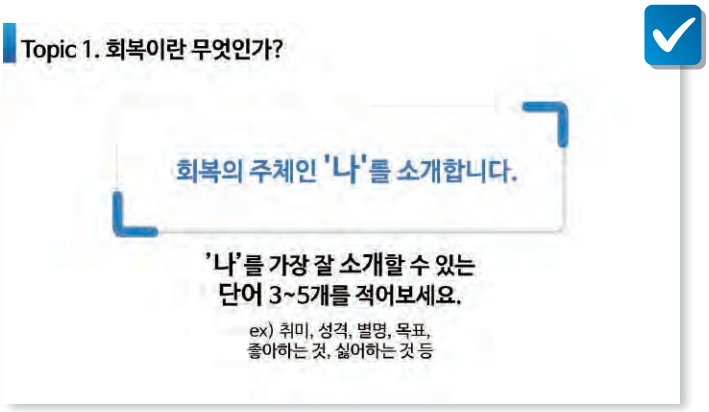
오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

Tips.

조장과 서기를 선정할 시간(보통 3분 이내)을 제공한 후, 진행자가 각 조의 조장과 서기를 호명하여 참여자 전체에게 박수를 받을 수 있도록 유도함으로써 서먹한 분위기를 반전시킬 수 있습니다. 프로그램 초반부에는 자발적으로 조장이나 서기를 맡으려는 참여자가 없을 수 있습니다. 이 경우, 진행자가 각 조에 속한 종사자 중 한 명을 조장으로 지정하여 당사자와 보호자의 적응을 도울 수 있습니다.

활동단계 전개



첫 번째 질문. 회복의 주체인 '나'를 소개합니다. (30~40분)



두 번째 질문. '회복'이란 무엇이라 생각하나요? (20분)

활동내용

Tips.
모든 질문과 조별 활동 시에는 '가사가 없는' 가벼운 음악을 틀어 이완된 분위기를 조성하는 것이 좋습니다.

진행자는
부록(Topic 1)을 출력하여 참여자 모두에게 제공합니다. 참여자 모두가 10~20분 정도 자신을 가장 잘 소개할 수 있는 단어 3~5개를 적도록 공지합니다.

Tips.
처음부터 적는 시간을 10분 주겠다고 이야기하여 참여자들이 정해진 시간 안에 활동을 마무리 하게끔 합니다.

진행자는
조별로 회복이란 무엇이라 생각하는지 토론하고, 결과를 서기가 조별로 주어진 종이나 화이트보드 시트에 작성하도록 공지합니다.

조별 토론을 마치면, 진행자는 조별로 발표자를 정해달라고 합니다. 이후 진행자의 진행 순서에 따라 발표자는 참여자 전체에게 자신의 조에서 나온 토론의 결과를 발표합니다.

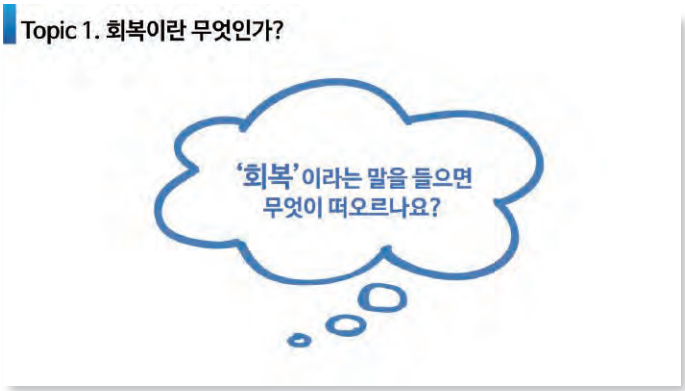
Tips.
· 발표 시간엔 모두 손에서 펜을 내려 놓고 발표자를 향해 의자를 틀고 경청하는 것이 규칙임을 이야기 합니다.

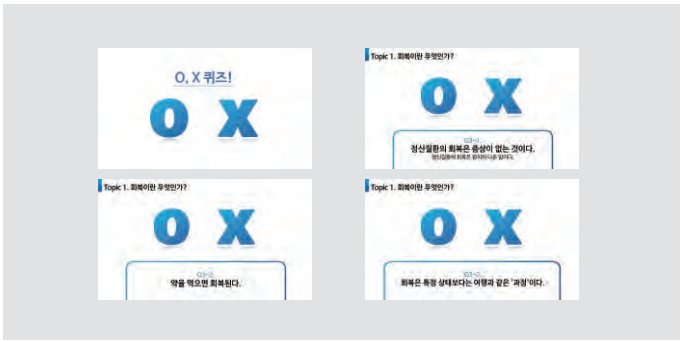
· 발표자는 자신에 대한 간단한 소개 후 토론 내용을 발표합니다.

· 발표 시에는 모두가 해당 조의 서기가 작성한 내용을 볼 수 있도록, 발표자를 제외한 다른 팀원들이 종이나 화이트보트 시트를 모두가 볼 수 있는 방향으로 들고 있습니다.

· 발표가 끝나면 진행자는 박수를 유도합니다.

활동단계 전개





세 번째 질문. '회복'이라는 말을 들으면 무엇이 떠오르나요? (10분)

활동내용

진행자는

회복에 대한 OX 퀴즈를 출제합니다.

조별 활동이 아닌 참여자 전체를 대상으로 진행합니다.

참여자 각자가 O라고 생각하는지, X라고 생각하는지 거수로 표현해 달라고 합니다.

정답이 없는 문제임을 설명해주십시오. 참여자 각자 어떻게 생각하고 있는지 서로 확인을 하고, 모두가 참여하는 분위기를 유도하는 것이 목적입니다.

Tips.

시간이 가능하다면, 각 문제에 대해 O라고 생각한 사람 중 한 명과 X라고 생각한 사람 중 한 명에게 그렇게 생각한 이유에 대해 이야기 해달라고 요청할 수 있습니다.

활동단계 전개



회복은 증상이 없는 상태 (관해)인가?

증상이 완전히 사라진 상태인 '완치'가 치료의 궁극적인 목표로 생각되기도 합니다.

활동내용

진행자는

내과, 외과, 정형외과, 정신과에서 말하는 완치가 무엇인지 질문합니다.

① 내과

극히 일부 감염성 질환에서는 감염 전후로 몸의 구조적/기능성인 변화가 없으면 완치라 부를 수 있지만, 의학이 발전함에 따라 점점 완치라는 개념이 무의미해 지고 있습니다.

고혈압, 당뇨, 천식, 자가면역성 질환 등 대부분의 질환은 진단 이후 평생 관리를 하는 질환입니다. 그리고 이러한 질환의 치료 목표는 '약을 끊는 것'이 아닌 '약을 먹으며 증상을 관리하는 것'입니다.

② 외과

암 수술을 했으면 완치가 된 것인가요? 수술을 한 부위는 예전과 동일한가요?

③ 정형외과

뼈가 부러진 뒤, 수술을 통해 다시 붙었으면 완치가 된 것인가요? 관절의 움직임이 예전과 동일한가요? 한번 부러졌던 부분은 다른 부분에 비해 또 부러질 가능성이 높지 않나요?

④ 정신과

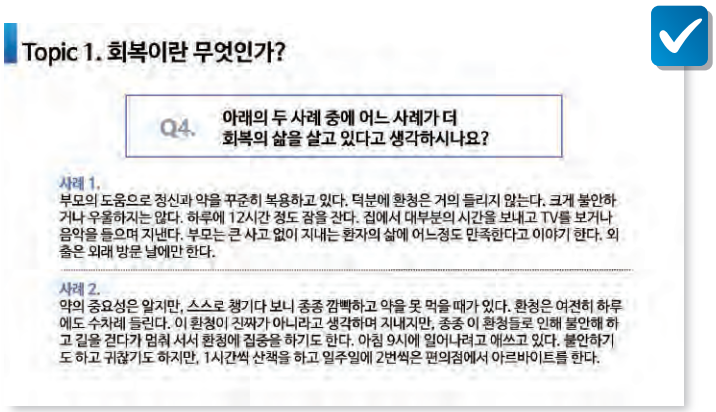
그렇다면, 정신과에서 말하는 완치란 무엇인가요?
완치라는 개념이 우리가 궁극적으로 추구해야 하는 개념이 맞나요?

Tips.

· 참여구성원들의 이해도를 확인하여 해당 용어(상태, 완치, 관해)를 좀 더 자세히 설명할 수 있습니다.

· 진행자가 선호하는 한 두 과만 이야기 할 수도 있습니다.

활동단계 전개



Topic 1. 회복이란 무엇인가?

Q4. 아래의 두 사례 중에 어느 사례가 더 회복의 삶을 살고 있다고 생각하시나요?

사례 1.
부모의 도움으로 정신과 약을 꾸준히 복용하고 있다. 덕분에 환청은 거의 들리지 않는다. 크게 불안하거나 우울하지는 않다. 하루에 12시간 정도 잠을 잔다. 집에서 대부분의 시간을 보내고 TV를 보거나 음악을 들으며 지낸다. 부모는 큰 사고 없이 지내는 환자의 삶에 어느정도 만족한다고 이야기 한다. 외출은 외래 방문 날에만 한다.

사례 2.
약의 중요성은 알지만, 스스로 챙기다 보니 종종 깜빡하고 약을 못 먹을 때가 있다. 환청은 여전히 하루에도 수차례 들린다. 이 환청이 진짜가 아니라고 생각하며 지내지만, 종종 이 환청들로 인해 불안해 하고 길을 걷다가 멈춰 서서 환청에 집중을 하기도 한다. 아침 9시에 일어나려고 애쓰고 있다. 불안하기도 하고 귀찮기도 하지만, 1시간씩 산책을 하고 일주일에 2번씩은 편의점에서 아르바이트를 한다.

네 번째 질문. 아래의 두 사례 중에 어느 사례가 더 회복의 삶을 살고 있다고 생각하시나요? (20분)

활동내용

진행자는

'사례 1'이나 '사례 2'를 참여자에게 천천히 읽어주되 특정 사례가 더 바람직하다는 뉘앙스의 선입견이 전달되지 않도록 각별히 주의합니다.

이후, 조별토론 시간을 20분으로 공지하고, 각 조의 조장에게 진행을 맡깁니다.

20분 이후, 발표자를 정하여 조를 대표해 전체 참여자 앞에서 발표하도록 합니다.

조별 발표 후, 진행자는 사례 1과 사례 2 중 회복에 대한 정답은 없다는 사실을 강조합니다.

회복에 대해 사례 1을 선택한 것도, 사례 2를 선택한 것도 모두 존중 받아야 할 각자의 회복에 대한 생각임을 이야기합니다.

Tips.

진행자는 조별 활동 결과를 교정해 주거나, 일방적인 강의 형식으로 진행되지 않도록 주의합니다.

(보통 종사자들은 '사례 2'를 선택하지만, 상당수의 당사자와 보호자는 '사례 1'을 선택하는 경향이 있습니다.)

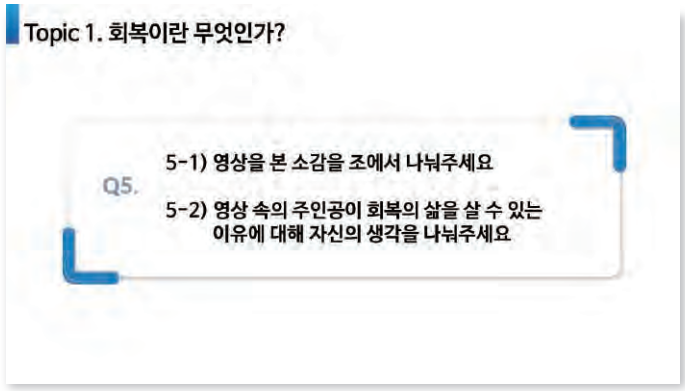
활동단계 전개



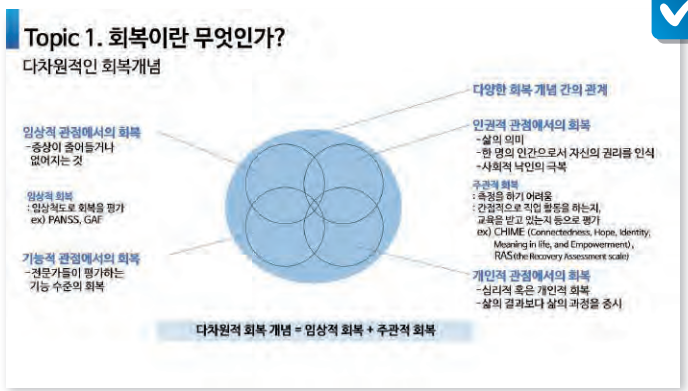
네 번째 질문에 대한 모든 조의 발표를 들은 뒤, 참여자에게 질문 합니다.



출처: https://www.youtube.com/watch?v=yyNZMIE8htE&t=682s



다섯 번째 질문(Q5)에 대해 조별 활동을 진행합니다. (30분)



다차원적인 회복개념을 설명합니다. [4)]

참고: Ponce-Correa F, Caqueo-Urízar A, Berrios R, Escobar-Soler C. Defining recovery in schizophrenia: A review of outcome studies. Psychiatry Res. 2023 Apr;322:115134.

활동내용

진행자는

'증상이 남아 있으면 회복이 안 된 것일까요?'
이후 **애니메이션 효과 (클릭) 를 이용하여 '만약, 증상이 환청/망상과 같은 무척이나 심각한 것이라 면요?'에 대해 강조해서 질문합니다.

진행자가 질문한 내용에 대한 답은 영상 링크를 통해 유튜브에서 다 같이 시청합니다. (14분 17초)

Tips.

· 영어 영상이며, 한글이 자막으로 제공됩니다.

· 당사자나 고령의 보호자 중에는 자막을 따라가는데 어려움이 있는 사람들이 있을 수 있습니다.

· 영상이 종료된 이후 진행자가 영상을 요약해 주면 도움이 됩니다.

진행자는

① 시간 공지
② 조별 발표 순서를 정하고 참여자들이 발표자에게 집중하도록 이야기
③ 발표를 마치면 박수를 유도하며 질문에 대한 토론 활동을 마무리 합니다.

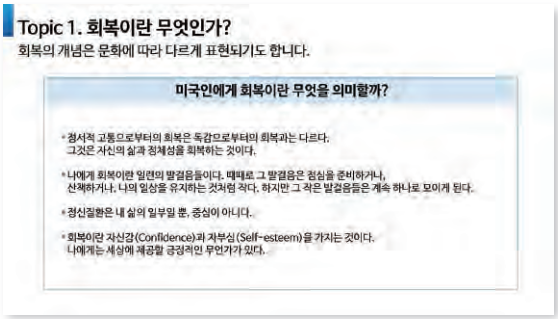
1부 끝 시간 부족 시

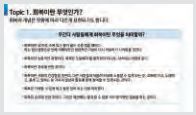
활동내용

회복은 크게 '임상적 회복'과 '주관적 회복'으로 나눌 수 있습니다. 임상적 회복은 우리가 익숙한 '증상'이나 '기능'에 초점을 맞춘 개념입니다. 주관적 회복은 개인적 관점과 인권적 관점에서 추구해야 할 회복 개념을 설명하고 있어 모호하면서도 익숙하지 않을 수 있습니다.

진행자는 회복은 다차원적인 개념이며, 단순히 증상이 줄어들거나 없어지는 것만으로 설명할 수 없다는 내용을 강조합니다.

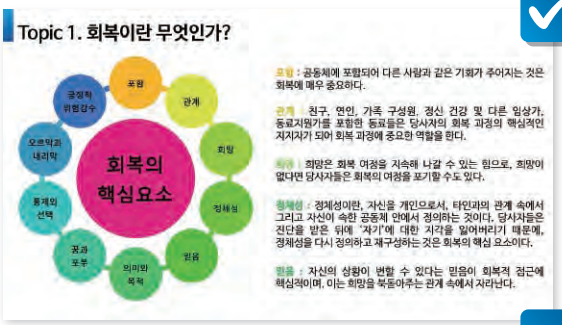
활동단계 전개





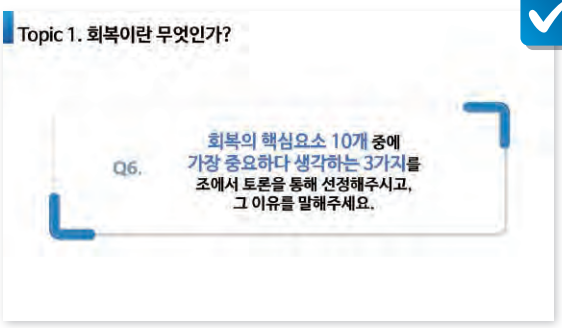
참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 1: What is recovery?)

회복은 다차원적이며 문화에 따라서도 다양하게 해석될 수 있습니다. [5), 7), 8)]





회복의 핵심요소에 대해 설명합니다. [5), 6)]



Q6 질문을 진행합니다. (20분)

활동내용

진행자는

퀄리티라이츠에서 조사한 미국과 우간다 사람들이 정의한 회복에 대해 소개하며 회복의 입체적인 개념을 이야기합니다.

이렇듯 회복이란 쉽게 정의할 수 없으며, 개인별로 다를 수 있는 회복의 정의는 모두 존중 받아야 함을 설명합니다.

진행자는

회복의 10가지 핵심요소를 한 명씩 돌아가며 읽도록 합니다.

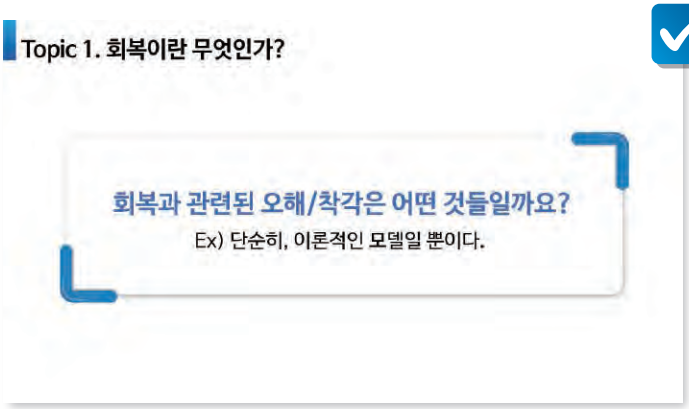
진행자는

부록1을 활용하여 각자 10가지 핵심요소 중 가장 중요하다고 생각하는 3가지를 적고 조장의 진행에 맞추어 자신의 생각을 공유하도록 합니다.

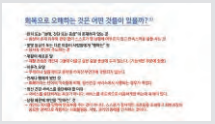
조에서 진행하는 활동으로 참여자 전체 앞에서 발표하는 순서는 없습니다.

정해진 시간이 되었다면, 진행자는 조별 토론 활동을 마무리하고 다음으로 넘어갑니다.

활동단계 전개



회복으로 오해하는 것들에 대해 이야기 합니다. [9]



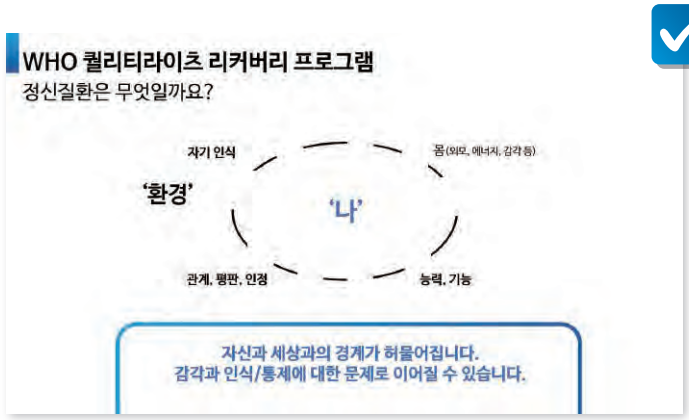
참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 1: What is recovery?)

활동내용

진행자는

퀄리티라이츠에서 제시한 회복에 대한 오해와 그에 대한 대답을 소개합니다.

활동단계 정리



정신질환은 무엇일까요? [1), 2)]



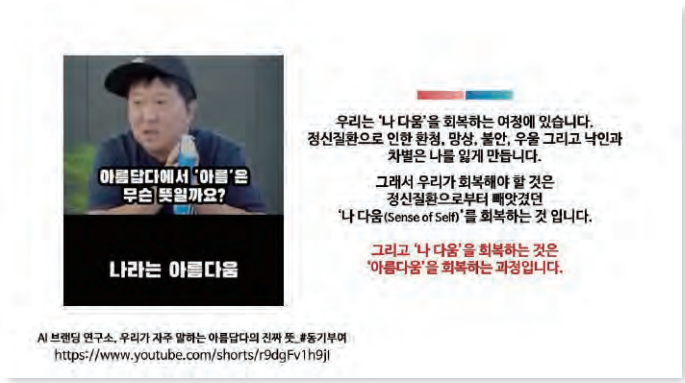
활동내용

진행자는

오리엔테이션에서 소개한 '자아의 경계' 개념을 다시 설명합니다.

정신질환 치료의 궁극적인 목표는 '회복'이고, 조금 더 구체적으로 '자기감의 회복'이며, 다른 말로 '나'다움의 회복임을 반복하여 강조합니다.

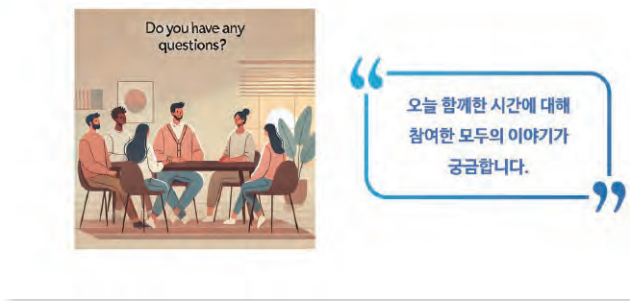
활동단계 정리



영상 시청 (0:56)

출처: https://www.youtube.com/shorts/r9dgFv1h9jI

모두 한마디!



참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.



참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

활동내용

'나'다움은 '아름'다움의 다른 말입니다.
Topic 1에서의 내용을 정리합니다.

- 정신질환 치료의 궁극적인 목표는 회복이다.
- 회복은 증상의 관해 이상의 다차원적 개념이다.
- 회복은 구체적으로 '나'다움의 회복이고 이것은 '아름'다움의 회복이기도 하다.

이를 통해 참여자들을 격려해 주세요.

Tips.

- 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.
- 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 이야기를 한마디씩 들어보는 시간을 가지는 것을 권장합니다.

Tips.

- 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
- 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
- "아름다운 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

01 Topic 1. 회복이란 무엇인가?

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q1. 회복이란?

1조
- 어울림 속에 행복을 느끼는 것(기도 찬양, 등산)
- 대화를 통해 자신의 마음을 잘 표현하는 것 (신앙, 믿음)
- 산책하기 (활동하기, 영화, 가을에 산책하기)
- 웃음 잃지 않는 것, 긍정적 사고방식으로 생활하는 것
- 좋아하던 것을 다시 좋아할 수 있는 마음, 이전의 행복을 느끼는 것(산책, 웃긴것)
- 아담. 이브 때의 완전함 (하나님에 대한 믿음)
- 스스로의 안정 (잠만보,집순이, 먹기위해 사는 사람)

2조
- 하고 싶은 일을 하는 것
- 함께 살아가는 힘을 기르는 것
- 나를 찾아가는 여행
- 약을 잘 먹는 것
- 꿈을 가지는 것
- 끝이 없는 무한한 것, 개인적인 것.욕망과 권태사이에서 현실을 직면하여 균형을 이루는 것

3조
- 자연스럽고 웃음이 나올 때 회복같다
- 조현병은 완치는 없지만 회복할 수 있어서 주위 사람들이 안심한다
- 마음을 열고 내 속마음을 터놓고 공감해줄 수 있는 것
- 건전한 여유와 안락한 표현이 일상이 되는 온상
- 원래의 내 모습과 나다움을 어느정도 회복하는 것
- 자리에서 자리로 옮겨지는 것이 회복
- 이전에 행복했던 상태로 돌아가는 것

4조
- 관계회복, 있는 그대로 봐주는 것, 일상생활 유지, 포기하지 않고 꾸준히 나아가는 것, 불안해하지 않는 모습
- 마음에 평안,기쁨,소망,청결,건강(몸도 마음도 건강했으면 좋겠어요)
- 긍정- 긍정적인 마인드로 지내는 것
- 튼튼한 몸, 명랑해지는 모습, 운동, 장애인 돌보기, 웃어른 돌보기
- 드라이브(서울 숲, 한강), 팝송 들으면서 산책
- “꿈”+희망 =만사형통, 즐거움, 건강(치유), 도전, 친구(외로움 해소), 평화(고민x), 무지개, 등산(정상), 음식(맛난 음식)

01 Topic 1. 회복이란 무엇인가?

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q1. 아래의 두 사례 중에 어느 사례가 더 회복의 삶을 살고 있다고 생각하시나요?

1조 사례 1. (1명)

- 1번 사례는 내면에 집중하는 것으로 보임 내면의 평화가 회복에 가까워 보임

사례 2. (6명)

- 대상자 스스로 삶에 집중하려 하는 의지가 보임
- 불안하지만 자신의 자리를 찾으려는 모습이 보임
- 일찍 일어나려 애쓰는 모습, 아르바이트, 산책하려 노력하는 모습이 보임
- 힘들고 고통스러워도 사람들과 소통하려는 의지를 보이는 것이 더불어 살아가는 인간의 본래의 모습을 보인 것 같다
- 악을 잘 챙겨 먹는 모습이 회복되는 것으로 보임
- 환청을 가짜라고 여기는 것

2조 사례 1 (0 명 → 회복의 삶이라 생각되지 않는 이유)

- 잠을 너무 많이 잔다
- 외출 안함 - 계속 집, 답답함
- 안정적으로 보이지만 사회화가 안되어 있다
- 어쨌든 집 밖으로 나갔으면 좋겠다
- 부모의 태도: 사고 치는 것을 겁내는 태도

사례 2. (6명)

- 사회와 연결
- 재발의 확률 적다, 최상의 회복 - 직장 다님 (자율적)
- 규칙적인 생활
- 사람과의 관계 회복 - 최우선
- 회복의 끝- 규칙적인 삶, 근로활동

3조 사례 1. (5명)

- 차라리 충분히 자는 게 더 나아서 (2명)
- 혼자서 활동할 수 있으니까
- 하루 12시간 잠을 잘 수 있으니까
- 집에 있고 생활이 안정적이니까

사례 2. (1명)

- 증상은 남아 있지만 스스로 노력하고 있고 일상을 건강하게 유지하려고 하는 것 같아서

4조 사례 1 (2명)

- 부모님이 지켜보고 있고 편안한 삶을 살고 있기 때문에
- 부모의 도움으로 정신과 약을 꾸준히 복용하고 있고 집에서 잠을 충분히 잔다.

사례 2 (4명)

- 대상자 스스로가 어려움에 부딪혀도 스스로 극복하려는 의지가 회복이라고 생각한다.
- 스스로 극복하려는 의지가 느껴져서

02 Topic 2. 회복 지향적 접근



핵심목표

내가 가진 장점을 1개 이상 다른 사람 앞에서 말할 수 있다.

핵심질문

① 지향점이란?

② 당사자를 바라보는 관점에 따라 치료의 지향점이 달라질까? - 유라와 근하 이야기를 통해 달라질 수 있음을 이해한다.

③ 자산/강점 기반 접근과 결손 기반 접근이란?

④ 회복을 촉진하거나 방해하는 요인은?

⑤ 스스로 자신을 정의한다면?

핵심내용

① 결손 기반 접근, 자산/강점 기반 접근 모두 중요하지만, 익숙하게 느끼는 결손 기반 접근에서 자산/강점 기반 접근으로 시선을 옮기는 것이 중요합니다.

② 스스로를 자산/강점 기반 접근에 따라 정의하는 것이 회복 지향적 접근의 시작입니다.

영상

MBCentertainment, [Indinite Challenge] 무한도전 - Sagging Snail - As I say, 처진 달팽이 - 말하는 대로 (3:25)

Tips. 상황에 따라 진행자가 영상 시청 없이 내용을 요약하여 전달할 수 있습니다.

준비사항 체크리스트

☐ 명찰

☐ 프로그램 환경조성

· 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.

· 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다.

☐ 조별활동 책상배치

: 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다.

이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

참·고·사·항

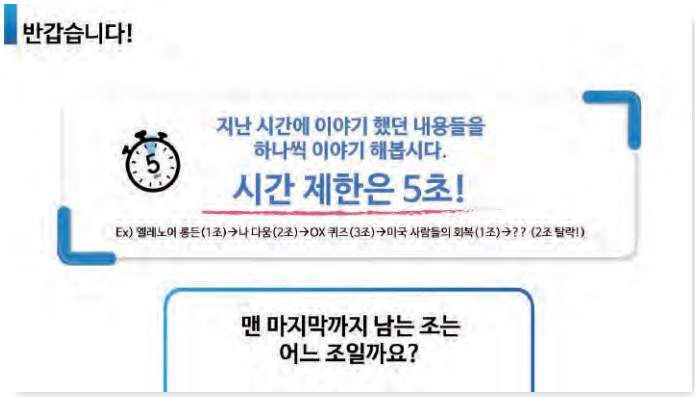
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행 : 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다.)

2. 주요 부분만 진행 : 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 140분 입니다.**

활동단계 도입



참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시키며 새로운 회기를 시작합니다.



지난 시간의 주요 내용을 요약합니다.





활동내용

진행자는

① 조별로 돌아가면서, 지난 시간에 이야기 했던 내용들을 하나씩 이야기 합니다.
② 제한 시간은 5초입니다.
③ 조에서 누구든 외치면 됩니다.
④ 제한 시간 안에 답하지 못하거나, 지난 시간에 이야기 했던 내용이 아닌 단어를 이야기 하면 탈락입니다.

Tips.

· 게임을 활용하여 지난 시간의 내용을 상기시킵니다.
· 즐겁고 밝은 분위기를 유도하는 것이 필요하며, 머뭇거리는 조가 있다면, 다같이 카운트 다운을 하게끔 하는 것도 좋습니다.

진행자는

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 도입



각 조의 조장과
서기를 뽑아주세요.

오늘 저희 조의 조장은 _____ 님 입니다.

오늘 저희 조의 서기는 _____ 님 입니다.

조장과 서기를 선출합니다.

Topic 2. 회복 지향적 접근



지향점

어디서 무엇을
바라볼 것인가?

활동내용

진행자는

각 조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간을 줍니다.
조장은 조별 활동을 주도하며 전체 흐름을 이끕니다.

서기는 토론 중에 나온 의견들을 큰 종이나 화이트보드 등에 정리하여, 발표자가 발표할 때 참고할 수 있도록 합니다.

발표자는 발표가 필요한 토론 활동마다 조에서 자율적으로 정합니다

진행자는

본격적으로 '회복 지향적 접근'을 다루기 전에, '지향점'의 개념을 그림을 통해 소개하고, 이를 통해 참여자의 관심을 유도한 뒤 브레인스토밍을 합니다.

활동단계 전개

Topic 2. 회복 지향적 접근

유라 이야기

유라는 당사자로, 정신과에서
치료받고 있는 환자입니다.
다음은 유라에 대한 3가지 묘사입니다.

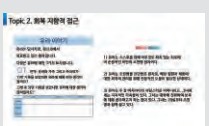
Q1. 당신이 유라라면,
위의 3가지 묘사들 중 어떤 것이 당신을
묘사하는데 쓰였으면 좋겠습니까?
그 이유는 무엇일까요?

1) 유라는 스스로를 위해 아무것도 하지 않는 치료에 비 순응적인 비만의 조현병 환자이다.

2) 유라는 조현병을 진단받은 환자로, 해당 질환과 체중에 대한 최적의 관리를 위해 전문적인 도움이 필요한 상태이다.

3) 유라는 두 살 여자아이의 자랑스러운 어머니이고, 그녀에게는 지지적인 가족들이 있다. 그녀는 대학에 진학하여 보육에 대해 공부하고자 하는 꿈이 있다. 그녀는 20살부터 조현병과 함께 살고 있다.

유라 이야기로 조별 토론활동을 진행합니다. (30~40분)



참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 3: A focus on assets and strengths)

활동내용

진행자는

유라라는 한 인물에 대한 서로 다른 3가지 묘사를 소개합니다. 진행자는 참여자에게 3가지 묘사를 천천히 읽어주되 특정 묘사가 더 바람직하다는 뉘앙스의 선입견이 전달되지 않도록 각별히 주의합니다.

Q1. 을 조별 토론활동으로 진행합니다. (10~15분)
조장의 진행에 따라 조에서 자유롭게 토론하고, 약속된 시간이 되면 발표자가 대표로 모든 참여자에게 조에서 이야기 된 내용을 발표합니다. (당사자와 보호자는 2번을, 종사자는 3번을 선택하는 경향이 있습니다.)

Q1. 에 대한 발표를 마치면, 같은 방식으로 Q2)를 진행하도록 안내합니다.

활동단계 전개

진행자는
조별 활동 결과를 교정해 주거나, 일방적인 강의를 하지 않도록 주의해 주세요.

Tips.
진행자는 Q2)에 대한 추가설명을 제공할 수 있습니다.

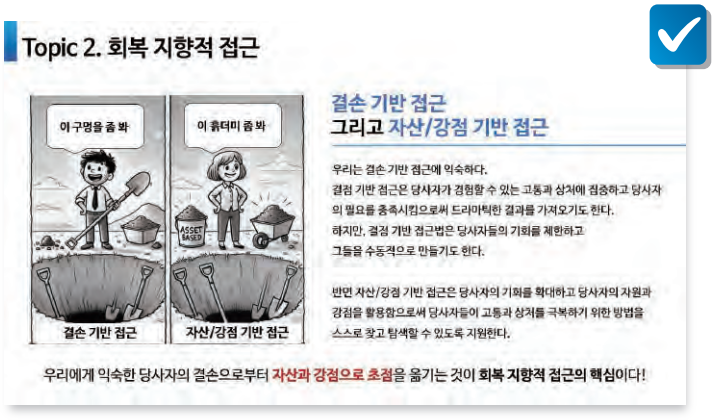
예를 들어, 유라가 이사를 가서 주치의가 바뀌었다고 상상해 봅시다. 이전 주치의가 새로운 주치의에게 전달할 의뢰서에 유라를 1번, 2번, 3번으로 묘사했다고 한다면, 새로운 주치의는 각각의 의뢰서를 통해 유라에 대해 어떤 생각을 가지게 될까요?

질문 설명
1번과 2번의 묘사는 보통 당사자에게 부족한 부분이 있거나 도움이 필요하다는 점을 강조하며, 의학적 개입이 필요함을 나타내는 '결손 기반 접근'인 경우가 많습니다.

반면 3번의 묘사는 의학적 개입의 관점을 벗어나, 개인의 꿈이나 강점, 가능성을 강조하는 '자산/강점 기반 접근'인 경우가 많습니다.

진행자는
조별 토론 결과를 활용하여 참여자가 작성한 1번과 2번 묘사에 대한 내용과 3번 묘사에 대한 내용 사이에 확연한 차이가 있음을 강조할 수 있습니다.

활동단계 전개



자산/강점 기반 접근 그리고 결손 기반 접근 (10분)에 대해 설명합니다. [10)-12)]



참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 3: A focus on assets and strengths)

활동내용

진행자는
주어진 슬라이드의 내용으로 자산/강점 기반 접근과 결손 기반 접근에 대해 설명합니다.

Tips.
이때, 자산/강점 기반 접근과 결손 기반 접근 모두 필요한 치료이며, 둘을 이분법적으로 비교하며 한쪽의 접근은 옳지 않다는 식의 뉘앙스가 전달되지 않도록 주의가 필요합니다.

두 접근 모두 의미가 있으며 필요하지만, 회복 지향적 접근에서는 익숙한 결손 기반 접근에서 초점을 자산/강점 기반 접근으로 옮기는 것이 중요함을 설명합니다.

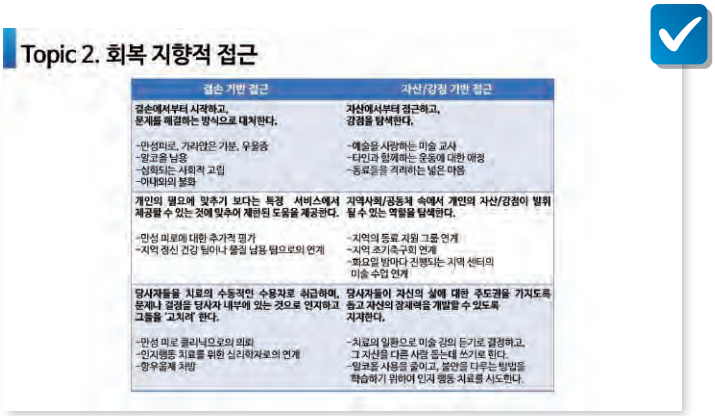
1부 끝 시간 부족 시

활동단계 전개



근하 이야기로 조별 토론활동을 진행합니다. (30~40분)

참고 : World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 3: A focus on assets and strengths)



퀄리티라이츠 리커버리 프로그램이 제시한 내용을 설명합니다.

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 3: A focus on assets and strengths)

활동내용

진행자는
시간을 정해주고, 조장은 Q3과 Q4에 대한 토론 활동을 진행합니다. 토론 활동을 마친 후, 각 조에 뽑힌 발표자는 Q3과 Q4를 한번에 발표합니다.

진행자는
조별 활동 결과를 교정해 주거나, 일방적인 강의를 하지 않도록 주의해 주세요.

질문설명
Q3의 답은 자산/강점 기반 접근의 묘사와 결손 기반 접근의 묘사가 확연히 차이를 보일 수 있습니다.

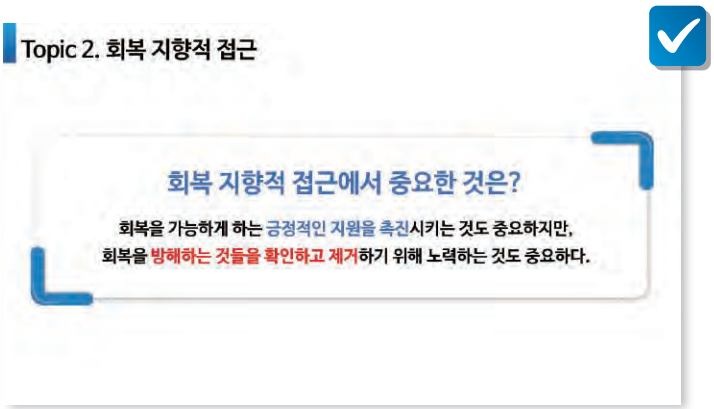
하지만, Q4는 Q3에 비해 차이를 보이지 않을 가능성이 높습니다. 참여자들이 자산/강점 기반의 치료 접근이 익숙하지 않거나 경험해 보지 못했기 때문입니다.

진행자는
조별 토론 결과물을 활용하여 위의 내용을 설명할 수 있습니다.

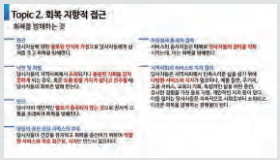
3개의 행 중, 첫번째 행은 Q3에 대한 내용입니다.
두번째, 세번째 행은 Q4에 대한 내용입니다.

참여자들이 Q4를 작성하기 어려운 이유를 통해 우리가 익숙한 결손 기반 접근에서 강점/자산 기반 접근으로 초점을 옮겨야 한다는 점을 강조하여 보여줍니다.

활동단계 전개



회복 지향적 접근을 설명합니다. (10분)[13), 14)]

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 1: What is recovery?)

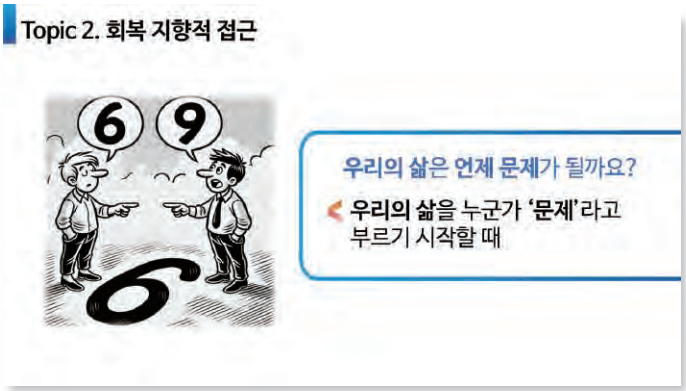
활동내용

진행자는

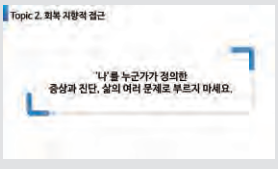
회복을 촉진하는 것과 회복을 방해하는 것에 대해 설명합니다.

참여자 모두가 돌아가면서 내용을 읽도록 하여 중요한 내용에 집중할 수 있도록 합니다

활동단계 정리



우리의 삶은 언제 문제가 될까요?



활동내용

애니메이션 효과 (클릭)

진행자는 유라와 근하의 묘사가 달라지면, 유라와 근하에 대한 생각과 치료 방향성까지도 달라진다는 것을 상기시킵니다.

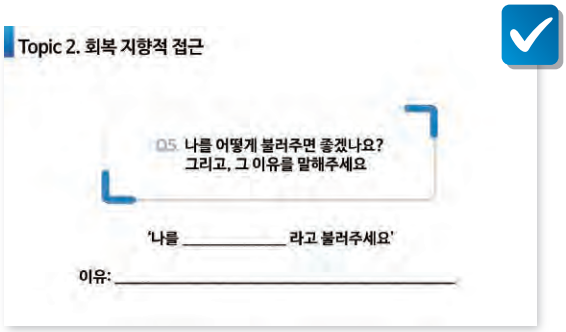
나 스스로 나를 정의하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다. 물론, 누군가가 정의한 것도 나의 일부입니다. 진단을 부정하자는 것이 아닙니다. 그러나 그것이 나의 전부는 아닙니다.

활동단계 정리



영상 시청 (3:25)[15]

출처: https://www.youtube.com/watch?v=N77IUZvYoVY



나를 ~~ 라고 불러주세요 (10분)





다음 Topic 소개

활동내용

진행자는

잘 알려진 노래를 통해, 회복 지향적 접근의 중요한 내용을 상기 시킵니다.

영상 시청 후, 진행자는 10분의 시간을 주고 앞으로 자신을 어떻게 불러주었으면 좋겠는지, 그 단어와 이유를 적어 달라고 요청합니다.

진행자는

모두 한 마디씩 할 수 있도록 해주세요. 오늘 프로그램에 참여한 소감과 함께, '나를 ~~라고 불러주세요'에서 적은 단어와 이유를 간단히 이야기 합니다.

Tips.

- 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
- 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
- "자산/강점이 가득한 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q1. 당신이 유라라면, 위의 3가지 묘사들 중 어떤 것이 당신을 묘사하는데 쓰였으면 좋겠습니까? 그 이유는 무엇일까요?

1조

1번 묘사 – 없음

2번 묘사 – (1명)

· 환자로 인식되어 치료받고 싶다

3번 묘사 (5명)

· 아름답게 표현

· 아픈 것은 일부분이다. 그것을 전체화 할 때 이웃은 이상하게 보므로

· 꿈과 포부가 있기 때문에

· 가족들의 지지가 있는 사람이다

· 정서적인 안정의 표현이 회복에 도움 될 거 같다

2조

1번 묘사 – 없음

2번 묘사 – (1명)

3번 묘사 – (5명)

· 엄마. 대학진학, 조현병

· 두아이의 엄마. 간호사

· 조현병 집중X. 긍정적 활력=여러 관계 속

· 병이 있으나 뭔가 해보려 하는 의지가 있음

· 현재 나의 상황과 같음

· 나의 바람. 현재 상황

3조

1번 묘사 – (1명)

· 1번 문장이 나를 그대로 표현하는 것 같아서

2번 묘사 – (1명)

· 사실적인 표현이 마음에 들었다

3번 묘사 – (3명)

· 그녀는 20살부터 조현병과 함께 살고 있다의 문장이 마음에 들어서

· 조현병이 나에게 걸림돌이 아닌 나와 함께하는 나의 일부처럼 느껴졌기 때문

· 조현병에만 초점을 맞추지 않고 유라자체를 표현한 거 같아서

· 자랑스러운 지지적인 가족들 공부하고자 하는 꿈을 이러한 긍정적인 말들이 회복으로 가는 좋은 표현인 것 같다.

03 Topic 3. 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진



핵심목표

나에게 '희망이 있다'고 소리내 볼 수 있다.

핵심질문

① 증상의 관해와 회복의 관계는?
- 선지이야기를 통해 회복에 대해 알아본다.

② 두 가지 정신건강서비스 모델의 특징과 차이점은?

③ 회복에서 희망의 중요성이란?

④ 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 관계란?

핵심내용

① 증상의 관해만으로 회복을 단정지을 수 없습니다.

② 증상의 관해에만 초점을 맞춘다면, 치료를 통해 희망을 잃을 위험이 있습니다.

③ 회복 지향 정신건강 서비스는 희망을 증진시키는 서비스입니다.

영상

세바시 강연 Sebasi Talk, 연이은 절망 속에서도 희망을 찾는 법 (7:56)

Tips. 상황에 따라 진행자가 영상 시청 없이 내용을 요약하여 전달할 수 있습니다.

03 Topic 3. 회복 지향 정신건장 서비스와 희망의 증진

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 '사례 모음' 중 [선지 이야기]
  각 조마다 한 세트씩 출력본을 준비해 둡니다.
- ☐ 프로그램 환경조성
  - 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 조별활동 책상배치
  - 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다.
    이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

참·고·사·항

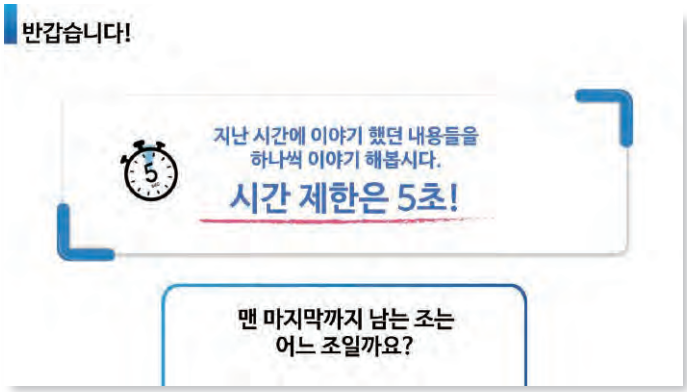
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

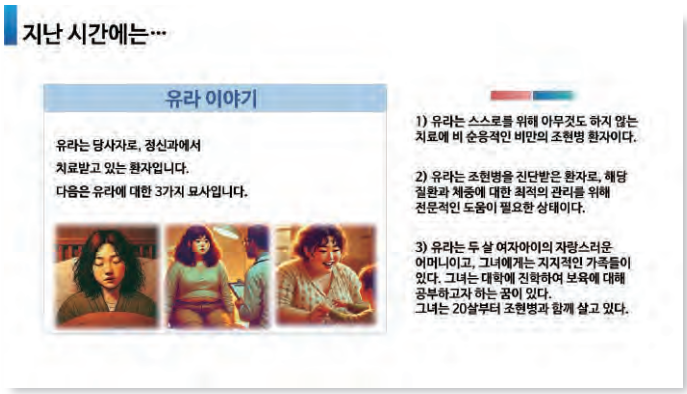
2. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다..

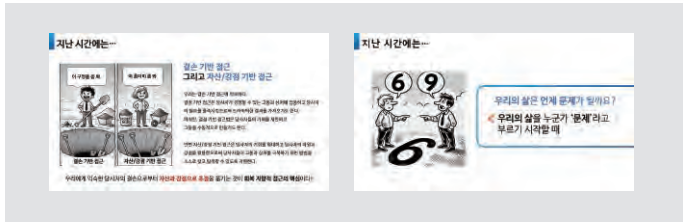
프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 170분 입니다.**

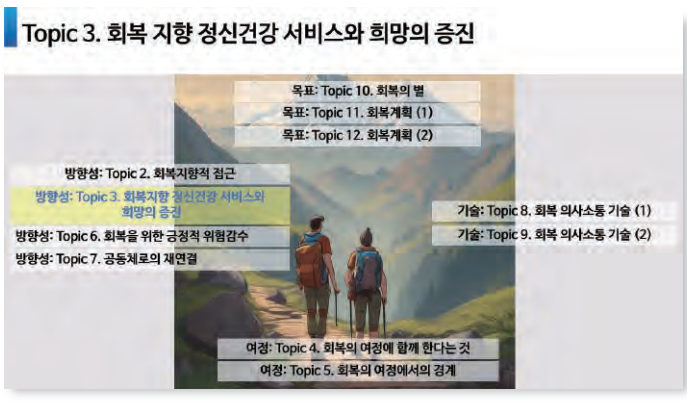
활동단계 도입



참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시키며 새로운 회기를 시작합니다.







회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진

활동내용

진행자는

이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 도입



조장과 서기 선출

활동내용

진행자는

조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간을 줍니다.

만약 여전히 자발적인 참여자가 없다면, 진행자가 직접 조장을 정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

- 조장은 조별 활동을 주도하며 전체 흐름을 이끕니다.
- 서기는 토론 중에 나온 의견들을 큰 종이나 화이트보드 시트 등에 정리하여, 발표자가 발표할 때 참고할 수 있도록 합니다.
- 발표자는 발표가 필요한 토론 활동마다 조에서 자율적으로 정합니다.

활동단계 전개



사례 설명. 선지 이야기

이야기 속의 선지는 병식이 없는 당사자로, 약물 복용에 소홀하여 입퇴원을 반복합니다. 선지는 4번째 보호입원에서 상당 기간 약물 치료를 받으며 증상이 호전됩니다. 증상만을 본다면 성공적인 입원 치료였지만, 여전히 병식은 없고, 치료진과의 치료적 동맹도 잘 형성되지 않은 상황입니다.

퇴원이 결정되었지만, 선지와 보호자, 주치의 모두 마음이 무겁다는 아이러니한 사례입니다.

활동내용

진행자는

슬라이드에 제시된 삽화와 선지의 속마음을 소개하며, 참여자들에게 사례에 대한 흥미와 궁금증을 유발합니다.

Tips.

- 본 슬라이드만 보고 어떤 이야기일 것 같을지 추측해 보자고 제안하며, 참여자들의 추측을 들어보는 것도 좋습 니다.

- 부록 중 '사례 모음'에서 [선지 이야기]를 미리 출력하여 각 조마다 한 세트씩 제공하며, 이때 미리 사례를 읽어보지 않도록 뒤집어 놓습니다.

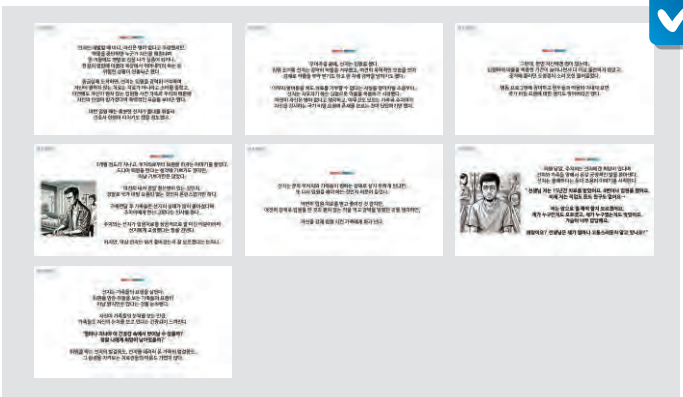
- 진행자가 사례를 읽기 시작할 때, 각 조마다 제공된 출력물을 함께 보자고 이야기합니다.

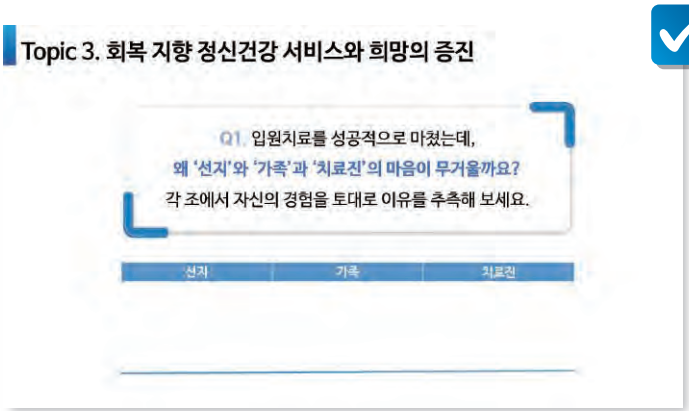
- 이후 사례와 관련된 토론 활동을 할 때도 자유롭게 출력물을 보면서 토론을 진행할 수 있습니다

활동단계 전개



선지 이야기 사례를 소개합니다.





사례 설명

이 토론 활동의 핵심은 사례를 통해 당사자, 보호자, 종사자 각자의 입장이 되어 서로의 마음을 헤아려 보는 것입니다.

각 조의 조장에 따라 토론 활동을 진행합니다. 토론 활동을 마친 후, 각 조의 발표자가 토론 결과를 모두에게 발표합니다.

활동내용

진행자는

슬라이드를 천천히 읽어 주며, 마치 구연 동화처럼 큰 따옴표 속의 대화와 작은 따옴표 속의 속마음을 실감 나게 표현합니다.

Tips.

몇몇 문장은 참여자 중 한 명에게 실감 나게 읽어 달라고 요청하여 사례에 대한 집중도를 높일 수 있습니다.

Q1. 왜 선지와 가족과 치료진의 마음이 무거울까요? (30분)

진행자는

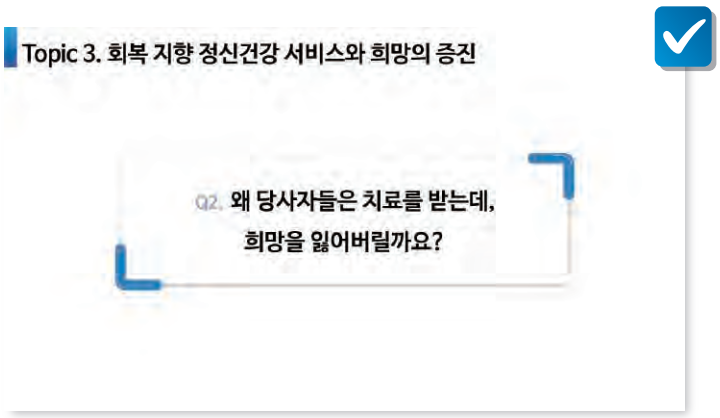
조별 토론이 원활히 진행되는지를 살펴보고, 발표 순서를 정합니다.

발표 직후의 역할은 아래와 같습니다.
① 명확하지 않은 부분을 명료하게 정리하는 역할
② 발표자의 발표 미숙으로 전달이 잘 안된 부분을 참여자 전체에게 원활하게 전달하는 역할
③ 발표자와 토론 활동을 한 참여자들을 격려하는 역할

진행자는

조별 활동 결과를 교정해 주거나, 일방적인 강의를 하지 않도록 주의해 주세요.

활동단계 전개



활동내용

Q2. 왜 당사자들은 치료를 받는데, 희망을 잃어버릴까요? (20분)

두번째 토론활동을 진행합니다.

진행자는

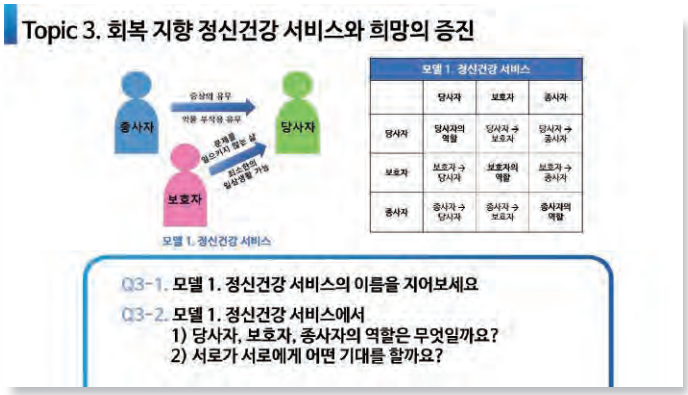
"우리는 오랜 기간 치료를 받을수록 증상은 호전되지만, 오히려 자신을 잃고 꿈과 희망을 잃어버리는 경우를 마주치곤 합니다. 그 이유가 무엇이라고 생각하는지 조별로 토론해 주세요."

Tips.

진행자는 참여자들이 이 토론 활동 중 자신이 받고 있는 기존 치료에 대해 비난하지 않도록 주의해 주세요.

이 토론의 핵심은 기존 치료를 부정하거나 비난하는 것이 아니라, 앞으로 나아가야 할 방향과 필요성에 대해 자유롭게 이야기하는 것입니다.

1부 끝 시간 부족 시



이 토론 활동은 난이도가 있습니다. 진행자는 만약 참여자들이 이 토론을 소화하기 어렵다고 판단된다면, Q5 또는 Q6으로 넘어갈 수 있습니다.

활동내용

Q3. 모델 1 정신건강 서비스에 관한 토론을 진행합니다. (20분)

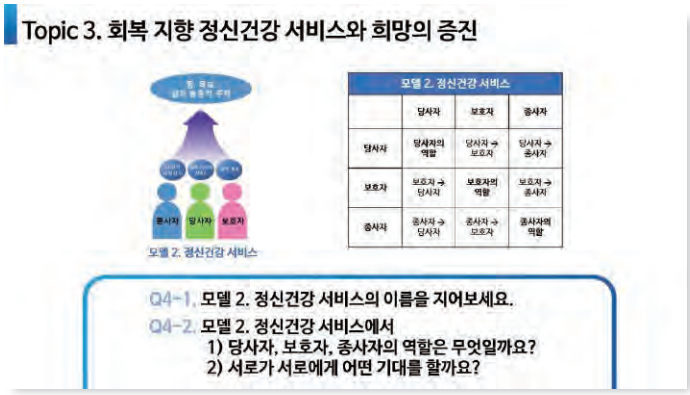
진행자는

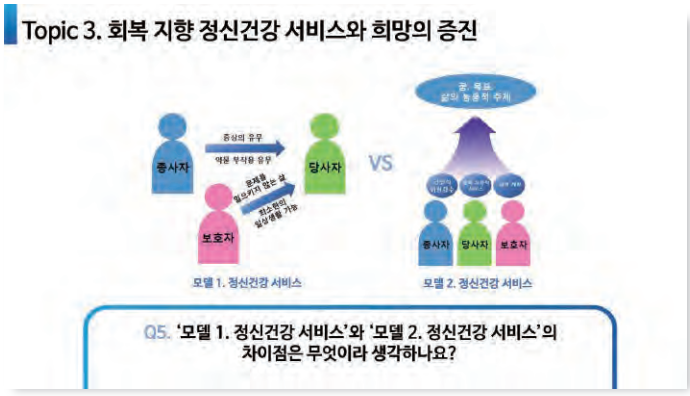
모델 1. 정신건강 서비스에 대한 도식을 천천히 설명합니다. 화살표는 일방향으로 표시되어 있습니다. 종사자는 '증상과 부작용'에 대해, 보호자는 '문제와 일상 생활'에 대해 당사자에게 화살표가 향해 있습니다. 당사자로부터 시작되는 화살표는 없습니다.

이후, 토론 활동을 통해 채울 3x3 표에 대해 설명합니다.

예를들면, '당사자 → 보호자' 칸에는 모델 1. 정신건강 서비스에서 당사자가 보호자에게 어떤 기대를 할 수 있을지를 토론한 결과를 적습니다. 마찬가지로 '보호자의 역할' 칸에는 모델 1. 정신건강 서비스에서 보호자가 맡게 되는 역할에 대한 토론 결과를 기록합니다.

활동단계 전개





활동내용

Q4. 모델 2. 정신건강 서비스에 관한 토론을 진행합니다. (20분)

진행자는

모델 2. 정신건강 서비스에 대한 도식을 천천히 설명합니다.

이후, 토론 활동을 통해 채울 3x3 표에 대해 설명합니다.

Q5. 모델 1. vs 모델 2. 정신건강 서비스에 관한 토론을 진행합니다. (20분)

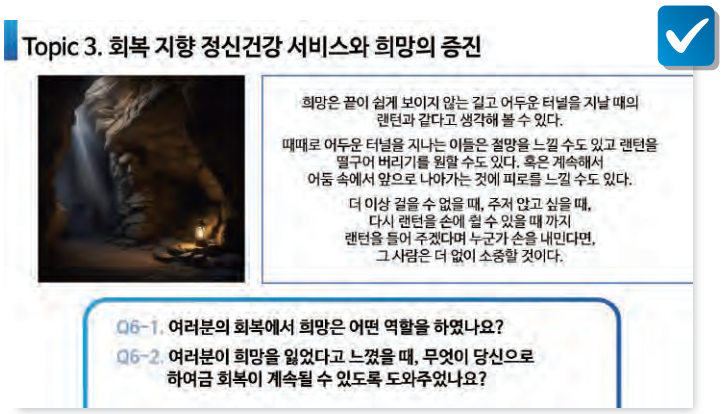
진행자는

각 조에서 Q3와 Q4에 대한 토론 활동을 완료했다면, 그 연장선 상에서 Q5 토론 활동을 진행합니다.

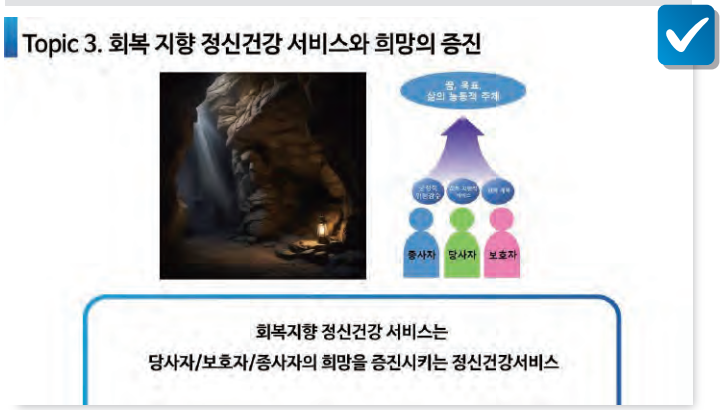
진행자는 Q3 토론 활동을 위해 20분의 시간을 제공합니다. Q3를 마친 뒤 발표 없이 Q4 토론 활동을 위한 20분의 시간을 제공합니다. 마찬가지로 Q4가 끝난 후, 발표 없이 Q5 토론 활동을 위한 20분을 제공합니다.

Q5까지 모든 토론 활동을 마친 후, 각 조의 발표자는 한 번에 Q3, Q4, Q5의 결과를 발표합니다.

활동단계 전개



참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 4: Promoting hope)



회복지향 정신건강 서비스란?[16)-18)] Q3, 4, 5, 6 을 종합하는 슬라이드 입니다.

활동내용

Q6. 회복과 희망에 관한 토론을 진행합니다. (20분)

진행자는

진행자가 슬라이드에 제시된 삽화와 글을 천천히 읽거나, 참여자들에게 돌아가면서 한 문장씩 읽도록 이야기합니다.

Q6 토론 활동의 경우, 참여자들에게 자신의 경험을 바탕으로 이야기해 달라고 요청합니다. 이때 보호자나 종사자의 경우, 곤경이나 위기에 처했을 때를 떠올리며 이러한 상황에서의 회복에 있어 희망이 어떤 역할을 했는지 생각해 보도록 안내합니다.

진행자는

회복 지향 정신건강 서비스에 대한 여러 정의가 있겠지만, 공통적으로 '희망'이 중요함을 설명합니다.

활동단계 정리



영상 시청 (7:56)

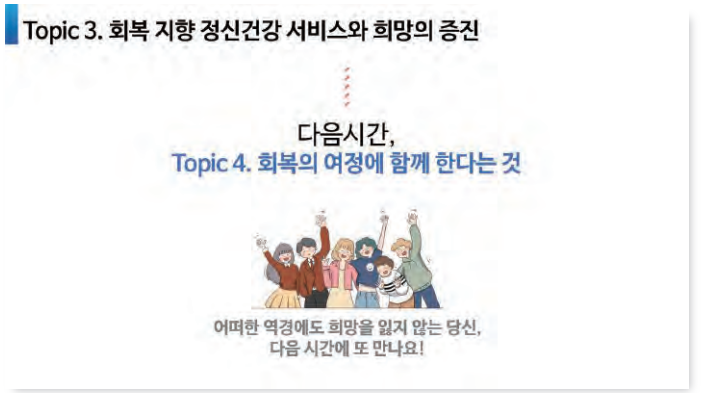
활동내용

연이은 절망 속에서도 희망을 잃지 않는 당사자의 경험담을 통해 토론 활동을 했던 내용들을 다시금 상기시킵니다.

활동단계 정리



모두 한마디!



다음 Topic 소개

활동내용

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.

- 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.
- 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 한마디씩을 듣는 시간을 꼭 지키는 것을 권장합니다.

Tips.

- 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
- 각 과마다 ' 당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
- "어떠한 역경에도 희망을 잃지 않는 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

03 Topic 3. 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q1. 왜 선지와 가족과 치료진의 마음이 무거울까요?

1조

선 지	가 족	치료진
· 약 복용 후 나아지는 경험을 통해 정체성 혼란으로 마음이 무거워짐	· 퇴원 후 약 복용 중지	· 퇴원 후 약 복용을 할까
· 강제 입원이었기에 퇴원후 약 복용 중지하면 또 다시 강제입원 시킬까봐 두려움	· 가족과 불화 염려	· 가족과 잘 지낼 수 있을까
· 여전히 본인은 환자가 아니라고 생각하여 약, 입원을 부당하다고 생각함	· 두려움	· 다시 입원하지 않을까 염려됨
	· 가족 원망할까 걱정	

2조

선 지	가 족	치료진
· 처음부터 자연스럽지 않은 입원이라서, 강제입원 이라서	· 완치는 아니니까 언제 재발할지 걱정도 되고 당사자 스스로 약의 필요성을 못 느끼고 병식이 없이 혼란스러워 보여서.	· 얼마가지 않아 다시 보지 않을까 하는 걱정
· 퇴원을 했어도 반복해서 입원을 하는 것에 대한 불안감	· 집에서 케어해야 하는 것에 대한 부담감 (비협조적일 때)	· 눈앞에 사라지면 케어해 드릴 수 없어서.
· 결과는 성공적이었으나 과정에서의 시련과 어려움으로 안 좋은 기억이 남아서		· 약 뿐만 아니라 건강한 일상이 유지될까 하는 불안으로 마음이 무겁다
· 이해가 잘 되지 않고 잘 모르겠다. 잘 퇴원한 것 같은데...		

3조

선 지	가 족	
· 일상생활에서 일반인들과 섞일 수 있을까, 불안하기 때문에	· 상태가 유지가 안되고 재발이 될까 마음이 무겁다.	· 병원 밖에서 치료가 유지가 잘 될 수 있을까?
· 입원도 가족에 의해서, 치료도 가족에 의해서 나는 앞으로 가족 뜻에만 따라야 할까.	· 병원을 벗어나면 우리가 관리를 해야 하는데 우리도 일상을 지내야 하는데 관리가 잘 될까?	· 지금 상황에 퇴원을 하시는 게 맞을까?
· 이게 완전한 회복인지 모르겠다. · 병증 회복에 대한 자신감의 부족.		· 더 완벽한 퇴원은 없을까?

03 Topic 3. 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q3. 모델 1. 정신건강 서비스의 이름과 각자의 역할

1조 모델 1 이름 : 과부하 풍선

	당사자	보호자	종사자
당사자	**역할** 폐를 끼치지 않고 다른 사람을 힘들지 않게 하는 역할	당사자가 힘들 때 보호자에게 의지할 수 있게 하는 역할	심리적으로 편하게 해주고 약물조정을 해주는 역할
보호자	돌보아 주는 역할	**역할** 행복한 일상생활을 할 수 있게 도와주는 역할	보호자가 없을 때도 당사자가 당사자끼리 친하게 지낼 수 있게 하는 역할
종사자	증상이 호전 될 수 있게 도와줌	약을 잘 먹게 일상을 잘 유지하게 도와줌	**역할** 시간을 들여서 당사자의 이야기를 들어주는 역할

2조 모델 1 이름 : 일방통행

	당사자	보호자	종사자
당사자	**역할** · 약 복용 잘하기 · 도움요청 잘하기 · 권리의 주체	· 힘든 나를 알아줘 · 육체적, 심리적으로 케어해줘	· 잘 챙겨줬으면 좋겠다. · 화합하고 지내고 싶어.
보호자	· 약 잘먹기 · 일상 자기관리 잘하기 · 직면했음 좋겠다.	**역할** · 관리자(환자케어) · 기다려 주는 사람 · 회복을 돕는 사람 · 지지자	· 내 가족처럼 했음 좋겠다. · 나라에서 더 케어해줬으면 좋겠어. (+강제성을 더해서)
종사자	· 얘기를 해줘 · 믿어줘 (우리를)	· 우리를 믿어줘 · 우리가 못 하는 부분을 해줘	**역할** · 치료진 - 동행자 -지지자 · 리더 -교육자

03 Topic 3. 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q4. 모델 2. 정신건강 서비스의 이름과 각자의 역할

3조 모델 2 이름 : 하모니

	당사자	보호자	종사자
당사자	**역할** 병을 인지 : 회복 의지 가짐	나를 믿고 기다려줘	나의 얘기를 들어주고 이해해주기
보호자	· 아픔 딛고 현실을 안주하지 않고 희망을 품자	**역할** · 당사자에 대한 편견 버림 · 치료에 대한 희망을 가짐	당사자를 계속 믿어주고. 치료 프로그램 제공(약 처방 이외)
종사자	· 당사자 상황을 종사자에게 솔직하게 얘기하기. · 삶의 목표 정하고 삶의 능동적 주체가 되기	· 당사자의 든든한 울타리 되어주기 · 당사자, 종사자 믿어주기	**역할** 당사자에게 회복에 대한 신뢰, 믿음 주기

4조 모델 2 이름 : 동행

	당사자	보호자	종사자
당사자	**역할** 마음을 편하게 가진다	· 고맙다는 표현을 한다 · 제 말을 잘 들어주면 좋겠다 (경청)	· 종사자에 대한 신뢰 · 최선의 진료(마음에 와닿는 진료)
보호자	건강을 유지하는 것	**역할** · 얘기를 잘 들어주는 것 · 사소한거라도 잘 들어주는 것, 사주는 것	대충하지 않고 확실하게 임하는 자세
종사자	· 당사자 스스로 자신의 삶에 대한 가치관 등을 적극적으로 표현하는 것 · 힘들어도 포기하지 않고 나아가는 마음가짐	· 당사자를 같은 사람으로 봐주기, 짐이 아닌 존재로 · 당사자를 있는 그대로 봐주기 의견을 부정하지 않고 인정하는 태도	**역할** 증상 외에도 필요한 꿈이나 목표를 함께 찾고 지원하기

04 Topic 4. 회복의 여정에 함께 한다는 것



핵심목표

나의 회복의 여정에 어떤 사람이 함께 하고 있는지 적을 수 있다.

핵심질문

① '함께'한다는 것은 무엇일까?

② 나의 회복의 여정에 함께 하는 것과 함께 한다고 오해하는 것은?

은성이와 은성이 아버지 사례와 자신의 경험을 이야기합니다.

③ 회복의 여정에서 각자의 역할은 무엇일까?

주인공과 지지자 그리고 조력자의 역할을 이해합니다.

핵심내용

① 치료에 대한 목표가 같고, 당사자를 위하는 마음만으로는 회복의 여정에 '함께' 한다고 이야기 할 수 없습니다.

② 회복의 여정에 함께 하기 위해선 회복의 주인공, 조력자, 지지자의 역할을 이해하는 것이 중요합니다.

영상

SportsToto, 세상은 누군가와 함께 가는 길 (1:38)

Tips. 상황에 따라 진행자가 영상 시청 없이 내용을 요약하여 전달할 수 있습니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 '사례 모음' 중 [은성이와 은성이 아버지 이야기]
  각 조마다 한 세트씩 출력본을 준비해 둡니다.
- ☐ 프로그램 환경조성
  - 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 조별활동 책상배치
  - 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다.
    이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

참·고·사·항

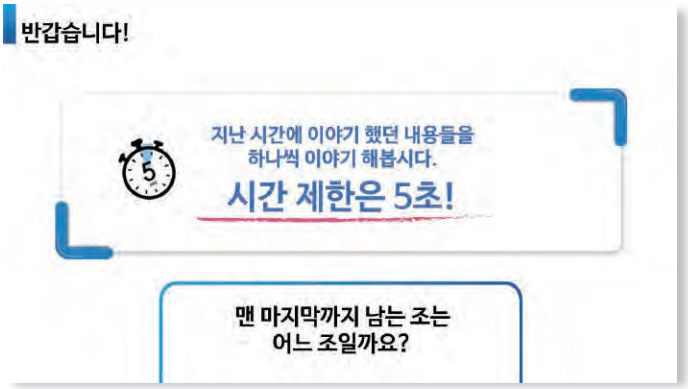
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

1. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 180분 입니다.**

활동단계 도입

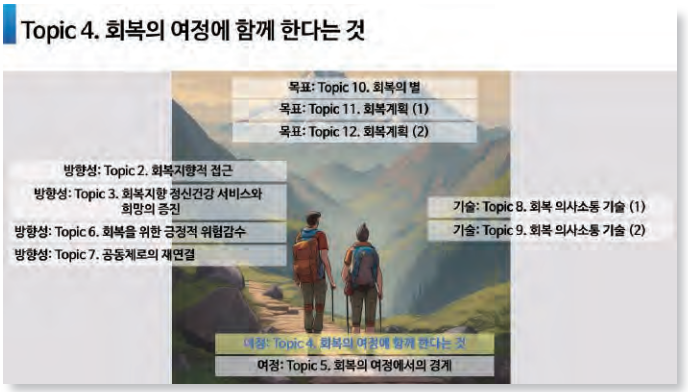


참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시키며 새로운 회기를 시작합니다.



오늘의 주제는 회복의 여정에 함께 한다는 것입니다.





활동내용

진행자는

이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

진행자는

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

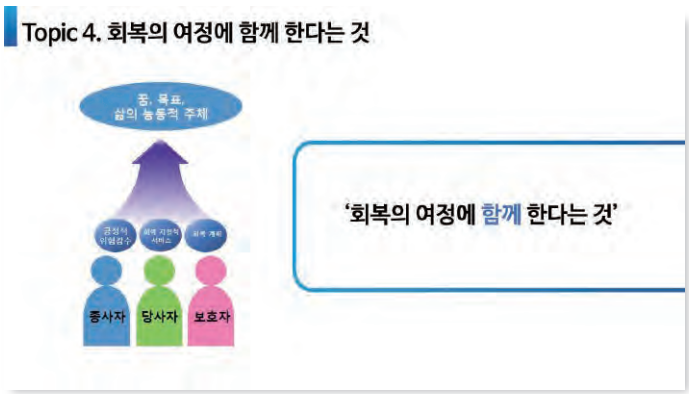
04 Topic 4. 회복의 여정에 함께 한다는 것

활동단계 도입

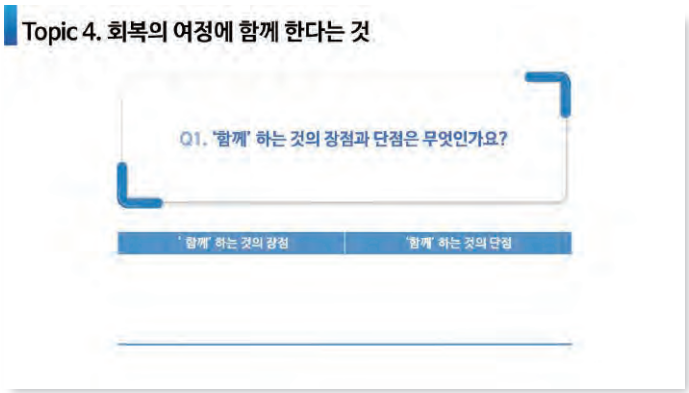


조장과 서기 선출를 진행합니다.

활동단계 전개



회복의 여정에 함께 한다는 것에 대해 질문합니다.



활동내용

진행자는

조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간 (보통 3분 이내)을 줍니다. 만약 여전히 자발적인 참여자가 없다면, 진행자가 직접 조장을 정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

- 조장은 조별 활동을 주도하며 전체 흐름을 이끕니다.
- 서기는 토론 중에 나온 의견들을 큰 종이나 화이트보드 시트 등에 정리하여, 발표자가 발표할 때 참고할 수 있도록 합니다.
- 발표자는 발표가 필요한 토론 활동마다 조에서 자율적으로 정합니다.

활동내용

Tips.

지난 시간에 사용했던 도식이 다시 등장했다는 점을 언급하여, 참여자들이 프로그램의 연속성을 느끼고, 오늘 주제에 대해 더 큰 친근감과 익숙함을 가질 수 있도록 안내합니다.

Q1. '함께'하는 것의 장단점 (20분)
''함께' 에 대한 브레인스토밍 질문 입니다.

진행자는

조장의 진행에 따라, 각 조는 '함께 무언가를 해 본 경험'을 바탕으로, 함께하는 것의 장점과 단점에 대해 자유롭게 토론하도록 합니다.

토론 활동 후에는 조별로 발표자를 정해 전체 참여자 앞에서 내용을 공유하도록 안내합니다.

진행자는

발표 내용을 요약하거나 명료화하고 참여자들을 격려할 수는 있지만,
발표 내용을 교정하거나 특정 조의 발표를 '정답'처럼 받아들이는 반응은 피해야 합니다.

.

활동단계 전개





사례 설명

은성이와 은성이 아버지 이야기

[이야기 속의 은성이는 지적장애가 있는 당사자입니다.
은성이 아버지는 헌신적으로 아들을 돌보는 보호자 입니다.
은성이 아버지는 최선을 다해 은성이의 회복에 함께하고자 애쓰지만,
오히려 그 헌신으로 인해 은성이는 자신의 회복에서 소외되는 안타까운 사례입니다.]

활동내용

Q2. 함께 하지만 함께 하지 않는 것 (10분)
Q1과 마찬가지로, 이번에도 '함께' 에 대한 브레인스토밍 질문입니다.

이 질문은 조별 토론이 아닌, 참여자들이 자유롭게 손을 들어 자신의 의견을 말하는 방식으로 진행해도 좋습니다.
두 그림 모두 '회의 중'인 상황을 표현하고 있지만, 첫 번째 그림은 모두가 적극적으로 참여하는 모습, 두 번째 그림은 각자 딴생각을 하는 모습을 보여줍니다.

진행자는

두 그림의 공통점과 차이점에 대해 참여자들이 자유롭게 이야기할 수 있도록 유도합니다. 이어서, '함께 있지만 함께하지 않는 상황'에 대해 떠오르는 생각을 참여자들이 손을 들어 자유롭게 이야기하도록 안내합니다.

진행자는

슬라이드에 제시된 삽화와 은성이 아버지의 인자한 목소리를 따라하며, 참여자들에게 사례에 대한 흥미와 궁금증을 유발합니다.

Tips.

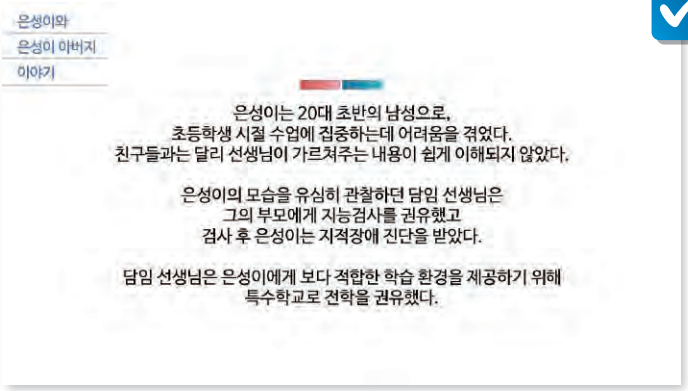
본 슬라이드만 보고 어떤 이야기일 것 같은지 추측해 보자고 제안하며, 참여자들의 추측을 들어보는 것도 좋습니다.

부록 중 '사례 모음'에서 [은성이와 은성이 아버지 이야기]를 미리 출력하여 각 조마다 한 세트씩 제공하며, 이때 미리 사례를 읽어보지 않도록 뒤집어 놓습니다.

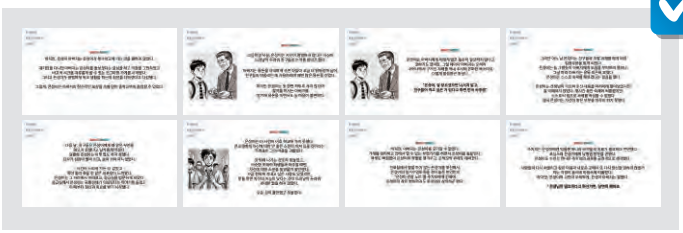
진행자가 사례를 읽기 시작할 때, 각 조마다 제공된 출력물을 함께 보자고 이야기합니다.

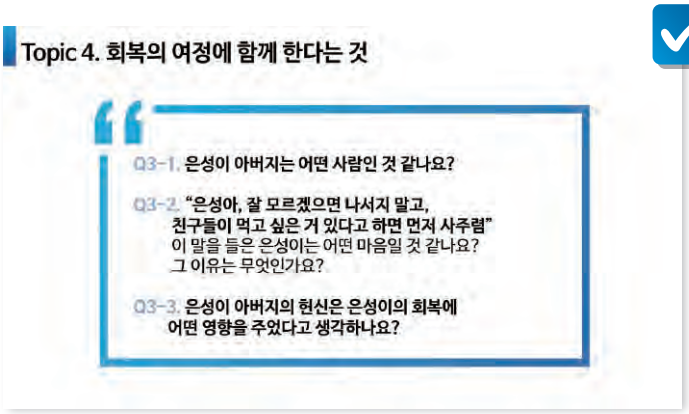
이후 사례와 관련된 토론 활동을 할 때도 자유롭게 출력물을 보면서 토론을 진행할 수 있습니다.

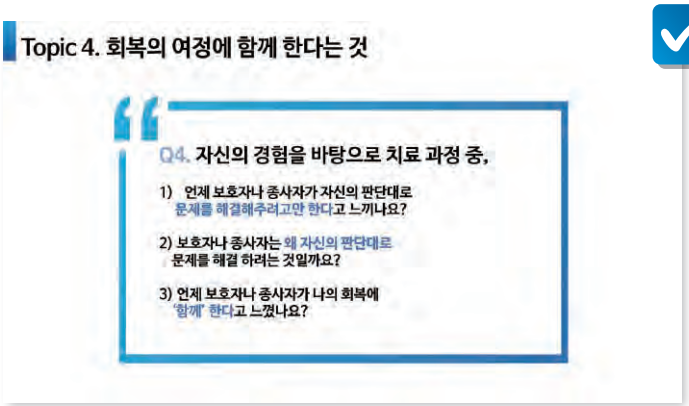
활동단계 전개



은성이와 은성이 아버지 이야기에 대해 소개합니다.







활동내용

진행자는

슬라이드를 천천히 읽어 주며, 마치 구연 동화처럼 큰 따옴표 속의 대화와 작은 따옴표 속의 속마음을 실감 나게 표현합니다.

Tips

몇몇 문장은 참여자 중 한 명에게 실감 나게 읽어 달라고 요청하여 사례에 대한 집중도를 높일 수 있습니다.

Q3. 은성이와 은성이 아버지에 대하여 (20+20 = 40분)
진행자는 Q3-1, Q3-2에 대해 우선 조별 토론을 하고 발표를 하도록 안내합니다. (20분)

애니메이션 효과 활용 = 클릭

Q3-1, Q3-2에 대한 발표를 마친 뒤에 클릭을 하면 Q3-3이 나타납니다.

진행자는 Q3-3에 대해 조별 토론을 하고 발표를 하도록 안내합니다. (20분)

Q4. 문제를 해결하는 것과 함께 하는 것 (40분)
진행자는 Q4의 1), 2) 에 대해 우선 조별 토론을 하고 발표를 하도록 안내합니다.

애니메이션 효과 활용 = 클릭

Q4의 1), 2) 에 대한 발표를 마친 뒤에 클릭을 하면 3)이 나타납니다. 진행자는 Q4의 3)에 대해 조별 토론을 하고 발표를 하도록 안내합니다.

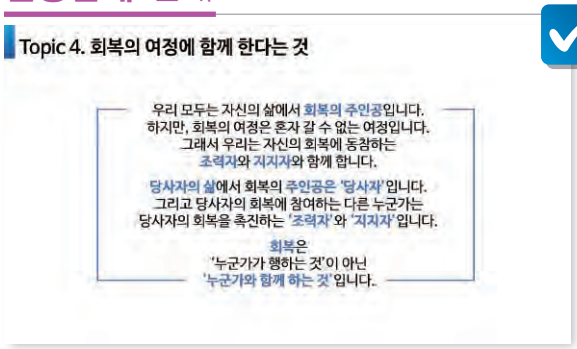
활동단계 전개



은성이와 은성이 아버지 이야기에 대해 소개합니다.

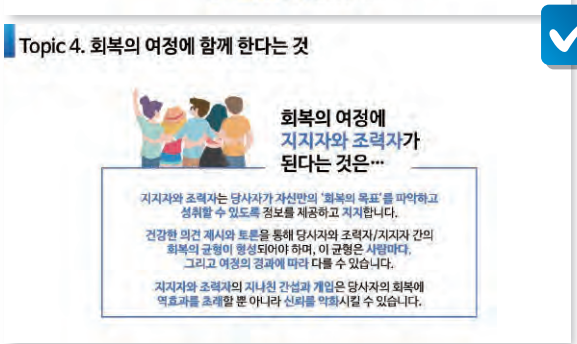
출처: https://www.youtube.com/watch? v=3733nPZ9hbc&t=1s

활동단계 전개



회복의 여정에 함께 한다는 것에 대한 설명 (10분)





활동내용

시각장애를 가진 탠덤사이클 선수와 파일럿 선생님의 영상을 시청합니다.

진행자는

이 질문은 조별 토론이 아닌, 참여자들이 자유롭게 손을 들어 자신의 의견을 말하는 방식으로 진행해도 좋습니다.

1부 끝 시간 부족 시

활동내용

진행자는

아래와 같이 설명할 수 있습니다.

"각자의 삶에서 회복의 주인공은 자기 자신입니다."
"당사자의 삶에서 회복의 주인공은 당사자 자신입니다. "
"보호자와 종사자는 함께하며 조력자이자 지지자로서의 역할을 수행합니다. "

진행자는 슬라이드 내용을 바탕으로
회복의 여정에 주인공이 된다는 것의 의미를 설명합니다.

또한, 회복의 여정에 지지자와 조력자가 된다는 것의 의미를 설명합니다.

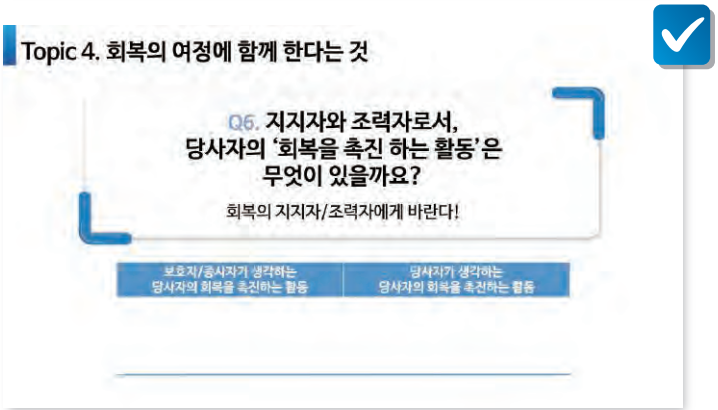
참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 6: Working alongside people)

활동단계 전개



추가적인 회복의 여정에 함께 한다는 것에 대한 설명





활동내용

영화 [반지의 제왕]을 알고 있는 참여자가 많다면, 추가로 활용할 수 있는 슬라이드 입니다.

진행자는

"영화 속 주인공은 가장 작고 연약한 인물인 프로도입니다.

그의 곁에는 크고 힘이 세며, 강력한 마법을 사용하는 동료들이 함께합니다."
"영화를 보는 내내 이들의 강인함은 프로도의 연약함과 대비되어, 주인공이 답답하게 느껴지기도 합니다.

하지만 주인공만이 감당해야 할 역할을 다른 동료가 대신하거나 빼앗으려 할 때, 반지 원정대는 늘 위기를 맞게 됩니다."

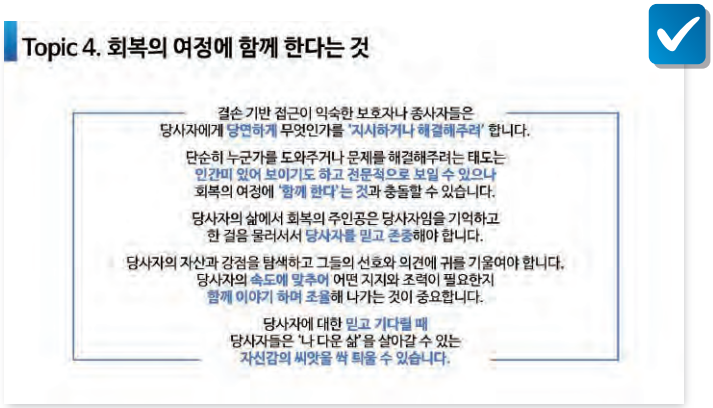
"이 이야기를 통해 우리는 당사자의 행동이 더디고 부족해 보여도, 그가 감당해야 할 '주인공의 역할'을 대신하거나 빼앗으려 해서는 안 된다는 교훈을 얻을 수 있습니다."

Q6. 지지자와 조력자 → 회복을 촉진하는 활동 (20분)
진행자는 조별 토론에 앞서, 질문에 대한 추가 설명을 제공합니다. → '당사자의 회복을 촉진하는 활동'에 대해 조별로 토론하되, 각 조에 속한 보호자, 종사자, 당사자의 입장에서 생각하는 내용을 구분하여 표에 정리하도록 안내합니다.

조별 발표를 들은 후, 진행자는 다음과 같이 정리합니다.
①각 조에서 나온 다양한 아이디어에 대해 격려합니다.
②보호자·종사자의 생각과 당사자의 생각 사이에 간극이 느껴지는지, 느껴진다면 어떤 지점에서 차이가 있는지 간단히 짚어줍니다.

이를 통해 참여자들이 실제 당사자가 원하는 조력과 지지가 무엇인지 듣고, 이해하는 시간이 되도록 돕습니다. 이때, 당사자가 원하는 것만이 정답이라는 오해에 빠지지 않도록 주의가 필요합니다. → 핵심은, 같은 목표를 가지고 있더라도 당사자와 보호자·종사자 간에 생각의 차이가 있을 수 있다는 점을 이해하는 것입니다.

활동단계 정리

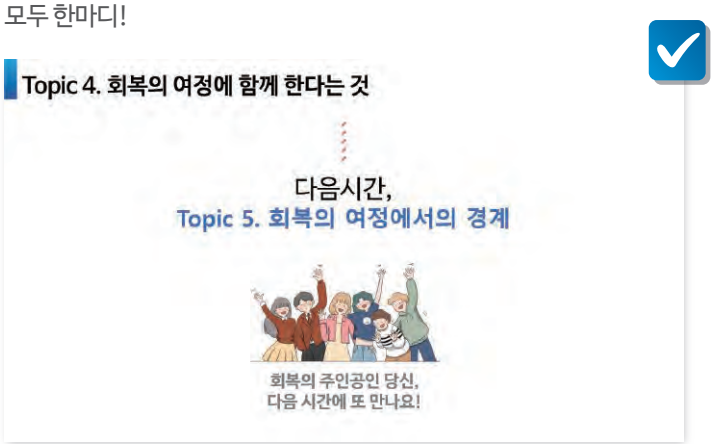


'함께'에 대한 오해 (5분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 6: Working alongside people)



모두 한마디!



다음 Topic을 소개합니다.

활동내용

진행자는

슬라이드의 내용을 천천히 읽어주며, Topic 2에서 다뤘던 '결손 기반 접근'이 보호자와 종사자로 하여금 무의식적으로 당사자에게 지시하거나 대신 해결하려는 태도로 이어질 수 있음을 설명합니다.

이어서, 누군가와 여정을 함께할 때 필요한 '믿음', '존중', '속도 맞추기', '조율'의 중요성에 대해 이야기합니다.

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips

- 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.
- 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 한마디씩을 듣는 시간을 꼭 지키는 것을 권장합니다.

Tips

- 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
- 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
- "회복의 주인공인 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q1. '함께' 하는 것의 장점과 단점은 무엇인가요?

1조

1. 장점 ① 의지할 곳이 있다.
② 자기를 객관적으로 볼 수 있다.
③ 힘이 날 것 같다. (버틸 수 있다, 오래할 수 있다)
④ 자신감을 가질 수 있다.
2. 단점 ① 지나친 의존성이 생길 수 있다. (독립성 저하)
② 미안함, 죄책감(나를 신경 써줘야 될 것 같음)
③ 솔직하게 표현하지 못할 거 같다.

2조

1. 함께 하는 것의 장점

① 외롭지 않다.
② 당장 무슨 일을 해야 할지 모를 때 서로 도울 수 있다.
③ 혼자일 때 보다 더 오래 여정을 함께할 수 있다.
④ 서로 양보할 수 있다.

2. 함께 하는 것의 단점

① 마음이 맞지 않을 때 다툼이 있을 수 있다.
② 내가 하고 싶은대로만 할 수 없다.
③ 가면을 쓰고 상대방을 위하는 척 할 수 있다. (진심이 아닌..)

3조

1. 함께 하는 것의 장점

① 회복이 빠를 것 같다.
② 개인의 욕심이 없어진다.
③ 마음이 나는 사람이 있다는 것
④ 일으켜준 사랑이 있다는 것

2. 함께 하는 것의 단점

① 생각이 많아질 것 같다.
② 개인보다 남을 배려하는 마음이 힘들 것 같아.
③ 의견 충돌로 인해 감정이 상할 수 있다.
④ 나의 생각만을 이야기 (주장) 할 수 없을 것이다.

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q3-1) 은성이 아버지는 어떤 사람인 것 같나요?
Q3-2) 아버지의 말을 들은 은성이는 어떤 마음일 것 같나요?

1조

Q3-1) ① 아들을 무척 사랑하는 헌신적이다. (희망적)
② 책임감이 강하시다.
③ 실패를 두려워 하심
④ 자기 중심적이다. (자녀의 의견 반영 x)

Q3-2) ① 은성이의 의견 (반영 x)
② 은성이는 아버지의 의견 잘 들었음
③ 두려움(처음 접하는 낯 병원과 등료)
④ 불안감 (아버지의 도움이 없었으면?)

2조

Q3-1) ① 자상한 분인 거 같다.
② 강박적인 거 같다.
③ 의사의 말을 지나치게 믿는다.
④ 본인의 뜻이 확고하다.
⑤ 신적인 분 (모든 결정을 다 줌)

Q3-2) ① 무기력증을 느낄 듯 좌절감 (새로운 일을 시작 못할 것 같음)
② 좌불안석 부담. 혼란 생각이 많아진다.
③ 많이 힘들 것 같다. 숨이 막힌다.
④ 미안함, 죄책감
⑤ 자기주장을 못 내세울 듯함

3조

Q3-1) ① 헌신적이나 의사소통 하면서 일방적으로 아들을 대한다.
② 고지식하고 자기중심적인 사람
③ 지금도 잘 해주지만 더 잘 해주기 위해 노력하고 불안감을 가진 사람

Q3-2) ① 자신의 아버지에 대해 불편함이 클 것 같다. : 낮 병동에서 또 다시 자신이 밝혀질 것 같아 두려운 있음
② 서운했을 것 같다. : 자신의 인격을 존중해주지 않아 자존감이 낮아졌다.
③ 아버지의 기대에 미치지 못하며 부담감이 들었을 것 같다.
④ 아버지의 말에 따라서 노력을 많이 했을 것 같다. : 성장하면서 지기 자신에 대해 알게 되어서...

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q3-1) 은성이 아버지는 어떤 사람인 것 같나요?
Q3-2) 아버지의 말을 들은 은성이는 어떤 마음일 것 같나요?

4조

Q3-1) ① 희생적이다, 내 인생을 포기할 정도로 헌신적이다.
② 은성이의 인생을 대신 살아주는 사람이다.
③ 지난주 했던 모델 1의 보호자 같다.

Q3-2) ① 은성이는 점점 자신감이 떨어질 것 같다.
(은성이가 하고 싶은 것이 있을 텐데 아버지가 시키는 대로 해야 하니까)
② 내 의견이 존중받지 못한 느낌이 든다.
(내 결정은 없고 아빠가 모든 결정을 하니까)

04 Topic 4. 회복의 여정에 함께 한다는 것

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q4-1) 언제 보호자나 종사자가 자신의 판단대로 문제를 해결해주려고만 한다고 느끼나요?
Q4-2) 보호자나 종사자는 왜 자신의 판단대로 문제를 해결하려는 것일까요?
Q4-3) 언제 보호자나 종사자가 나의 회복에 '함께'한다고 느꼈나요?

1조

Q4-1) ① 늘상 그랬다
② 회복 프로그램을 권유할 때
③ 외래진료를 볼 때 내 의견보다는 치료진과 보호자가 치료방향을 결정한다

Q4-2) ① 당사자 스스로 결정을 못하니까
② 보호자나 종사자가 경험이 많으니까

Q4-3) ① 내가 (당사자) 얼마나 힘들었을지 공감해 줄 때
② 의견을 물었을 때 기다려줄 때
③ 대화를 통해서 서로의 마음을 위로해 줄 때

2조

Q4-1) ① 시설에서 같이 사는 사람을 임의로 배정해줄 때
② 자기 생활 하는데 있어서 무조건적으로 참여해야 할 일들을 정해줄 때
③ 약물을 무조건적으로 복용을 하게 하나 부작용에 대해서 의견을 들어주지 않을 때

Q4-2) ① 치료 주체 중 보호자, 종사자가 우위에 있다고 생각하기 때문
② 치료자가 전문가이기 때문에 판단에 맡기게 된다
③ 보호자가 치료자보다 오랫동안 생활했기에 더욱 잘 안다고 생각하기 때문
④ 종사자는 객관적인 정보와 치료 방법을 알고 있기 때문

Q4-3) ① 자신의 말을 들어줄 때
② 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램
③ 당사자, 종사자, 보호자가 한 자리에서 대화할 때

04 Topic 4. 회복의 여정에 함께 한다는 것

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q4-1) 언제 보호자나 종사자가 자신의 판단대로 문제를 해결해주려고만 한다고 느끼나요?
Q4-2) 보호자나 종사자는 왜 자신의 판단대로 문제를 해결하려는 것일까요?
Q4-3) 언제 보호자나 종사자가 나의 회복에 '함께'한다고 느꼈나요?

3조

Q4-1) ① 강제입원시, 병원결정을 부모 마음대로
② 나를 감시한다고 느낄 때
③ 퇴원결정을 보호자가가 할 때 (나는 퇴원하고 싶은데...)

Q4-2) ① 당사자를 믿지 못해서
② 최선이라고 생각하기 때문
③ 경험이 없으니까
④ 치료를 중단할까봐
⑤ 걱정이 되어서

Q4-3) ① 나를 배려해줄 때 (나 대신 청소를 해 줌)
② 내 의견을 잘 들어줄 때
③ 입원했을 때 간식도 챙겨주고 심적으로 걱정도 많이 해줄 때

4조

Q4-1) ① 처음 발병했을 때, 재발했을 때
② 집에서만 생활하고 있을 때, 씻지 않을 때
③ 경제적인 문제가 커질 때
④ 자신의 의견을 계속 말하지 않을 때

Q4-2) ① 나아야 하니까, 걱정되니까, 답답하니까
② 내 방법 외에는 알 수가 없으니까 내 판단대로
③ 위생에 안 좋으니까, 건강에 안좋으니까
④ 당장 살아가는데 문제가 되니까

Q4-3) ① 자조 모임이나 프로그램을 같이 해줬을 때 함께 한다고 느낌
② 가정이 화목할 때, 가족이 함께 시간을 보낼 때, 기다려줄 때, 틀린 말이라도 의견을 경청해 줄 때

05 Topic 5. 회복의 여정에서의 경계



핵심목표

회복에 여정에서 경계를 잘 지키고 있는지 스스로 답해볼 수 있다.

핵심질문

① 회복의 여정에서 경계란?

- 홍기와 홍기 어머니 사례와 자신의 경험을 통해 과도 관여와 과소 관여에 대해 이야기 한다.

② 회복의 여정에서 경계에 대해 생기는 오해는?

- 경계를 지킬 때, 서로의 온전함이 보호되고 건강한 관계를 형성할 수 있음을 이해한다.

핵심내용

① 지난 주제를 통해, 회복은 함께 가는 여정임을 배웠습니다.

② 이번 주제에서는, 그 여정을 함께하기 위해 서로의 온전함을 지켜주는 '경계'가 얼마나 중요한지 이해합니다.

③ 이 경계에 문제가 생기면 건강한 관계 형성이 어려워지고, 과도 관여나 과소 관여로 이어질 수 있음을 배웁니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 '사례 모음' 중 [홍기와 홍기 어머니 이야기]
  각 조마다 한 세트씩 출력본을 준비해 둡니다.
- ☐ 프로그램 환경조성
  - 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 조별활동 책상배치
  - 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다.
    이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

참·고·사·항

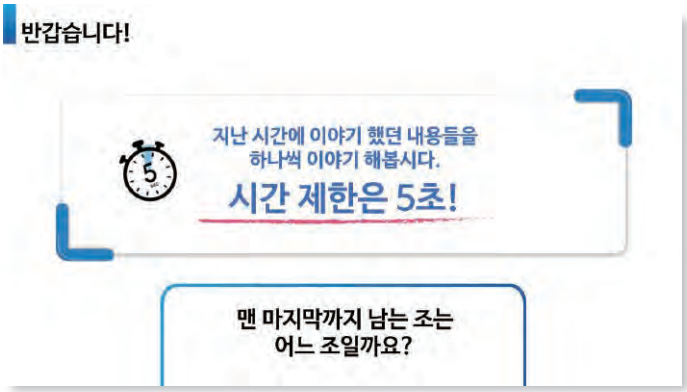
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다.)

2. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 150분 입니다.**

활동단계 도입

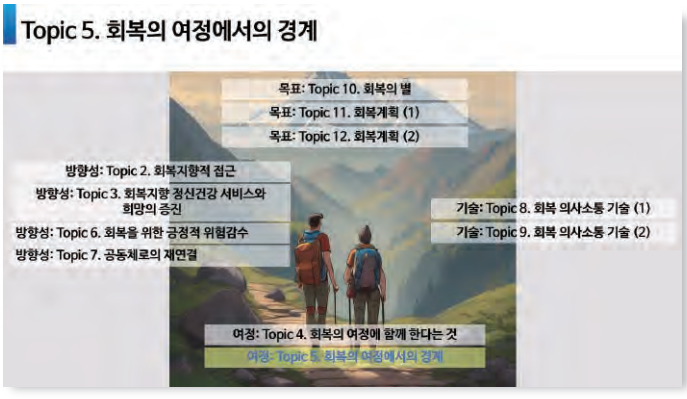


'함께'에 대한 오해 (5분)



지난 시간에는…





회복의 여정에서의 경계

활동내용

진행자는

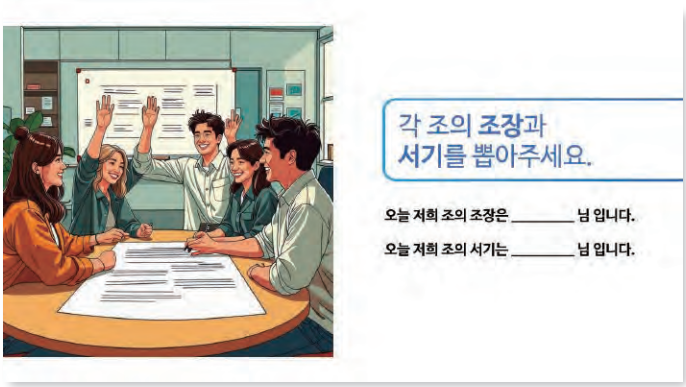
이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 도입



조장과 서기 선출

활동내용

진행자는
조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간을 줍니다.

만약 여전히 자발적인 참여자가 없다면, 진행자가 직접 조장을 정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

- 조장은 조별 활동을 주도하며 전체 흐름을 이끕니다.
- 서기는 토론 중에 나온 의견들을 큰 종이나 화이트보드 시트 등에 정리하여, 발표자가 발표할 때 참고할 수 있도록 합니다.
- 발표자는 발표가 필요한 토론 활동마다 조에서 자율적으로 정합니다.

활동단계 전개



출처: https://www.youtube.com/watch?v=sHTEAZlGsrY



활동내용

Q1. '경계'라는 말을 들으면 어떤 생각이 떠오르나요? (5분) 영상 시청 (2:37) '경계'에 대한 개념을 소개하는 영상입니다

진행자는
① 영상 시청에 앞서, 참여자들에게 '경계'라는 단어를 보고 떠오르는 생각이나 이미지를 자유롭게 나누어 달라고 안내합니다.
② 영상을 시청합니다.
③ 영상 시청 후에는, 참여자들이 이야기한 내용과 영상 속 내용을 통합하여 '경계'에 대해 정리·설명합니다.

진행자는
경계에 대한 충분한 브레인스토밍이 이루어졌다면, 이제 '회복의 여정에서 경계가 갖는 의미'에 대해 설명합니다.

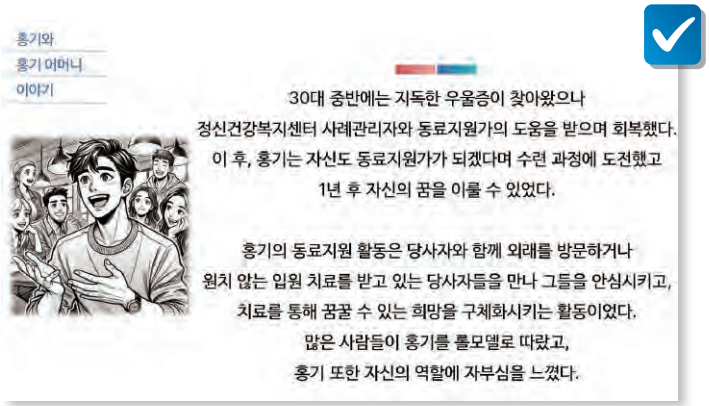
활동단계 전개



사례 설명- 홍기와 홍기 어머니 이야기

이야기 속의 홍기는 양극성 장애를 가진 당사자로, 여러 차례 재발을 경험한 인물입니다. 재발이 있을 때마다 홍기 어머니는 아들을 강제로 입원시킬 수밖에 없었고, 그 경험은 어머니에게도 깊은 상처로 남아 있습니다.

홍기는 자신의 치료에 지속적으로 간섭하려는 어머니가 답답하게 느껴지고, 어머니는 그동안 나름대로 참고 인내해 왔지만, 아들이 또다시 재발하자 더 이상 치료를 홍기에게만 맡길 수 없다는 다짐을 하게 되는 사례입니다.



사례. 홍기와 홍기 어머니 이야기



활동내용

진행자는

슬라이드에 제시된 삽화와 문장을 따라 읽으며, 참여자들에게 사례에 대한 흥미와 궁금증을 유발합니다.

Tips.

· 본 슬라이드만 보고 어떤 이야기일 것 같은 지 추측해 보자고 제안하며, 참여자들의 추측을 들어보는 것도 좋습니다.

· 부록 중 '사례 모음'에서 [홍기와 홍기 어머니 이야기]를 미리 출력하여 각 조마다 한 세트씩 제공하며, 이때 미리 사례를 읽어보지 않도록 뒤집어 놓습니다.

· 진행자가 사례를 읽기 시작할 때, 각 조마다 제공된 출력물을 함께 보자고 이야기합니다.

· 이후 사례와 관련된 토론 활동을 할 때도 자유롭게 출력물을 보면서 토론을 진행할 수 있습니다.

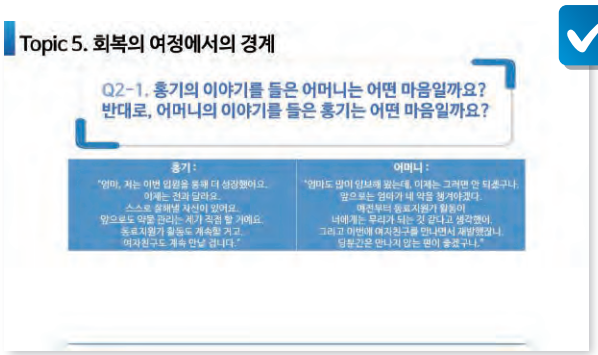
진행자는

슬라이드를 천천히 읽어 주며, 마치 구연 동화처럼 큰 따옴표 속의 대화와 작은 따옴표 속의 속마음을 실감 나게 표현합니다.

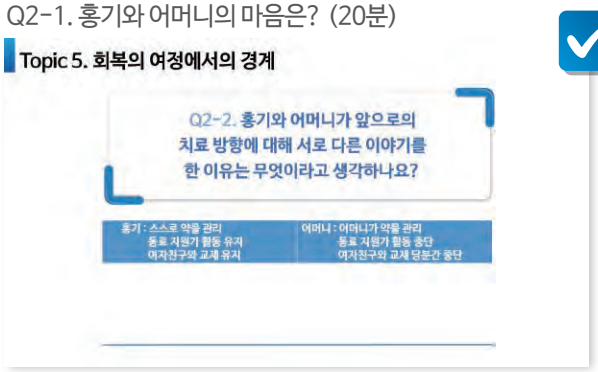
Tips.

몇몇 문장은 참여자 중 한 명에게 실감 나게 읽어 달라고 요청하여 사례에 대한 집중도를 높일 수 있습니다.

활동단계 전개



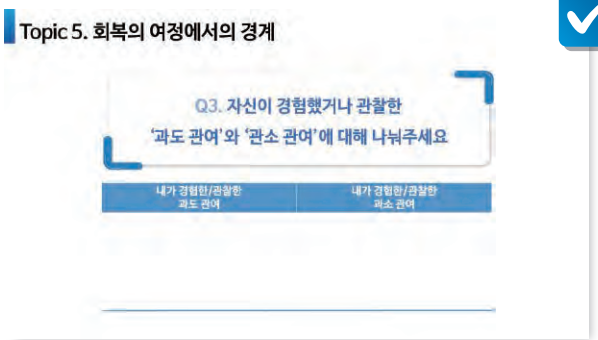
Q2-1. 홍기와 어머니의 마음은? (20분)



Q2-2. 홍기와 어머니의 치료 방향이 다른 이유 (20분)



과도 관여와 과소 관여 (10분)



Q3. 자신이 경험했거나 관찰한 '과도 관여'와 '과소 관여' (20분)

활동내용

진행자는

참여자들은 사례를 읽은 뒤, 홍기 어머니에 대해 부정적인 인식을 가질 수 있습니다. 따라서 조별 토론에 앞서, 진행자는 참여자들이 홍기 뿐 아니라 홍기 어머니의 입장에도 충분히 공감할 수 있도록 그 배경과 감정을 충분히 설명해 주는 것이 중요합니다.

Q2-1과 Q2-2는 한 번에 조별로 토론하고 발표합니다. 먼저 Q2-1에 초점을 맞추어, 퇴원을 앞둔 홍기와 홍기 어머니의 갈등 장면을 생생하게 읽어준 뒤, 참여자들이 홍기의 입장에서 그리고 홍기 어머니의 입장에서 각각 어떤 마음일지 헤아려볼 수 있도록 안내합니다. 그 다음, Q2-2 질문을 함께 읽고, 조별 토론을 시작하도록 안내합니다.

진행자는

발표 내용을 듣고 이를 교정하거나, 일방적인 강의 형식으로 진행하지 않도록 주의합니다. 진행자의 역할은 토론과 발표에 대해 격려를 전하고, 발표 내용을 요약하거나 중요 내용을 강조하며, 전달이 다소 어려웠던 부분을 전체 참여자가 이해할 수 있도록 명료하게 정리해주는 것입니다.

1부 끝 시간 부족 시

활동내용

진행자는

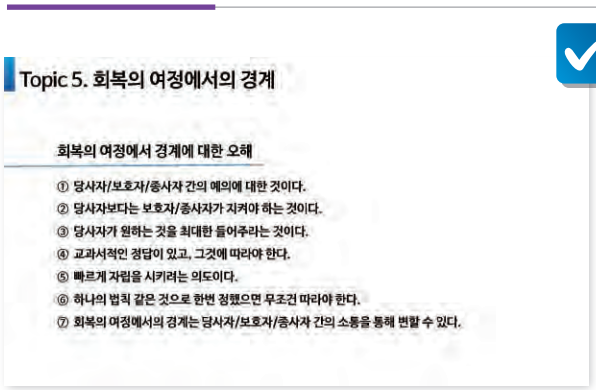
슬라이드에있는 '과도 관여'와 '관소 관여'에 대해 설명합니다.

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 7: Boundaries within the context of recovery practices)

진행자는

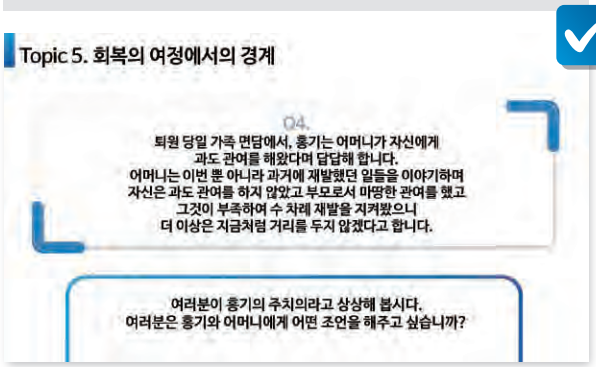
조별 토론에 앞서, 주제에 대한 부연 설명을 할 수 있습니다.
① 당사자는 자신이 경험한 '과도한 관여'와 '과소한 관여'에 대해 이야기할 수 있습니다.
② 보호자와 종사자는 자신이 했던 '과도한 관여'와 '과소한 관여'에 대해 이야기할 수 있습니다.

활동단계 전개

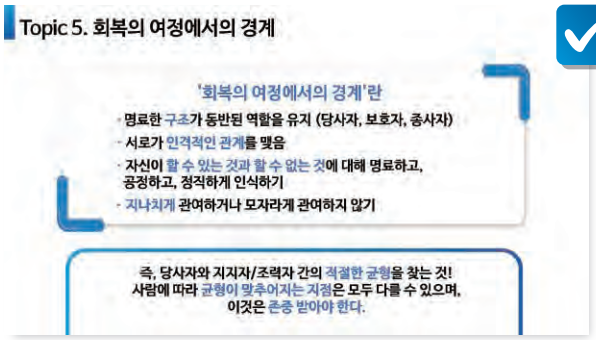


회복의 여정에서 경계에 대한 오해

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 7: Boundaries within the context of recovery practices)



Q4. 여러분이 홍기의 주치의라면? (30분)



회복의 여정에서의 경계란



회복의 여정에서의 경계란

활동내용

진행자는

슬라이드에 제시된 '회복의 여정에서 경계에 대한 오해'들을 함께 읽고, 그 의미를 설명합니다.

조별 토론에 앞서, 홍기와 홍기 어머니의 의견이 대립되었던 세 가지 주제에 대해 간단히 소개합니다.
① 약물 관리
② 동료지원가 활동
③ 여자친구 문제
위의 세 가지 주제에 대해 어떤 조언을 해주고 싶은 지 토론하도록 안내합니다. 또한, 이 외에도 홍기와 어머니에게 해주고 싶은 조언이 있다면 조 안에서 자유롭게 나눌 수 있도록 안내합니다.

슬라이드의 내용을 바탕으로, 회복의 여정에서 '경계'가 갖는 의미에 대해 설명합니다.

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 7: Boundaries within the context of recovery practices)

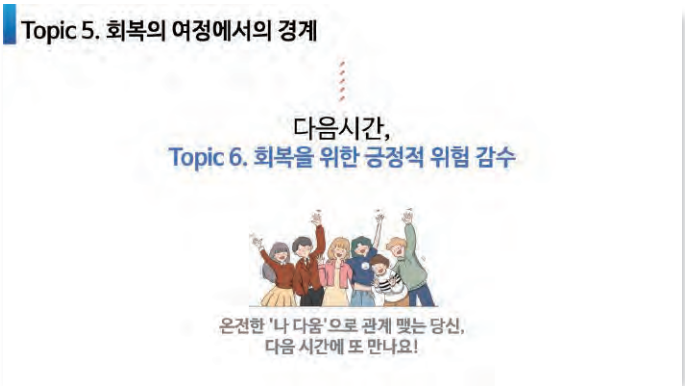
모든 관계에는 서로의 온전함을 지킬 수 있는 '적절한 거리'가 필요하며, 이 거리가 지켜지지 않으면 '나 다움'과 '너 다움' 모두가 훼손될 수 있음을 설명합니다.

활동단계 정리





모두 한마디!



다음 Topic 소개

활동내용

회복의 여정에서 '온전한 나'와 '온전한 너'를 가능하게 하는 경계가, 건강한 관계를 형성하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 설명합니다.

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.
- 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.
- 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 한마디씩을 듣는 시간을 꼭 지키는 것을 권장합니다.

Tips.
- 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
- 각 과마다 '3당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
- "온전한 '나 다움'으로 관계 맺는 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q2-1) 홍기와 어머니, 각자의 마음은 어떨까요?

1조

홍기의 마음
① 여자친구도 못 사귀고 동료지원가도 못 하게 하시고 부모님이 이해가 안 된다.
② 여자친구가 홍기님에게 회복에 도움이 될지 체크해 볼 것이다.
③ 부모님이 못하게 한 의도를 알기 때문에 홍기님은 부모님을 설득시킬 것이다.
④ 반감도 들고 부모 말을 들어야 겠다는 생각도 든다.

어머니의 마음
① 알고 있는 입장에서도 다시 챙겨주는 마음이다.
② 부모 입장에서 잠 자는 시간도 알려주거나 외래 진료를 앞당기는 것은 과도 관여라고 보기는 어렵다.
③ 일단은 극복(회복)은 되었다. 그런데 10번도 넘게 그 과정을 되풀이 했기 때문에 부모님 입장에서는 답을 찾지 못했다고 느낄 수 있다.

2조

홍기의 마음
① 믿고 기다려줘야 하지만, 굉장히 걱정이 돼서 자기 주장을 말할 것 같다.
② 또 입원을 하면 어쩌지 하는 불안감이 있을 것 같다. (최악의 상황에 대한 트라우마가 있기 때문...)
③ 계속 지켜볼 마음도 있을 것 같다.
④ 정말 잘할까 하는 의문이 들 것 같아.

어머니의 마음
① 자신을 믿고 기다려 달라는 말이 반항적인 태도로 이어질까 걱정된다.
② 홍기가 내 눈치를 많이 볼 것 같다.
③ 홍기가 자신의 의견을 들어주지 않아 슬플 것 같다.
④ 여러모로 고민이 많다. (동료지원가. 여자친구)

3조

홍기의 마음
① 불쾌하고, 자신에 대해 무기력을 느낀다.
② 분노의 감정을 느낀다.
② 부모님의 '기준이 확고하다'라고 생각할 것 같다.
③ 자포자기 할 것 같다.
④ 부모님의 말을 들어볼까? 라는 생각(부모의 의견을 고려해본 것 같음)
⑤ 부모님이 없으면 좋겠다. 독립하고 싶다.
⑥ 자기가 하고 싶은 대로 밀고 나갈 것 같다.

어머니의 마음
① 홍기에 대해 잘 알고있다.
② '그것봐. 내가 너에 대해 더 정확하게 알고 있잖아' 라고 생각하며 앞으로도 부모의 말을 따라야 한다고 생각할 것 같다.
③ 강가에 내놓은 아이처럼 불안한 것 같다.
④ 부모의 입장에서 잘못된 길로 갈까봐 걱정되고 괘씸하다.
⑤ 부모는 아이에 대해 다 알지 못한다.
⑥부모님은 아이를 위해 희생적인 것 같다.
⑦ 다시 입원하게 않도록 다른 방법들을 강구해볼 것 같다.
⑧ 주치의를 통해서 여자친구를 만나지 않도록 요구할 것 같다.

06 Topic 6. 회복을 위한 긍정적 위험감수



핵심목표

어떠한 긍정적 위험감수를 할 지 한 가지 이상 말할 수 있다.

핵심질문

① 위험감수는 피해야 할까요?

'한나와 한나 어머니'의 이야기를 통해, 정신질환 당사자에게 긍정적인 위험 감수가 무엇을 의미하는지 이해한다.

② 긍정적 위험감수를 위해서 필요한 것은?

핵심내용

① 긍정적 위험 감수는 특별한 사건이 아니라, 우리 삶의 일상입니다.

② '나다움'의 회복을 위해서는 긍정적 위험 감수가 필요합니다.

③ 위험 감수를 단순히 '선택의 결과'로 오해해서는 안 됩니다.

④ 긍정적 위험 감수는 회복의 주인공인 당사자에게 초점을 맞추어 가는 '과정 전체'를 의미합니다.

⑤ 당사자, 보호자, 종사자 모두가 자산·강점 기반 접근을 하는 것이 필요하다.

영상

CGN SOON, 나는 언제나 너를 선택한다 어떤 이가 세상을 다 준다 해도 (4:01)

Tips. 상황에 따라 진행자가 영상 시청 없이 내용을 요약하여 전달할 수 있습니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 '사례 모음' 중 [한나와 한나 어머니 이야기]
  각 조마다 한 세트씩 출력본을 준비해 둡니다.
- ☐ 프로그램 환경조성
  - 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 조별활동 책상배치
  - 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다.
    이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

참·고·사·항

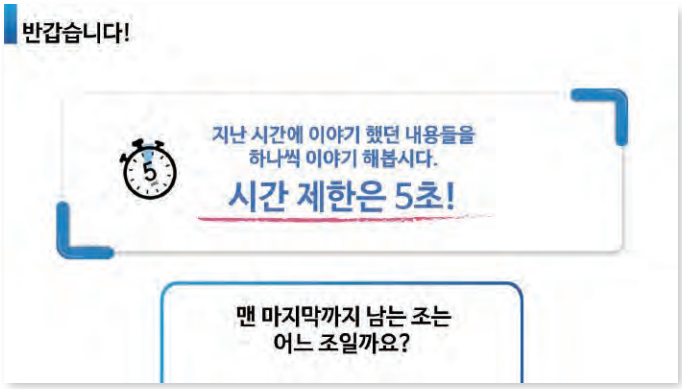
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

2. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 110분 입니다.**

활동단계 도입

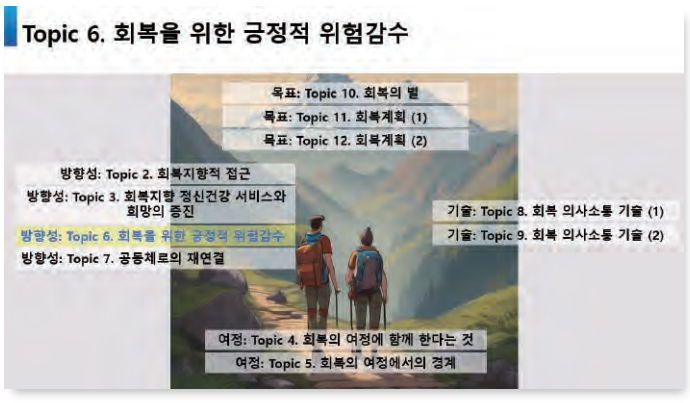


이어말하기 게임



지난 시간에는…





회복을 위한 긍정적 위험감수

활동내용

진행자는

이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

진행자는

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 도입



조장과 서기 선출를 진행합니다.

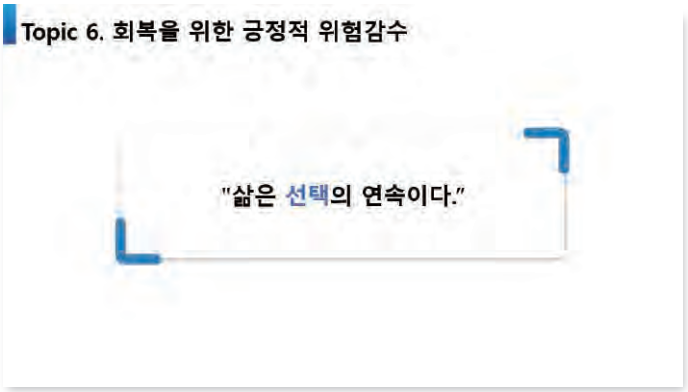
활동내용

진행자는

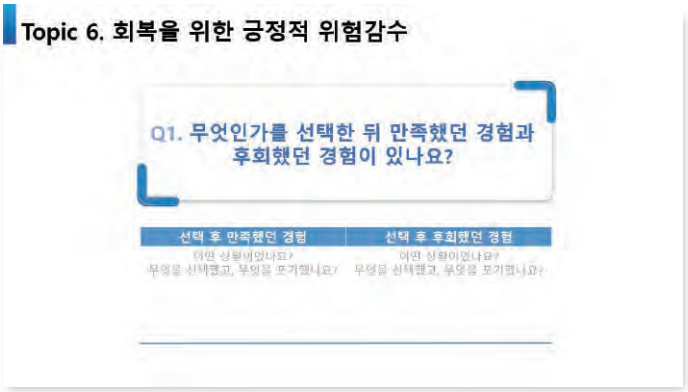
조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간 (보통 3분 이내)을 줍니다. 만약 여전히 자발적인 참여자가 없다면, 진행자가 직접 조장을 정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

- 조장은 조별 활동을 주도하며 전체 흐름을 이끕니다.
- 서기는 토론 중에 나온 의견들을 큰 종이나 화이트보드 시트 등에 정리하여, 발표자가 발표할 때 참고할 수 있도록 합니다.
- 발표자는 발표가 필요한 토론 활동마다 조에서 자율적으로 정합니다.

활동단계 전개



삶은 선택의 연속이다.



Q1 선택과 후회의 경험 (20분) 앞선 브레인스토밍과 연결된 질문입니다.

활동내용

진행자는 익숙한 문장을 활용하여 오늘의 주제인 '긍정적 위험 감수'에 대한 흥미를 유도하고, 이를 바탕으로 브레인스토밍을 진행합니다.

조장의 진행에 따라, 각 조는 '선택 후 만족했던 경험'과 ' 선택 후 후회했던 경험'에 대해 이야기를 나눕니다.

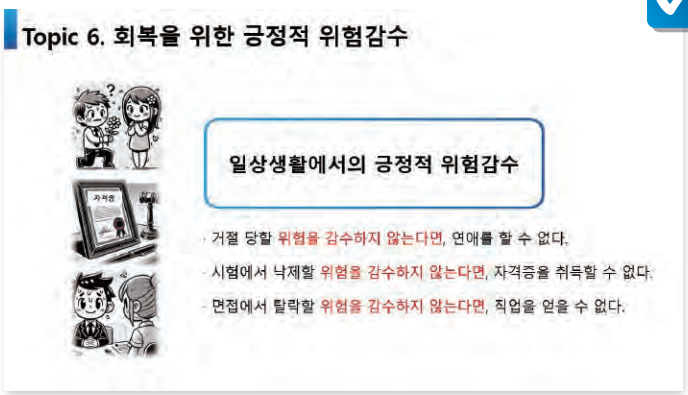
이후, 발표자를 정해 조별로 이야기한 내용을 전체 참여자에게 발표합니다.

활동단계 전개



선택은 곧 위험감수(Risk taking)이다..

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 8: Positive risks in recovery)



일상생활에서의 긍정적 위험감수[13), 22), 23)]

활동내용

"무언가를 선택한다는 것은, 필연적으로 선택하지 않은 다른 것을 포기한다는 것을 의미합니다."

"따라서, 삶은 선택의 연속이고, 선택은 위험감수이니 삶은 위험감수의 연속이라는 말과 같습니다. "

"우리는 늘 두 종류의 위험감수를 하며 살아갑니다.
첫 번째, 부정적 위험감수 두 번째, 긍정적 위험감수."

위험감수라는 단어는 우리에게 잘 와닿지 않습니다.

진행자는 이해도에 따라 위험감수에 대한 구체적인 예시를 제공합니다.

활동단계 전개



사례 설명

한나와 한나 어머니 이야기

이야기 속의 한나는 주요우울장애를 가진 당사자입니다.
과거 동물병원에서 일하던 중, 돌보던 동물이 죽은 사건을 계기로
병이 발병했습니다. 이 사실을 잘 알고 있는 한나의 어머니는,
한나가 다시 동물과 관련된 일을 하려고 하자 이를 말리고 싶어합니다.
그러나 자신의 말을 한나가 듣지 않는다는 것을 알게 되자,
센터 사례관리자인 설희에게 부탁이자 경고의 의미로 개입을
요청하는 사례입니다.

활동내용

진행자는

슬라이드에 제시된 삽화와 문장을 따라 읽으며, 참여자들에게 사례에 대한 흥미와 궁금증을 유발합니다.

[한나와 한나 어머니 이야기]는 사례 중간에 Q2, Q3, Q4에 대한 조별 토론 활동이 포함되어 있으며, 이후 다시 사례가 이어집니다.

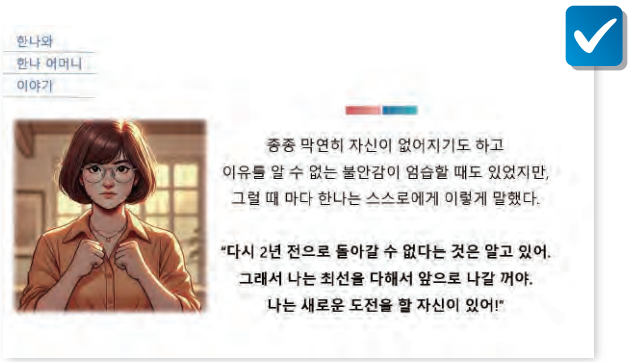
Tips.

· 본 슬라이드만 보고 어떤 이야기일 것 같은 지 추측해 보자고 제안하며, 참여자들의 추측을 들어보는 것도 좋습니다.

· 부록 중 '사례 모음'에서 한나와 한나 어머니 이야기를 미리 출력하여 각 조마다 한 세트씩 제공하며, 이때 미리 사례를 읽어보지 않도록 뒤집어 놓습니다.

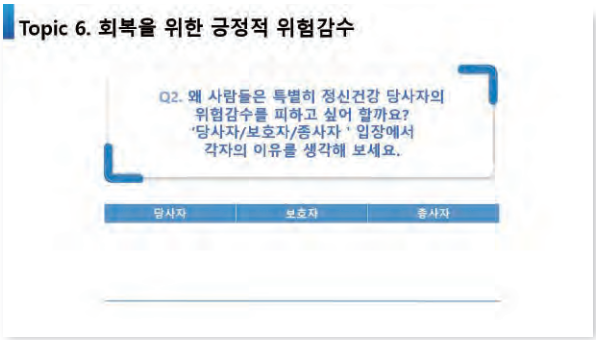
· 진행자가 사례를 읽기 시작할 때, 각 조마다 제공된 출력물을 함께 보자고 이야기합니다. 이후 사례와 관련된 토론 활동을 할 때도 자유롭게 출력물을 보면서 토론을 진행할 수 있습니다.

활동단계 전개



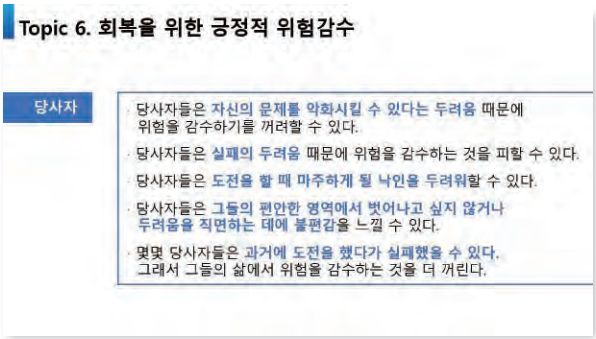
사례. 한나와 한나 어머니 이야기





Q2. 정신건강 당사자의 위험감수를 피하고 싶어하는 이유는? (30분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 8: Positive risks in recovery)





활동내용

진행자는

슬라이드를 천천히 읽어 주며, 마치 구연 동화처럼 큰 따옴표 속의 대화와 작은 따옴표 속의 속마음을 실감 나게 표현합니다.

Tips.

몇몇 문장은 참여자 중 한 명에게 실감 나게 읽어 달라고 요청하여 사례에 대한 집중도를 높일 수 있습니다.

한나와 한나 어머니의 사례를 바탕으로, 당사자, 보호자, 종사자의 입장에서 정신건강 당사자의 '위험 감수'를 피하고 싶어하는 이유에 대해 조별로 토론합니다.

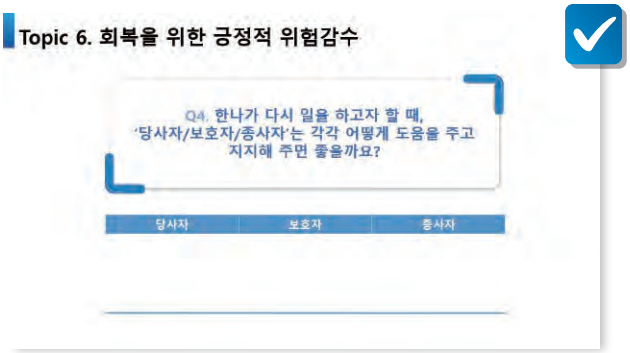
토론 후, 각 조에서 선정된 발표자가 조별 논의 내용을 전체 참여자에게 발표하도록 안내합니다.

슬라이드의 내용을 통해 당사자의 위험감수를 피하려는 당사자/보호자/종사자의 이유를 설명합니다.

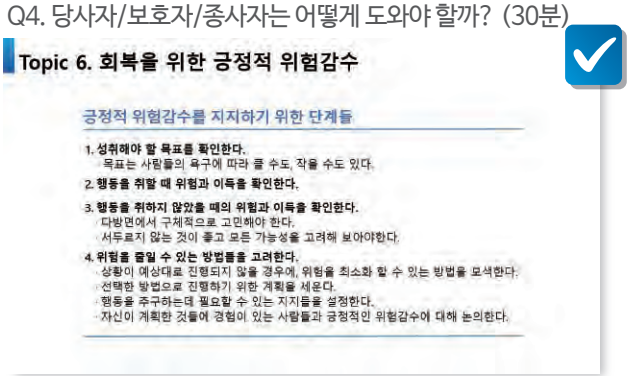
1부 끝 시간 부족 시

활동단계 전개





Q4. 당사자/보호자/종사자는 어떻게 도와야 할까? (30분)



긍정적 위험감수를 지지하기 위한 단계들 Q4를 정리하는 슬라이드 입니다.



Q4. 당사자/보호자/종사자는 어떻게 도와야 할까? (30분)

활동내용

진행자는

'한나가 다시 일을 시작하는 경우'와 '조금 더 쉬는 경우' 각각에 대해, 어떤 이점과 위험이 있는지 조별로 토론하고 정리한 뒤 전체 참여자에게 발표하도록 안내합니다.

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 8: Positive risks in recovery)

진행자는

다시 일을 하기로 결정한 상황이라면, 당사자, 보호자, 종사자가 어떻게 조력하고 지지할 수 있을지 조별로 토론하도록 합니다. 이때, 익숙한 결손 기반 접근 뿐 아니라 강점/자산 기반 접근을 고려하여 토의 및 발표하라고 안내합니다.

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 8: Positive risks in recovery)

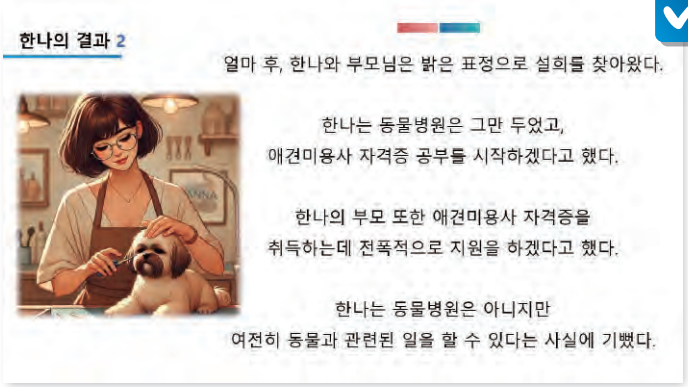
진행자는 해당 내용을 설명합니다.

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 8: Positive risks in recovery)

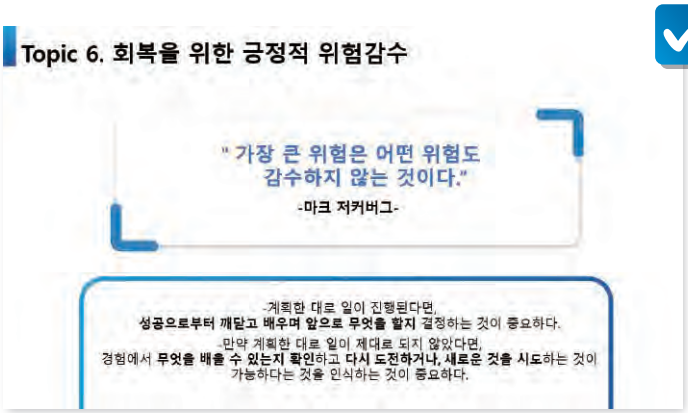
진행자는 다시 한나와 한나 어머니의 사례로 돌아가 보자고 제안합니다.

'결과 1'은 한나가 바라는 최상의 시나리오입니다.

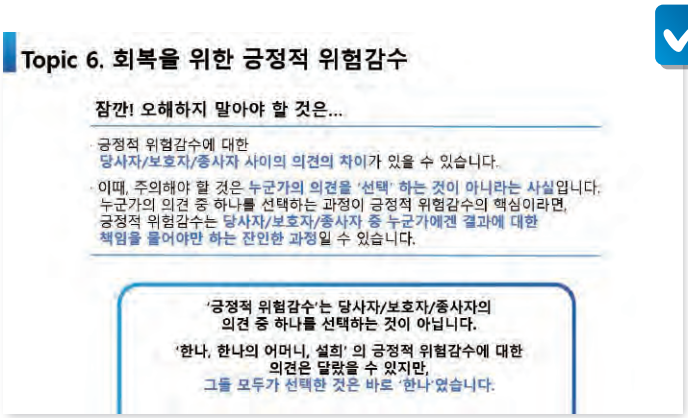
활동단계 전개



사례. 한나와 한나 어머니 이야기 (결과 2)



가장 큰 위험은 어떤 위험도 감수하지 않는 것이다.



잠깐 오해하지 말아야 할 것은…

활동내용

진행자는
삶이 언제나 예측한 대로 흘러가지 않을 수 있다는 점을 언급하며, '결과 2'를 읽어줍니다.

'결과 2'에서는, 한나가 한 달도 되지 않아 그만두기를 결심할 정도로 적응에 어려움을 겪습니다.

그러나 자신의 회복을 지지해주는 설희와 가족들 덕분에, 한나는 다시 용기를 내어 새로운 도전에 나서고, 처음부터 원했던 것처럼 동물과 관련된 일을 이어가게 됩니다.

진행자는
"우리는 삶에서 위험을 감수하지 않을 수 없습니다.

위험을 감수한 결과, 원하지 않았거나 예측하지 못한 상황에 처할 수도 있습니다."
"그래서 우리는 종종, 그런 상황이 올까 두려워하며 망설이곤 합니다. "

"하지만, 가장 큰 위험은 어떤 위험도 감수하지 않는 것입니다."

진행자는
"긍정적 위험 감수는 당사자·보호자·종사자가 힘을 모아 가장 합리적인 결정을 내리는 것이라고 오해할 수 있습니다."

"하지만 우리는 미래를 알 수 없기 때문에, 아무리 합리적인 결정을 내렸다고 해도 원치 않는 결과를 마주할 수 있습니다."

"긍정적 위험 감수는 '회복의 주인공'인 당사자에게 초점을 맞추고, 당사자/보호자/종사자가 함께 선택하고 경험해 나가는 과정 전체를 의미합니다."

활동단계 정리

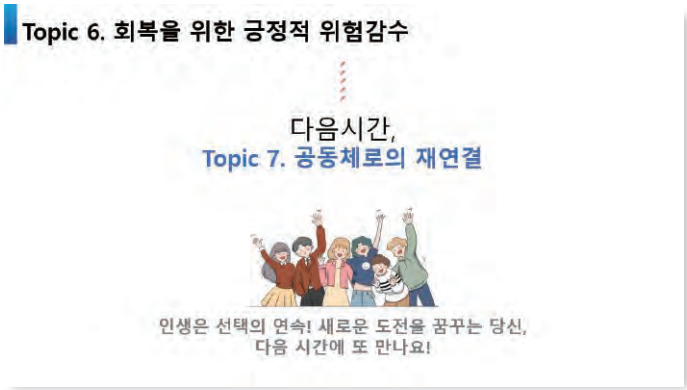


영상 시청 (4:01)
어떤 상황에서도, 어떤 조건에서도 사랑하는 사람을 선택하겠다는 내용의 영상을 시청합니다.

출처: https://www.youtube.com/watch?v=gjC03eCgkvw



모두 한마디



다음 Topic 소개

활동내용

Tips
· 이 영상은 부모의 아가페적 사랑을 표현하고 있습니다.

· 영상을 보기 전에, 의견이 다르고 종종 부딪히기도 하지만, 어떤 상황에서도 어떤 조건에서도 서로를 선택하는 가족을 떠올리며 감상해 보자고 안내하면, 영상의 메시지가 더욱 깊이 있게 다가올 수 있습니다.

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.
· 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.

· 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 이야기를 한마디씩 듣는 시간을 가지는 것을 권장합니다.

Tips.
· 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.

· 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.

· "인생은 선택의 연속! 새로운 도전을 꿈꾸는 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

06 Topic 6. 회복을 위한 긍정적 위험감수

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q2. 왜 사람들은 특별히 정신건강 당사자의 위험감수를 피하고 싶어 할까요?

1조

당사자
① 타인의 편견 (낙인). 자신의 부족한 모습 노출에 대한 두려움
② 생활환경의 적응 어려움. 지나친 안정감 추구(현실 안주)
③ 두려움 (실수에 대한), 적응실패

보호자
① 추가적인 상처로 인한 재발/악화 우려
② 당사자에 대해 책임을 져야 하는 (가족) 부담
③ 다른 가족에게 미치는 영향 (안정된 분위기 붕괴 우려)

종사자
① 소송으로의 위험과 같은 위험감수 피하기 위함, 책임의 무게
② 고민으로 인한 결정 지연. 말 한마디의 무게(책임). 비협조적인 태도(당사자)
③ 회복의 기준이 다름 (의사소통 부족)

2조

당사자
① 상황이 주는 스트레스를 못 버틸 것 같아서
② 실패에 대한 두려움 때문에, 재발할까 봐

보호자
① 상대방에게 피해를 줄까 봐 (과거 재발의 경험) + 위협이 될까 봐

종사자
① 부정적인 사회적 인식 때문에
② 긍정적이 아니라 부정적 위험감수가 될까 봐
③ 회복의 과정에서 위험감수로 자존감이 낮아질까 봐

06 Topic 6. 회복을 위한 긍정적 위험감수

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q3. 한나가 다시 일을 하는 것과 조금 더 쉬는 것의 이득과 위험은 무엇인가요?

1조

	이 득	위 험
다시 일을 하는 것	· 새로운 관계 형성 · 갈 곳이 생기는 것 · 가족들의 여유시간 · 자립심, 독립준비 · 자신감이 생김	· 재발 (스트레스) · 사회적 인식으로 인한 차별 · 일을 못하면 오히려 자신감 감소 · 신체적으로 다칠까 봐
조금 더 쉬는 것	· 체력 충전 · 정신적인 안정 · 미래를 계획할 수 있는 여유 · 가족들의 안도감 (위험에 노출되지 않아서)	· 재발 (스트레스, 무기력, 우울) → 일을 할 수 있는데 못하고 있다는 점에서 · 우울감과 불안감이 강해짐 · 현실에 안주하는 것 (똑같지 않고 다른 삶을 사는 것에 대한 부담감)

2조

	이 득	위 험
다시 일을 하는 것	· 성취감 · 소속감으로 인한 안정감 · 자아정체성 증진/자아실현 · 경제적 이득 (돈) · 가족의 행복, 건강해짐 · 인간관계 기술, 사회성 증진 · 독립성 증진(내돈 내산) / 자율성 상승	· 스트레스로 인한 재발 · 해고나 권고사직의 위험. · 주변의 시선/편견의 스트레스 · 타인의 시선으로 인한 약물 관리 어려움. (복용누락) · 타인과 관계 (직장동료) 스트레스
조금 더 쉬는 것	· 현상유지에 대한 안정감 (재발되지 않음의 안정감) · 정서적 안정감 · 가족 간 대화 시간. 유대감 증진 · 충분한 준비 기간 확보 · 더 회복이 될 수 있음 (치료 집중)	· 무료함 · 권태감(열정감소) · 도태에 대한 불안 · 단절감 · 조급함/불안함 · 독립성 저하 , 의존성 증가

06 Topic 6. 회복을 위한 긍정적 위험감수

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q4. 한나가 다시 일을 하고자 할 때, '당사자/보호자/종사자'는 각각 어떻게 도움을 주고 지지해 주면 좋을까요?

1조

당사자
① 스스로에게 격려/용기줌 , 건강관리 신경쓰기
② 일기쓰기(자기객관화/성찰). 약물 스케줄 구체적으로 관리
③ 자신만의 스트레스 관리법 마련, 운동, 걱정시간 정하기
④ 나만의 좌우명 정하기

보호자
① 당사자에 대한 정서적지지 (스트레스 해소 통로)
② 건강 챙겨줌. 보호자의 입장 충분히 전달 (구체적인 가이드라인 제시)
③ 스트레스 요인/상황 미리 교육 (경험 공유). 충분한/구체격인 사례 통한 교육(대처교육)
④ 경청/위로 공감 (심리적 안전기지 = 가족)

종사자
① 직업재활프로그램(Ex.인턴) 추천. 재발징후교육
② 그에 대한 대처교육. 동료 지원가/같은 경험자 멘토 연결
③ 사회적인 제도에 대한 다양한 정보 제공

2조

당사자
① 좋아하는 일을 하고 싶다 , 심리적 지원

보호자
① 물질적 지원, 심리적 지원 → 지지와 응원의 말을 많이 해주기
② 약물복용 가이드, 사회적 질서 교육(조직 안에서)
③ 좋은 글귀로 하루를 시작해라 (성경.등)
④ 일기를 쓰도록 할 것 (자신을 되돌아보는 시간)

종사자
① 증상이 있을 때 대처방법 알려주기 (도움을 받을 수 있는 곳)
② 직업의 방향성. 앞으로의 계획 같이 수립하기
③ 좋아하고 잘하는 것에 대한 직업 연계하기

07 Topic 7. 공동체로의 재연결



핵심목표

내가 원하는 공동체를 한 가지 이상 고민하여 말할 수 있다.

핵심질문

① 공동체란?

자신이 생각하는 또는 실제로 경험한 공동체에 대해 이야기 한다. 기원이 사례를 통해, 당사자가 공동체와의 연결을 잃게 되는 원인에 대해 살펴본다.

② 자기감의 회복을 위해 왜 공동체로의 재연결이 필요한가?

자아의 경계 개념을 바탕으로 이유를 이해한다. 당사자가 공동체와 다시 연결될 수 있도록, 지지자들이 어떤 도움을 줄 수 있을지에 대해 이야기한다.

핵심내용

① 자기감의 회복을 위해 공동체로의 재연결은 필수적입니다.

② 그러나 당사자에게 공동체로 다시 연결되는 과정은 외부적·내부적 장애물과 과거 대인관계에서의 상처로 인해 매우 조심스럽게 접근해야 하는 주제입니다.

③ 어떤 활동이 당사자에게 효과적이고 실제로 도움이 되는 공동체 재연결의 방식일지, 당사자와 지지자, 종사자가 함께 고민해 봅니다.

영상 ① KBS추적, [J컷]'안인득=정신병'으로 낙인 찍은 후 우리가 놓친 것 (1:55)

② 샘튜브, [영화리뷰] 정신장애 당사자가 바라본 정신건강 영화, 솔로이스트 2 (7:22)

Tips. 상황에 따라 진행자가 영상 시청 없이 내용을 요약하여 전달할 수 있습니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 '사례 모음' 중 [한나와 한나 어머니 이야기]
  각 조마다 한 세트씩 출력본을 준비해 둡니다.
- ☐ 프로그램 환경조성
  - · 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - · 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 조별활동 책상배치
  - · 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배정합니다.
    이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

참·고·사·항

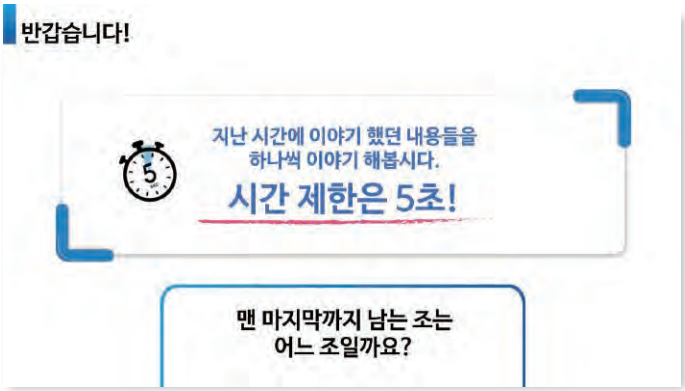
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

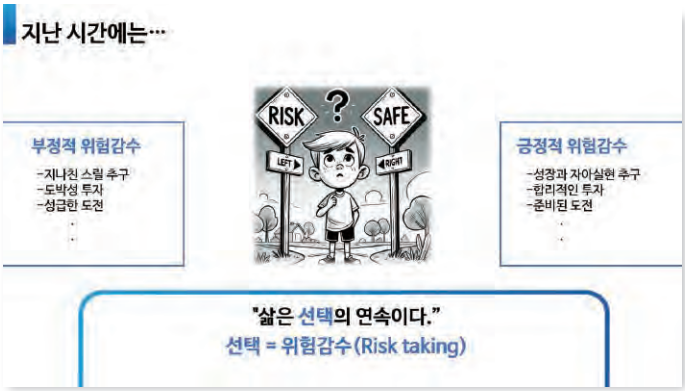
2. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 150분 입니다.**

활동단계 도입

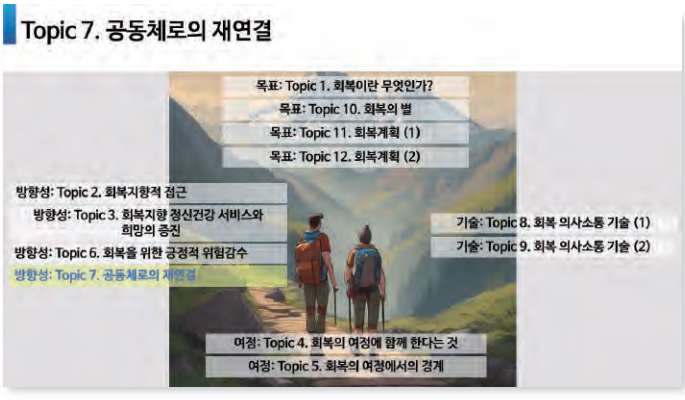


이어말하기 게임



지난 시간에는…





공동체로의 재연결

활동내용

이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 도입



조장과 서기 선출

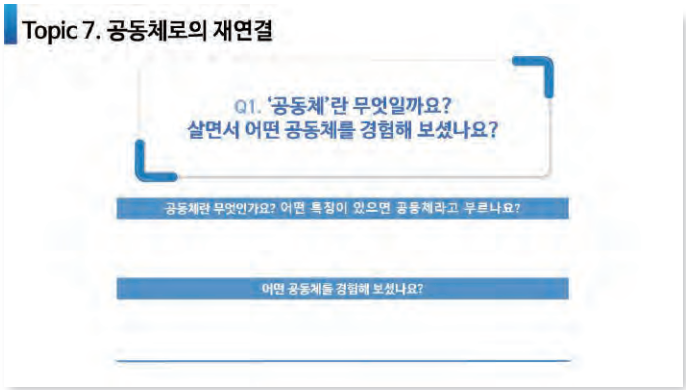
활동내용

진행자는
조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간을 줍니다.

만약 여전히 자발적인 참여자가 없다면, 진행자가 직접 조장을 정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

- 조장은 조별 활동을 주도하며 전체 흐름을 이끕니다.
- 서기는 토론 중에 나온 의견들을 큰 종이나 화이트보드 시트 등에 정리하여, 발표자가 발표할 때 참고할 수 있도록 합니다.
- 발표자는 발표가 필요한 토론 활동마다 조에서 자율적으로 정합니다.

활동단계 전개



Q1. '공동체'란 무엇인가? (20분)

활동내용

자신이 경험해본 공동체에 대해 이야기하며, 오늘의 주제인 '공동체로의 재연결'에 대한 브레인스토밍을 진행합니다.

진행자는 이 질문은 조별 토론 후 발표하는 방식으로 진행해도 좋고, 조별 토론 없이 진행자의 진행에 따라 참여자들이 손을 들어 자유롭게 자신의 생각을 나누는 방식으로도 진행할 수 있습니다.

활동단계 전개

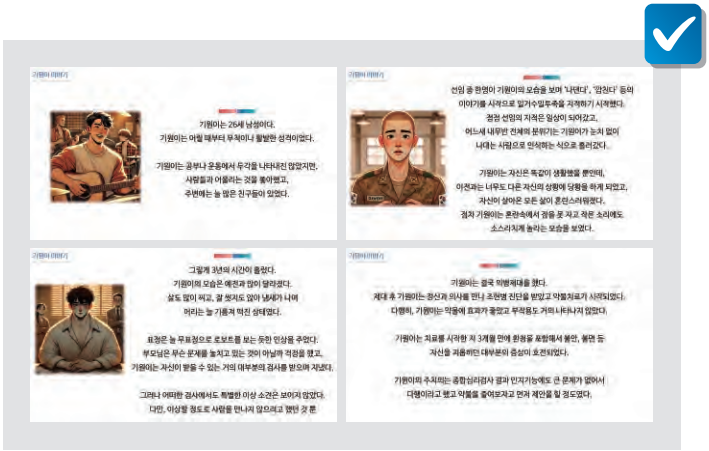


사례 설명

기원이 이야기

이야기 속의 기원이는 발병 이전에는 매우 활발한 성격으로, 주변에 늘 많은 친구들이 있었습니다. 하지만 군 복무 중 정신질환이 발병한 이후, 외부와의 연결을 끊고 혼자 지내기 시작합니다. 다행히 약물 치료로 환청을 포함한 증상은 빠르게 호전되었지만, 수년이 지난 지금까지도 기원이는 혼자 지내며, 그런 삶을 스스로 합리화하고 있습니다.

더 이상 뚜렷한 증상은 없지만, 기원이는 그 어느 때보다도 회복이 필요한 상태에 있는 사례입니다.



활동내용

진행자는

슬라이드에 제시된 삽화와 문장을 따라 읽으며, 참여자들에게 사례에 대한 흥미와 궁금증을 유발합니다.

Tips.

본 슬라이드만 보고 어떤 이야기일 것 같은 지 추측해 보자고 제안하며, 참여자들의 추측을 들어보는 것도 좋습니다.

부록 중 '사례 모음'에서 기원이 이야기를 미리 출력하여 각 조마다 한 세트씩 제공하며, 이때 미리 사례를 읽어보지 않도록 뒤집어 놓습니다.

진행자가 사례를 읽기 시작할 때, 각 조마다 제공된 출력물을 함께 보자고 이야기합니다.

이후 사례와 관련된 토론 활동을 할 때도 자유롭게 출력물을 보면서 토론을 진행할 수 있습니다.

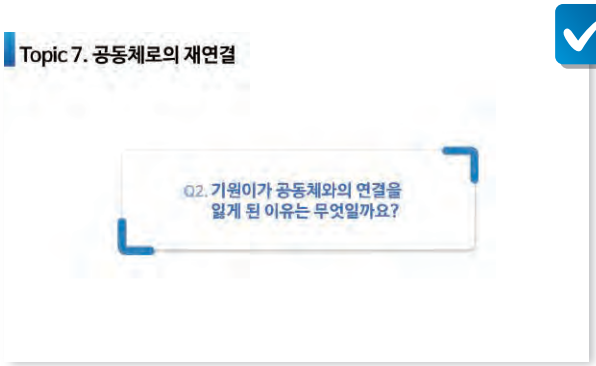
진행자는

슬라이드를 천천히 읽어 주며, 마치 구연 동화처럼 큰 따옴표 속의 대화와 작은 따옴표 속의 속마음을 실감 나게 표현합니다.

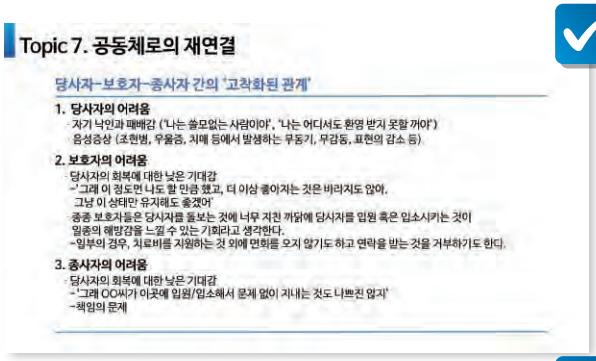
Tips.

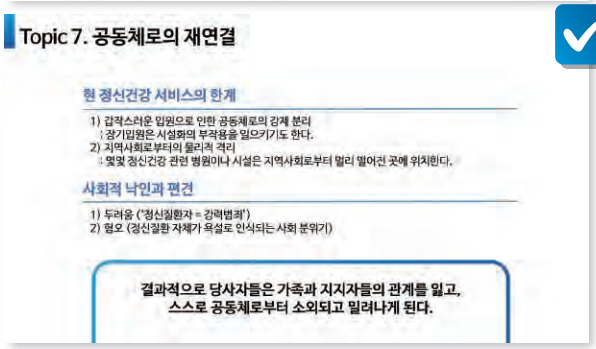
몇몇 문장은 참여자 중 한 명에게 실감 나게 읽어 달라고 요청하여 사례에 대한 집중도를 높일 수 있습니다.

활동단계 전개



Q2. 기원이가 공동체와의 연결을 잃게 된 이유는? (20분)





Q2. 기원이가 공동체와의 연결을 잃게 된 이유는? (20분)



영상 시청 (1:55)

활동내용

진행자는

'기원이 이야기'를 중심으로 조별 토론을 진행한 뒤, 각 조에서 발표자를 정해 전체 참여자에게 토론 내용을 발표하도록 안내합니다.

진행자는

Q2 토론 및 발표에 이어, 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에서 제시하고 있는 당사자가 공동체와의 연결을 잃게 된 이유를 설명합니다.

① 당사자-보호자-종사자 간의 '고착화된 관계'
② 현 정신건강 서비스의 한계
③ 사회적 낙인과 편견

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 9: Supporting people to reconnect with their communities)

Tips.

당사자·보호자·종사자 간의 '고착화된 관계'는, 각자의 입장과 상황으로 인해 당사자의 치료 목표가 표면적으로는 합의된 것처럼 유지되지만, 실제로는 성장이나 변화 없이 멈춰 있는 정체된 상태를 의미합니다.

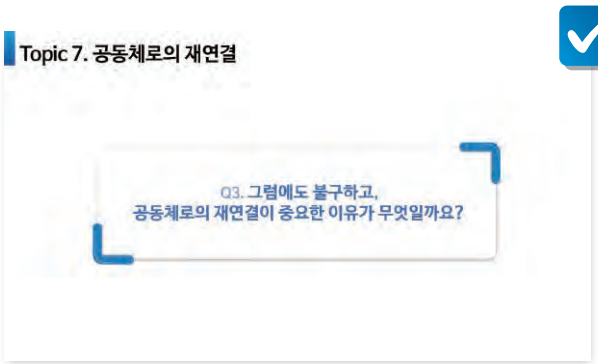
참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 9: Supporting people to reconnect with their communities)

진행자는

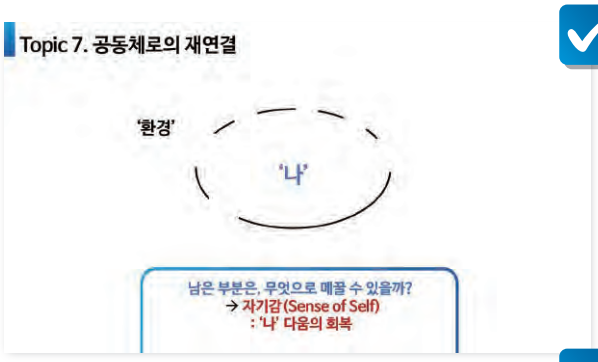
앞 슬라이드에 이어, 실제로 당사자가 겪는 사회적 낙인과 편견에 대해 살펴봅니다.

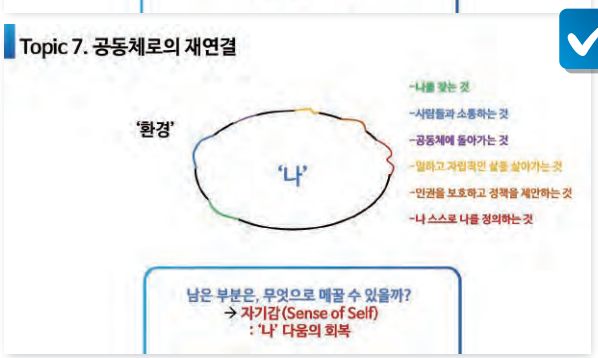
출처: https://www.youtube.com/watch?v=tp0QO7PiuAo

활동단계 전개

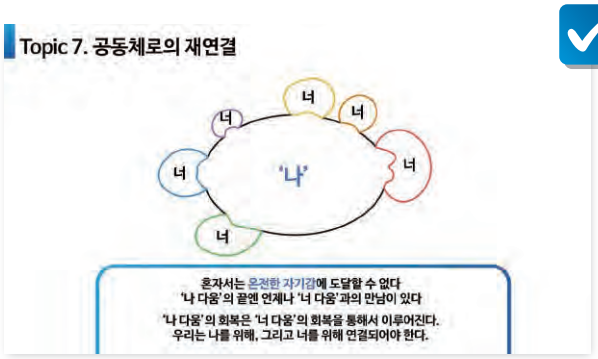


Q3. 그럼에도 불구하고, 공동체로의 재연결이 중요한 이유는? (20분)





자기감의 회복을 위해 필수적인, 공동체와의 재연결 (10분) [24)-26)]
오늘 주제에서 가장 중요한 내용을 담고 있는 핵심 슬라이드들 입니다.



활동내용

진행자는
앞에서 살펴본 여러 어려움에도 불구하고, 당사자의 회복 과정에서 공동체로의 재연결이 왜 중요한지에 대해 조별로 토론하도록 안내합니다.

토론 후에는 각 조에서 발표자를 정해, 모든 참여자들 앞에서 논의한 내용을 발표하도록 안내합니다.

진행자는
참가자들에게 '퀄리티라이츠 리커버리 프로그램' 초반부에서 다뤘던 '자아의 경계'와 '자기감의 회복'에 대해 다시 상기시킵니다.

무너진 자아의 경계는 나를 찾고, 사람들과 소통하며, 공동체로 돌아가고, 직업 생활을 영위하며, 나와 이웃의 인권을 보호하고 정책을 제안하는 것, 그리고 나 스스로를 정의하는 과정을 통해 회복될 수 있었습니다.

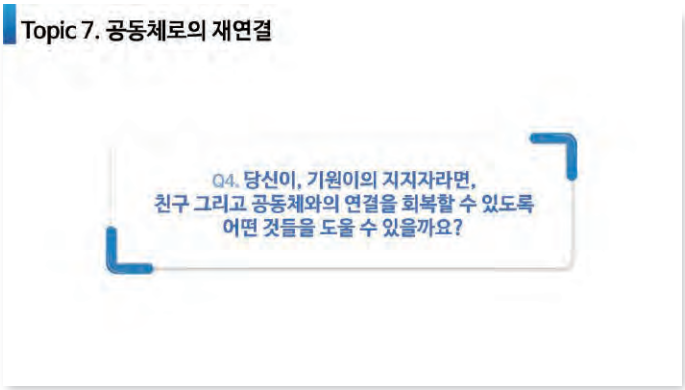
우리는 이 과정을 '나다움'의 회복이라고 불렀습니다.

애니메이션 효과 활용 → 클릭 (다음 슬라이드로 이동)

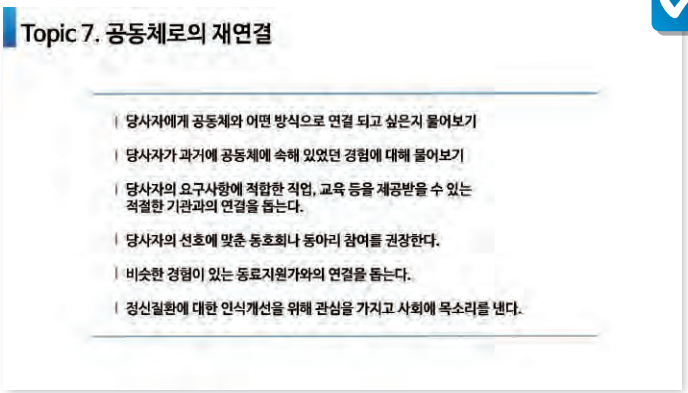
사실, '나'에 집중되어 있던 이 그림의 완성된 모습은,
'나 다움'의 회복이 나 혼자 이룬 것이 아니라
'너'와의 연결을 통해 이루어진 것임을 보여줍니다.

1부 끝 시간 부족 시

활동단계 전개

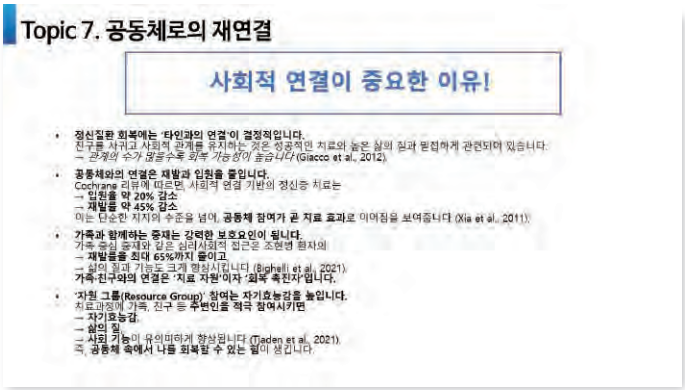


Q4. 기원이가 공동체와 다시 연결될 수 있도록, 지지자로서 어떤 도움을 줄 수 있을까요? (20분)



지지자로서 어떤 도움을 줄 수 있을지 설명합니다.

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 9: Supporting people to reconnect with their communities)



사회적 연결이 중요한 임상적인 근거들 [27)-31)]

활동내용

진행자는

기원이의 사례를 바탕으로, 조별로 '지지자로서' 어떤 구체적인 도움을 줄 수 있을지에 대해 토론하도록 안내합니다.

토론 후에는 각 조에서 발표자를 정해, 모든 참여자들 앞에서 논의한 내용을 발표하도록 안내합니다.

Q4 토론 및 발표에 이어, 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에서 제안하는 당사자의 '공동체로의 재연결'을 위한 지지자의 지원 방법을 설명합니다.

진행자는

공동체로의 재연결이 왜 중요한지를 보여주는 임상적 근거들을 소개합니다.

활동단계 정리

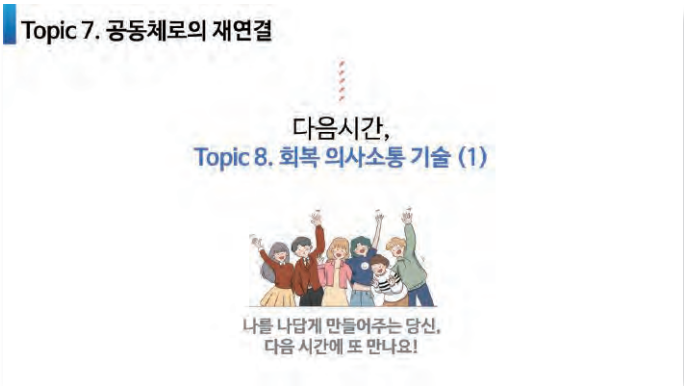


영상 시청 (7:22)

출처: https://www.youtube.com/watch?v=zVcHtxEn4p4



모두 한마디



다음 Topic 소개

활동내용

진행자는

영상 시청에 앞서, 간단한 배경 설명이나 참여자의 흥미를 끌 수 있는 이야기를 나눌 수 있습니다.

영상 시청 후에는, 정신장애 당사자가 직접 제작한 영화 리뷰를 통해 공동체로의 재연결이 왜 중요한지, 그 필요성에 대해 설명합니다.

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.

· 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.
· 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 이야기를 한마디씩 듣는 시간을 가지는 것을 권장합니다.

Tips.

· 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
· 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
· "나를 나답게 만들어주는 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q1. 공동체란 무엇일까요? 어떤 공동체를 경험해 보셨나요?

1조

공동체란? ① 목표가 같은 집단 (교회(종교), 동아리 (취미))
② 같은 업무와 목표를 추구하는 집단 (직장, 학교, 나눔 공동체)
③ 주기적. 계획적으로 모임을 가지는 집단 (규칙이 있는 집단)
④ 상호작용을 하는 관계 (교제, 삶에 대한 나눔)

어떤 공동체를 경험했나?
① 교회 – 아들 (기독교 고등학교), 신앙심을 통한 대외 활동
② 향기로운집 (정신건강 시설), 규칙을 통한 공동체 생활
③ 고등학교, 배움을 목적으로하는 집단 공동체

2조

공동체란? ① 동그라미
② 함께하는 것
③ 여러 사람이 모여서 얘기하는 것
④ 포함되어 있는 것
⑤ 질서가 있는 것

어떤 공동체를 경험했나?
① 걸스카우트
② QR 프로그램 참여
③ 금지된 곳 방문 ex) 노래방
④ 여행, 함께 쇼핑, 수다
⑤ 군대, 휴가 나오면 친구 모임
⑥ 재수학원 - 싸움, 예민, 뒷담화

3조

공동체란 + 어떤 공동체를 경험했나?
① 스포츠(축구)도 될 수 있다
② Rule이 있어야 하고 무언가를 함께 하는 것
③ 모임, 소속감, 조직
④ 공통점 (관심사)가 있어야
⑤ 만나야 형성되는 것
⑥ 교회 등 종교활동
⑦ 매주 목요일 진행되는 QR 활동 program
⑧ 아르바이트
⑨ 동창회, 동호회 (암벽등반...)
⑩ 여행. 관광, 직장, 학교
⑪ 인생 자체가.. (가족~)

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q2. 기원이가 공동체와의 연결을 잃게 된 이유는 무엇일까요?

1조

① 군 시절 때 상처 때문에 나와서 또 상처받는 것을 두려워 함
② 군대에서는 사람이 튀는 행동보다는 획일한 행동을 원하기 때문에
③ 기원이의 친화력이 인정 못 받았다. 사회는 친화력이 괜찮은데
④ 트라우마 영향이 아직도 잔존 하기 때문에
⑤ 자존감을 너무 많이 상실함. 너무 상처가 컸음
⑥ 군대는 계급 사회이고 적응을 못 한 것이다
⑦ 자기다움, 본인의 정체성을 상실함

2조

당사자 대답
① 트라우마
② 부정적. 소극적
③ 방어적, 비관적인 생각
④ 선임때문
⑤ 낯선환경
⑥ 자기부정.

보호자 대답
① 선임 때문
② 약해서
③ 군대문화. 열악한 환경

종사자 대답
① 공동체가 단단하지 못해서 (충분한 의사소통 부족)
② 군대 계급사회

3조

① 사랑에 대한 불신
② 자존감 하락
③ 이전 과거 경험에 대한 기억
④ 자기 자신에게 문제를 찾으려고 하는것
⑤ 외부의 질타로 인한 상처
⑥ 외적인 모습
⑦ 공동체에 대한 적응 X. 상황판단 X

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q4. 당신이 기원이의 지지자라면, 공동체와의 연결을 회복할 수 있도록 어떤 것들을 도울 수 있을까요?

1조

① 기원이의 원래 강점인 친화력을 살릴 수있는 가족과 같은 작은 친밀한 모임 (EX, 교회의 청년부)을 독려한다.
(친밀하게 상호작용할 수 있는 곳)
② 기원이의 연락처를 먼저 물어보고 가도 되는지 물어본다. 그 다음 기원이가 좋아할만한 취미를 함께 찾아 동아리 모임을 함께 한다
③ 오픈 다이얼로그를 시도해본다
④ 기원이의 이야기를 많이 들어서 라포를 형성한다

2조

① 속에 있는 이야기를 들어주고 꺼내게 해준다. → 같이 욕한다
② 기원이의 관심사. 흥미를 살려 활동할 수 있게 해준다
③ 외부활동 (운동) 격려
④ 만나준다. 친구들 소개시켜준다(동료지원가)
⑤ 센터 자원 소개
⑥ 일상을 함께 한다 (목적 없이)
⑦ 그냥 자주 만난다
⑧ 된다 안된다의 결정은 내가 내리는게 아니다

3조

① 그냥 옆에 있어주기 (조언 X)
② 함께 좋아하는 음악 (노래) 듣기
③ 같이 밥먹자. 산책하기. 운동하기.
④ 원하는 것 물어보기 (일상에서 할 수 있는것) - 취미활동, 심리테스트 등
⑤ 상담 프로그램 찾아보기. 전문가 도움 받기
⑥ 할 수 있는 것과 할 수 없는 것 구분해주기
⑦ 종교활동 할 수 있도록 도움주기
⑧ 작은 것이라도 내 감정 표현해주기, 들어주기
⑨ 부담주지 않기 (“할 수 있어” 금지)
⑩ 어설픈 위로하지 않기 (EX. 밑거름이 될꺼야)
⑪ 유튜브에서 좋은 글귀 찾아 보내주기

08 Topic 8. 회복 의사소통 기술(1)



핵심목표

당사자 혹은 지지자가 회복의 과정에서 어떠한 고민이 있는지 한 개 이상 생각해 볼 수 있다.

핵심질문

① 의사소통이란?

개인적인 경험을 떠올리고 이야기를 나눠본다.

규성씨 사례를 통해, 일상에서 자주 마주하게 되는 실질적인 의사소통의 어려움에 대해 토론한다.

② 당사자, 보호자, 종사자 각각의 관점에서 서로의 마음은 어떤가?

규성씨의 사례를 다양한 관점에서 살펴보고 서로의 마음을 헤아려본다.

③ '대화(Dialogue)'란?

회복을 위한 '대화를 위한 대화'에 대해 이야기한다.

핵심내용

① 효과적인 의사소통은 회복을 돕습니다. 그러나 당사자, 보호자, 종사자 간의 회복을 위한 의사소통은 결코 쉽지 않습니다.

② 서로의 마음을 헤아리는 것, 그것이 진정한 '대화를 위한 대화'의 첫걸음입니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 '사례모음' [규성이 어머니 이야기]
  각 조마다 한 세트씩
  이전 시간과는 달리 큰 종이에 출력하면 좋습니다.
- ☐ 필기구
  조마다 형광펜 준비
- ☐ 프로그램 환경조성
  · 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  · 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다.
- ☐ 조별활동 책상배치
  · 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배치합니다.
  이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

부록(Topic 8)에는 '대화를 위한 공간', '반응적 경청', '반영하기', '함께의 대화/관하여의 대화'에 대한 교육 자료가 포함되어 있습니다. (이를 미리 출력하여 참여자들에게 한 부씩 배부하면, 관심 있는 참여자들이 자율적으로 내용을 학습할 수 있도록 도울 수 있습니다.)

참·고·사·항

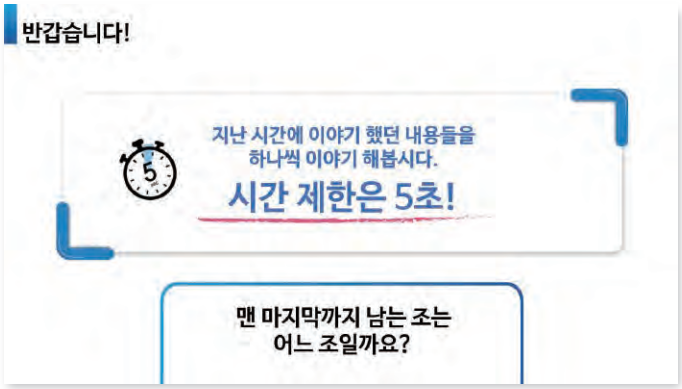
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

2. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 170분 입니다.**

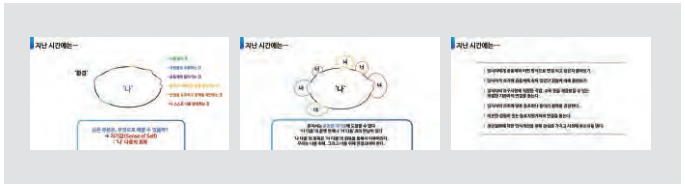
활동단계 도입

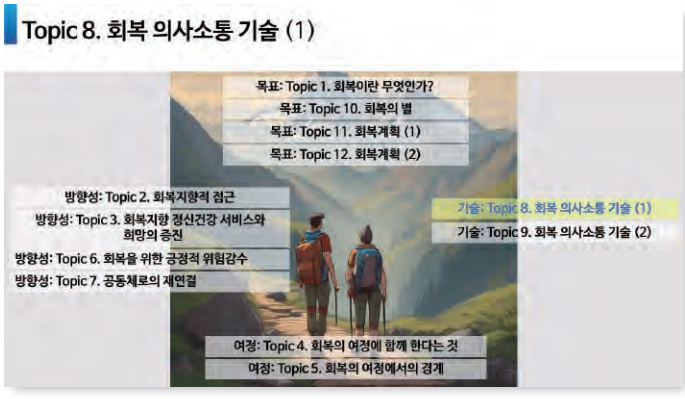


이어말하기 게임



지난 시간에는…





회복 의사소통 기술 (1)

활동내용

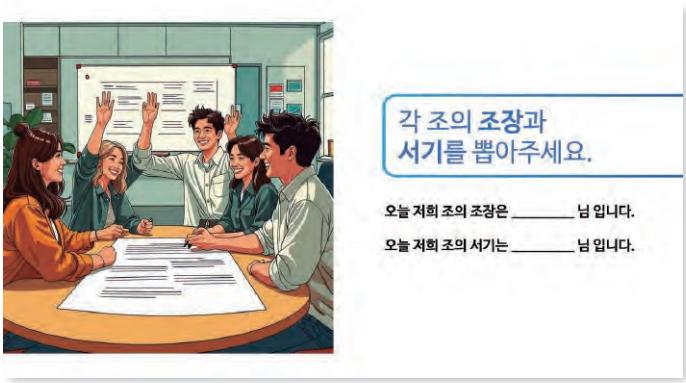
이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 도입



조장과 서기 선출

활동내용

Tips.

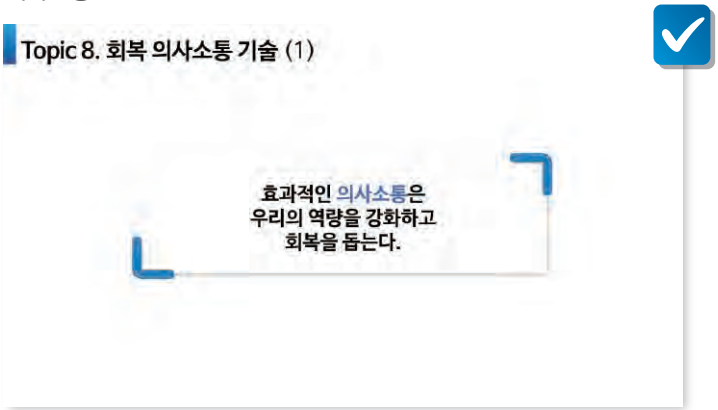
조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간을 줍니다. 만약 여전히 자발적인 참여자가 없다면, 진행자가 직접 조장을 정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

· 조장은 조별 활동을 주도하며 전체 흐름을 이끕니다.
· 서기는 토론 중에 나온 의견들을 큰 종이나 화이트보드 시트 등에 정리하여, 발표자가 발표할 때 참고할 수 있도록 합니다.
· 발표자는 발표가 필요한 토론 활동마다 조에서 자율적으로 정합니다.

활동단계 전개



의사소통



효과적인 의사소통은 회복을 돕는다

활동내용

진행자는

오늘의 주제를 본격적으로 시작하기에 앞서, 참여자들과 '의사소통'에 대해 이야기 나누며 브레인스토밍을 유도할 수 있습니다.

Tips.

참여자들의 자연스러운 브레인스토밍을 이끌어내기 위해 다음과 같은 방법을 활용할 수 있습니다:

① 삽화를 보여주고 떠오르는 생각이 무엇인지 질문하며 참여를 유도할 수 있습니다. (애니메이션 효과 전에는 삽화만 제시되어 있습니다.)
② '말'과 관련된 속담을 아는지 물어보는 방식으로, 의사소통의 중요성을 자연스럽게 상기시킬 수 있습니다.

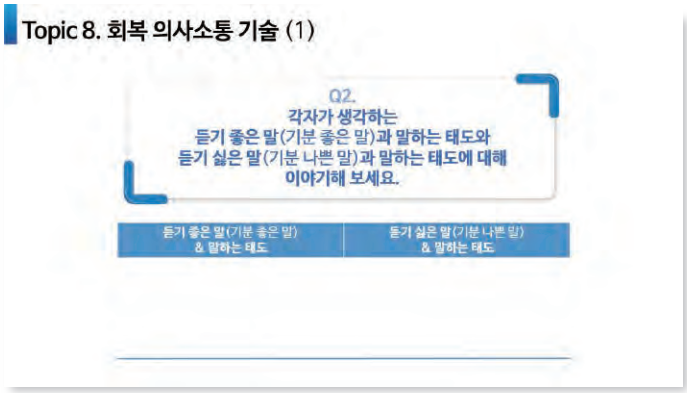
슬라이드에 제시된 문구를 참여자들과 함께 읽으며, 오늘 주제의 중요성을 강조합니다.

"의사소통은 회복과 어떤 관계가 있을까요? 함께 읽어봅시다. 효과적인 의사소통은 우리의 역량을 강화시키고 회복을 돕는다."

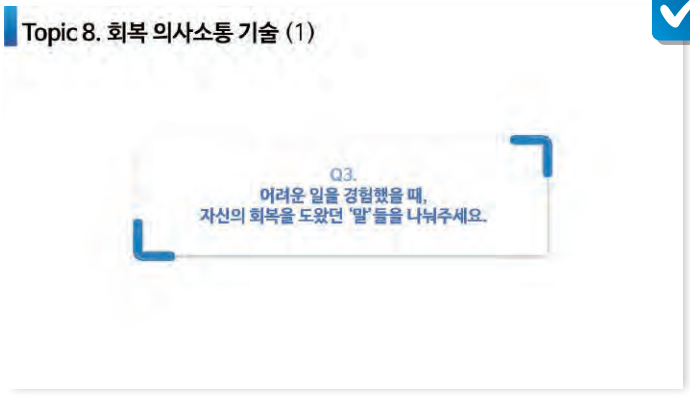
활동단계 전개



영상 시청 (2:07)



Q2. 듣기 좋은 말/태도 그리고 듣기 싫은 말/태도 (20분)



Q3. 어려운 일을 경험했을 때 회복을 도운 말 (20분)

활동내용

Q1-1 영상 속의 두 아이가 소통하고 있다고 생각하나요?
Q1-2 두 아이가 어떤 주제에 대해 이야기 하고 있나요?
(20분)

아직 말을 배우지 않은 두 아이가, 마치 대화를 나누듯 자신들만의 소리로 감정을 주고받는 모습을 담은 영상입니다.

Q1-1은 조별 토론보다는, 참여자들이 손을 들어 자유롭게 자신의 의견과 그 이유를 말하는 방식으로 진행합니다.

Q1-1이 끝난 후, 진행자는 Q1-2가 조별 토론으로 진행될 것임을 안내하고, 영상을 한 번 더 시청하자고 제안합니다.

두 번째 영상 시청이 끝난 뒤에는, 조장의 진행에 따라 조별 토론을 진행하고, 토론을 마친 후 각 조에서 발표자를 정해 전체 참여자 앞에서 토론 결과를 발표하도록 안내합니다.

진행자는

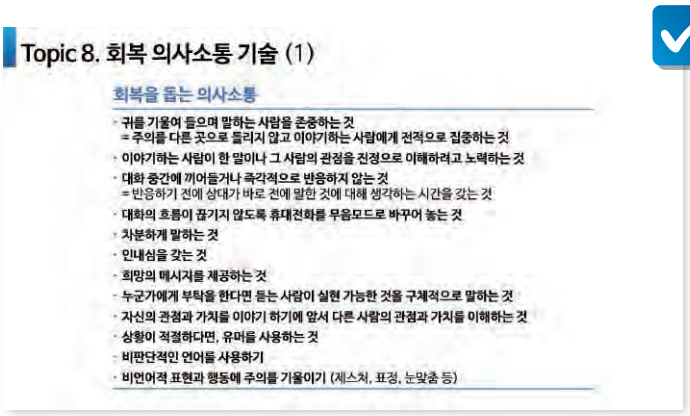
Q2를 시작하기에 앞서, 각자가 기분이 좋았던 말 또는 기분이 상했던 말을 들었던 경험을 떠올려 보도록 안내합니다.

그 후, 조장의 진행에 따라 조별 토론을 진행하고, 토론을 마친 뒤 발표자를 정해 전체 앞에서 발표하도록 안내합니다.

Q2에 대한 조별 활동이 끝난 후, 진행자는 자연스럽게 Q3로 넘어갑니다.
Q3 역시 각자의 경험을 바탕으로 조별 토론을 진행하도록 안내합니다.

각 조의 발표가 끝날 때마다, 진행자는 발표자와 조별 토론 결과에 대해 격려의 말을 전하고, 발표 내용을 간단히 요약하며 핵심을 강조합니다. 또한 전달이 충분하지 않았던 부분이 있다면 전체 참여자에게 명확하게 다시 설명해 줍니다. 단, 발표자를 지적하거나 토론 내용을 교정하거나 수정하려는 태도는 피해야 합니다.

활동단계 전개



회복을 돕는 의사소통

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 10: Communication skills)



사례 설명 규성이 이야기

이야기 속의 규성씨는 조현병 진단을 받고 치료를 시작한 지 20년이 지난 당사자입니다. 오랜 기간 약물치료를 통해 어느 정도 호전은 있었지만, 여전히 증상이 남아 있는 '부분 관해(Partial remission)' 상태에 머물러 있습니다. 하지만 규성씨를 가장 힘들게 하는 것은 남아 있는 증상 그 자체가 아니라, 누구도 자신의 이야기를 진심으로 귀 기울여 들어주지 않는다는 사실입니다.

이 사례의 핵심은, 규성씨도, 그의 부모님도, 주치의도 누구 하나 악한 의도를 가진 사람은 없다는 점입니다. 모두가 규성씨를 위한다고 하지만, 결국 규성씨의 차마 다 털어놓지 못한 공허한 외침만이 남게 된 안타까운 사례입니다.

활동내용

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에서 제시하는 '회복을 돕는 의사소통'의 특징을 천천히 함께 읽으며, 참여자들에게 그 의미를 설명합니다.

진행자

슬라이드에 제시된 삽화와 문장을 따라 읽으며, 참여자들에게 사례에 대한 흥미와 궁금증을 유발합니다.

Tips.

· 본 슬라이드만 보고 어떤 이야기일 것 같은 지 추측해 보자고 제안하며, 참여자들의 추측을 들어보는 것도 좋습니다.

· 부록 중 '사례 모음'에서 규성이 이야기를 미리 출력하여 각 조마다 한 세트씩 제공하며, 이때 미리 사례를 읽어보지 않도록 뒤집어 놓습니다.

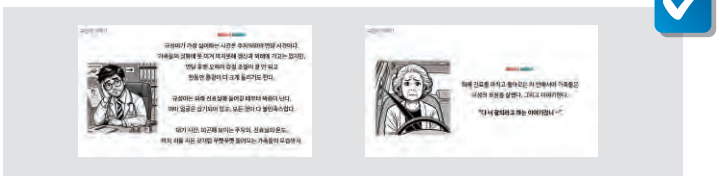
· 진행자가 사례를 읽기 시작할 때, 각 조마다 제공된 출력물을 함께 보자고 이야기합니다.

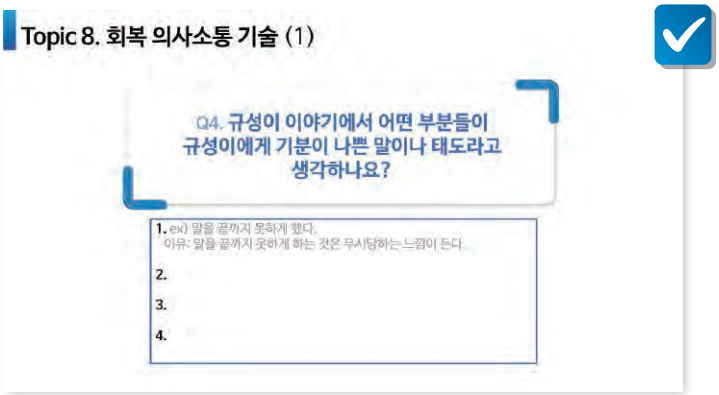
· 이후 사례와 관련된 토론 활동을 할 때도 자유롭게 출력물을 보면서 토론을 진행할 수 있습니다.

활동단계 전개

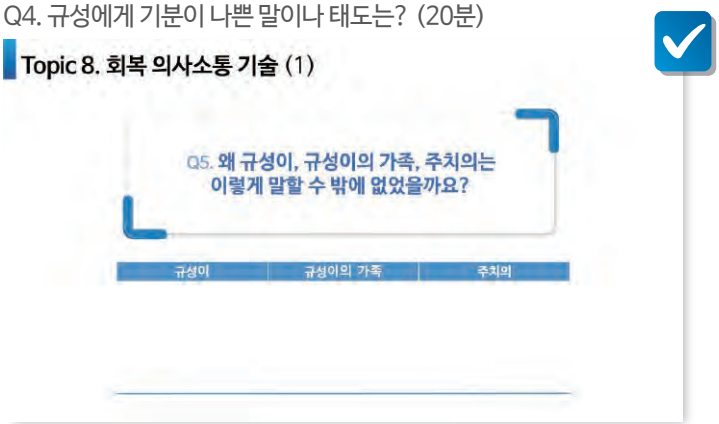


사례. 규성이 이야기





Q4. 규성에게 기분이 나쁜 말이나 태도는? (20분)



Q5. 왜 규성이, 규성이의 가족, 주치의는 이렇게 말할 수 밖에 없었을까요? (30분)

활동내용

진행자는

슬라이드를 천천히 읽어 주며, 마치 구연 동화처럼 큰 따옴표 속의 대화와 작은 따옴표 속의 속마음을 실감 나게 표현합니다.

Tips.

몇몇 문장은 참여자 중 한 명에게 실감 나게 읽어 달라고 요청하여 사례에 대한 집중도를 높일 수 있습니다.

진행자는

진행자는 각 조별로 토론을 진행하며, 규성씨의 이야기 속에서 규성씨에게 상처가 되었을 법한 말이나 태도를 찾아보고 정리해 보도록 안내합니다.

토론이 끝난 후에는 발표자를 정해, 조별로 그 내용을 전체 앞에서 발표하도록 안내합니다.

Tips.

· Q4 조별 토론에 앞서, 진행자는 규성씨의 이야기를 처음부터 천천히 다시 읽어주거나, 프로그램 시작 전 각 조에 제공된 '부록: 규성이 이야기'를 함께 살펴보며 토론을 진행하도록 안내할 수 있습니다.

· 또한 조별 토론 시, 각 조에서는 부록 자료를 함께 읽으며 규성씨에게 상처가 되었을 법한 말이나 태도를 형광펜 등으로 표시하면서 살펴보아도 좋다고 안내할 수 있습니다.

진행자는

오늘 토론 질문 중 가장 핵심이 되는 질문입니다. 사례 속에서 문제점을 지적하기보다는, 규성씨와 그의 가족, 주치의가 그러한 말을 할 수밖에 없었던 마음을 헤아리는 것이야말로 회복을 돕는 의사소통 기술의 첫걸음임을 설명합니다.

조장의 진행에 따라 조별 토론을 진행하고, 토론을 마친 후 발표자를 정해 전체 앞에서 발표하도록 안내합니다.

1부 끝 시간 부족 시

활동단계 전개



Q6. 대화의 변화

활동내용

진행자는
Q4, Q5에 이어 진행되는 조별 토론입니다.

Q4와 Q5에서 도출된 조별 토론 결과를 바탕으로 Q6을 이어서 진행하도록 안내합니다.

Tips. 각 조별로 Q4에서 도출한 내용을 다시 살펴보며, 그 상황을 어떻게 바꾸면 좋을지 구체적인 예시를 작성하도록 안내하면, Q6 토론을 보다 수월하게 시작할 수 있습니다.

활동단계 정리



Q6. 대화의 변화

출처: https://www.youtube.com/shorts/6XoJ3fa4jOk



Q6. 대화의 변화

활동내용

진행자는
영상을 시청하기 전, 참여자들에게 아래와 같이 질문을 할 수 있습니다.

"우리가 오늘 회복 의사소통에 대해 이야기 하고 있지만, 왜곡되고 뭔가 부정적이고 공격적으로 대화하는 사람들과 대화하는 것은 늘 어렵습니다. 이 영상은 이러한 어려움에 대해 이야기 합니다. 함께 볼까요?"

영상을 마친 후 참여자들과 함께 슬라이드에 있는 문장을 소리 내어 읽어볼 수 있습니다.

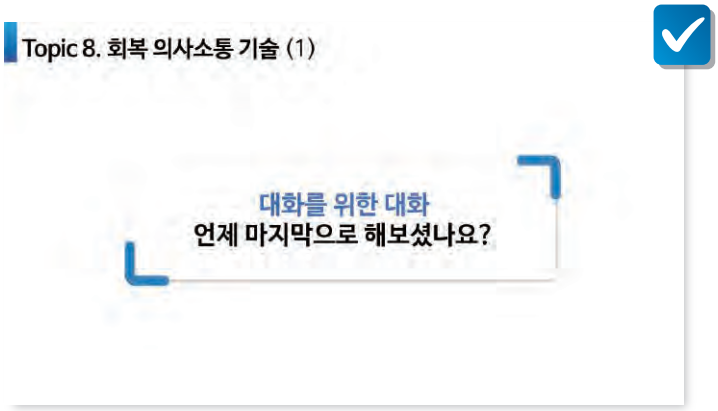
진행자는
"'Dialogue(대화)'는 헬라어 어원인 Dia와 Logos에서 유래된 단어입니다."

"'Dia'는 단순히 '둘'이라는 숫자 개념을 넘어서, '둘 사이'의 관계성과 흐름을 내포하고 있으며, 'Logos'는 진리, 이성, 말, 말씀 등을 의미하는 단어로, 인간 존재의 가장 본질적이고 진실된 것을 가리킵니다."

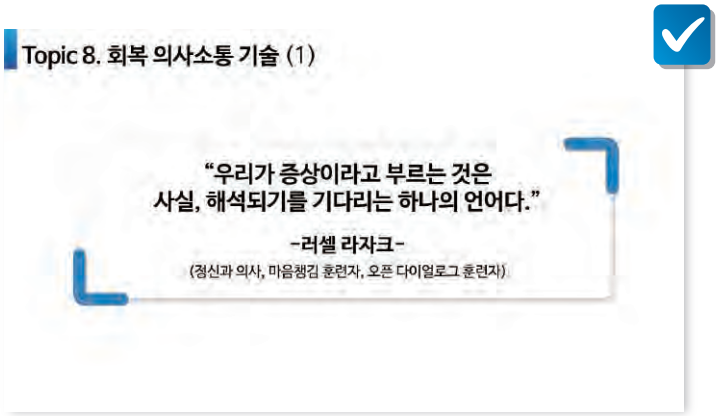
"즉, 헬라어 어원에 따르면 대화란 '둘 사이에서 가장 진실된 것을 주고받는 과정'을 뜻합니다."

(다음 슬라이드로 넘어갑니다.)

활동단계 정리



대화(Dialogue) 2 [32)-34)]





대화(Dialogue) 3

활동내용

진행자는

"이 어원을 통해 우리는 '가장 대화다운 대화란, 바로 대화를 위한 대화'임을 깨닫게 됩니다. 하지만 우리가 일상에서 나누는 많은 대화는, 정보를 전달하는 대화 혹은 주고받기보다는 내 생각과 입장을 일방적으로 주장하는 데 그치는 대화인 경우가 많습니다."

"어쩌면, 오늘 처음에 보았던, 아직 말을 배우지 못한 어린 아이들의 모습이 가장 대화다운 대화를 보여주고 있었는지도 모릅니다."

"여러분은 '대화를 위한 대화'를 마지막으로 해본 것이 언제인가요?"

진행자는

"외국의 정신과 의사인 러셀 라자크는 '증상'에 대해 이렇게 말합니다."

"우리가 증상이라고 부르는 것은 사실, 해석되기를 기다리는 하나의 언어다."

(다음 슬라이드로 넘어갑니다.)

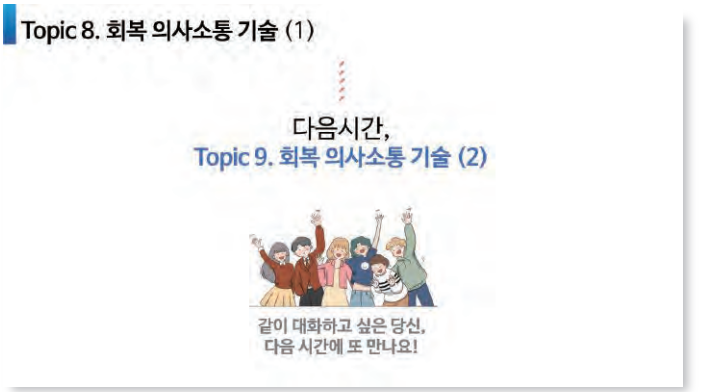
"여러분은 어떤 사람들은 '증상'이라고 부르는 그들의 삶과 대화를 위한 대화를 할 준비가 되어있나요?"

"우리가 '증상'이라고 부르는 것은, 어쩌면 당사자가 우리에게 건네는 가장 본질적이고 진실된 대화일 수 있습니다. 당사자가 어렵게 우리를 초대한 이 대화 앞에서, 우리는 어떤 태도로 서 있었는지 함께 고민하며 오늘의 프로그램을 마무리하겠습니다."

활동단계 전개



모두 한마디



다음 Topic 소개

활동내용

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.

· 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.

· 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 이야기를 한마디씩 들어보는 시간을 가지는 것을 권장합니다.

Tips.

· 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.

· 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.

· "같이 대화하고 싶은 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q2. 각자가 생각하는 듣기 좋은 말(기분 좋은 말)과 말하는 태도와 듣기 싫은 말(기분 나쁜 말)과 말하는 태도에 대해 이야기해 보세요.

1조

듣기 좋은 말과 태도
① 처음 간 모임에서 모든 모임 참여자에게 눈을 맞추고 이야기를 잘 반영해 준 태도
② 병원진료 볼 때 의사선생님이 "당사자의 잘못도, 보호자의 잘못도 아니다" 라고 했을 때 위로가 됨
③ "감당할 수 있으니까 그런 아이를 준 것 같아요."
④ "힘드시겠어요"
⑤ "당신은 굉장히 중요한 일을 하고 있어"
⑥ 질문을 많이 해줄 때

듣기 싫은 말과 태도
① 처음 간 모임에서 너무 좋으신 분께 한 남자분이 일방적으로 질문을 쏟아내서 기분이 나빴음
② 비합리적 낙관적인 말
③ "무조건 잘 될거에요."
④ "애를 어떻게 키웠길래...."
⑤ "우리 애도 그래요."
⑥ "너는 아무것도 할 수 없어"
⑦ "너 바보냐!!"

2조

듣기 좋은 말과 태도
① "오늘 하루 어땠어? 오늘 표정이 좋다" (안부, 관심)
② "어머, 오늘 너 옷 참 잘입었네!"
③ "옷 산거야? 머리했어? 잘 어울린다!"(관심)
④ "맛있는 과일먹자!".
⑤ "오늘 날 만나 기뻤어. 너랑 있으면 기분이 좋아"
⑥ "너는 뭐든지 잘해!"
⑦ 인정, 수용, 위로, 긍정적, 나에게 관심있는 태도.
⑧ "너 덕분에 든든해 힘이 된다."

듣기 싫은 말과 태도
① "넌 이게 문제야"
② 넌 항상 이런식이야"
③ "이게 최선이야? 정말 노력했니?"
④ "아는 것도 없으면서 아는 척 하지마!"
⑤ 날 무시하는 태도. 비난하는 태도. 잘 모르면서 날 판단하는 말

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q2. 각자가 생각하는 듣기 좋은 말(기분 좋은 말)과 말하는 태도와 듣기 싫은 말(기분 나쁜 말)과 말하는 태도에 대해 이야기해 보세요.

3조

듣기 좋은 말과 태도
① "이거 먹어볼래?" "잘했어." "고맙다." "사랑해."
② "예쁘다." 화장했을 때 바로 알아차릴 때
③ "대단하다. 너무 잘한다." 노력한 것을 알아줄 때
④ 칭찬 격려해주는 것. "네가 하는 일이 너무 중요해. 계속 네가 좋아하는 길을 걸어갔으면 좋겠어."
⑤ "네가 최고다." 인정해 줄 때

듣기 싫은 말과 태도
① 썩소를 지으며 비꼬는 태도, 인정해 주지 않는 태도. 무시하는 태도
② "그건 틀렸어." "니 까짓 게 뭘 한다고"
③ "그래 그렇게 살다가. 죽어라."
④ "그걸 왜 열심히 하지?"

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q4. 규성이 이야기에서 어떤 부분들이 규성이에게 기분이 나쁜 말이나 태도라고 생각하나요?

1조

듣기 좋은 말과 태도

① 내가 말한 부분을 무시한 태도
② 다른 사람이 생각한 부분을 다른 사람과 비교하는 점
③ 보호자의 소리치며 말하는 태도
말을 끊고 내 말에 공감해주지 않는 태도
영혼이 없이 말하는 태도
④ 그게 바로 증상이라는 말 전에 힘드셨겠어요 라고 먼저 이해해줬더라면 좋았을 것이다
⑤ 내가 힘든 부분을 확인시키는 건 기분 나쁘다
⑥ 내 스토리에는 관심이 없는 부분
내 약에만 관심을 보이는 부분이 기분 나쁘다

2조

① "얘는 또 쓸데 없는 소리를 하네..." 말을 끊음
② 고민에 대해 공감. 이해해주지 못함
③ 자신이 이야기한 적이 없음에도 병을 진단하고 판단하는 느낌
④ 자신의 권리와 의사결정을 존중하지 않음
⑤ 부모님의 쭈뼛쭈뼛한 태도를 보고 자신의 병이 죄인가. 라는 생각

3조

① 자신의 표정 살피지 않고 말 가로막고, 별거 아닌 듯 모니터만 보고 피곤한 티를 내며 자신의 일 함
② 가족들이 규성이의 일 가로막을 때 → 오히려 규성이가 눈치보는 느낌
③ 다 너 잘 되라고.. → 나를 위한게 맞나?
④ 치료 받는데 나아지지 않는, 도움이 되지 않는 상황
⑤ 영혼 없는 듯한 의사의 말. 영혼 없는 온화함.
내 걱정에 대해 쉽게 이야기하는 듯한.

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q5. 왜 규성이, 규성이의 가족, 주치의는 이렇게 말할 수 밖에 없었을까요?

1조

규성이

① 오랜 기간 증상이 호전이 없는데 그것이 가족, 주치의 때문인 것 같음

② 강제적으로 주변에서.

③ 가족이 계속 동행하니까.

규성이의 가족

① 주위 치료진이나 주치의에게 잘 보여야 하기 때문에 → 당사자에게 영향이 갈 까봐 (간접적인 영향이 안 갈수가 없다.)

② 원활한 의사소통을 위해

③ 본인이 이야기를 안하니까 대변해서 말할 수 밖에... (말을 해주기를 바라지만)

④ 전문가라고 하면 꿈뻑 죽는다. 일단 전문가의 이야기가 중요하다 (을의 입장이기 때문에)

주치의

① 체계적인 문제 → 환자를 볼 수 있는 시간이 너무 적은 시스템, 초점에 맞춰 진료를 할 수 밖에...

② 이미 많은 정보와 데이터가 있기 때문에... (의학 정보, 많은 환자들을 경험, 대상자 과거력)

2조

규성이

① 내가 당장 힘들고 화도 나서, 내가 살려고

② 이 치료에 대해 확신이 안들고. 힘들 것 같다

③ 충분한 설명이 없어서

④ '약' 때문에 힘든데-충분한 설명 없어서 (부작용에 대한 설명)

⑤ 규성이 자신을 부모님이 싫어하는 느낌이 들어서

규성이의 가족

① 죄책감 때문에, 내 탓이라 생각해서

② 규성이가 다른 사람에게 폐를 끼칠까봐 사전에 차단/규성이 진정시키고, 안심시키러

주치의

① 나의 감정을 방어해서 너무 깊이 들어가지 않으려, 영향을 받지 않기 위해서

② 바빠서, 대기 환자가 많아서 (설명은 해주고, 가이드 해줘야 하는데)

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q5. 왜 규성이, 규성이의 가족, 주치의는 이렇게 말할 수 밖에 없었을까요?

1조

규성이

① 나는 분명 환청이 있는데 억울해서 화가 났다.
② 나를 이해해주지 않고 의사소통이 되지 않아 이런 결과를 낳았다.
③ 의료진에 대한 신뢰를 잃었기 때문

규성이의 가족

① 규성의 가족은 규성이의 상황이 안타까워서 그랬을 것이다.
② 치료에 대한 현실적인 협조를 한 것이다.
③ 규성이의 말을 끊은 보호자가 이해가지 않는다.
④ 가족이 이미 지치고 한계를 느껴서 그렇게 말하는 것 같다.

주치의

① “정말 힘드셨겠어요” 라고 공감하는 말을 먼저 해주면 좋겠다.
② 당사자와 보호자를 따로 진료보는 시간이 있었으면 좋겠다. (시스템적으로)
③ 주치의는 진료 볼 때 눈맞춤을 잠깐이라도 해주면 좋겠다.

08 Topic 8. 회복 의사소통 기술(1)

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q6. 회복 의사소통을 위해서 규성이, 규성이의 가족, 주치의의 대화는 어떻게 바뀌었으면 좋을지 이야기해보세요.

1조

규성이

① 여유 있는 마음을 가지고 살아가면 좋을 것 같다.
② 규성이도 주치의의 상황을 이해해주면 좋겠다.
③ 규성이도 하고싶은 말을 미리 준비해서 진료를 보면 좋겠다.
④ 규성이도 자신의 증상에 학습할 필요가 있다.

규성이의 가족

① 진료 전에 규성이의 모습을 잘 메모해 두고 진료를 봤으면 좋겠다.
② 규성이와 부모는 평소 대화를 많이 했으면 좋겠다.
③ 규성이에게 온정적인 태도를 보였으면 좋겠다.

주치의

① 의사는 환청과 같은 증상을 실제로 느낀 것이 아니라 책으로만 읽어서 그렇다.
② 지금 듣는 환청이 사실이 아닐 수도 있다는 걸 알리기 위함
③ 대기하고 있는 대상자들이 너무 많아서
④ 회진이 있을 수 있다.

2조

규성이

① 약을 계속 먹는다.
② 말을 표현하려는 노력 (써서 자신의 의견을 밝힘.)
③ 증상에 대한 정보를 알려는 노력 (교육, 공부, QR)

규성이의 가족

① 경청. 스스로 말할 수 있는 기회를 준다.
② 질문을 통해 대화 유도하기
③ 증상에 대한 정보를 알아가려는 노력 (교육 참여, 공무)

주치의

① 환자를 무시하는 태도 말투를 지양한다. (바꿀 필요)
② 눈 맞춤을 해줄 필요.
③ 부모랑 분리해서 진료

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q6. 회복 의사소통을 위해서 규성이, 규성이의 가족, 주치의의 대화는 어떻게 바뀌었으면 좋을지 이야기해보세요.

3조

규성이

① 내 자신의 이야기 '표현'
② 어떤 것이 힘든 지 설명 +증상 써오기(불편한 점)
③ 긍정적 마음으로 적극적 행동하기
④ 객관적으로 자신의 상태 평가 (약 효과 인정하기)
⑤ 나의 가족도 힘들다는 것 인정하고, 같이 노력한다

규성이의 가족

① 규성이를 잘 복돋아준다
② 규성이 이야기를 들어준다
③ 규성이 입장을 한번 더 생각해본다 +서로 입장을 바꿔 생각해보기

주치의

① 여유로운 외래시간 알려주기
② 잠깐이라도 들어주기
③ 솔직히 이야기해주기 '시간은 0분 있는데 들어드리겠습니다.'

09 Topic 9. 회복 의사소통 기술(2)



핵심목표

내 보호자가 회복의 과정에서 가장 듣고 싶은 말을 생각해보고 이를 직접 역할극을 통해 표현해 볼 수 있다.

핵심질문

① 회복 의사소통 기술이란?

규성이 어머니 사례를 통해 보호자의 관점을 이해하고, 그들이 겪는 심리적 고통에 공감해본다.

② 보호자를 위한 회복 의사소통 방안에는 무엇이 있을까?

자산/강점 기반 접근을 바탕으로 , 보호자를 위한 회복 의사소통 방안에 대해 조별로 토론해본다.

역할극을 통해 앞서 다룬 회복 의사소통 기술을 실제로 경험해본다.

핵심내용

① 보호자에게도 회복이 필요합니다. 이를 위해서는 보호자의 마음을 깊이 헤아리는 의사소통이 중요합니다.

② 역할극 속의 대화는 물론, 소감을 나누는 대화까지 포함하여 앞서 다룬 회복 의사소통 기술을 직접 경험해보는 시간을 가집니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 '사례모음' [규성이 어머니 이야기]
  각 조마다 한 세트씩
  이전 시간과는 달리 큰 종이에 출력하면 좋습니다.
- ☐ 필기구
  조마다 형광펜 준비
- ☐ 프로그램 환경조성
  · 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  · 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다.
- ☐ 조별활동 책상배치
  · 프로그램 참여자를 사전에 조사하여 미리 조를 배치합니다.
  이때, 가족인 당사자와 보호자는 한 조에 배치할 수 없습니다.

부록(Topic 9)에는 '정신증 환자의 언어와 행동에 대한 이해'와 '정신증 환자와의 대화를 위한 실질적인 지침'에 관한 교육 자료가 포함되어 있습니다. 이 자료를 미리 출력하여 참여자들에게 한 부씩 배부하면, 관심 있는 참여자들이 자율적으로 학습할 수 있도록 도울 수 있습니다.

참·고·사·항

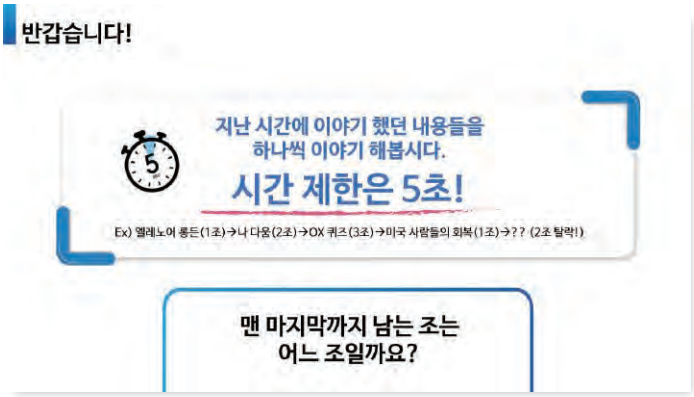
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

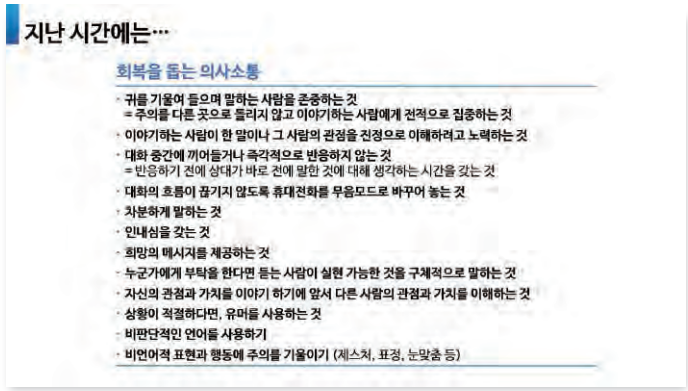
2. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 220분 입니다.**

활동단계 도입

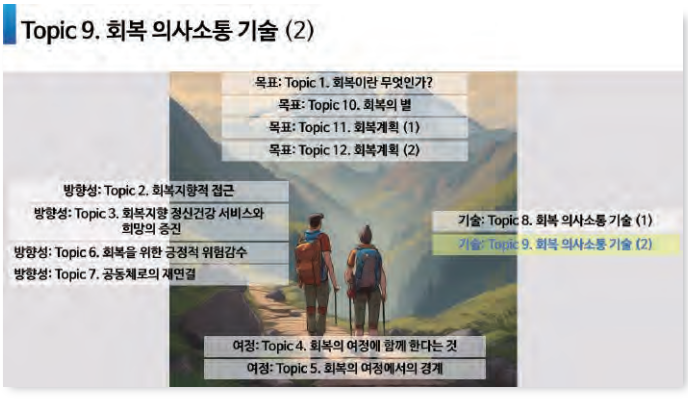


이어말하기 게임



지난 시간에는…





회복 의사소통 기술 (2)

활동내용

이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어 말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 도입



조장과 서기 선출

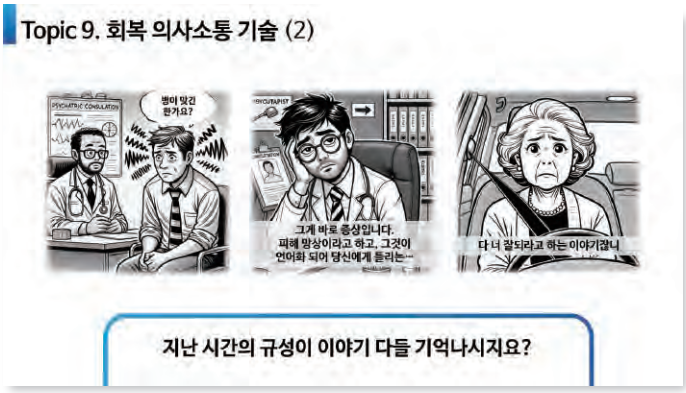
활동내용

진행자는

조에서 오늘의 조장과 서기를 뽑을 시간을 줍니다.

만약 여전히 자발적인 참여자가 없다면, 진행자가 직접 조장을 정하는 방법도 고려할 수 있습니다.

활동단계 전개



규성이 이야기를 상기시킵니다

활동내용

진행자는

이번 세션에서는 지난 시간에 소개된 규성이 이야기에 등장했던 규성이 어머니의 시선을 중심으로 이야기를 이어갑니다.

먼저, 진행자가 규성이의 사례를 간략히 요약한 후, 규성이 어머니의 경험과 관점을 함께 살펴볼 것을 안내합니다.

활동단계 전개



사례 설명

규성이 어머니 이야기

이야기 속에서 규성이는 어머니에게 삶의 전부와도 같은 존재였습니다. 그런 아들에게 병이 찾아오고, 규성이의 입에서 나오는 말들을 어머니는 도무지 감당할 수 없었습니다.

어머니는 자신만이 아들을 예전 모습으로
되돌릴 수 있다는 생각에 사로잡히고, 그때부터 규성이와의 대화는
멈춘 채, 규성이의 '증상'과 외로운 싸움을 시작합니다. 그 싸움 속에서,
규성이가 자신을 잃어갔듯, 어머니 역시 점점 자신을 잃어갑니다.

어머니는 자신이 듣고 싶은 말만 해줄 의사를 찾아 병원을 전전하다가,
어느 날, 병원 엘리베이터 안 거울에 비친 자신의 모습을 마주하며,
정신질환이 아들만이 아니라, 자신도 빼앗아갔다는 사실을 비로소
깨닫게 됩니다.

활동내용

진행자는

슬라이드에 제시된 삽화와 선지의 속마음을 소개하며, 참여자들에게 사례에 대한 흥미와 궁금증을 유발합니다.

Tips.

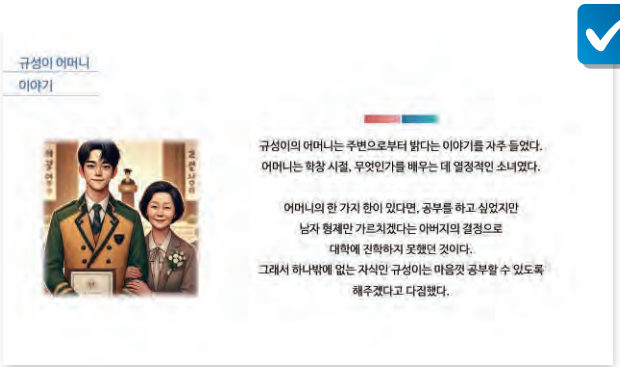
· 본 슬라이드만 보고 어떤 이야기일 것 같은지 추측해 보자고 제안하며, 참여자들의 추측을 들어보는 것도 좋습니다.

· 부록 중 '사례 모음'에서 규성이 어머니 이야기를 미리 출력하여 각 조마다 한 세트씩 제공하며, 이때 미리 사례를 읽어보지 않도록 뒤집어 놓습니다.

· 진행자가 사례를 읽기 시작할 때, 각 조마다 제공된 출력물을 함께 보자고 이야기합니다.

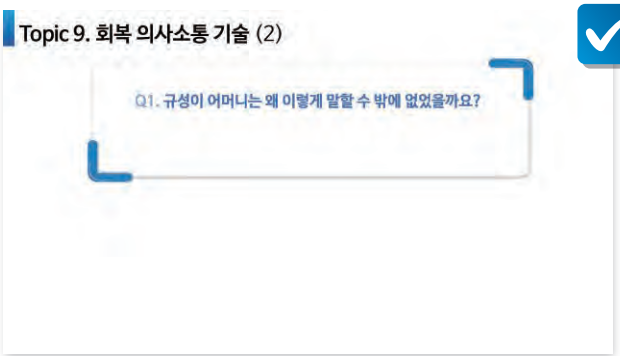
· 이후 사례와 관련된 토론 활동을 할 때도 자유롭게 출력물을 보면서 토론을 진행할 수 있습니다.

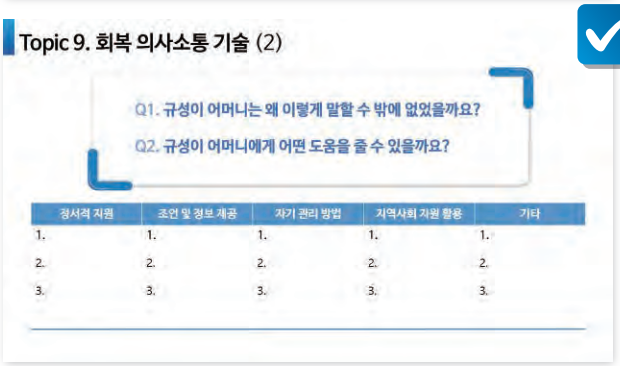
활동단계 전개



규성이 어머니 이야기







Q1. 규성이 어머니는 왜 이렇게 말할 수 밖에 없었을까요? (20분)
Q2. 규성이 어머니에게 어떤 도움을 줄 수 있을까요? (30분)

활동내용

진행자는

슬라이드를 천천히 읽어 주며, 마치 구연 동화처럼 큰 따옴표 속의 대화와 작은 따옴표 속의 속마음을 실감 나게 표현합니다.

Tips.

몇몇 문장은 참여자 중 한 명에게 실감 나게 읽어 달라고 요청하여 사례에 대한 집중도를 높일 수 있습니다.

진행자는

지난 시간에 이어, 누군가와 진정한 의사소통(대화)을 하기 위해서는 먼저 그 사람의 '마음의 극장'에서 어떤 이야기가 일어나고 있는지를 이해하는 것이 중요합니다.

이전 시간에는 규성이의 진료실 안에서 있었던 사례를 통해, 규성이 어머니의 마음을 단편적으로 헤아려 보았습니다. 이번 시간에는 보다 구체적인 정보를 추가하여, 규성이 어머니의 마음을 더 깊이 이해해 보도록 안내합니다.

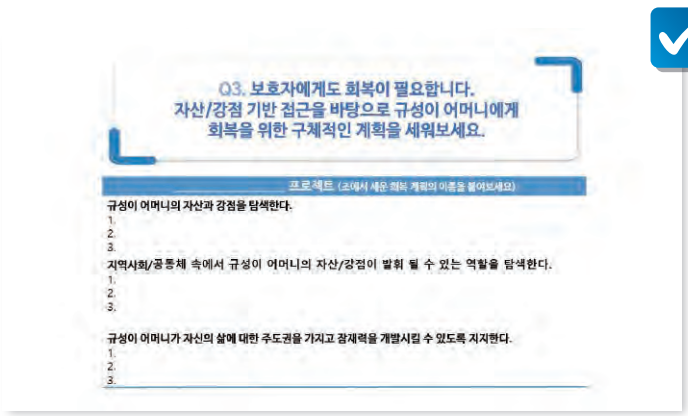
우선 Q1에 대한 조별 토론과 발표를 진행한 뒤, 애니메이션 효과를 활용해 Q2로 자연스럽게 넘어갑니다.

(참고: 애니메이션 효과가 적용되기 전까지는, 참여자에게 Q1만 보입니다.)

Q1이 끝난 후, 진행자는 애니메이션 효과를 활용해 참여자들에게 Q2를 공개합니다. 진행자는 참여자들에게, 마음을 헤아려본 규성이 어머니에게 어떤 도움을 줄 수 있을지에 대해 각 항목별로 구체적인 아이디어를 함께 고민해볼 것을 안내합니다.

마지막 '기타' 항목에는, 제시된 내용 외에 조별로 창의적인 아이디어를 자유롭게 추가하여 토론을 진행하도록 합니다. 조별 토론을 마친 후에는 발표자를 정해 전체 참여자 앞에서 토론 결과를 발표하도록 안내합니다.

활동단계 전개



Q3. 보호자에게도 회복이 필요합니다. 자산/강점 기반 접근을 바탕으로 규성이 어머니에게 회복을 위한 구체적인 계획을 세워보세요 (30분)



영상 시청 (8:37)

출처: https://www.youtube.com/watch?v=ls0htwj7EhM

활동내용

진행자는

'Topic 2. 회복 지향적 접근'에서 다루었던 결손 기반 접근과 자산/강점 기반 접근에 대해 간략히 설명한 뒤, 조별 토론을 시작합니다.

토론이 끝나면 각 조에서 발표자를 정해 전체 참여자 앞에서 토론 결과를 발표하도록 안내합니다.

발표 이후, 각 조가 스스로 작성 한 Q2와 Q3 토론 결과를 함께 되짚어보며, 서로 어떤 차이가 보이는지 자연스럽게 의견을 나눌 수 있도록 안내합니다.

마지막으로, Q2와 Q3의 내용을 종합하여, 규성씨의 어머니에게 결손을 메우는 접근과 자산/강점을 강화하는 접근을 균형 있게 제안하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

Tips.

'Topic 2. 회복 지향적 접근' PPT 파일을 열어 슬라이드 #14, #15에 있는 근하 이야기와 Q3, Q4 내용을 참여자들에게 보여준 후, 본 조별 토론을 시작해도 좋습니다.

진행자는

진행자는 회복은 당사자만이 아니라 보호자에게도 필요하다는 점을 강조하며, 회복의 삶을 살아가고 있는 한 가족의 이야기를 함께 들어보자고 안내한 뒤 영상을 시청합니다.

영상을 마친 후 참여자들과 함께 슬라이드에 있는 문장을 소리 내어 읽어볼 수 있습니다.

1부 끝 시간 부족 시

활동단계 전개



역할극 36)-38)

- 각 기관의 일정과 시간 여건에 따라 '역할극'은 생략될 수 있습니다.
- 역할극을 진행하기 위해서는 조별 토론에 맞춰 놓인 좌석을 역할극에 적합한 형태로 재배치해야 합니다.(영상 시청 후 쉬는 시간을 활용하여 좌석을 역할극에 맞게 조정해 보시기 바랍니다.)

활동내용

역할극은 치료적 상황에서 실제 또는 가상의 갈등 상황, 관계 문제, 감정 반응 등을 연기하며 경험해 보는 기법입니다. 정신과 영역에서는 환자, 보호자, 종사자 모두 에게 상호 이해, 감정 인식, 공감 훈련, 의사소통 기술 향상 등을 위해 활용됩니다.

역할극을 통해 조별 토론으로는 얻기 어려운 소중한 경험을 직접 체험하며, '회복 의사소통 기술'을 몸으로 익히는 것은 매우 중요합니다.

조별 토론과 역할극의 특징 비교 (표)

구 분	조별 토론	역 할 극
접근 방식	말로 설명하고 듣는 방식	직접 상황을 행동으로 재현
학습 방식	인지적 이해 중심	정서적/신체적 체험 중심
관점 전환	타인의 말로 이해	타인의 몸과 감정으로 직접 경험
안전성	감정 개입이 상대적으로 적음	감정 개입이 크지만, 안전한 환경에서 가능
효과	서로의 생각 차이를 알고 조율	갈등 상황 속 감정과 반응을 통째로 체험



활동내용

진행자는

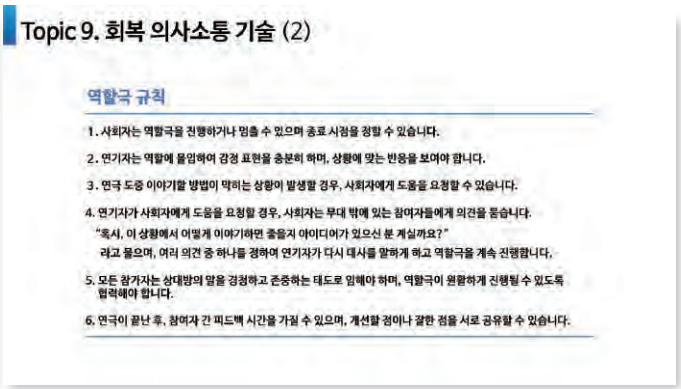
역할극을 진행하기로 결정되었다면, 진행자는 아래와 같은 멘트로 역할극을 시작할 수 있습니다.

"지금까지는 사례를 중심으로 서로의 생각과 입장을 말로 나누는 토론을 해왔습니다. 이번에는 서로의 입장을 직접 연기하며 체험해 보는 '역할극'을 해보려 합니다.

말로는 쉽게 표현할 수 없었던 감정과 태도, 무심코 지나쳤던 말투나 시선의 차이를 직접 느껴보는 경험이 될 수 있을 것입니다. 실수를 해도 괜찮습니다. 우리는 여기서 '정답'을 찾는 것이 아니라, 회복의 의사소통이란 어떤 것인지 몸으로 배우는 과정을 함께 하고자 합니다."

활동단계 전개




Topic 9. 회복 의사소통 기술 (2)

역할극 규칙

1. 사회자는 역할극을 진행하거나 멈출 수 있으며 종료 시점을 정할 수 있습니다.
2. 연기자는 역할에 몰입하여 감정 표현을 충분히 하며, 상황에 맞는 반응을 보여야 합니다.
3. 연극 도중 이야기할 방법이 막히는 상황이 발생할 경우, 사회자에게 도움을 요청할 수 있습니다.
4. 연기자가 사회자에게 도움을 요청할 경우, 사회자는 무대 밖에 있는 참여자들에게 의견을 묻습니다.
"혹시, 이 상황에서 어떻게 이야기하면 좋을지 아이디어가 있으신 분 계실까요?"
라고 물으며, 여러 의견 중 하나를 정하여 연기자가 다시 대사를 말하게 하고 역할극을 계속 진행합니다.
5. 모든 참가자는 상대방의 말을 경청하고 존중하는 태도로 임해야 하며, 역할극이 원활하게 진행될 수 있도록 협력해야 합니다.
6. 연극이 끝난 후, 참여자 간 피드백 시간을 가질 수 있으며, 개선할 점이나 잘한 점을 서로 공유할 수 있습니다.

역할극 소개

진행자는

먼저 역할극의 정의, 특징 그리고 치료적 적용에 대해 설명합니다.
이후, 역할극의 4단계 순서를 다음과 같이 안내합니다.

① 상황 설정
- 가장 먼저, 역할극의 상황을 설정합니다.
- 특정 상황을 진행자가 지정할 수도 있고, 참여자가 자신의 실제 상황을 제안해 구성할 수도 있습니다.
- 다만, 역할극은 안전한 환경에서 진행되는 것이 중요하므로, 진행자가 통제할 수 있는 '지정된 상황'을 사용하는 것을 권장합니다.

② 상황극 진행
- 설정된 상황에 따라 역할극을 진행합니다.
- '1:1 상황극': 두 사람만 역할을 맡고 나머지는 지켜봅니다.
- '1:다수 상황극': 상황극 도중 청중이 중간에 개입하거나 의견을 제시할 수 있습니다.

③ 소감 나누기
- 상황극이 끝난 후, 연기를 한 참여자들과 지켜본 관람자들이 각자의 소감을 공유합니다.
- 역할을 수행한 사람의 감정과 인식, 관찰자의 시선과 인상을 함께 나눔으로써 다각적인 이해가 가능해집니다.

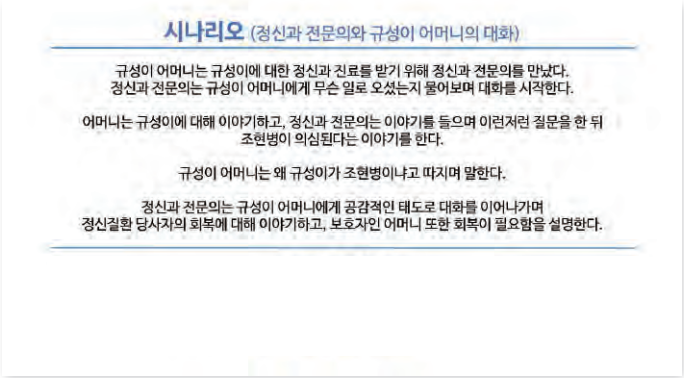
④ 회복 요소 찾기
- 상황극과 소감 나눔에서 등장한 말, 태도, 감정, 반응 등을 바탕으로 회복적 의사소통의 요소들을 찾아보고, 일상에 적용 가능한 실천 전략을 함께 고민해 봅니다.

이어서, 역할극 규칙을 슬라이드를 참고하여 설명합니다.

Tips.

- 역할극에서는 진행자의 개입과 조율이 매우 중요합니다.
연기자들의 표현이 너무 가볍거나 지나치게 무겁지 않도록 균형을 유지할 수 있게 도와야 하며,
필요 시 역할극을 잠시 멈추고 무대 밖 참여자들에게 다양한 의견을 물은 뒤, 그 중 연기자가 가장 공감하는 의견을 선택해 반영하며 역할극을 이어가도록 안내합니다.
- 이를 효과적으로 진행하기 위해서는 역할극 규칙 중
  - '3. 연극 도중 이야기 흐름이 막힐 경우…'
  - '4. 연기자가 사회자에게 도움을 요청할 경우…'
  에 해당하는 조항을 적극적으로 활용해야 합니다.

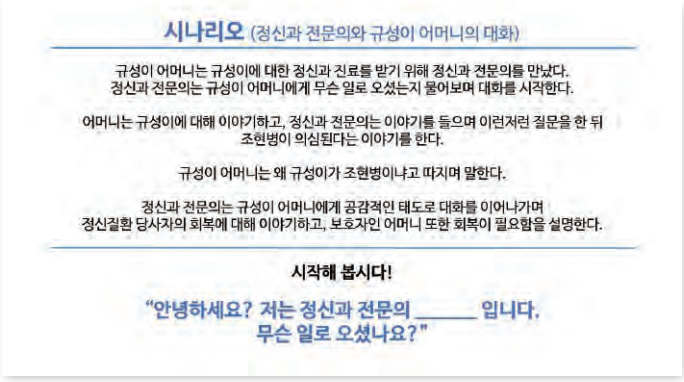
활동단계 전개



시나리오 소개



연기자 지원



역할극 시작 (20~30분)

활동내용

진행자는
늘 함께 살펴본 규성씨 어머니의 이야기에서 이어지는 장면을 바탕으로 역할극을 진행할 것임을 안내합니다.

이야기의 마지막 장면은, 규성씨와 어머니가 진료를 받기 위해 병원 엘리베이터를 탔고, 엘리베이터 거울 속에서 자신의 모습을 마주한 상황이었습니다.

→ 이제 역할극은, 엘리베이터 이후 규성씨 어머니와 정신건강의학과 전문의가 나누는 대화로 이어집니다.

진행자는
시나리오 소개 이후, 규성이 어머니를 해보거나, 정신과 전문의 연기를 할 연기자를 지원받습니다.

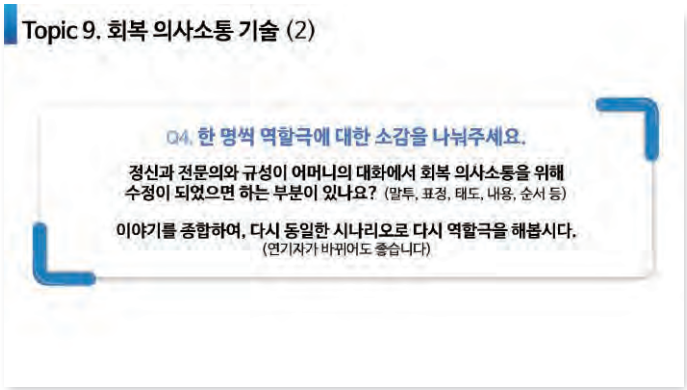
Tips.
지원자가 적다면, 역할극 경험이 있는 종사자에게 역할 중 하나를 맡겨도 좋습니다.

진행자는
연기자가 정해졌다면, 슬라이드에 제시된 정신건강의학과 전문의의 첫 대사로 역할극을 시작하도록 안내합니다.

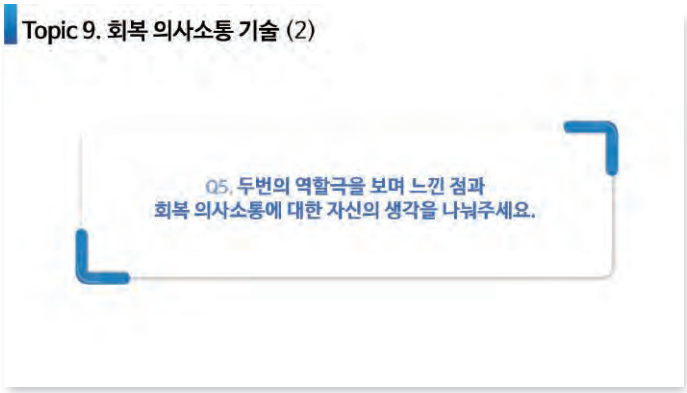
Tips.
참여자들이 시나리오 설명을 통해 전체 내용을 이미 알고 있기 때문에, 역할극의 시작 시점을 혼동할 수 있습니다.

이럴 경우, 진행자는 역할극이 시작되는 시점이 '규성씨와 어머니가 엘리베이터에서 내려 정신과 전문의를 처음 만나는 장면'임을 명확히 안내해 주는 것이 좋습니다.

활동단계 전개



Q4. 한 명씩 역할극에 대한 소감을 나눠주세요. (20~30분)



Q5. 두번의 역할극을 보며 느낀 점과 회복 의사소통에 대한 자신의 생각을 나눠주세요. (20~30분)

활동내용

진행자는

역할극이 끝난 후, 진행자는 연기자에게 격려의 말을 전하며 박수를 유도합니다.

이어, 역할극에 함께 참여한 모든 참여자들에게도 감사와 격려의 뜻으로 다시 한 번 박수를 유도합니다.

그 다음, 연기자를 포함한 모든 참여자들에게 관람 소감을 자유롭게 나눌 수 있도록 요청하고, 회복 의사소통의 관점에서 수정되었으면 좋겠다고 느낀 부분이 있다면 자유롭게 이야기해 달라고 안내합니다.

두번째 역할극 진행 (20~30분)

참여자들의 소감과 회복 의사소통 관점에서의 제안(회복 요소 찾기)를 충분히 나눈 뒤, 그 의견들을 바탕으로 동일한 상황의 역할극을 다시 한 번 진행합니다.

진행자는

두 번째 역할극이 끝난 후, 진행자는 처음과 마찬가지로 연기자와 역할극에 참여한 모든 이들에게 격려의 박수를 유도합니다.

이어, 연기자를 포함한 전체 참여자들에게 관람 소감을 자유롭게 나눌 수 있도록 요청하고, 회복 의사소통의 관점에서 수정되었으면 좋겠다고 느낀 부분이 있다면 편하게 이야기해 달라고 안내합니다.

마지막으로, 진행자는 참여자들이 함께 찾아낸 회복의 요소들을 정리하여 간단히 요약하고 설명합니다.

활동단계 정리

Topic 9. 회복 의사소통 기술 (2)



리킨들 REKINDLE, 정신질환 당사자, 그들에게 필요한 것은? (cf. 오픈 다이얼로그)
https://www.youtube.com/watch?v=JeibmoCsZ7k

대화를 위한 대화의 회복

영상 시청 (2:36)

출처: https://www.youtube.com/watch?v=JeibmoCsZ7k

모두 한마디!



"오늘 함께한 시간에 대해 참여한 모두의 이야기가 궁금합니다."

모두 한마디

Topic 9. 회복 의사소통 기술 (2)

다음시간,
Topic 10. 회복의 별



회복 의사소통을 하는 당신,
다음 시간에 또 만나요!

다음 Topic 소개

활동내용

진행자는

'회복 의사소통 기술 (1)/(2)'을 마무리하며, 핀란드에서 시작된 '오픈 다이얼로그(Open Dialogue)'를 소개하는 영상을 시청합니다.

→ 이를 통해 '대화를 위한 대화'의 회복이 왜 중요한지를 다시 한 번 상기시킵니다.

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.

· 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.
· 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 이야기를 한마디씩 듣는 시간을 가지는 것을 권장합니다.

Tips.

· 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
· 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
· "회복 의사소통을 하는 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

역할극

본 센터에서는 한 보호자가 조현병 당사자인 아내와의 대화에서 느끼는 어려움을 공유하며, 해당 주제를 상황극으로 다루기를 희망했습니다. 이에 당사자인 아내는 자신의 사례가 참여자들 앞에서 상황극으로 활용되는 것에 동의하였고, 종사자 중 한 명이 아내 역할을 맡아 보호자와 함께 첫번째 상황극을 진행하였으며, 이후 참여자 모두의 소감을 듣고 두번째 상황극은 동일 인물이 역할을 바꾸어 진행했습니다. 아래의 표는 두번째 상황극에 대한 주요 내용 정리입니다.

상 황	**대상 : 당사자, 그의 남편** 당사자는 본인의 남편이 외도를 하고 있다고 의심하거나 교회에서 뒷돈을 받아 숨기고 있다고 의심하는 상황.
상황극	**아내역할(남편), 역할(종사자)** 아내 : 당신이 다른 여자랑 몰래 바람폈지? 교회에서 뒷돈 받아서 나한테 숨기고 있었지? 왜 연락을 안받니 다른 여자랑 연락을 하고 있었던거니? 남편 : 내가 누구랑 바람을 펴 일하고 오느라 연락을 못 받았어. 그런 돈이 어디 있어 내가 돈을 받았으면 얘길 했겠지. 일 하는데 전화를 못 받을 수도 있지 이제 그만 좀 해.
소 감	· 남편이 아내의 망상으로 인한 스트레스를 많이 받았을 것 같다 그래도 그 사람이 왜 그런 생각으로 얘기했는지 마음을 알면 좋겠다. · 아내는 남편이 무조건 적으로 그 행동을 했다고 의심하고 화내지 않고 차분하게 본인의 생각을 얘기하는게 좋을 것 같다. · 남편이 정말 힘들 것 같다. · 아내가 의심하는게 힘들 수 있지만 그 비롯된 마음은 남편을 사랑하기 때문이라고 생각한다. 남편도 가족으로서 보듬어주는게 필요할 것 같다.

역할극이 진행되는 동안, 이야기의 주인공인 당사자 아내는 남편과 종사자가 번갈아 가며 자신의 이야기를 연기하는 모습을 조용히 지켜보았습니다. 상황극이 끝나고 소감을 나누는 시간, 잠시 머뭇거리던 그녀는 조용히 이렇게 말했습니다.

"저는 남편을 정말 사랑합니다"

그 고백은 현장에 있던 모든 참여자에게 깊은 울림을 전했고, 당사자와 남편 모두에게 따뜻한 공감과 실질적인 지지를 전하려는 움직임으로 자연스럽게 이어졌습니다. 이후, 두 사람은 서로에 대한 더 깊은 이해를 바탕으로 새로운 의사소통을 위한 구체적인 약속과 규칙을 함께 정하며 역할극을 마무리했습니다.

10 Topic 10. 회복의 별



핵심목표

지금 내 상태에 맞춘 회복의 별을 작성해 볼 수 있다.

핵심질문

① 회복의 별이란?

② 회복의 별을 구성하는 8가지 요소의 의미란?

③ 나의 회복의 별은?

당사자, 보호자, 종사자 모두 스스로 빛을 내기에 충분한 존재이다.

핵심내용

① 회복의 별 작성 방법을 익혀, 추후에도 스스로 자신의 회복 여정을 기록해 나갈 수 있도록 합니다.

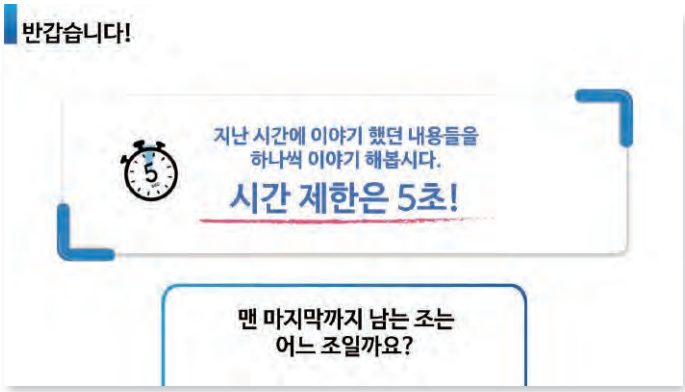
② 회복의 별을 작성할 때에는, 자신의 삶에 실천할 수 있는 현실적이고 개인 맞춤형 계획으로 구성하는 것이 중요합니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 Topic 10. '회복의 별'
  최소 당사자 1인당 3부 이상 준비한다.
  이를 통해 추후에도 당사자가 스스로 회복의 별을 작성하며 자신의 회복 여정을 기록해 나갈 수 있도록 돕습니다.
- ☐ 필기구 : 1인당 서로 다른 색의 펜을 2개 이상
- ☐ 프로그램 환경조성
  - 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 조별활동 책상배치
  - 당사자를 중심으로 2~3인이 함께 앉을 수 있도록 책상을 배치한다.
  - 조별 활동이 아니므로, 사전에 조를 나눌 필요는 없다.
  - 당사자는 보호자와 함께 앉는 것을 원칙으로 하되, 종사자가 추가로 함께 참여할 수 있다.
  - 보호자가 참석하지 않은 경우에는, 당사자를 잘 아는 종사자가 보호자 자리에 함께 앉는다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 60분 입니다.**

활동단계 도입



이어말하기 게임







회복의 별

활동내용

진행자는

이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어 말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

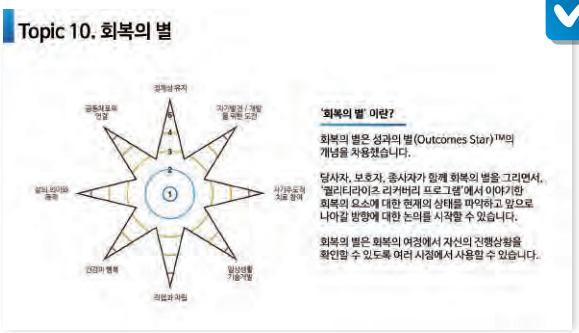
오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 전개

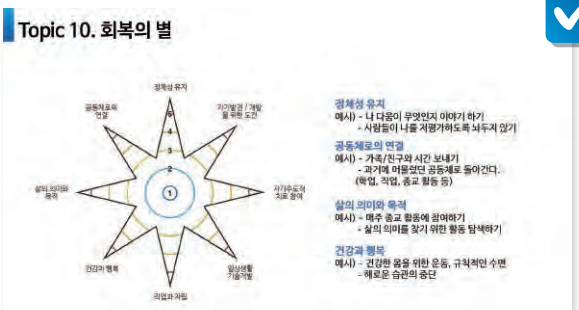


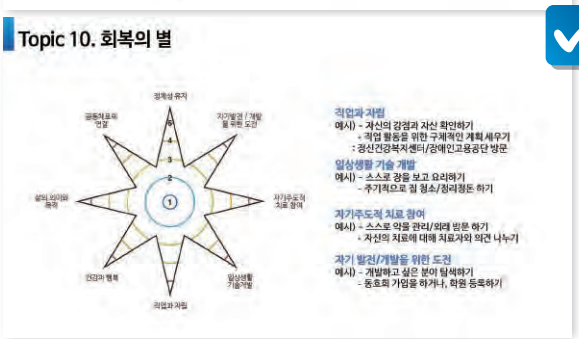
별이 빛나는 밤



회복의 별 소개 [39)-41)]

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 12: Recovery Wheel)





회복의 별을 이루는 8가지 요소

활동내용

진행자는
그림을 활용해 참여자의 관심을 이끌어냅니다.

예)
- 이 그림에 대해 알고 계신 분이 있을까요?
- 이 그림을 보며 어떤 느낌이 드시나요?
- (그림의 특정 부분을 가리키며) 이 부분은 무엇을 표현한 것 같나요? 왜 이렇게 그려졌을까요?

진행자는
슬라이드 내용을 바탕으로, '회복의 별'이 '성과의 별' 개념을 차용한 것임을 설명하고, 이를 통해 Topic 9까지 함께 나눈 토론과 이야기를 실제 삶에 적용할 수 있음을 안내합니다.

진행자는
슬라이드 내용을 바탕으로 '회복의 별'을 구성하는 8가지 요소를 예시와 함께 설명합니다.

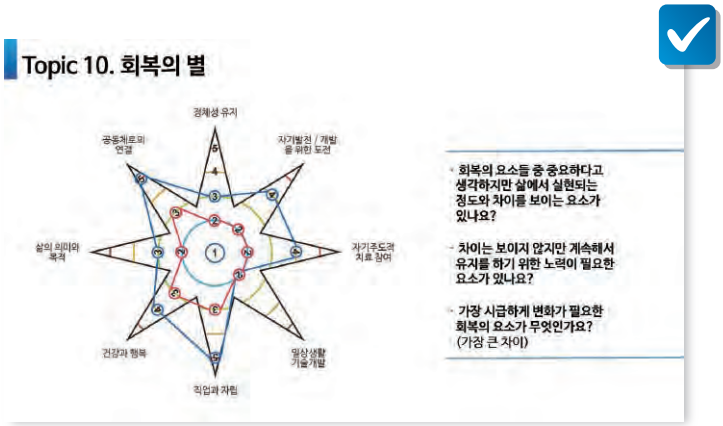
활동단계 전개



활동 1. 각 항목별 중요도 표시하기 (10분)



활동 1. 각 항목별 중요도 표시하기 (10분)



활동 1과 활동 2의 간극 살펴보기

활동내용

진행자는

이전 슬라이드에서 소개한 8가지 회복 요소들이 각자의 삶에서 얼마나 중요한지 생각해 보고, 각 항목에 대해 1~5점으로 표시해 달라고 안내합니다.
(슬라이드에 제시된 중요도 척도 설명을 참고하세요.)

점수를 모두 표시한 후에는, 해당 점들을 선으로 연결해 '회복의 별' 그림을 완성해 보도록 요청합니다.

진행자는

활동 1과 동일한 방식으로, 8가지 회복 요소들이 각자의 삶에서 얼마나 실현되고 있는지를 생각해 보고, 각 항목에 대해 1~5점으로 표시해 달라고 안내합니다.

(슬라이드에 제시된 중요도 실현 정도 설명을 참고하세요.)

모든 항목에 점수를 표시한 후에는, 활동 1과 마찬가지로 점들을 선으로 연결하여 '회복의 별' 그림을 완성해 보도록 요청합니다.

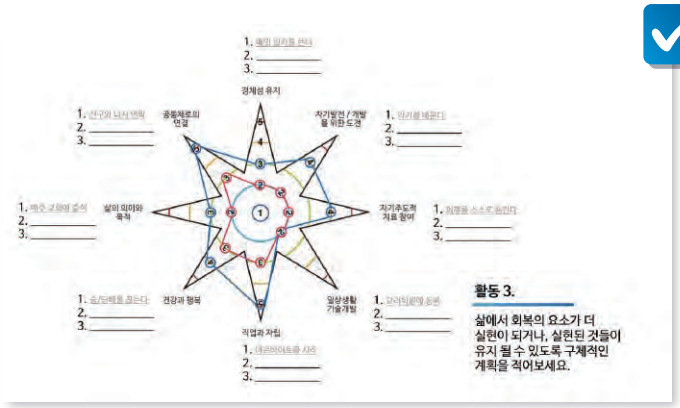
활동 1과의 구분을 위해, 반드시 다른 색의 펜을 사용해 주세요.

진행자는

활동 1과 활동 2 사이의 차이를 '가치와 현실 사이의 간극'이라고 표현할 수 있음을 설명합니다.

① 먼저, 간극이 큰 항목이 무엇인지 참여자 스스로 확인해보도록 안내합니다.
② 그 다음, 간극은 크지 않지만 지속적인 노력이 필요한 요소가 무엇인지 살펴보도록 합니다.
③ 마지막으로, 현재 가장 시급하게 변화가 필요한 요소가 무엇인지 표시해 보도록 안내합니다.

활동단계 전개



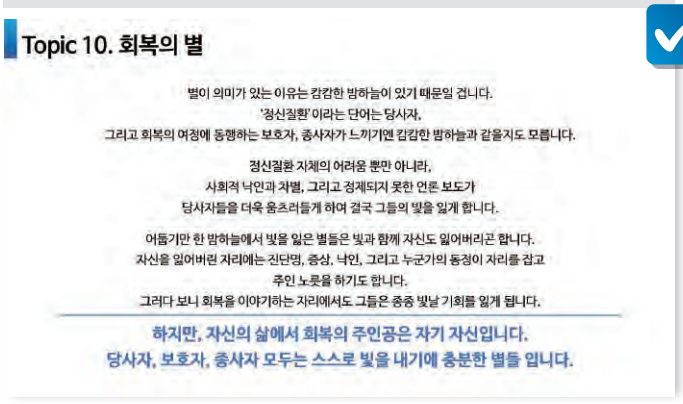
활동 3. 간극을 줄이기 위한 구체적인 계획 작성 (20분)

활동단계 정리



영상 시청 (11:07)

출처: https://www.youtube.com/watch?v=OQKG_yhnYW4



스스로 빛을 내기에 충분한 별

활동내용

진행자는

활동 1과 활동 2의 작성 결과를 바탕으로, 가치와 현실 사이의 간극을 메우기 위한 구체적인 계획을 수립하도록 안내합니다. 참여자들이 각 요소별 계획 수립에 어려움을 느낄 경우, 슬라이드에 제시된 예시(회색 글씨)를 참고하도록 도와줄 수 있습니다.

이 계획은 당사자가 실제 삶에서 실천하는 것을 목적으로 하기 때문에, 반드시 당사자의 상황에 맞는 현실적이고 실현 가능한 맞춤형 계획이 될 수 있도록 당부합니다.

Tips.

· 진행자는 '회복의 별' 활동 1부터 활동 3까지를 한꺼번에 설명하고, 이후 일괄적으로 활동을 진행하도록 안내할 수도 있습니다.

· 그러나 이 경우, 참여자마다 작성 시간이 크게 달라질 수 있고, 집중력이 분산되어 그룹치료의 구조화가 흐트러질 위험이 있습니다.

· 따라서 각 활동별로 시간을 명확히 안내하고, 활동이 끝난 후에는 참여자들이 자신이 그렇게 표시한 이유를 간단히 나눌 수 있도록 하면, 그룹의 집중도를 유지하고 구조화된 치료 환경을 지키는 데 도움이 됩니다.

진행자는

오늘 프로그램 시작 시 함께 보았던 그림에 대한 설명과 그 속에 담긴 이야기를 소개하는 영상을 함께 시청하며, 오늘 참여자들이 완성한 '회복의 별'의 의미와 목적을 다시 한 번 상기시킵니다.

영상 시청 후, 진행자는 슬라이드의 글을 천천히 읽어주며 당사자, 보호자, 종사자 모두는 스스로 빛을 내기에 충분한 별들이라고 이야기 합니다.

활동단계 정리



모두 한마디!



다음 Topic 소개

활동내용

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.

- 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.
- 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 한마디씩을 듣는 시간을 꼭 지키는 것을 권장합니다.

Tips.

- 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.
- 각 과마다 ' 당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.
- "별처럼 빛나는 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

11 Topic 11. 회복 계획(1)



핵심목표

나의 목표와 실질적인 실천 전략을 담은 회복 계획을 작성해 볼 수 있다.

핵심질문

① 회복계획이란?

당사자와 지지자가 함께, 꿈과 목표를 위한 그리고 '건강한 나'를 유지하기 위한 회복 계획을 작성한다.

핵심내용

① 회복 계획은 당사자 중심의 문서로, 당사자의 현재 상태를 파악하고 앞으로 나아갈 방향을 제시하는 삶의 이야기가 담긴 계획서입니다.

② 이 회복 계획의 두 축은 1) 당사자의 꿈과 목표, 2) '건강한 나'의 상태를 유지하기 위한 실질적인 실천 전략이며, 이는 당사자 스스로의 노력과 지지자의 역할을 함께 담고 있습니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 Topic 11. '회복 계획'
  최소 당사자 1인당 2부 이상 준비한다.
  (이를 통해 당사자와 보호자가 추후에도 자신의 회복 계획을 작성하며, 앞으로 나아가야 할 방향을 스스로 기록해 나갈 수 있도록 돕습니다.)
- ☐ 필기구
- ☐ 프로그램 환경조성
  - 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 자리배치
  - 당사자를 중심으로 2~3인이 함께 앉을 수 있도록 책상을 배치한다.
  - 조별 활동이 아니므로, 사전에 조를 나눌 필요는 없다.
  - 당사자는 보호자와 함께 앉는 것을 원칙으로 하되, 종사자가 추가로 함께 참여할 수 있다.
  - 보호자가 참석하지 않은 경우에는, 당사자를 잘 아는 종사자가 보호자 자리에 함께 앉는다.

참·고·사·항

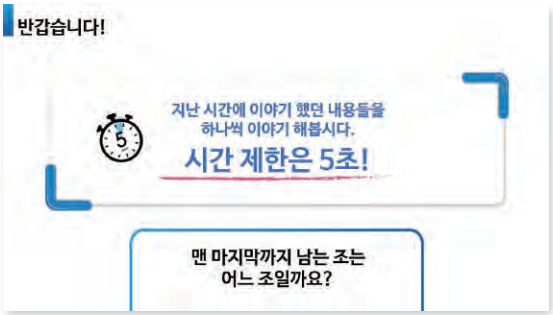
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다)

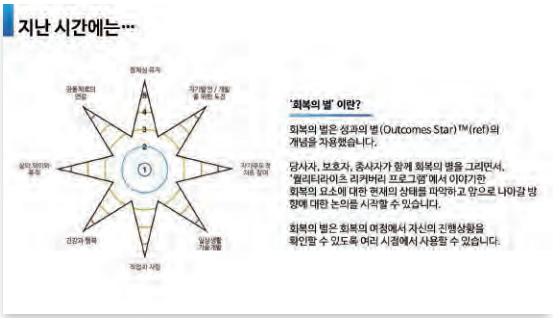
1. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 240분 입니다.**

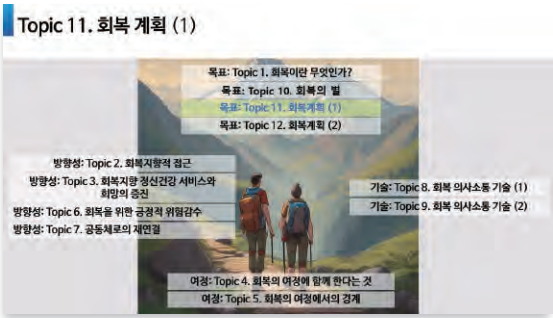
활동단계 도입



이어말하기 게임



지난 시간에는…



회복 계획(1)

활동내용

진행자는

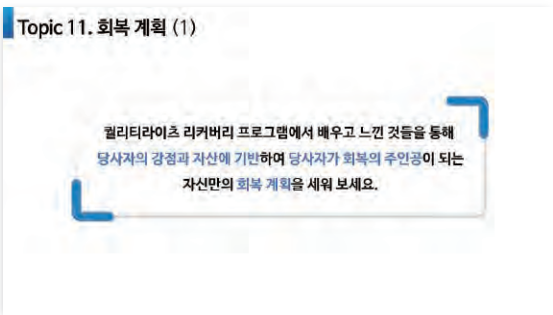
이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

활동단계 전개

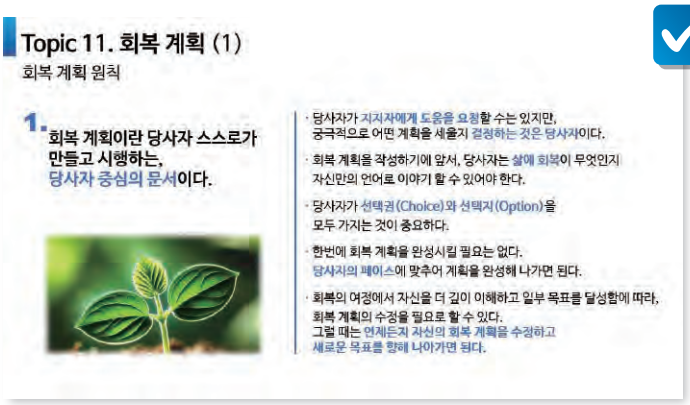


회복 계획(1)

활동내용

슬라이드에 제시된 내용을 참고하여, 오늘 진행할 회복 계획 작성에 대해 설명합니다.

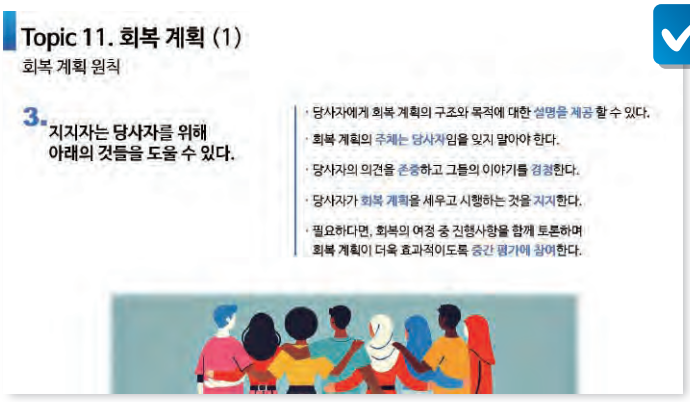
활동단계 전개



회복 계획 원칙 1 42)-45)



회복 계획 원칙 2 42)-45)



회복 계획 원칙 3 42)-45)

활동내용

진행자는

회복 계획을 작성하기에 앞서, 당사자와 보호자가 함께 이해해야 할 회복 계획 작성의 원칙을 설명합니다.

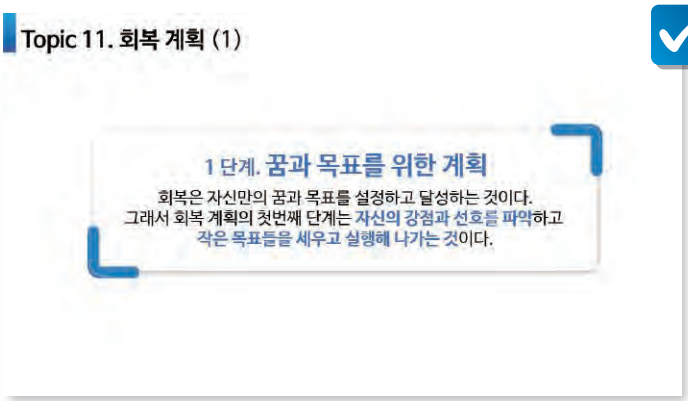
첫째, 이 문서가 '당사자의 언어'로 쓰이고, '당사자가 선택'하며, '당사자의 속도와 상황'에 맞추어진, 철저히 '당사자 중심'의 계획이어야 한다는 점입니다.

둘째, 이 문서는 당사자의 필요, 강점, 그리고 자산을 기반으로 작성된다는 점입니다.

셋째, 당사자와 함께 회복 계획을 작성하는 지지자(보호자/종사자)를 위한 지침입니다.

보호자와 종사자는 'Topic 4. 회복의 여정에 함께한다는 것'과 'Topic 5. 회복의 여정에서의 경계'에서 나누었던 내용을 떠올리며, 지지자이자 조력자의 역할에 충실할 것을 요청합니다.

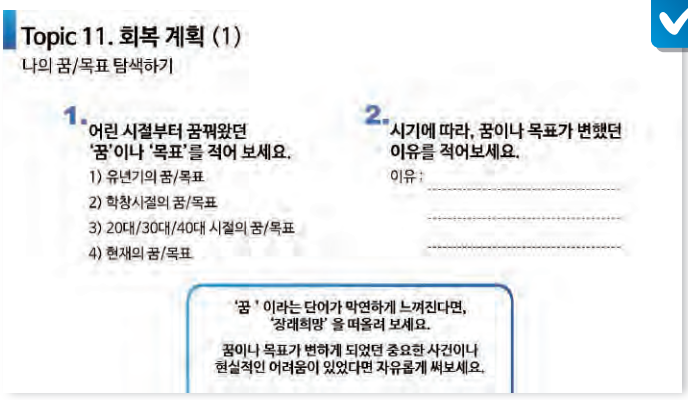
활동단계 전개



1 단계: 꿈과 목표를 위한 계획



도식을 통한 1 단계 설명



나의 꿈/목표 탐색하기 (20분)

Tips.

· '꿈'이라는 단어가 막연하게 느껴질 경우, '장래희망'을 떠올려 보도록 안내합니다.

· 2번 문항 작성에 어려움을 느낀다면, 꿈이나 목표가 변하게 된 중요한 사건이나 현실적인 어려움이 있었다면 그것을 중심으로 작성해 보도록 안내합니다.

활동내용

진행자는 꿈과 목표를 설정하고 이루기 위한 첫걸음은, 자신의 강점과 선호를 파악하는 것임을 설명합니다.

Tips.

· '회복의 별' 활동과 마찬가지로, 회복 계획도 처음부터 끝까지 한 번에 설명하고 작성하게 하기보다는, 각 단계를 나누어 진행하는 것이 좋습니다.

· 각 문항마다 시간을 정해주고, 그 시간 안에 작성한 후 자신이 쓴 내용을 발표하고, 다른 참여자의 발표도 들은 뒤 다음 단계로 넘어가는 방식을 권장합니다.

→ 이러한 방식은 참여자들이 더 집중력 있게 회복 계획을 작성하는 데 도움이 됩니다.

진행자는 슬라이드에 제시된 도식을 활용하여 회복 계획 작성의 1단계를 설명합니다.

· 처음부터 큰 목표를 설정하는 것은 쉽지 않습니다.

· '꿈'이나 '목표'라는 단어 자체가 막연하게 느껴질 수 있기 때문에, 먼저 자신의 강점과 선호를 파악하는 것부터 시작합니다.

· 강점과 선호에 대한 탐색이 이루어졌다면, 이를 바탕으로 작은 목표들을 세워볼 수 있습니다.

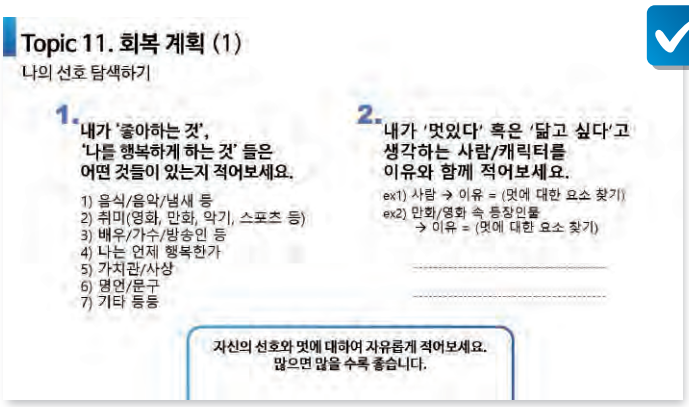
· 이 목표들은 달성될 수도, 달성되지 않을 수도 있습니다. 이때 'Topic 6. 긍정적 위험감수'에서 다루었던 내용을 떠올려보세요. : 목표를 설정한다는 것은 실패할 수도 있다는 위험을 감수하는 것이며, 그 속에서 우리는 중요한 배움과 경험을 얻게 됩니다.

· 이러한 경험들이 쌓이면 점차 더 크고 의미 있는 목표로 나아갈 수 있게 됩니다.

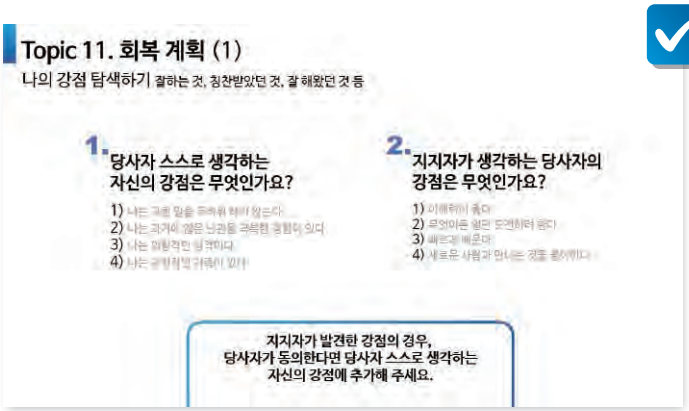
· 그리고 이 과정이 반복되면서, 결국에는 스스로 큰 목표를 세울 수 있는 힘에 도달하게 됩니다.

진행자는 참여자들에게 1번과 2번 문항을 주어진 시간 내에 작성하도록 안내합니다. 대부분의 참여자들이 작성을 마친 것으로 판단되면, 남은 시간에 따라 모든 참여자에게 발표를 요청하거나, 자발적으로 발표를 희망하는 참여자 또는 진행자가 지정한 몇몇 참여자에게 자신이 작성한 내용을 발표해 달라고 요청합니다.

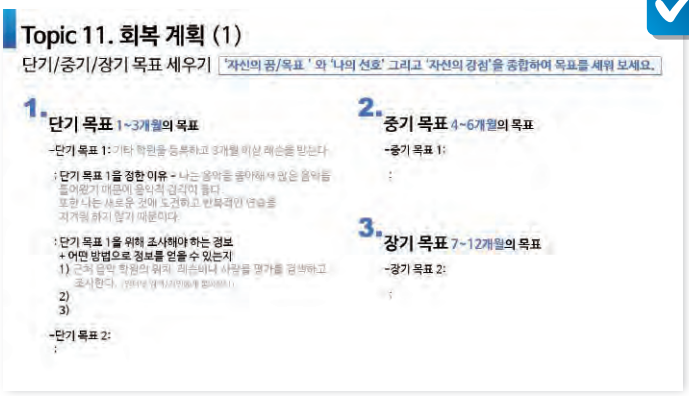
활동단계 전개



나의 선호 탐색하기 (20분)



나의 선호 탐색하기 (20분)



단기/중기/장기 목표 세우기 (20분)

활동내용

진행자는 꿈과 목표 작성에 이어, 선호와 관련된 1번과 2번 문항을 주어진 시간 내에 작성하도록 안내합니다. 대부분의 참여자들이 작성을 마친 것으로 판단되면, 남은 시간에 따라 모든 참여자에게 발표를 요청하거나, 자발적으로 발표를 희망하는 참여자 또는 진행자가 지정한 몇몇 참여자에게 자신이 작성한 내용을 발표해 달라고 요청합니다.

Tips.
선호에 대한 발표는 스스로를 정의하는 데 매우 중요한 과정입니다. 시간이 다소 부족하더라도, 당사자들이 자신의 선호에 대해 참여자들 앞에서 발표할 수 있도록 하는 것을 권장합니다.

진행자는 선호 작성에 이어, 강점과 관련된 1번과 2번 문항을 주어진 시간 내에 작성하도록 안내합니다. 대부분의 참여자들이 작성을 마친 것으로 판단되면, 남은 시간에 따라 모든 참여자에게 발표를 요청하거나, 자발적으로 발표를 희망하는 참여자 또는 진행자가 지정한 몇몇 참여자에게 자신이 작성한 내용을 발표해 달라고 요청합니다.

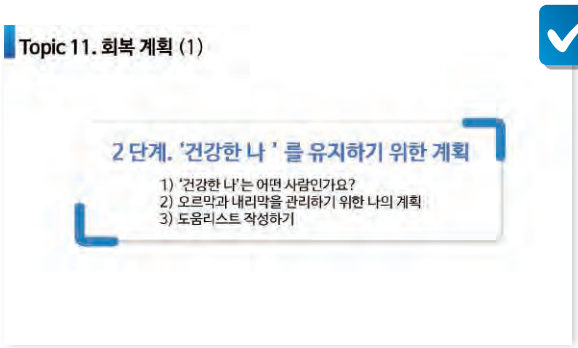
Tips.
1번 문항을 통해 당사자가 스스로 발견한 강점과, 2번 문항을 통해 보호자나 종사자가 발견한 강점은 서로 다를 수 있습니다. 이 경우, 당사자가 동의한다면 2번 문항의 일부 내용을 1번 문항에도 함께 기록할 수 있습니다.

진행자는 슬라이드의 내용을 바탕으로, 1~3개월 이내에 성취 가능한 단기 목표, 4~6개월 이내의 중기 목표, 그리고 약 1년 정도의 시간이 필요한 장기 목표를 각각 작성하도록 안내합니다.

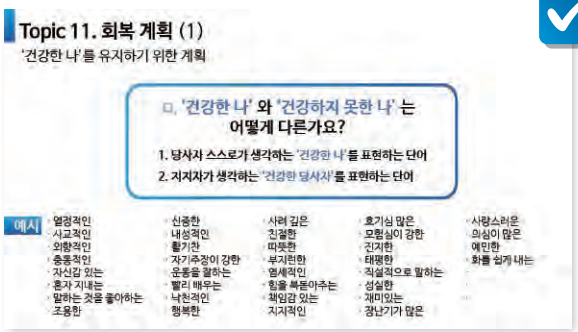
Tips.
· 일부 당사자들이 막연하고 이상적인 목표를 세우지 않도록 유의하며, 지극히 개인적인 자신의 삶이 반영된 현실적인 목표를 세울 수 있도록 돕습니다.

· 또한, 그 목표를 이루기 위해 필요한 구체적인 정보나 방법을 함께 고민해보고, 스스로 동기를 부여할 수 있도록 '왜 이 목표를 세웠는지'에 대한 이유를 적도록 안내합니다.

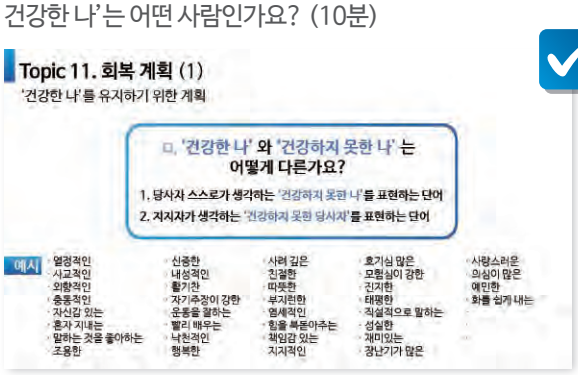
활동단계 전개



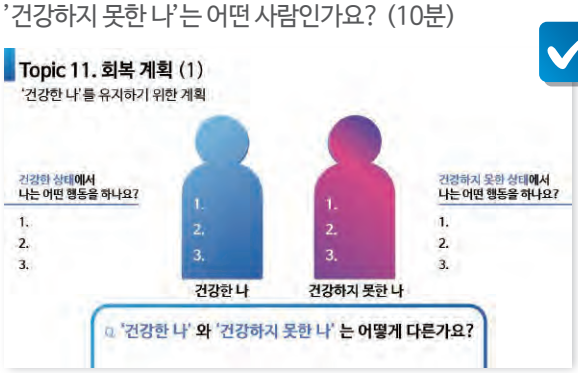
2 단계: '건강한 나'를 유지하기 위한 계획



건강한 나'는 어떤 사람인가요? (10분)



'건강하지 못한 나'는 어떤 사람인가요? (10분)



'건강한 나' vs '건강하지 못한 나' (10분)

활동내용

진행자는

"꿈과 목표를 이루기 위해서는 '건강한 나'를 유지하는 것이 중요합니다.
이제, 건강한 나를 유지하기 위한 구체적인 회복 계획을 함께 세워봅시다."

진행자는

"슬라이드에 제시된 예시를 참고하여, 당사자가 생각하는 '건강한 나'와 지지자가 생각하는 '건강한 당사자'를 각각 형용사 3개 이상으로 표현해 봅니다.

작성 후, 당사자와 지지자가 선택한 형용사가 유사한지 살펴보고, 만약 서로 다른 단어를 선택했다면 왜 그렇게 생각했는지 구체적인 예시를 들어 설명해 봅니다."

Tips.

· 막연히 긍정적이고 이상적인 단어보다는, 실제로 '건강한 당사자의 모습'을 잘 드러낼 수 있는 형용사를 선택할 수 있도록 안내합니다.
· 또한, 당사자와 지지자가 서로 다른 형용사를 선택했다면, 이는 서로가 미처 인식하지 못한 새로운 모습을 발견했거나, 서로에 대한 기대가 달랐기 때문일 수 있음을 설명해 주세요.

진행자는

"'건강한 나'에 대해 작성했던 방식과 동일하게, 이번에는 당사자와 지지자가 함께 당사자의 '건강하지 않은 상태'를 나타내는 형용사를 선택해 봅니다."

진행자는

그 후, '건강한 나'와 '건강하지 않은 나'를 표현하는 형용사를 각각 적고, 그 상태일 때 당사자가 보이는 행동은 무엇인지 함께 작성해 보도록 안내합니다.

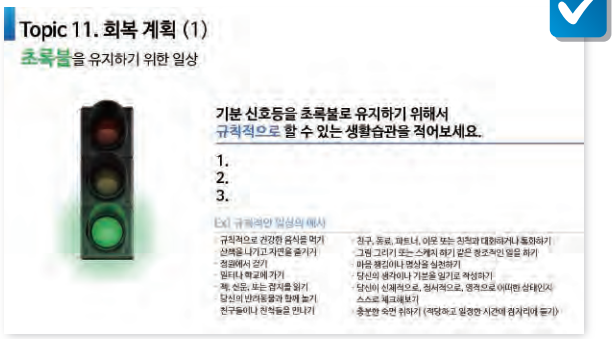
1부 끝 시간 부족 시

활동단계 전개



기분신호등

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)



초록불을 유지하기 위한 일상 1 (10분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)



초록불을 유지하기 위한 일상 2 (10분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)

활동내용

진행자는

이전 활동에 이어, 건강할 때와 건강하지 않을 때 사용하는 형용사가 크게 다르며, 그에 따라 나타나는 행동 또한 크게 달라진다는 점을 다시 한 번 상기시킵니다. 이후, 건강하지 않은 상태는 갑작스럽게 나타나는 것이 아니라, 신호등처럼 '노란불' 단계를 거쳐 '빨간불'로 진행된다는 점을 설명하며 '기분 신호등' 개념을 소개 합니다.

'기분 신호등'을 통해 현재 자신의 상태를 인식하고, 노란불 단계에서 빨간불로 넘어가지 않도록 하기 위한 전략을 세우는 것이 중요함을 안내합니다.

진행자는

초록불 상태('건강한 나' 상태)를 유지하기 위해 어떤 건강한 습관이 도움이 될 수 있을지, 예시를 활용해 생각해보고 작성하도록 안내합니다.

Tips.

이전 활동들과 마찬가지로, 막연히 긍정적이거나 이상적인 습관을 적기보단, 실제 당사자의 특징과 상황을 고려하여, 실제 삶에서 적용할 수 있을 만한 활동 들을 적게끔 합니다.

진행자는

초록불 상태('건강한 나' 상태)를 유지하기 위해, 실천해야 할 습관 뿐 아니라 피하거나 중단해야 할 습관을 알고 조정하는 것도 중요하다는 점을 설명합니다.

Tips.

당사자의 삶에서 행동 수정이 필요한 부분을 작성할 때, 보호자가 이를 빌미로 당사자를 비난하거나 지나치게 무리한 요구를 하지 않도록 주의해야 함을 함께 안내합니다.

초록불을 유지하기 위한 일상 3

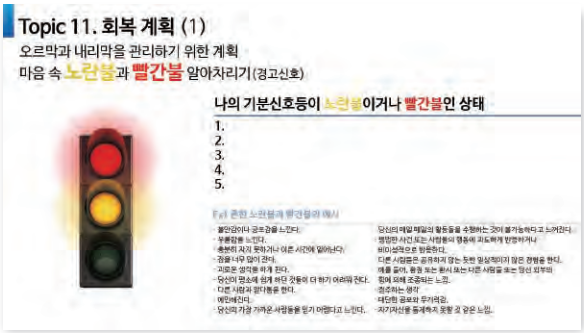
진행자는 시간이 허락된다면, 부록(Topic 11)에 포함된 '초록불을 유지하기 위한 시간표' 작성을 이어서 진행할 수 있습니다. 만약 시간이 부족하다면, 앞서 작성한 '초록불을 유지하기 위한 일상 1, 2' 활동을 바탕으로, 시간표 작성을 숙제로 진행하자고 안내할 수 있습니다.

활동단계 전개



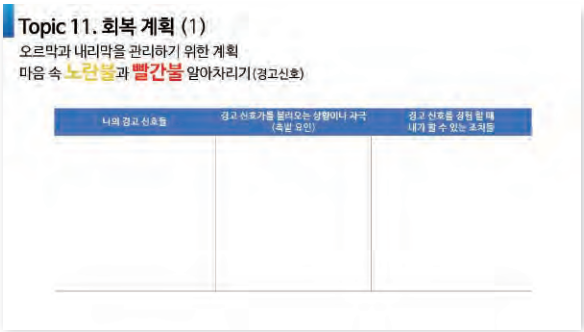
마음속 빨간불과 노란불 알아차리기 [44)]

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)



마음속 빨간불과 노란불 알아차리기1(10분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)



마음속 빨간불과 노란불 알아차리기2(10분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)

활동내용

진행자는

초록불 관련 작성을 마친 후, 노란불과 빨간불에 대한 작성을 시작하기에 앞서, 슬라이드에 제시된 그림을 활용하여 경고신호를 조기에 인식하고 신속하게 대응하는 것이 회복 과정에서 얼마나 중요한지 설명합니다.

진행자는

당사자와 지지자가 함께 논의하여, 당사자의 노란불과 빨간불 상태를 구체적으로 작성하도록 안내합니다.

Tips.

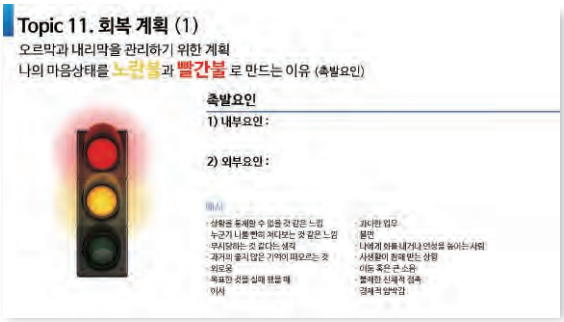
· 노란불 상태와 빨간불 상태는 종종 연속적인 흐름 안에 있기 때문에, 이를 명확히 구분하는 것이 쉽지 않을 수 있습니다.

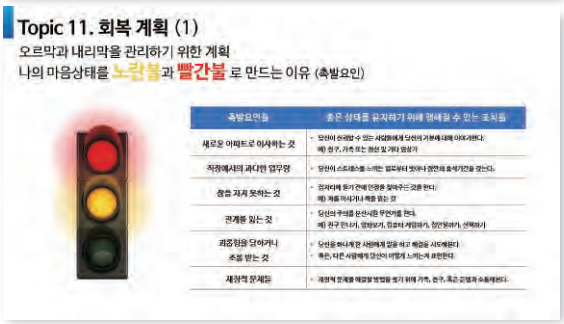
· 그럼에도 불구하고, 가능하다면 두 상태를 구별해 보도록 권유하며, 각 상태의 특징을 구체적으로 떠올릴 수 있도록 도와줍니다.

진행자는

앞선 활동을 정리하는 차원에서, 작성된 경고 신호들을 빈도순으로 다시 정리하고, 각 상황에서 실천할 수 있는 구체적인 대응 방법을 함께 작성하도록 안내합니다.

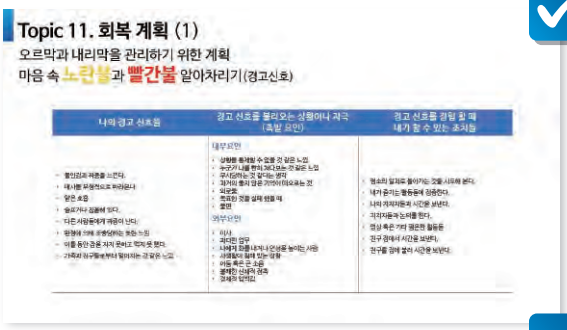
활동단계 전개





마음속 빨간불과 노란불 알아차리기2(20분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)





마음속 빨간불과 노란불 알아차리기3(20분)

참고: World Health Organization. (2019). Recovery practices for mental health and well-being. World Health Organization. (Topic 11: Recovery plans)

활동내용

진행자는

당사자와 지지자가 함께 논의하여, 당사자를 노란불 또는 빨간불 상태로 이끄는 구체적인 원인이나 상황을 함께 탐색하도록 안내합니다.

또한, 확인된 각 촉발 요인에 대해 어떤 방식으로 대처할 수 있을지 구체적인 대응 방법을 작성하도록 안내합니다.

Tips.

· 촉발 요인을 '내부 요인'과 '외부 요인'으로 구분하는 것은 각각에 대한 대처 방향이 달라지기 때문에 매우 중요합니다.

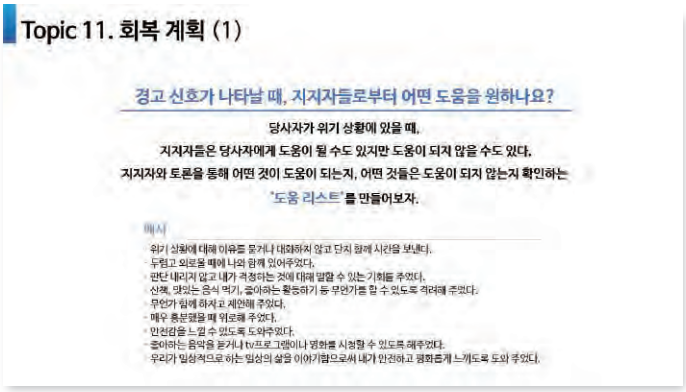
· 하지만 처음부터 이를 명확히 구분하기 어려운 경우에는, 먼저 떠오르는 모든 촉발 요인을 자유롭게 나열한 후, 이후에 내부 요인과 외부 요인으로 분류해보는 방식이 보다 효과적일 수 있습니다.

진행자는

노란불/빨간불 관련 작성을 마무리하는 활동을 소개합니다.

슬라이드에 제시된 예시를 참고하여, 당사자와 지지자가 함께 작성한 내용을 바탕으로 경고 신호, 촉발 요인, 그리고 취할 수 있는 조치들을 한눈에 볼 수 있도록 정리해보도록 안내합니다.

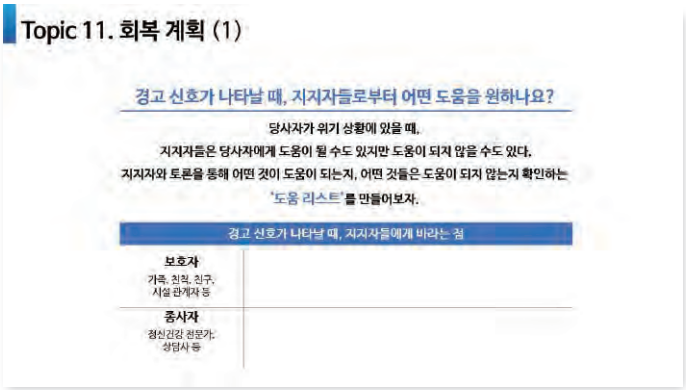
활동단계 전개


Topic 11. 회복 계획 (1)

경고 신호가 나타날 때, 지지자들로부터 어떤 도움을 원하나요?

당사자가 위기 상황에 있을 때,
지지자들은 당사자에게 도움이 될 수도 있지만 도움이 되지 않을 수도 있다.
지지자와 토론을 통해 어떤 것이 도움이 되는지, 어떤 것들은 도움이 되지 않는지 확인하는
'도움 리스트'를 만들어보자.

예시
- 위기 상황에 대해 이유를 묻거나 대화하지 않고 단지 함께 시간을 보낸다.
- 두렵고 외로울 때에 나와 함께 있어주었다.
- 판단 내리지 않고 내가 걱정하는 것에 대해 말할 수 있는 기회를 주었다.
- 산책, 맛있는 음식 먹기, 즐아하는 활동하기 등 무언가를 할 수 있도록 격려해 주었다.
- 무언가 힘에 하지고 제안해 주었다.
- 매우 흥분했을 때 위로해 주었다.
- 안전감을 느낄 수 있도록 도와주었다.
- 좋아하는 음악을 듣거나 tv프로그램이나 영화를 시청할 수 있도록 해주었다.
- 우리가 일상적으로 하는 일상의 삶을 이야기함으로써 내가 안전하고 평화롭게 느끼도록 도와 주었다.

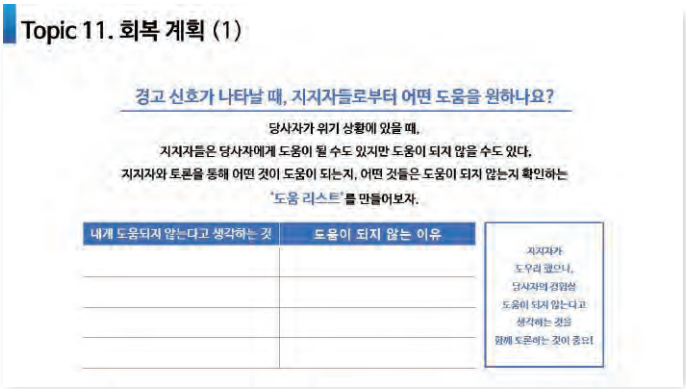

Topic 11. 회복 계획 (1)

경고 신호가 나타날 때, 지지자들로부터 어떤 도움을 원하나요?

당사자가 위기 상황에 있을 때,
지지자들은 당사자에게 도움이 될 수도 있지만 도움이 되지 않을 수도 있다.
지지자와 토론을 통해 어떤 것이 도움이 되는지, 어떤 것들은 도움이 되지 않는지 확인하는
'도움 리스트'를 만들어보자.

경고 신호가 나타날 때, 지지자들에게 바라는 점	
보호자 가족, 친척, 친구, 시설 관계자 등	
증사자 정신건강 전문가, 상담사 등	

지지자들로부터 어떤 도움을 원하나요? 1 (20분)


Topic 11. 회복 계획 (1)

경고 신호가 나타날 때, 지지자들로부터 어떤 도움을 원하나요?

당사자가 위기 상황에 있을 때,
지지자들은 당사자에게 도움이 될 수도 있지만 도움이 되지 않을 수도 있다.
지지자와 토론을 통해 어떤 것이 도움이 되는지, 어떤 것들은 도움이 되지 않는지 확인하는
'도움 리스트'를 만들어보자.

내게 도움되지 않는다고 생각하는 것	도움이 되지 않는 이유	지지자가 도우려 했으나, 당사자의 경험상 도움이 되지 않는다고 생각하는 것을 함께 토론하는 것이 중요!

지지자들로부터 어떤 도움을 원하나요? 1 (20분)

활동내용

진행자는

기분 신호등 활동을 마친 뒤, 새로운 활동으로 넘어간다는 점을 안내합니다.

이번 활동은 경고 신호가 나타났을 때, 지지자들이 어떤 도움을 주었으면 좋겠는지, 반대로 어떤 도움은 오히려 효과가 없었는지를 함께 토론하는 활동임을 설명합니다.

이어서 당사자 입장에서, 경고 신호가 나타났을 때 어떤 형태의 도움을 받고 싶은지 구체적으로 작성하도록 안내합니다.

Tips.

도움 목록 작성을 시작하기 전, 당사자가 자신의 경험을 떠올리며 실제로 도움이 되었던 것들을 자유롭게 브레인스토밍하고, 그중에서 가장 효과적이었던 것부터 순서대로 작성할 수 있도록 돕는 것이 좋습니다.

진행자는

이어서, 지지자의 어떤 도움이 오히려 도움이 되지 않았다고 느꼈는지에 대해 당사자와 지지자가 충분히 토론한 뒤, 그 이유를 함께 나누고 표에 정리해 작성하도록 안내합니다.

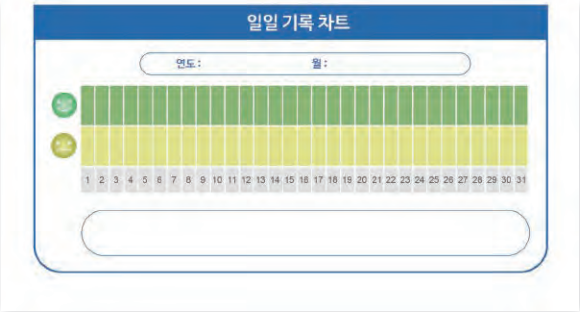
Tips.

· 이 활동에 앞서, 진행자는 당사자가 지지자를 비난하거나 단순히 간섭하지 말라고 주장하는 것은 '회복의 여정을 함께 걸어가는' 방향성과 어긋날 수 있음을 설명하고, 이 활동이 서로 조율하고 맞춰가는 과정임을 안내합니다.

· 또한, 당사자의 이야기를 듣고 죄책감이나 당황스러움을 느끼는 지지자가 있을 수 있다는 점을 인정하며, 지지자 또한 그동안 최선을 다해왔음을 상기시킵니다. 비록 최선의 결과가 늘 최상의 결과는 아닐 수 있지만, 그 노력은 '사랑의 수고'였음을 강조하며, 당사자와 지지자 모두를 따뜻하게 격려합니다.

활동단계 전개





기분 달력 설명 42)-45)

활동내용

진행자는

오늘의 활동을 마무리하며 '기분 달력'에 대해 설명합니다.

"기분 달력은 오늘 활동에서 작성한 기분 신호등을 바탕으로, 매일 하루의 평균적인 기분 상태를 기록하고, 변화의 추이를 한눈에 파악할 수 있도록 돕는 도구입니다.

만약 노란불 상태가 연속적으로 표시된다면, 이는 당사자와 지지자 모두가 주의를 기울여야 함을 의미합니다."

활동단계 정리



모두 한마디



다음 Topic 소개

활동내용

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips. 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다. 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 이야기를 한마디씩 들어보는 시간을 가지는 것을 권장합니다.

Tips.

· 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.

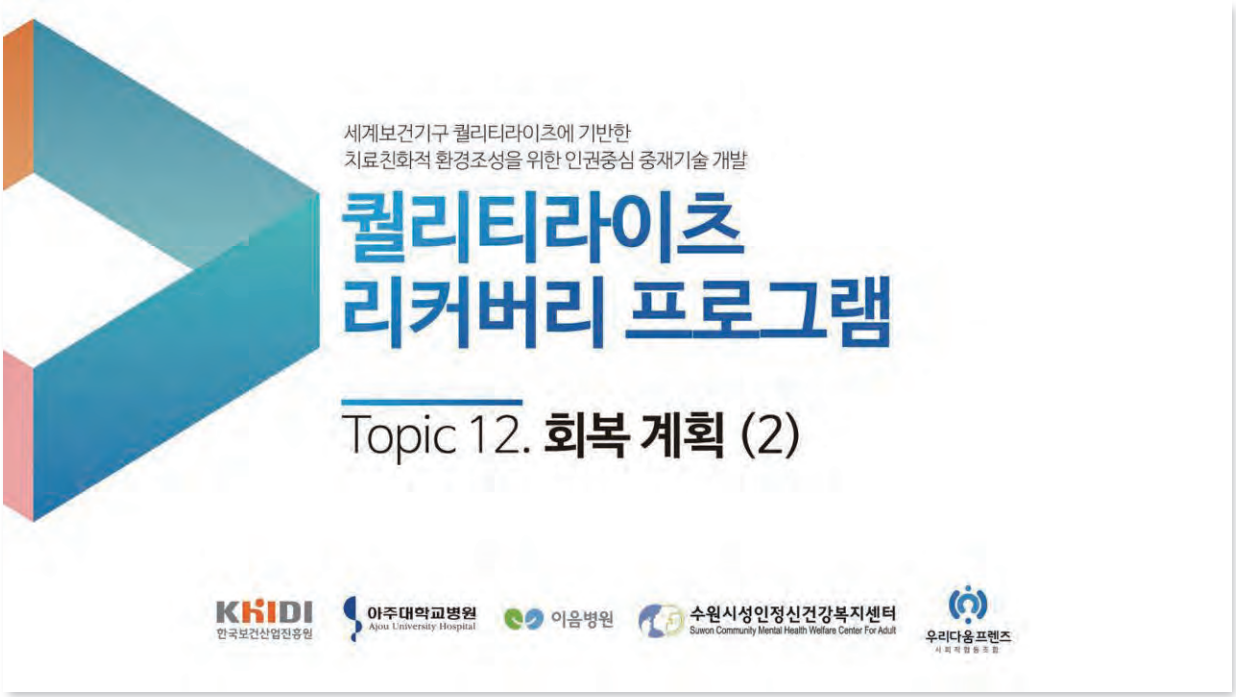
· 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습 니다.

· "늘 푸른 당신, 다음 시간에 또 만나요!"
(늘 초록불 상태가 유지되기를 바라는 마음으로)

다음 시간을 위한 준비 사항 공지

다음 시간에는 정신질환 및 신체질환과 관련하여 복용 중인 약물의 용량과 복용 횟수 등을 작성하는 활동이 진행됩니다. 따라서 다음 프로그램에 참여할 때에는, 본인이 복용하는 약물의 이름, 용량, 하루 복용 횟수를 종이에 적어 오거나, 처방전을 지참해 올 것을 안내합니다.

12 Topic 12. 회복 계획(2)



핵심목표

사전 정신의료 의향서를 작성해 볼 수 있다.

핵심질문

사전 정신의료 의향서란?

당사자와 지지자가 함께, 위기 상황에서도 당사자가 원하는 치료의 방향성이 존중 받을 수 있도록 하는 회복 계획과 사전 정신의료 의향서를 작성합니다.

핵심내용

의사결정 능력을 상실하는 위기 상황은 언제든 누구에게나 찾아올 수 있습니다. 그러한 순간에도 당사자의 뜻과 선호하는 치료 방향이 존중받을 수 있도록, 회복 계획을 미리 작성하는 일은 매우 의미 있는 과정입니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록 Topic 12. '회복 계획 2'
- ☐ 부록 Topic 12-2. '〈사전의료 및 돌봄 의향서〉'
  최소 당사자 1인당 2부 이상 준비한다.
  (이를 통해 당사자와 보호자가 추후에도 자신의 회복 계획을 작성하며, 앞으로 나아가야 할 방향을 스스로 기록해 나갈 수 있도록 돕습니다.)
- ☐ 필기구
- ☐ 프로그램 환경조성
  - · 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  - · 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 조별활동 책상배치
  - · 당사자를 중심으로 2~3인이 함께 앉을 수 있도록 책상을 배치한다.
  - · 조별 활동이 아니므로, 사전에 조를 나눌 필요는 없다.
  - · 당사자는 보호자와 함께 앉는 것을 원칙으로 하되, 종사자가 추가로 함께 참여할 수 있다.
  - · 보호자가 참석하지 않은 경우에는, 당사자를 잘 아는 종사자가 보호자 자리에 함께 앉는다.

참·고·사·항

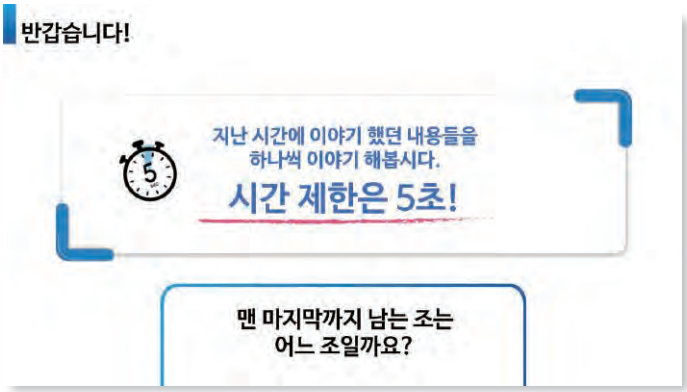
기관의 사정에 따라 한 회기를 60~90분으로 조정해야 할 경우, 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 진행하는 것을 권장합니다.

1. 1부-2부 진행: 프로그램을 두 부분으로 나눠서 진행하는 것을 고려해 주세요. 첫 번째 부분의 끝은 가이드북에 선으로 표시되어 있어서, 어디에서 나눠야 할지 쉽게 알 수 있습니다. (1부 마무리시에 다음회기 예고 및 이번회기 정리를 권장합니다.)

2. 주요 부분만 진행: 각 세션의 중요한 내용은 파란색 박스로 표시되어 있습니다. 시간이 부족할 때는 파란색 체크를 ☑ 중심으로 세션을 진행하세요. 이렇게 하면 시간을 효율적으로 사용하면서도 중요한 정보를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 110분 입니다.**

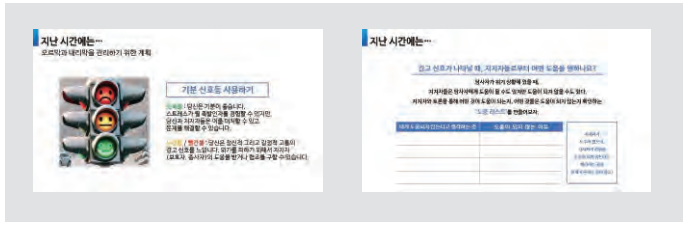
활동단계 도입

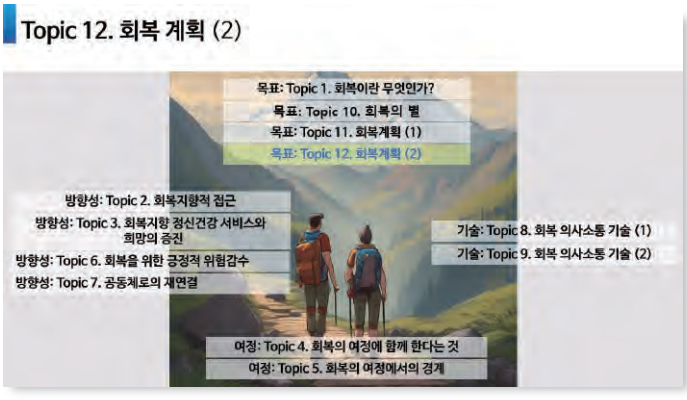


이어말하기 게임



지난 시간에는...





회복 계획(2)

활동내용

진행자는

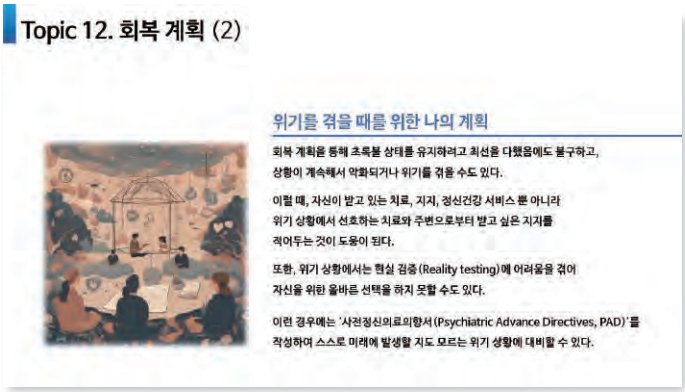
이어말하기 게임을 하며, 참여자들에게 지난 시간에 함께 했던 프로그램 내용을 상기시킵니다.

이어말하기 게임 이후 지난 시간의 주요 내용을 이야기 합니다.

오늘 진행할 프로그램 주제가 전체 12개 주제 중 어떤 것인지를 소개합니다.

오늘의 주제가 이전 주제들과 앞으로 다룰 주제들 속에서 어떤 위치에 있는지 설명하여, 참여자들이 전체 흐름과 맥락을 이해할 수 있도록 돕습니다.

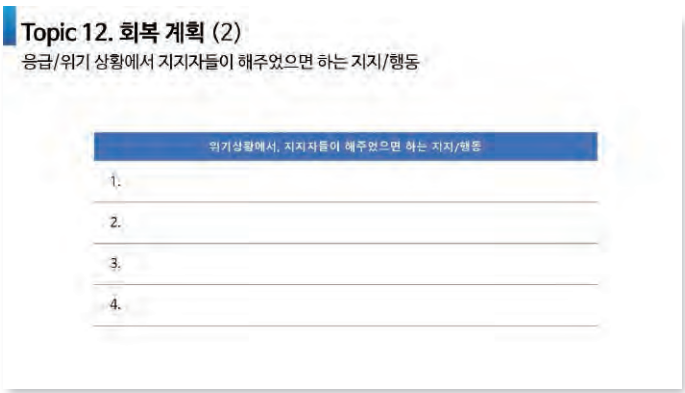
활동단계 전개



위기를 겪을 때를 위한 나의 계획



응급/위기 상황에서 연락할 사람 (5~10분) [42)-45)]



응급/위기 상황에서 지지자들이 해주었으면 하는 지지/행동 (5~10분) [42)-45)]

활동내용

진행자는

지난 시간에 이어, 오늘도 회복 계획을 작성하는 시간을 갖는다고 안내합니다. 특히 오늘은 '위기 상황'에 대비한 구체적인 회복 계획을 세우는 시간임을 강조합니다.

"위기는 언제든 우리의 삶에 찾아올 수 있습니다. 그러나 위기는, 때로는 '기회'라는 또 다른 이름으로 불리기도 합니다. 위기에 잘 대비하고 극복해 낼 때, 우리는 삶의 주도권을 더욱 확고히 하고, '나 다움'을 회복하는 데 있어 큰 성장을 이룰 수 있습니다.

오늘은 위기 상황에 대한 구체적인 전략을 당사자와 지지자가 함께 모색하고, '사전 정신의료 의향서'를 함께 작성해보는 시간을 갖겠습니다."

Tips.

· 이번 시간에 작성한 내용은 전체 참여자 앞에서 발표하지 않아도 됩니다.
· 진행자는 작성 마감 시간을 안내하되, 작성 후에는 별도의 발표 시간을 갖지 않고 다음 작성 단계로 바로 넘어갈 예정임을 미리 설명합니다.

진행자는

당사자와 지지자에게, 응급/위기 상황 시 연락을 받고 도움을 주었으면 하는 사람의 목록을 작성하도록 안내합니다.

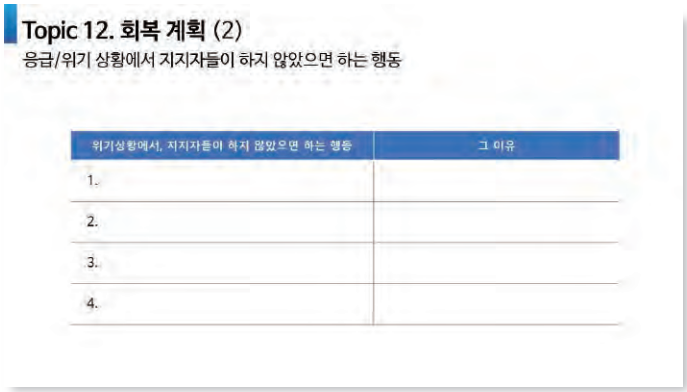
Tips.

· 원한다면, 응급/위기 상황에서 연락을 원하지 않는 사람에 대해서도 작성할 수 있으나, 시험/시범 운영 결과 법적 보호자를 제외하려는 사례가 종종 있었습니다.
· 다만, 한국의 임상 환경에서는 법적 보호자가 제외된 계획은 실제 상황에서 활용에 제약이 많기 때문에, 해당 항목은 작성하지 않는 것을 권장합니다.

진행자는

당사자와 지지자에게, 응급/위기 상황 시 지지자들이 해주었으면 하는 지지 혹은 행동을 작성하도록 안내합니다.

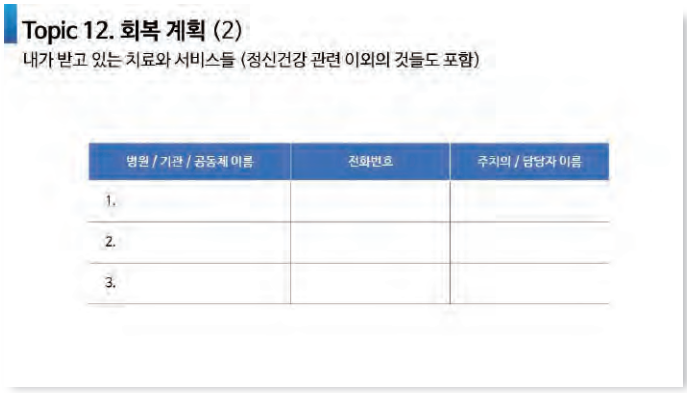
활동단계 전개



Topic 12. 회복 계획 (2)
응급/위기 상황에서 지지자들이 하지 않았으면 하는 행동

위기상황에서, 지지자들이 하지 않았으면 하는 행동	그 이유
1.	
2.	
3.	
4.	

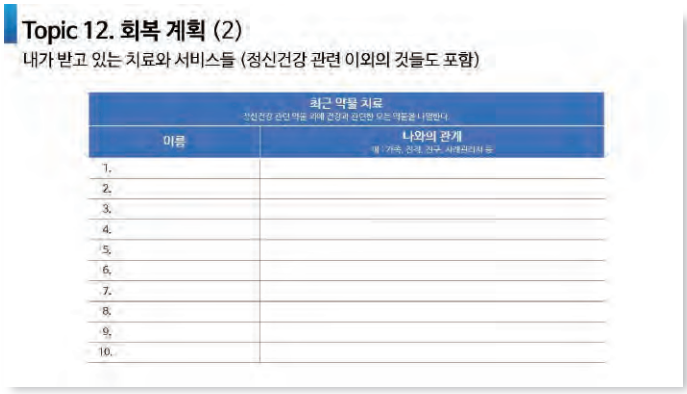
응급/위기 상황에서 지지자들이 하지 않았으면 하는 지지/행동(5~10분) [42)-45)]



Topic 12. 회복 계획 (2)
내가 받고 있는 치료와 서비스들 (정신건강 관련 이외의 것들도 포함)

병원 / 기관 / 공동체 이름	전화번호	주치의 / 담당자 이름
1.		
2.		
3.		

내가 받고 있는 치료와 서비스들 1 (5~10분) [42)-45)]



Topic 12. 회복 계획 (2)
내가 받고 있는 치료와 서비스들 (정신건강 관련 이외의 것들도 포함)

최근 약물 치료	
이름	나와의 관계
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

내가 받고 있는 치료와 서비스들 2 (5~10분) [42)-45)]

활동내용

진행자는
당사자와 지지자에게, 반대로 응급/위기 상황 시 지지자들이 하지 않았으면 하는 행동과 그 이유를 작성하도록 안내합니다.

Tips.
· 앞서 진행한 활동들과 마찬가지로, 이번 활동 역시 당사자와 지지자가 서로를 비난하거나 일방적인 요구만을 주장하는 자리가 아님을 강조합니다.

· 이 활동은 서로를 더욱 깊이 이해하고, 함께 회복 지향적인 약속을 만들어가는 과정임을 분명히 안내합니다.

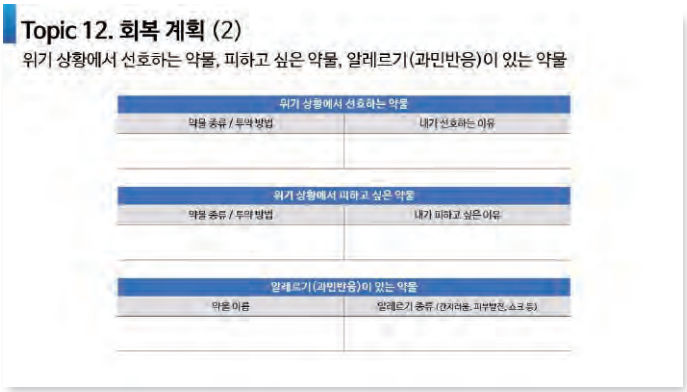
진행자는
당사자가 현재 받고 있는 치료와 서비스를 한눈에 파악할 수 있도록 정리해 작성하도록 안내합니다.

이때, 정신질환과 관련된 치료뿐 아니라, 신체 질환에 대한 치료, 상담, 그 외의 다양한 지원이나 서비스들도 함께 작성하도록 안내합니다.

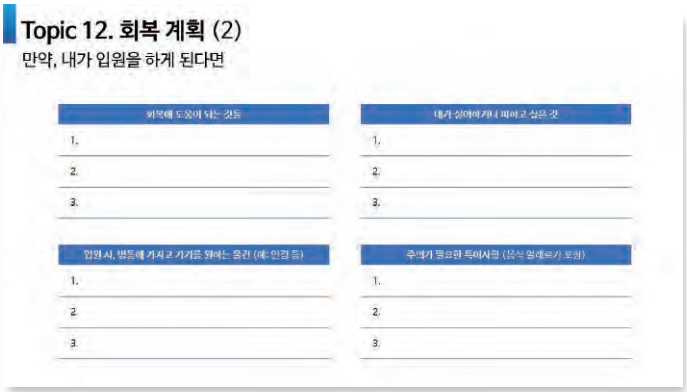
진행자는
당사자가 현재 복용 중인 약물의 이름, 용량, 복용 횟수를 한눈에 파악할 수 있도록 정리하여 작성하도록 안내합니다.

이때, 정신질환과 관련된 약물 뿐만 아니라 신체 질환과 관련된 약물도 함께 작성하도록 안내합니다.

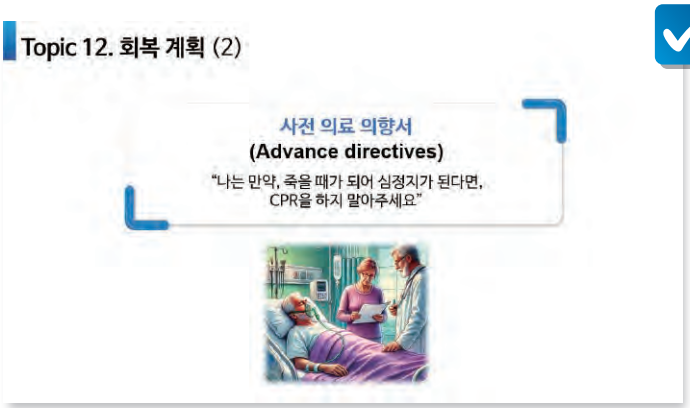
활동단계 전개



위기 상황과 약물들 (5~10분) [42)-45)]



만약, 내가 입원을 하게 된다면 (10~15분) [42)-45)]



사전 의료 의향서

활동내용

진행자는

위기 상황에서 선호하는 약물이나 투약 방법, 또는 피하고 싶은 약물이나 투약 방법에 대해 작성하도록 안내합니다. 또한, 약물 투약과 관련된 사고를 예방하기 위해 알레르기 있는 약물을 함께 기록하여, 위기 상황 시 지지자가 의료기관에 정확한 정보를 전달할 수 있도록 안내합니다.

Tips.

일반적으로 특별한 경험이 없는 당사자의 경우, 약물이나 투약 방법에 대해 구체적인 선호가 없을 수 있습니다. 이럴 땐 간단하고 포괄적인 표현으로 작성해도 괜찮습니다.

예) "입이 마르는 약은 피하고 싶다."

예) "주사 치료는 가능하면 적게 받고 싶다."

진행자는

당사자가 위기 상황에서 입원을 하게 되는 상황을 상상해 보도록 제안합니다. 그런 상황에서 지지자가 의료기관에 당사자의 회복과 관련해 어떤 내용을 전달하면 좋을지 함께 토론하도록 안내합니다.

Tips.

· 의료기관마다 병동 운영에 대한 고유한 지침이 있어, 지금 작성한 내용이 모두 반영되지 않을 수도 있습니다.

· 그럼에도 불구하고, 당사자와 지지자가 함께 작성한 이 내용은 당사자의 회복을 위한 중요한 의사소통 자료이며, 충분히 의미 있는 작업이라는 점을 강조합니다.

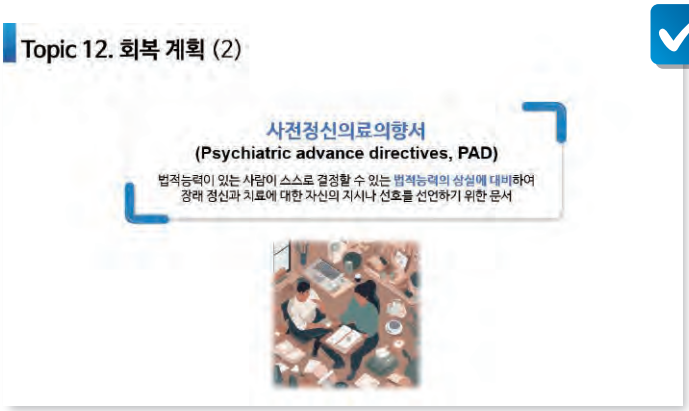
1부 끝 시간 부족 시

활동내용

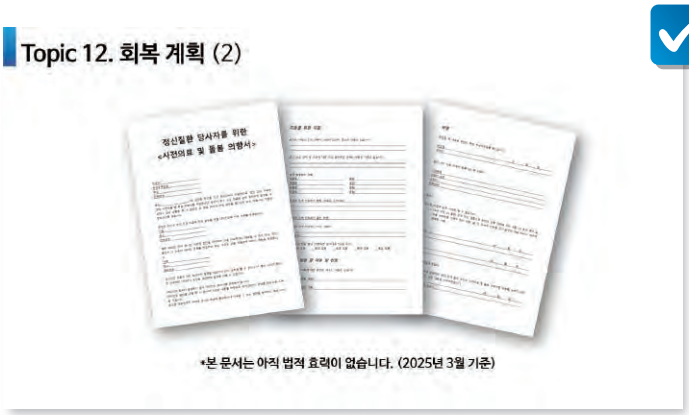
진행자는

'사전 의료 의향서'에 대해 설명을 합니다. "사전의료 의향서는 자신이 의사결정을 할 수 없는 상황(예: 의식이 없는 상태, 정신적 혼란, 위기 상황 등)이 되었을 때를 대비하여, 자신의 치료에 대한 선호나 원하지 않는 치료, 연락 받았으면 하는 사람, 투약 및 입원 관련 의견 등을 미리 기록해두는 문서입니다. 이 문서를 통해 의료진과 지지자(보호자, 종사자 등)는 당사자의 뜻을 더 정확하게 이해하고 존중할 수 있게 됩니다."

활동단계 전개



사전 정신의료 의향서 [46)-48)]



사전 정신의료 의향서 작성(20분)

활동내용

진행자는

'사전 의료 의향서'에 대한 설명에 이어 '사전 정신의료 의향서'에 대해 설명합니다.

"사전 정신의료 의향서는 정신질환을 앓고 있는 당사자가, 정신적 위기 상황(예: 조현병의 급성 악화, 조증, 심한 불안 발작 등)으로 인해 스스로 의사 결정을 하기 어려운 상태에 놓이게 될 경우를 대비해, 자신이 원하는 치료 방향이나 회복에 도움이 되는 방법 등을 미리 기록해 두는 문서입니다."

진행자는

오늘 함께 정리한 내용을 바탕으로, 당사자와 지지자가 미리 배부된 부록(Topic 12-2)인 '사전 정신의료 의향서'를 함께 작성하도록 안내합니다.

이 문서는 현재 대한민국에서 법적 효력은 없지만, 회복의 여정 속에서 당사자의 의사를 미리 정리하고 나누는 일은 매우 의미 있는 작업입니다.

Tips.

· 작성할 내용이 많기 때문에, 서두르지 않고 천천히 읽으며 작성하도록 돕습니다.

· 지지자와 함께 내용을 한 줄씩 소리 내어 읽고, 대화를 나누며 함께 작성해보는 것도 좋은 방법입니다.

활동단계 정리



모두 한마디

활동내용

참여한 모든 사람에게 프로그램에 대한 소감을 들어봅니다.

Tips.

· 이 시간은 매우 유익하고 의미 있는 시간입니다.

· 시간이 부족하더라도, 참여자 모두의 이야기를 한마디씩 들어보는 시간을 가지는 것을 권장합니다.

활동단계 정리



다음 Topic 소개

활동내용

Tips.

· 참여자들이 다음 시간을 기대할 수 있도록 동기 부여를 해주세요.

· 각 과마다 '당신'을 표현하는 것이 달라집니다. 마치기 전에 진행자나 참여자 전체가 함께 읽으며 마무리하면 좋습니다.

· "회복의 여정 중에 있는 당신, 다음 시간에 또 만나요!"

다음 시간을 위한 준비 사항 공지

이 수료식은 단순한 마무리가 아닌, 지금까지 함께 배운 내용을 간략히 정리하고, 회복의 여정 끝에 어떤 의미가 기다리고 있는지를 나누는 시간입니다.

· 본 프로그램을 통해 각자가 자신의 회복 여정을 어떻게 걸어가고 있는지 스스로 선언하는 의미 있는 시간도 마련되어 있습니다.

· 프로그램에 성실히 참여한 참여자들을 위한 작은 시상식도 준비되어 있으니, 모두 함께 참여하여 서로의 회복 선언에 따뜻한 증인이 되고, 함께 축하하고 격려하는 시간을 가지게 될 것임을 안내합니다.

· 또한, 기관의 일정에 따라 '퀄리티라이츠 리커버리 프로그램'을 통해 스스로의 변화를 확인하는 질문지 및 사후 설문지를 작성하는 시간이 추가로 필요할 수 있습니다. 이 경우, 평소보다 약 30분 정도 일찍 내원해 주시도록 안내할 수 있습니다.

13 수료식



핵심목표

나에게 있어 회복이 무엇인지 선언할 수 있다.

핵심질문

① 당신에게 회복이란?

자신에게 있어 회복이란 무엇인지 사람들과 이야기 할 수 있습니다.

② 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램이란?

그동안 함께 이야기 한 내용을 정리합니다.

준비사항 체크리스트

- ☐ 명찰
- ☐ 부록(수료식-1) '나에게 회복이란 ___입니다.'
  당사자·보호자·종사자 모두가 작성할 수 있도록 준비합니다.
- ☐ 부록(수료식-2) '수료증 및 상장'
  수료증은 총 출석률이 70% 이상인 경우에 한해 발급합니다.
  기관의 운영 상황에 따라, 다양한 주제의 상장을 제작해 참여자들에게 수여할 수 있습니다.
  (ex) 베스트 성실상, 베스트 발표상, 베스트 가족상, 베스트 직원상 등)
- ☐ 필기구
- ☐ 프로그램 환경조성
  · 발표자료를 컴퓨터에 설치하고 이상 없음을 확인했다.
  · 프로젝터 또는 모니터가 정상적으로 작동하는지 확인했다
- ☐ 자리배치
  · 당사자를 중심으로 2~3인이 함께 앉을 수 있도록 책상을 배치한다.
  · 조별 활동이 아니므로, 사전에 조를 나눌 필요는 없다.

프로그램 예상 시간 | **이 과의 권장 시간은 90분 입니다.**

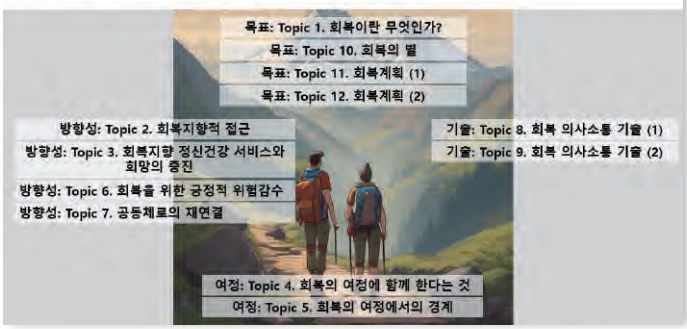
활동단계 전개

회복의 여정 중에 있는 당신에게



사후 설문지 작성(30~40분)

WHO 웰리티라이츠 리커버리 프로그램



활동내용

진행자는

질문지와 사후 설문지 작성을 안내합니다.

① 사전 설문지와 마찬가지로 당사자, 보호자, 종사자 모두 질문지와 사후 설문지를 작성합니다.

② 질문지와 사후 설문지는 비밀이 보장되며, 안전하게 보관되고 일정 기간 후에 파기됩니다.

당사자 중 동의서와 설문지 작성에 도움이 필요한 인원이 있다면, 기관의 종사자들이 적극적으로 지원하여 보호자가 자신의 설문지를 작성하는 데 집중할 수 있도록 돕는 것이 좋습니다.

진행자는

Topic 1부터 Topic 12까지의 흐름과 관계를 간략히 정리해 설명합니다.

수료식: 회복의 여정 중에 있는 당신에게

① 우리는 웰리티라이츠 리커버리 프로그램을 통해, 회복이란 무엇인지에 대한 질문으로 여정을 시작했습니다.
②~③ 이후, 회복 지향적 접근이 무엇인지 배우고, 이 가치가 반영된 정신건강 서비스는 어떤 모습이어야 하며, 그 서비스가 어떻게 희망과 연결되는지를 함께 살펴보았습니다.
④ 또, 회복은 고정된 상태가 아니라 함께 가는 과정이자 여정이라는 것을 이해하며, 그 여정 속에서 당사자, 보호자, 종사자 각각의 역할과 책임을 이야기했습니다.
⑤ 서로의 역할을 존중하고, 서로의 '됨'을 지켜주는 건강한 경계의 중요성도 함께 배웠습니다.
⑥ 우리는 회복의 여정 속에서 위험을 무조건 피하는 것이 아닌, 긍정적인 위험 감수가 필요하다는 것을 이해했습니다.
⑦ 그리고 그 여정의 끝에는 공동체로의 연결이 기다리고 있으며, '나 다움'을 회복하기 위해 공동체는 반드시 필요하다는 것을 나누었습니다.
⑧~⑨ 공동체에서 건강한 관계를 유지하기 위해 필요한 회복 의사소통 기술도 배우고, 실제로 경험해 보는 시간도 가졌습니다.
⑩~⑫ 마지막으로, 지금까지 배운 내용을 나의 삶에 회복 지향적인 방식으로 적용하기 위해 '회복의 별'을 그리고, 회복 계획을 함께 작성해보며 마무리했습니다."

활동단계 전개

WHO 퀄리티라이즈 리커버리 프로그램



WHO 퀄리티라이즈 리커버리 프로그램



회복의 여정 중에 있는 당신에게



회복의 여정 중에 있는 당신에게



활동내용

· 오리엔테이션

· Topic 1. 회복이란 무엇인가?

· Topic 2. 회복 지향적 접근

· Topic 3. 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진

진행자는 각 Topic의 핵심 슬라이드를 바탕으로, 각 회기의 주요 내용을 자신만의 방식으로 풀어 설명합니다.

Tips.

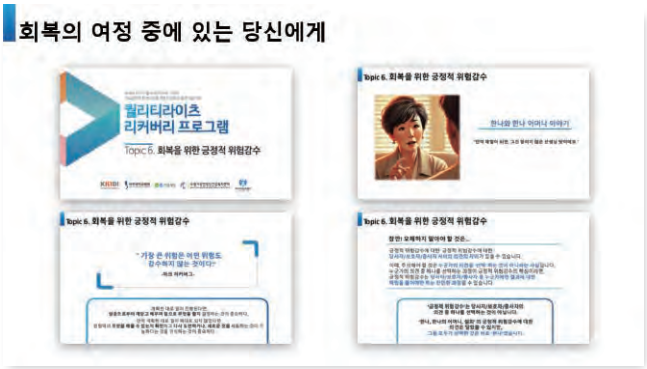
· 진행자는 가이드북에 제시된 각 Topic의 핵심 목표와 핵심 질문을 참고하여 내용을 정리해 설명할 수 있습니다.

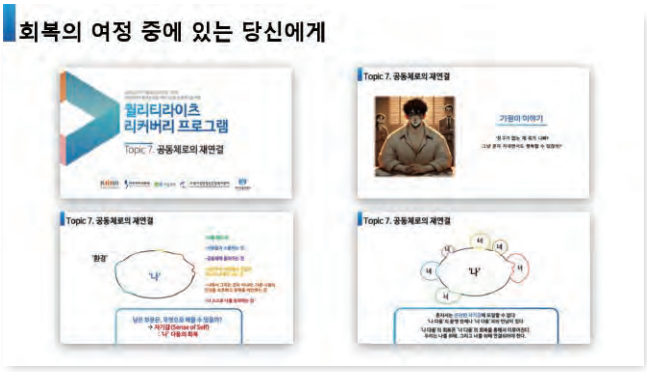
· 또한, 각 Topic에 등장하는 사례 속 주인공들의 이야기를 중심으로 내용을 소개하면, 참여자들이 각 회기의 내용을 보다 쉽게 떠올리고 공감하는 데 도움이 됩니다.

활동단계 전개









활동내용

· Topic 4. 회복의 여정에 함께 한다는 것

· Topic 5. 회복의 여정에서의 경계

· Topic 6. 회복을 위한 긍정적 위험감수

· Topic 7. 공동체로의 재연결

진행자는 각 Topic의 핵심 슬라이드를 바탕으로, 각 회기의 주요 내용을 자신만의 방식으로 풀어 설명합니다.

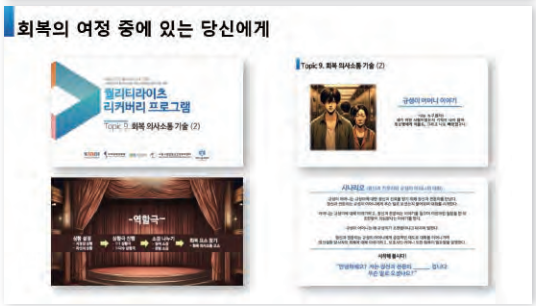
Tips.

· 진행자는 가이드북에 제시된 각 Topic의 핵심 목표와 핵심 질문을 참고하여 내용을 정리해 설명할 수 있습니다.

· 또한, 각 Topic에 등장하는 사례 속 주인공들의 이야기를 중심으로 내용을 소개하면, 참여자들이 각 회기의 내용을 보다 쉽게 떠올리고 공감하는 데 도움이 됩니다.

활동단계 전개











활동내용

· Topic 8/9. 회복 의사소통기술(1)/(2)

· Topic 10. 회복의 별

· Topic 11/12. 회복 계획 (1)/(2)

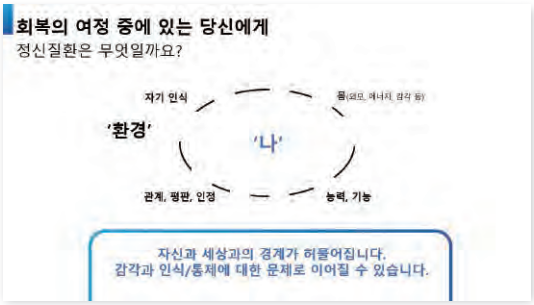
진행자는 각 Topic의 핵심 슬라이드를 바탕으로, 각 회기의 주요 내용을 자신만의 방식으로 풀어 설명합니다.

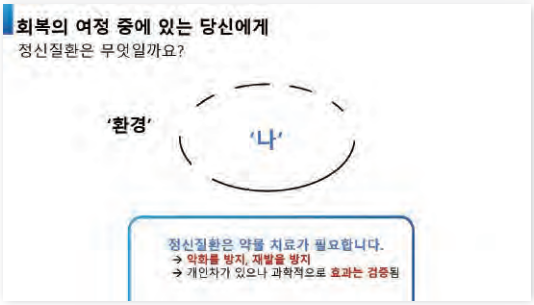
Tips.

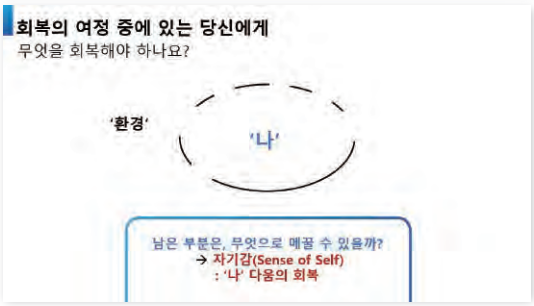
· 진행자는 가이드북에 제시된 각 Topic의 핵심 목표와 핵심 질문을 참고하여 내용을 정리해 설명할 수 있습니다.

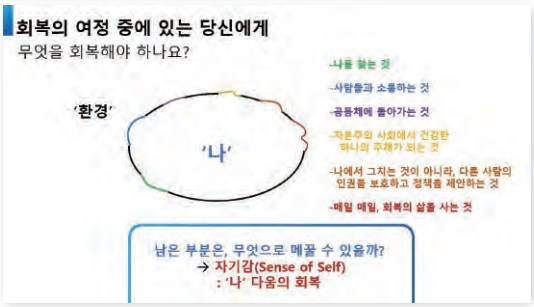
· 또한, 각 Topic에 등장하는 사례 속 주인공들의 이야기를 중심으로 내용을 소개하면, 참여자들이 각 회기의 내용을 보다 쉽게 떠올리고 공감하는 데 도움이 됩니다.

활동단계 전개











활동내용

진행자는

오리엔테이션에서 설명했던 '자아의 경계' 개념을 다시 상기시키며, 자아의 경계가 무너진 상태가 정신질환에서 어떤 의미를 가지는지 설명합니다.

이와 함께, 자아의 경계를 회복하기 위해 약물 치료가 도움이 될 수 있지만, 그에 더해 '자기감의 회복', 즉 '나 다움'을 회복하는 과정이 반드시 필요함을 강조합니다.

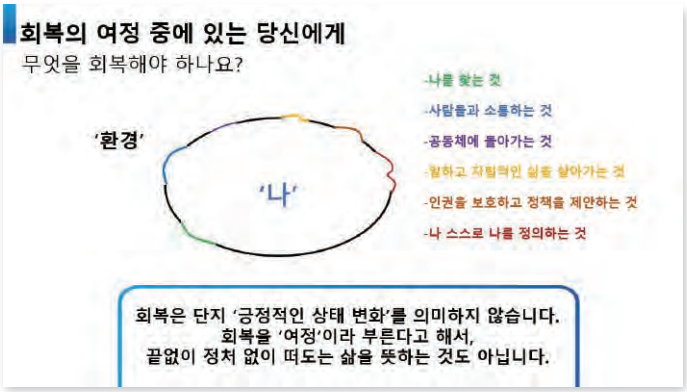
이어 '나 다움'의 회복이란 어떤 구체적인 요소들을 통해 자아의 경계를 회복하는지를 설명합니다.

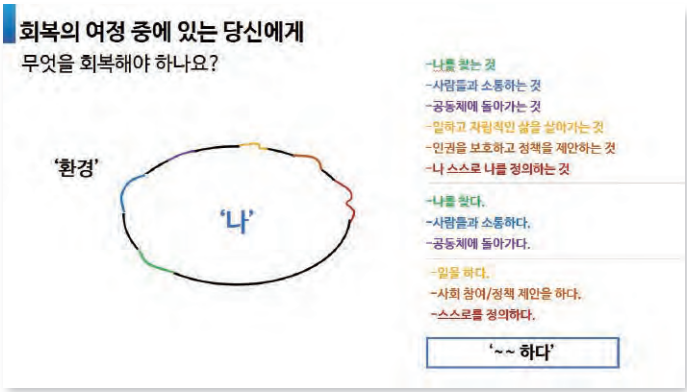
마지막으로, 이러한 자아의 경계를 회복하는 과정은 나 혼자의 힘만으로는 어려우며, 서로의 존재와 연결이 궁극적으로 필요하다는 점을 강조합니다.

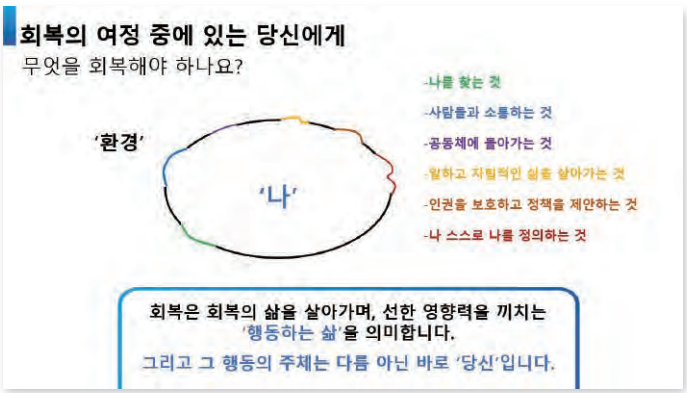
Tips.

가이드북의 '오리엔테이션' 부분을 참고하시면 보다 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

활동단계 전개







활동내용

진행자는
슬라이드 내용을 바탕으로, 회복에 대해 흔히 생길 수 있는 오해를 바로잡고, 올바른 이해가 필요함을 강조합니다.

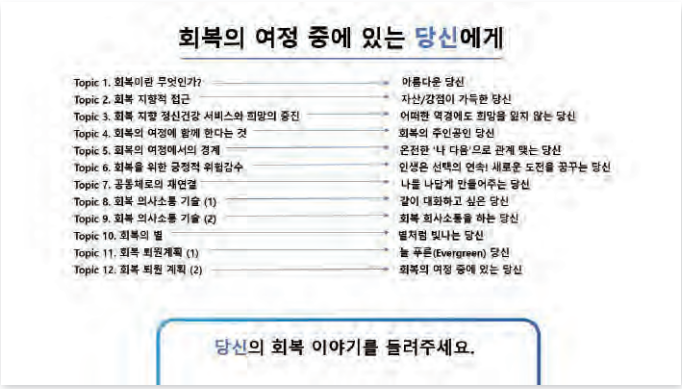
진행자는
자아의 경계를 회복하는 데 필요한 요소들이 공통적으로 '~하다'로 표현되는 '행동'임을 강조합니다.

진행자는
회복이 단순히 긍정적인 방향으로의 상태 변화만을 의미하지 않으며, 정처 없이 떠도는 여정을 뜻하는 것도 아님을 설명합니다.

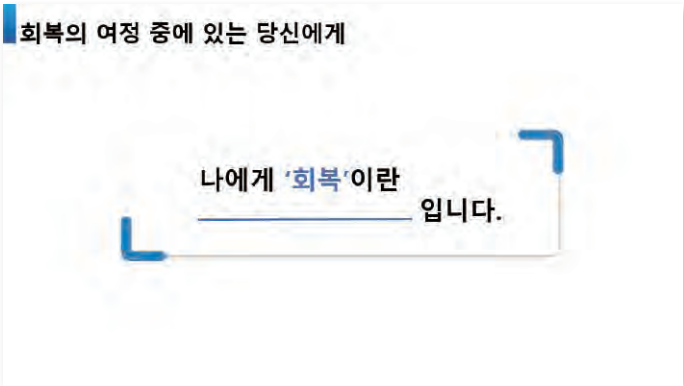
회복은 '선한 영향력을 끼치는 행동하는 삶'을 살아가는 것을 의미함을 강조합니다.

애니메이션 효과
그리고 그 행동의 주체는 다름 아닌 바로 '당신'임을 힘 있게 전달합니다.

활동단계 전개



회복의 여정 중에 있는 당신에게



나에게 '회복'이란 _____ 입니다. (10분)



수료증 수여식

활동내용

진행자는

각 Topic의 주제와, 그 주제 속 주인공인 '당신'에 대한 문구를 참여자들과 함께 읽습니다.

진행자는

'부록(수료식-1)'을 모든 참여자에게 배부하고, 각자에게 '회복'이란 무엇인지 자신의 언어로 작성해 보도록 안내합니다.

진행자는

70% 이상 출석한 참여자에게 수료증을 수여합니다.

수료증을 받은 참여자는, 자신의 자리로 돌아가기 전 '나에게 회복이란 _____입니다'라는 문장을 모두 앞에서 선언합니다.

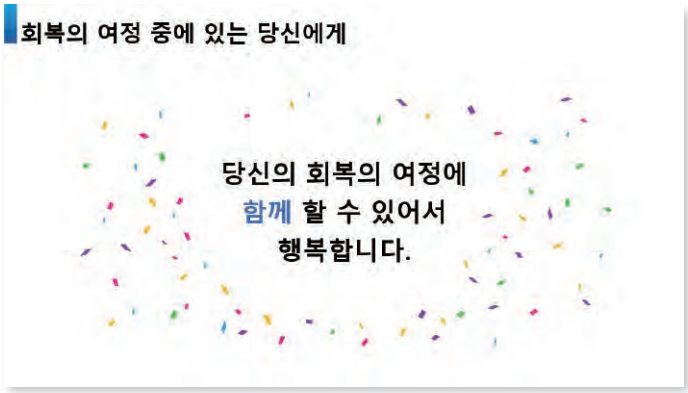
진행자는 각 참여자가 자신의 회복을 선언할 때마다 따뜻한 격려의 말과 함께, 그동안 프로그램에 성실히 참여한 것에 대해 응원의 박수를 보냅니다.

Tips.

· 기관의 사정에 따라 수료증 수여 후, '부록(수료식-2)'을 활용해 추가적인 시상식 순서를 진행할 수 있습니다.

· 상 이름은 기관의 분위기나 참여자 특성에 맞게 자유롭게 작명하여 수여하시면 더욱 의미 있는 시간이 될 수 있습니다.

활동단계 정리





활동내용

진행자는

마지막으로, 자신의 회복 여정에 기꺼이 서로를 초대해 준 모든 참여자에게 진심 어린 감사의 인사를 전하며 프로그램을 마무리합니다.

감사합니다.

참고자료
2024년 수원시 성인정신건강복지센터에서 진행한
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 토론 결과

Q. 나에게 '회복'이란 _____ 입니다.

종사자

김0희 : 나를 이해하는 과정이다.
이0주 : 다른 이들과 함께 있는 나의 발견이다.
권0록 : 다림질이다.
장0옥 : 진행중이다.

보호자

김0미 : 나 자신, 가족, 타인 간의 관계 회복이다.
양0상 : 있던 것을 원래의 것으로 돌아가는 것이다.
김0국 : 몸이 돌아오는 것, 이전으로 돌아가는 것이다.

당사자

홍0국 : 좋아하는 것을 발견하는 것이다.
이0진 : 있는 그대로이다.
김0경 : 도전이다.
오0순 : 행복이다.
설0윤 : 일상이다.

우수 당사자, 보호자, 종사자 시상

	이 름	상장 명	이 유
당사자	홍0국	베스트 성실상	매회기 지각 없이 꾸준히 참여하여 상장을 수여함.
	김0경	베스트 발표상	조별 발표시 누구보다 적극적인 태도로 조원들의 생각을 잘 모아 정리하고, 표현하는 멋진 발표자의 면모를 보여 상장을 수여함.
보호자	양0상	베스트 가족상	가족으로 참여하며 당사자의 말에 귀 기울여 듣고, 솔직한 감정과 생각을 나누는 등 회복을 향해 함께 노력하였기에 상장을 수여함.
종사자	장0옥	베스트 직원상	당사자와 가족과 함께 적극적으로 화목에 대해 소통하고자 노력하였기에 위 상장을 수여

14 참고문헌

Gallese V, Ardizzi M, Ferroni F. Schizophrenia and the bodily self. Schizophr Res. 2024 Jul;269:152-162.

Davidson L. Recovering a sense of self in schizophrenia. J Pers. 2020 Feb;88(1):122-132.

Sanz P, Tur N, LanaF. Mentalization-based approach for schizophrenia spectrum disorders: a psychotherapeutic proposal for evolved schizophrenic trajectories and serious mental disorders. Front Psychiatry. 2024 May 8;15:1240393.

Ponce-Correa F, Caqueo-Urízar A, Berrios R, Escobar-Soler C. Defining recovery in schizophrenia: A review of outcome studies. Psychiatry Res. 2023 Apr;322:115134.

The 10 Essential Shared Capabilities for Mental Health Practice: learning materials. Edinburgh: NHS Education for Scotland (NES); 2011

Leamy M, Bird V, Le Boutillier C, Williams J, Slade M. Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis. Br J Psychiatry.

Anthony WA. Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychiatr Rehabil J. 1993;16(4):11–23

Quote by Pat Deegan. Excerpt from The 10 Essential Shared Capabilities for Mental Health Practice: learning materials (page 21). Edinburgh: NHS Education for Scotland (NES); 2011.

Slade M, Amering M, Farkas M, Hamilton B, O'Hagan M, Panther G, et al. Uses and abuses of recovery: implementing recovery-oriented practices in mental health systems. World Psychiatry. 2014;13(1):12–20.

A glass half-full: how an asset approach can improve community health and well-being. London: Improvement and Development Agency's (IDeA) Healthy Communities Programme; 2009.

Yale University Program for Recovery and Community Health. Practice guidelines for recovery-oriented care for mental health and substance use conditions (second edition). Hartford (CT): Connecticut Department of Mental Health and Addiction Services; 2008.

The 10 Essential Shared Capabilities for Mental Health Practice: learning materials. Edinburgh: NHS Education for Scotland (NES); 2011.

Realising recovery: learning materials. Edinburgh: NHS Education for Scotland (NES) and the Scottish Recovery Network; 2011.

Heartsounds Uganda and Bubatika Hospital. SharingStories - Recovery in Uganda: Themes from recovery listening events. Summary of the workshops conducted in February 2015 in Kampala and Jinja aimed at enabling mental health service users and staff members to think about recovery. London: Tropical Health & Education Trust and the UK Department for International Development; 2015.

De Monte V, Veitch A, Dark F, Meurk C, Wyder M, Wheeler M, Carney K, Parker S, Kisely S, Siskind D. Measuring recovery-oriented rehabilitation language in clinical documentation to enhance recovery-oriented practice. BJPsych Open. 2023 Feb 15;9(2):e36.

Realising recovery: learning materials. Edinburgh: NHS Education for Scotland (NES) and the Scottish Recovery Network; 2011

Slade M, Amering M, Farkas M, Hamilton B, O'Hagan M, Panther G, et al. Uses and abuses of recovery: implementing recovery-oriented practices in mental health systems. World Psychiatry. 2014;13(1):12–20.

Repper J, Perkins R. Social inclusion and recovery. A model for mental health practice. London: Bailliere Tindall; 2003

Realising Recovery learning materials. Module 2: Using self to develop recovery focused relationships. Edinburgh: NHS Education for Scotland (NES) and the Scottish Recovery Network (SRN); 2011.

Brown W, Kandirikirira N. Recovering mental health in Scotland. Report on narrative investigation of mental health recovery. Glasgow: Scottish Recovery Network; 2007.

Banerjee, S. & Wesley, M. S. (2023). Boundary Constructions in Psychotherapeutic Relationships. International Journal of Indian Psychology, 11(1), 255-262.

Realising Recovery learning materials. Module 5: Sharing responsibility for risk and risk- taking. Edinburgh: NHS Education for Scotland (NES) and the Scottish Recovery Network (SRN); 2011

Mental health and social exclusion: Social Exclusion Unit Report Summary. London: Office of the Deputy Prime Minister; 2004.

Vanheule, S. (2017), Conceptualizing and Treating Psychosis: A Lacanian Perspective. British Journal of Psychotherapy, 33: 388-398.

Redmond JD. Contemporary perspectives on Lacanian theories of psychosis. Front Psychol. 2013 Jun 28;4:350

Wu, M.Mf. Habit and Mental Illness from an Hegelian Perspective. Hu Arenas 5, 245–261 (2022).

Alvarez-Jimenez, M., et al. (2021). "The Horyzons project: A randomized controlled trial of a novel online social therapy to maintain treatment effects from specialist first-episode psychosis services." World Psychiatry, 20(2), 233–243.

Bighelli, I., et al. (2021). "Psychosocial and psychological interventions for relapse prevention in schizophrenia: A systematic review and network meta-analysis." The Lancet Psychiatry, 8(11), 969–980.

Giacco et al. (2012). "Friends and symptom dimensions in patients with psychosis: A pooled analysis." PLOS ONE, 7(11), e50119.

Xia, J., et al. (2011). "Psychoeducation for schizophrenia." Cochrane Database of Systematic Reviews, 2011(6), CD002831.

14 참고문헌

Seikkula, Jaakko, and Mary E. Olson. "The open dialogue approach to acute psychosis: its poetics and micropolitics." Family process 42.3 (2003): 403-418.

Seikkula, Birgitta Alakare, Jukka Aaltonen, Jaakko. "Open dialogue in psychosis I: An introduction and case illustration." Journal of Constructivist Psychology 14.4 (2001): 247-265.

Bergström, Tomi, et al. "The family-oriented open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: Nineteen–year outcomes." Psychiatry research 270 (2018): 168-175.

Putman, N., & Martindale, B. (2023). Open dialogue for psychosis (K. S. Kim & D. H. Jeon, Trans.). Korea Institute for Clinical Psychoanalysis (ICP). (Original work published 2021)

Gutride, Martin E., Arnold P. Goldstein, and G. F. Hunter. "The use of modeling and role playing to increase social interaction among asocial psychiatric patients." Journal of Consulting and Clinical Psychology 40.3 (1973): 408.

Pylypenko, Nataliia, et al. "The psychodrama method of group psychotherapy." BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 14.3 (2023): 134-149.

Orkibi H, Feniger-Schaal R. Integrative systematic review of psychodrama psychotherapy research: Trends and methodological implications. PLoS One. 2019 Feb 19;14(2):e0212575.

The Recovery Star: Outcomes Star [website]. Brighton: Triangle Consulting Social Enterprise Limited; 2009–2015.

Dickens, Geoff, et al. "Recovery star: validating user recovery." The Psychiatrist 36.2 (2012): 45-50.

Onifade, Yetunde. "The mental health recovery star." Mental Health and Social Inclusion 15.2 (2011): 78-87.

Nottinghamshire National Health Service (NHS) Trust. Personal Recovery Plan. Nottingham, United Kingdom: Nottinghamshire NHS Trust.

Nottinghamshire National Health Service (NHS) Trust. Taking Back Control: A guide to planning your own recovery. Nottingham, United Kingdom: Nottinghamshire NHS Trust; 2008.

Nottinghamshire NHS Trust. Advance Statement [online publication]. United Kingdom; Nottinghamshire NHS Trust; 2008. (Available from: https://www.nottinghamshirehealthcare.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n1799.pdf&ver=1845., accessed 9 February 2017).

Nottinghamshire NHS Trust. Advance Statement (page 32) [online publication]. United Kingdom; Nottinghamshire NHS Trust; 2008. (Available from: https://www.nottinghamshirehealthcare.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n1799.pdf&ver=1845., accessed 9 February 2017).

Gaillard, Anne-Sophie, et al. "The content of psychiatric advance directives: a systematic review." Psychiatric Services 74.1 (2023): 44-55.

Srebnik, Debra S., et al. "The content and clinical utility of psychiatric advance directives." Psychiatric Services 56.5 (2005): 592-598.

Murray, Heather, and Hal S. Wortzel. "Psychiatric advance directives: origins, benefits, challenges, and future directions." Journal of Psychiatric Practice® 25.4 (2019): 303-307.

부 록

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

오리엔테이션

Q1. 어떤 기대를 가지고 오셨나요?

Q2. 정신질환의 회복과 관련하여 가장 원하는 것이 무엇인가요?

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

Topic 1. 회복이란 무엇인가?

Q1. '나'를 가장 잘 소개할 수 있는 단어 3~5개를 적어보세요

ex) 취미, 성격, 별명, 목표, 좋아하는 것, 싫어하는 것 등

회복의 핵심 요소



포함 - 공동체에 포함되어 다른 사람과 같은 기회가 주어지는 것은 회복에 매우 중요하다.

관계 - 친구, 연인, 가족 구성원, 정신 건강 및 다른 임상가, 동료지원가를 포함한 동료들은 당사자의 회복 과정의 핵심적인 지지자가 되어 회복 과정에 중요한 역할을 한다.

희망 - 희망은 회복 여정을 지속해 나갈 수 있는 힘으로, 희망이 없다면 당사자들은 회복의 여정을 포기할 수도 있다.

믿음 - 자신의 상황이 변할 수 있다는 믿음이 회복적 접근에 핵심적이며, 희망을 고취하는 관계로부터 길러진다

정체성 - 정체성이란, 자신을 개인으로서, 타인과의 관계 속에서 그리고 자신이 속한 공동체 안에서 정의하는 것이다. 당사자들은 진단을 받은 뒤에 '자기'에 대한 지각을 잃어버리기 때문에, 정체성을 다시 정의하고 재구성하는 것은 회복의 핵심 요소이다.

의미와 목적 - 회복은 당사자들의 삶을 재건하고 의미를 찾는 것을 돕는다는 점에서 중요하다.

꿈과 포부 - 회복적 접근은 사람들이 발전하고 꿈과 삶의 포부를 성취하도록 역량을 강화하고 지지하는 데에 도움이 된다.

통제와 선택 - 회복은 개인이 그들의 법적 역량을 사용하여 스스로의 결정을 내리는 것을 존중하는 것과, 개인에게 도움이 된다고 간주될 때에 언제나 지지를 제공하는 것에 초점을 둔다.

오르막과 내리막을 다루기 – 회복은 사람들이 삶의 부정적인 순간과 관련된 모든 촉발인자를 다루기 위해 요구되는 기술을 터득하는 것을 가능하게 한다.

긍정적인 위험성 감수 - 회복의 여정에는 위험 감수를 빼놓을 수 없다. 긍정적인 위험을 감수하기 위한 시작점에서 당사자들을 지지하는 것이 매우 중요하다.

조별활동

10가지 회복의 핵심요소 중 마음에 드는 3가지를 골라보고,
그 이유에 대해 간단히 적어보세요!

핵심요소	이 유

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

Topic 1. 회복이란 무엇인가?

엘리노어 롱든(Eleanor Longden)의 TED 강연 "내 머릿속의 목소리(The Voices in my head)"의 번역자막

영상 출처: 한글도서관, TED [엘레노어 롱든] 내 머릿 속의 목소리https://www.youtube.com/watch?v=yyNZMlE8htE&t=682s
번역자막 출처: http://www.ted.com/(번역자 Surie Lee, 감수자 Yong-Hu Fang)

0:11 집떠나 처음으로 대학교에 등교하던 날은 화창하고 넘칠듯한 희망과 낙관이 함께 한 날이었어요. 저는 학교에서 성적이 우수했고, 저에 대한 기대도 높았어요. 그리고 전 매우 기쁘게 강의와 파티, 교통 표지를 훔치고 다니는 학생 생활에 입문했어요.

0:27 저의 이런 모습들이, 물론 속임수일 수 있어요. 어느 정도까지는 이런 적극성, 수업에 참여하고 교통 표지를 훔치는 열정적인 성격은 잘 만들어지고 그럴듯하기만 한 겉포장이었어요. 그 이면에 저는 실제로 매우 불행하고, 불안하고, 근본적으로 두려워하고 있었어요 다른 이들을, 미래를, 실패를, 그리고 내면의 공허함을 두려워했어요. 하지만 저는 두려움을 숨기는데 익숙했고, 외부에서는 모든 것에 희망적이고 열정을 가진 이로 보였지요. 이 무적의 신화는 그렇듯 완벽해서 제 스스로도 속을 정도였어요. 그리고 나서 첫 학기가 끝나고 두번째 학기가 시작되자 무슨 일이 벌어질지 누구도 예견할 수 없는 상황이 벌어졌어요.

1:09 저는 세미나가 시작되자 자리를 뜨고 있었어요. 콧노래를 부르고 가방을 만지작거리면서 말이죠. 전에 백여 번은 했었던 것처럼요. 그런데 갑자기 나지막한 목소리가 들렸어요. "그녀가 방을 나가고 있어."

1:22 주변을 둘러보았지만 아무도 없었어요. 그러나 분명하고도 단호한 그 말은 잘못 들었을수가 없었어요. 저는 벌벌 떨면서 책을 계단에 둔 채로 집으로 서둘러 돌아왔어요. 그리고 나서 다시 그 목소리가 들렸어요. "그녀가 문을 열고 있어."

1:33 이것은 시작이었어요. 목소리가 저를 찾아온 거에요. 그리고 계속되었지요. 며칠 그리고 몇주, 쉬지 않고 말이에요, 제가 한 모든 행동에 대해 삼인칭으로 들려줬어요.

1:44 "그녀가 도서관에 가고 있어."

1:46 "그녀가 강의실로 가고 있어." 중립적이고 아무런 감정도 없이, 심지어 몇 번 반복된 후에는 친근하고 안심이 되기조차 했지요. 그 조용한 존재가 때로는 실수한다는 것과 이따금 숨은 감정을 반영한다는 것을 분명히 인지하고서도 말이지요. 즉 예를 들어, 화가 났지만 숨겨야 할 때 종종 그랬던 것처럼 매우 능숙하게 실제로 어떻게 느끼는지를 숨겼지만 그 목소리는 화난 것처럼 들렸어요. 그러나 불길하거나 불안하지는 않았어요. 그 시점에서 내 감정, 특히 멀고 접근할 수 없는 감정들과 나 사이에 소통할 그 무엇이 있다는 것이 분명했음에도 불구하고 말이죠.

2:21 그 당시 전 치명적인 실수를 했어요. 친구에게 그 목소리에 대한 이야기를 하자, 그 친구가 겁을 먹은거죠. 미묘한 조절 과정이 시작되었어요. 보통 사람들은 그 목소리를 듣지 않는다는 것의 의미와 제가 매우 심각하게 잘못된 것을 말했다는 사실 사이에 말이죠. 그 두려움과 의혹은 금새 전파되었어요. 갑자기 더이상 처음처럼 그 목소리가 그리 친절하게 들리지 않았어요. 친구는 진단을 받아야 한다고 저를 설득했고, 저는 그렇게 했구요, 그것이 저의 두번째 실수였지요.

2:49 학점에 대해서 얘기를 좀 하고선, 진짜 문제라고 여겨진 것들 -- 불안, 낮은 자존감, 미래에 대한 두려움에 대해 얘기하자 그 친구는 지루한 무관심을 보였고, 그 목소리에 대해 얘기하자 돌리던 펜을 떨구고 진정한 관심을 보이는 질문을 하기 시작했어요. 전 관심과 도움이 절실했기에 기이한 목소리에 대해 이야기하기 시작했지요. 그리고 전 이 시점에서 그 목소리가 항상 "그녀는 제 무덤을 파고 있어."라고 말해주었기를 바랬죠.

3:14 한 정신과 의사를 소개 받았는데, 그는 그 목소리의 존재에 대해 어두운 시각을 가지고 있었고, 그래서 제가 얘기하는 모든 것을 잠재적인 정신병의 관점에서 해석했습니다. 예를 들어, 저는 교내 소식을 전하는 학교 방송국에서 일했는데 약속 시간에 매우 늦어 "선생님 죄송하지만 가봐야겠어요. 여섯시에 뉴스를 진행해야 하거든요." 라고 했더니 진료 기록에 제게 방송국 뉴스 진행자라는 망상이 있다고 적어놓았습니다.

3:41 이 일을 시작으로 일련의 사건들이 저를 따라왔어요. 제일 먼저, 병원에 입원하게 되었고, 그 뒤에 정신 분열증 진단이 나왔어요. 그리고 최악이었던 것은, 제 자신과 제 장래에 대한 가망없고 굴욕적이며 절망적인, 끔찍하고 고통스러운 감정이 찾아온거에요.

4:01 그러나 그 목소리를 일상 경험이 아니라 병리 증상으로 보게 되면서 그에 대한 두려움과 저항은 더욱 가중되었어요. 필연적으로 제 의식에 대해서 호전적 태도를 갖게 되었어요. 일종의 정신적 전쟁이었죠. 그러자 목소리가 들리는 횟수가 더욱 잦아졌어요. 그리고 점점 적의와 위협의 수위가 높아졌어요. 무기력하고 절망스러운 나머지 저는 이 악몽같은 내면 세계에 굴복하기 시작하였고 결국 그 목소리는 운명적으로 저의 박해자이자 유일하게 인지되는 동반자가 되었어요. 예를 들어, 그 목소리들은 제가 도움을 받을만한 가치가 있는지를 증명하면 제 삶을 이전의 상태로 되돌려 줄 수 있다고 했고, 헤라클레스만이 능히 해낼 수 있을 법한 기괴한 일들이 연속해서 일어났어요. 아주 작은 것부터 시작했어요. 예를 들면, 머리카락 세 가닥을 뽑는 것같은 거죠. 하지만 점점 더 극단적인 것으로 발전해, 최고조에 이르자 자해를 지시하는 수준이 되었고, 특별히 극적인 지시가 내려졌어요.

4:55 "저기 저 강사 보이지? 저기 물컵 보이지? 좋아, 저 강사에게 가서 학생들이 보는 앞에서 컵에 든 물을 부어버려."

5:01 실제로 그렇게 했고, 말할 필요없이 교수님들은 저를 싫어했지요.

5:05 그 영향으로 잔인한 두려움과 회피, 불신과 오해의 순환이 반복되었고, 이 전쟁은 저를 무기력하게 만들고 아무런 평화나 화해도 찾을 수 없게 되었어요.

5:19 2년 후, 악화된 상태는 볼 만했어요. 지금까지 저는 모든 광적인 레퍼토리를 모두 갖고 있었어요. 겁나는 목소리, 기괴한 환영 괴상하고 떨칠 수 없는 망상들. 제 정신 건강 상태는 차별과 언어 폭력, 그리고 육체적이고 성적인 폭행의 근원이 되었고, 정신과 의사는 저에게 "엘레노어, 차라리 암에 걸리는게 나아, 암은 정신 분열증보다 고치기 쉽거든." 라고 하더군요. 진단받고 약도 처방 받았지만 결국 포기했고, 이제는 그 목소리로 인한 고통이 너무 심해 제 머리에 구멍을 뚫어 그들을 꺼내 버리려고까지 했어요.

5:57 이제와 그 파괴되고 절망스러웠던 그 시간들을 뒤돌아보면 누군가는 그 자리에서 죽고, 동시에 누군가는 살아남은 것처럼 보여요. 부서지고 무언가에 홀린 사람이 그 여정을 시작했으나 그 길에서 벗어난 사람은 살아남은 자였고, 결국은 제가 목표했던 사람으로 성장하게 되었습니다.

6:19 제 인생에서 많은 이들이 저를 다치게 하고 그들 모두를 기억하지만 저를 도와주었던 이들의 기억에 반해 그 기억은 점차 희미해지고 잊혀졌어요. 동반 생존자들, 내 말을 들어준 이들, 친구들과 협조자들, 저를 결코 포기하지 않으셨던 어머니, 어머니는 언젠가 제가 그 분에게 돌아올 걸 믿었고 그것이 얼마나 긴 시간이 걸릴지라라도 말이에요. 의사 선생님은 짧은 기간만 저를 치료해 주셨지만 저에게 회복이 가능할 뿐 아니라 꼭 이루어질 거라는 믿음을 주셨고, 충격적이었던 재발 기간동안 두려워하는 제 가족들에게 "희망을 버리지 마세요, 저는 엘레노어가 이 시기를 이겨낼 거라고 믿어요. 아시죠, 때로는 5월에도 눈이 내리지만 결국 여름은 오기 마련이에요." 라고 말해 주었습니다.

7:05 14분이란 이 짧은 시간은 모든 친절하고 고마운 이들, 내 편에서 나를 위해 싸워주고 괴롭고 외로운 곳에서 제가 돌아올 것을 기다려 준 이들 모두를 말씀드리기에는 부족한 시간이에요. 이들은 모두 함께 용기와 새로운 아이디어, 존엄성과 산산조각난 제 자아가 치료되고 재결합될 수 있다는 흔들리지 않는 믿음의 결합을 만들어주었어요. 이들이 저를 살렸다고 말하곤 하지만, 이제사 제가 알게된 것은, 그들이 한 일들이 제 자신을 살리도록 힘을 불어넣어 준 것 그 이상이고, 결정적으로 그들은 제가 늘 의심하던 어떤 것을 이해하는데 도움을 주었어요. 즉 그 목소리가 제 인생의 트라우마로 남은 기억들, 특히 어린 시절의 기억들에 대한 의미심장한 반응이고, 그것이 나의 적이 아니라 해결 가능한 감정적 문제에 대한 직관의 근원이라는 것을 이해하게 되었어요.

7:49 사실 처음에는 믿기 어려웠어요. 특히 그 목소리들이 적대적이고 위협적으로 나타났기 때문에 이 점에 있어서 제가 내디뎠던 가장 중요한 첫발은 은유적인 의미를 제가 알고 있었던 문자그 대로의 의미로부터 구분해 내는것을 학습하는 것이었어요. 즉 예를 들어 우리 집을 공격하겠다고 위협하는 목소리는 실제적인 구체적 대상의 위협이 아니라 내면의 두려움과 세상에 대한 불안한 감정들로 해석해야 한다는 것을 알게 되었어요.

8:14 처음에는 그 목소리들을 믿어야 했어요. 한 예로, 어느 날 밤 부모님의 방을 지키려고 깨어 앉아있었던 생각이 나요. 그 목소리의 위협이 실제 협박이라고 생각했기 때문이죠. 자해의 위험이 있었기 때문에 집안의 식사용 칼, 포크는 대부분 숨겨져 있었어요. 결국 저는 플라스틱 포크로 저 자신을 무장했어요. 그 소풍갈때 들고 가는거 말이에요, 그리곤 방문 앞에 앉아 무슨 일이 일어나면 즉시 대응하려고 했지요 그건 마치 "까불지마. 나한테 플라스틱 포크가 있어, 알지?" 라고 하는 것 같았죠. 나름 전략적이었죠.

8:43 하지만 그 이후의 대응은 훨씬 더 유용했는데, 문장 이면의 의미를 재구성해보려고 노력했어요. 그래서 그 목소리가 집을 떠나지 말라고 경고하면, 내가 얼마나 불안해하고 있는지를 알게해주어 감사하다고 느꼈지요. 제가 깨닫고 있으면 긍정적인 대응을 할 수 있으니까요. 그 목소리와 제 자신에게 모두 우리는 안전하고 더이상 두려워 할 필요가 없다고 안심시켰습니다. 그 목소리에 대한 경계를 정했고, 당당하지만 존중하는 태도로 그 목소리에 반응하려 노력했어요. 소통과 협력의 관계를 서서히 수립하고, 함께 일하고 서로를 도울 수 있는 방법을 배우기 위해서였죠.

9:17 이 모든 과정을 지나, 궁극적으로 깨달은 것은 각각의 목소리가 저의 다양한 모습들, 그 하나하나와 밀접하게 연관되어 있다는 것이었습니다. 그 각각은 압도적인 감정을 지니고 있어서 저는 성적인 트라우마와 성희롱의 기억들, 분노, 수치, 죄의식, 낮은 자존감 같은 것들을 진행하거나 해결할 수 있는 기회조차 갖지 못했습니다. 그 목소리는 이 아픔들의 자리를 차지하고 각각에 그 말들을 전해 주었던거에요. 그리고 가장 큰 수확 중 하나는 가장 적대적이고 공격적인 목소리의 대부분이 실제로는 마음 깊은 곳에서 받았던 상처를 대변한다는 것을 깨달았다는 점입니다. 그리고 그 말인 즉슨, 이 목소리가 가장 위로와 보호가 필요하다는 얘기지요.

9:52 이런 깨달음으로 무장하게되자, 결국 각각의 조각이 서로 다른 목소리를 반영하는 제 산산조각난 자아를 하나로 모아 점차 모든 약을 끊고 정신과 의사를 다시 찾았습니다. 이제는 다른 사람이 되어서요. 그 목소리가 찾아온지 십 년만에 심리학 전공으로 대학에서 줄 수 있는 가장 높은 점수를 받고 졸업한 뒤, 일년 후에는 최우등생으로 석사를 마쳤습니다. 미친 여자에게 그리 나쁘지 않은 거라 할 수 있겠네요. 사실은 목소리 중 하나가 실제로 시험보는 동안 답을 알려줬어요. 아마도 컨닝으로 판단될 수도 있을거에요.

10:26 솔직히 말해 가끔 그 목소리의 관심을 꽤나 즐기기도 했어요. 오스카 와일드가 말했듯이, 이야기의 대상이 되는 것보다 나쁜 것 단 하나는, 이야기의 대상이 되지 못하는 것이니까요. 또한 엿듣는 데에도 도움이 됩니다. 동시에 두 대화를 들을 수 있거든요. 그러니까 다 나쁜 것만은 아니에요.

10:40 전 정신 보건 단체에서 일했고, 학회에서 강연도 했고, 책도 내고 논문도 쓰고, 논쟁하고 또 계속 그렇게 할 겁니다. 이 개념의 타당성을 입증하기 위해서요. 정신 의학에서 중요한 질문은 무엇이 잘못되었는지가 아니라 무슨 일이 일어났는지를 물어야 한다는 것입니다. 그리고 항상, 저는 제 목소리를 듣습니다. 마침내 평화롭게 서로 존중하며 살기로 깨닫고, 그 보답으로 제 자신에 대한 연민과 긍정, 그리고 존경심을 보답해주는 그 존재 말이지요. 그리고 가장 가슴 뭉클하고 특별한 순간을 기억합니다. 내면의 목소리로 인해 철저히 파괴된 한 젊은 여성을 도왔을 때, 처음으로 온전히 이해했습니다. 제가 더 이상 그 상황에 처해있지 않다는 것을 깨닫고, 마침내 나랑 같은 처지의 다른 이를 도울 수 있는 경험자가 되었다는 것을요.

11:24 저는 이제 인터보이스의 일원이 된 것 을 자랑스럽게 생각해요. "국제 목소리 듣기 운동" 이라는 이 단체는 마리우스 롬 교수와 산드라 에셔 박사의 탁월한 업적에 의하여 설립되였어요. 우리는 목소리 듣기를 생존 전략으로써 정신 이상 상황에 대해 이성적인 대응은 정신 분열증의 비정상적인 증상을 견뎌야 할 것이 아니라 탐구해야 할 복잡하고도 분명하며 의미있는 경험이라고 보고 있어요. 우리는 함께 목소리 듣기를 이해하고 존중하는 사회를 꿈꾸고 또 이를 위해 노력합니다. 목소리를 듣는 이들의 필요와 온전한 시민으로써의 가치를 지지합니다. 이러한 사회는 가능할 뿐만 아니라, 이미 그 단계에 와있어요. 차베스 대통령의 말을 옮기자면, 사회의 변화가 시작되면 되돌릴 수 없습니다. 자부심을 느끼는 사람을 모욕할 수는 없어요. 더 이상 두려워하지 않는 사람을 억압할 수는 없어요.

12:20 저에게는 국제 목소리 듣기 운동의 성과가 공감과 교제, 정의와 존중이 말에 앞선다는 것을 새삼 일깨워줍니다. 이는 확신이자 믿음이고, 그 믿음은 세상을 바꿀 수 있습니다. 지난 20년 간 목소리 듣기 운동은 목소리 듣기 네트워크를 5대륙에 걸쳐 26개 국가에 설립했어요. 존엄과 연대, 그리고 정신 질환자들의 권익 보호를 위해 함께 일하며, 개개인의 힘을 믿는 흔들리지 않는 믿음을 한가운데에 두고 새로운 언어를 만들며 희망을 연습하고 있어요.

12:58 피터 레빈이 말했던 것처럼, 인간이란 동물은 특별한 존재로 본능적으로 치유할 수 있는 능력과 이런 내적인 능력을 보호하는 지적인 영혼을 갖춘 존재입니다. 이런 점에서, 사회의 구성원들에게는 증인이 되어주고, 손을 내밀고, 그가 겪는 짐을 나누며 회복에 대한 희망을 붙잡아 누군가를 치유하는 과정을 돕는 것처럼 더 큰 영예와 영광은 없습니다. 마찬가지로 고통과 역경을 이겨낸 이들에게는 우리에게 일어난 일들로 인해 손상된 것으로 정의된 삶을 살 필요가 없다는 것을 기억하게 해주지요. 우리 개개인은 특별해요 우리는 무엇과도 바꿀 수 없습니다. 우리 안에 있는 그 무엇도 우리를 지배하거나, 조종하거나, 빼앗을 수 없어요. 그 빛은 결코 사라지지 않습니다.

13:46 아주 훌륭한 의사가 저에게 말했듯이 말이에요. "다른 사람이 당신에 대해 이야기한 것 말고, 당신에 대해 얘기해 주세요."

13:55 감사합니다.

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

Topic 8. 회복 의사소통 기술 (1)

대화 = 과정인 동시에 목표

① 대화를 위한 공간

- 자기를 표현할 수 있는 공간
- 구성원들이 서로의 차이를 용인하면서 서로의 말을 신중하게 경청하는 공간
- 자신의 근심이 신중하게 경청되고 진지하게 받아들여지고 응답을 받는 공간

→ 회복 의사소통을 위해선, 대화를 할 수 있는 공간의 확보가 필요하다.

② 반응적 경청

- 대화의 목적은 무엇인가를 해결하려는 것이 아니다.
- 대화가 이끌어가는 데로 '따라가는 것'이 대화의 목적이다.
- 대화가 우리를 이끌기 위해서 모든 대화를 차별없이 존중하는 것이 필요하다.

→ 그것을 우리는 '경청'이라고 부른다.

종사자와 보호자가 자주하는 실수

Ex) 당사자의 증상을 평가하고 진단을 내리는 것을 대화의 목적이라고 생각한다.

→ 대화 중에 경험하고 있는 어려움이 무엇이고, 그것에 대해 각자가 어떻게 이해하고 있는지, 그리고 각자 어떤 것이 좋은 결과라고 생각하고 있는지에 대한 서로의 의견을 탐색하며 그 흐름을 따라가는 것이 중요하다.

→ 해답이 아닌 대화의 과정 속에서 존재하는 경험 자체를 얻는 것이 필요하다.

③ 반영하기 (Reflection)

- 경청의 주된 요소
- 자신의 감정이나 생각, 더 나아가 자신이 대화에 반영 되는 것

→ 받아들여지는 경험, 정서적 공명을 경험

반영을 위한 팁 → 복창하기 (바흐친 = 침투된 말_Penetrated word)

- 자신이 이야기 했던 언어가 타인에 의해 복창 될 때, 발화자에게 침투가 되어 자신이 이야기 했던 내용과 어조, 톤 등을 더 쉽게 발견할 수 있다.
- 타인에 의한 복창은 자신의 주장이 타인뿐만 아니라 자신에게도 청취되고 있다는 경험을 강조한다. 이는 자신의 이야기가 존중받고 있다고 느끼게 하여, 자기 경험의 내밀한 부분을 공유하도록 안심시켜 준다.
  또한, 고착 상태였던 자신의 생각에 변화를 이끌어 낼 수도 있다.

→ 반영을 할 때 대화를 하고 있는 사람들은 서로의 생각, 느낌, 연상 등을 일상 언어를 사용하여 공유하는 것이 중요하다.

④ '함께' 대화와 '관하여' 대화

- 대화를 촉진하기 위해선 '함께' 대화법이 필요하다.
- 종사자는 전문가의 위치에 갇힌 채로 임상적 응시를 하기 쉽다. (관하여 대화)
  Ex) "당신의 증상(전문용어를 사용하며)에 관하여 이야기 해볼까요?"
- 일상 언어를 사용하면서 대화에 참여한다. (함께 대화)

→ 자기 자신이 대화에 더 많이 투입된다. (자신의 경험, 감정 등)

→ 자신의 감정과 타인의 감정 반응에 집중하는 것이 필요하다.

Ex) "당신의 이야기를 들으니, 저도 속이 상합니다. 저는 그럴 때면, 좋아하는 음악을 듣곤해요.
혹시 당신은 좋아하거나 즐겨 듣는 음악이 있나요? 있다면 소개해 줄래요?"

출처

Putman, N., & Martindale, B. (2023). *Open dialogue for psychosis* (K. S. Kim & D. H. Jeon, Trans.). Korea Institute for Clinical Psychoanalysis (ICP). (Original work published 2021)

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

Topic 9. 회복 의사소통 기술 (2)

정신증 환자의 언어와 행동에 대한 이해

→ 극단적 스트레스에 대한 반응 = 능동적 노력의 결과

: (증상으로 인해) 감당하기 버거운 경험을 했기에, 합리적으로 이야기를 구성하는 것이 불가능했을 수 있다.
이러한 경험을 감당하기 위해 개인의 정신이 벌이는 능동적 노력의 결과로 이해할 수 있다.

: 정신증 환자의 언어와 행동은 은유를 통해 당사자의 경험을 '이야기하고' 행동화 한다고 이해 할 수 있다.

대화를 위한 실질적인 지침

1. 시종일관 관계에 집중하기

- 대화에 참여한 모두를 동등하게 존중하고 포용하는 대화를 생성한다.
- 당사자의 말을 계속 경청하고 숙고해야 한다.
- 종종 정신증적 발언을 포함할 수 있는 이야기를 들으면서 다른 가족 구성원들이 어떻게 반응하는지도 면밀히 살펴야 한다.
- 정신증적 내용의 진위여부를 판단하거나 동의/비동의를 결정하는 것이 아니라, 서로의 감정의 흐름에 집중하고 반응하는 것이 필요하다.

2. 정신증 경험을 무조건적으로 존중하기

① 현실을 지향하도록 정신증적 경험이 '증상' 이라고 이야기 할 수는 있다.

- 하지만, 적절한 순간이 아니라면 자신의 경험이 거부당했다고 느끼고, 더 이상의 은유적 대화를 보여주지 않을 수 있다.

"모임에 참석한 전문가들이 그 인물의 경험의 현실성을 받아들이지 않으면, 흔히 그 인물은 자신의 생각과 느낌을 스스로 통제할 능력이 실제보다 더 약하다고 느끼게 된다." -Avdi 2005, Harper 1995, Holma and Aaltonen 1998, Karatza and Avdi 2011-

② 뇌의 문제로 단정하는 '지식화'를 주의해야 한다.

- 자신이 경험한 것이 실제와는 무관하며 단순한 증상의 하나로 설명하는 것은 당사자의 혼란을 가중시키고, 이후의 대화에서 자기 주도성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 그 결과, 타인과의 소통 범위가 제한될 뿐만 아니라, 자신에게 이로운 나름대로의 자기 이해와 그로 인한 행동 개발에 제약을 줄 수 있다.

③ 정신증적 발언을 하는 것은, 발화자에게 무척이나 고통스러운 경험이다.

- 대화 중 누군가가 정신증적 발언을 하기 시작한다면, 이는 자신의 삶에서 가장 힘겨웠던(혹은 트라우마적이었던) 경험을 언급하기 시작하는 것일 가능성이 있다.
- 이때, 무조건적인 존중의 대화는 자신의 트라우마적인 경험을 스스로 '건드려' 정리하고 이야기 하게끔 한다.
- 정신병적 증상에 대한 발언이 나올 때, 이렇게 이야기 할 수 있다.
  "이야기를 꺼내주어 고마워요. 당신의 이야기를 더 듣고 싶어요"

예시1) 남편이 자신을 죽이려 오고 있다는 여자

"잠깐만요. 남편이 당신을 죽이러 온다는 생각이 든다고 이야기 한 것 같은데, 제가 제대로 들은 것이 맞나요? 잘 이해되지 않는 부분이 있습니다. 혹시, 제가 당신을 잘 이해할 수 있도록 조금 더 설명해주실 수 있을까요?"

"언제부터 그런 생각을 하셨지요? 그런 생각이 항상 드나요? 아니면 가끔씩 드나요?"

→ 전문용어를 사용하여 병리적인 표현이 아닌, 일상적인 대화에 머무르기

예시2) 누군가 자신을 괴롭히려고 소음을 발생시키고 있다는 남자

"이야기를 들어보니, 상당히 괴로울 것 같아요. 저는 당신을 돕고 싶습니다. 혹시 제가 어떻게 도우면 좋을지 생각해 본 방법이 있을까요?"

"들어보니, 정말로 당신에게 위협적인 상황인 것 같네요. 위협당할 때 어떤 느낌이 드는지 말해줄 수 있을까요?"

3. 지금, 여기(Here and Now) 대화법

- 대화에서 가장 중요한 것은 '지금, 여기'이다. 당사자가 지금, 여기서 하는 이야기에 초점을 맞추어야 한다.
- 과거의 일에 집중을 하면, 현재의 대화에서 스스로가 성찰을 할 기회를 잃는다.

4. 가족 구성원을 위한 회복 의사소통

① 정신병적 증상을 사랑하는 사람의 입에서 듣는 것은 무척이나 고통스러운 경험이다.

- 가족 구성원의 정신증적 사건은 가족 전체에게 매우 트라우마적인 경험이다.
- 가족 구성원들이 염려의 중심에 놓인 당사자에 대해 대화하며 서로의 마음을 공유하지 않기 때문에 트라우마는 더욱 심화된다.

(1) 부모나 형제로서 실패했다는 느낌
(2) 가족 구성원에 대한 죄책감
(3) 아들이나 딸을 치유하지 못한 치료 시스템에 대한 분노

→ 이 모든 감정적 경험과 느낌들이 발설되지 않은채 '급속 냉동된' 상태로 보존이 되어 있으며, 해동이 될 때마다 생생하게 트라우마를 재경험한다.

- 또한 사랑하는 사람의 입에서 정신증적 발언이 나온다면 가족들의 불안감은 올라가고, 빠르게 '교정'을 해주고 싶다는 욕구를 참기 어렵다.
- 하지만 성급하게 현실로 이끌기 시작하면 당사자가 자신의 삶에서 겪었던 고통스러운 경험에 대해 스스로의 생각을 펼쳐나가는 것이 불가능해질 위험이 있다.

② 당사자의 마음을 변화 시킬 수 있는 것은, 오직 '당사자' 뿐이다.

- 스스로가 '다른 생각'을 할 수 있도록 도와주고 기다려 주는 것이 필요하다.
- 환청을 포함한 정신증 증상을 자신의 인생 경험과 연결할 수 있게 하는 것이 필요하다.
- 만약, 회복 과정 중 당사자가 자신이 경험하고 있는 환청은 현실에 존재하지 않으며 자신의 내적 경험의 일부라고 생각한다면, 그에게 환청은 더 이상 증상이 아니다.

따라서 가족 구성원에게는 다음의 내용이 필요하다.

① 열린 대화와 소통: 당사자의 경험에 대한 서로의 마음을 공유하고, 감정을 허심탄회하게 나눌 수 있는 공간을 조성해야 한다. 이를 통해 트라우마가 심화되는 것을 방지하고 당사자를 염려의 중심에서 가족 구성원의 중심으로 초대할 수 있다.

② 감정의 수용: 각자가 가지고 있는 실패감이나 죄책감에 대해 수용하는 과정이 가족 전체의 회복에 필요하다.

③ 인내와 지원: 정신증적 언어와 행동이 당사자의 능동적 노력의 결과임을 이해하고, 당사자가 스스로 자신에 대한 이해를 발전 시킬 수 있도록 돕고, 인내하는 것이 필요하다.

④ 전문적인 자원 활용: 가족 구성원 스스로가 감당하기 어려운 감정이나 상황이 있다면, 전문적인 자원 (정신의학적 도움, 개인/가족 상담, 가족지원활동가 연계 등)을 활용하는 것이 필요하다.

출처 Putman, N., & Martindale, B. (2023). Open dialogue for psychosis (K. S. Kim & D. H. Jeon, Trans.). Korea Institute for Clinical Psychoanalysis (ICP). (Original work published 2021)

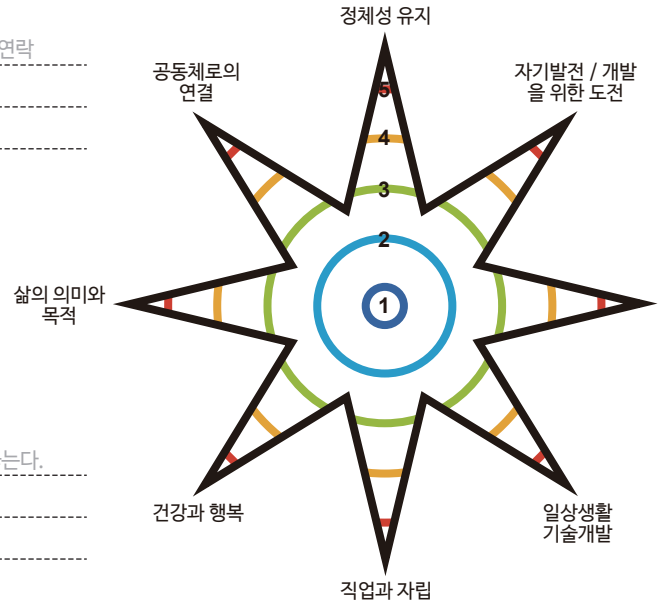
퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

Topic 10. 회복의 별

'회복의 별'이란?

- 회복의 별은 성과의 별(Outcomes Star)TM(Triangle Consulting Social Enterprise Limited, 2009 - 2015, Dickens et al., 2012, Onifade, 2011)의 개념을 차용했습니다.
- 당사자, 보호자, 종사자가 함께 회복의 별을 그리면서, '퀄리티라이츠 리커버리 프로그램'에서 이야기한 회복의 요소에 대한 현재의 상태를 파악하고 앞으로 나아갈 방향에 대한 논의를 시작할 수 있습니다.
- 회복의 별은 회복의 여정에서 자신의 진행상황을 확인할 수 있도록 여러 시점에서 사용할 수 있습니다.

님의 년 월 일의 회복의 별



1. 매일 일기를 쓴다.
2.
3.

1. 친구와 다시 연락
2.
3.

1. 악기를 배운다.
2.
3.

1. 매주 교회에 출석
2.
3.

1. 외래를 스스로 챙긴다.
2.
3.

1. 술/담배를 끊는다.
2.
3.

1. 요리학원에 등록
2.
3.

1. 아르바이트를 시작
2.
3.

'회복의 별'의 각 꼭지점

① 정체성 유지

예시) · 나 다움이 무엇인지 이야기 하기
· 사람들이 나를 저평가하도록 놔두지 않기

② 공동체로의 연결

예시) · 가족/친구와 시간 보내기
· 과거에 머물렀던 공동체로 돌아간다. (학업, 직업, 종교 활동 등)

③ 삶의 의미와 목적

예시) · 매주 종교 활동에 참여하기
· 삶의 의미를 찾기 위한 활동 탐색하기

④ 건강과 행복

예시) · 건강한 몸을 위한 운동, 규칙적인 수면
· 해로운 습관의 중단

⑤ 직업과 자립

예시) · 자신의 강점과 자산 확인하기
· 직업 활동을 위한 구체적인 계획 세우기
· 정신건강복지센터/장애인고용공단 방문

⑥ 일상생활 기술 개발

예시) · 스스로 장을 보고 요리하기
· 주기적으로 집 청소/정리정돈 하기

⑦ 자기주도적 치료 참여

예시) · 스스로 약물 관리/외래 방문 하기
· 자신의 치료에 대해 치료자와 의견 나누기

⑧ 자기 발전/개발을 위한 도전

예시) · 개발하고 싶은 분야 탐색하기
· 동호회 가입을 하거나, 학원 등록하기

'회복의 별'의 사용법

활동 1.

① 8가지 회복 요소가 자신의 삶에 얼마나 중요한지 1점부터 5점 사이에 표시해 주세요.

② 표시한 점수들을 이어 주세요.

중요성 (1 ~5점)

1점 : 조금 중요하다 → 나의 삶에 크게 영향을 미치지 않으며, 개선의 필요성을 크게 느끼지 않는다.

2점 : 다소 중요하다 → 나의 삶에 약간의 영향을 주는 편이며, 어느 정도 관심을 둬야 할 필요가 있다.

3점 : 보통 → 평균 수준으로 중요하며, 필요할 경우 주의를 기울인다.

4점 : 꽤 중요하다 → 나의 삶에 중요한 영향을 미치며, 개선을 위해 꾸준히 주의를 기울인다.

5점 : 매우 중요하다 → 삶의 질에 큰 영향을 미치는 요소로, 항상 우선순위에 두고 관리한다.

활동 2.

① '활동 1'에서 사용한 펜과는 다른 색깔의 펜을 사용하여, 8가지 회복의 요소가 자신의 삶에서 얼마나 실현되고 있는지 1점부터 5점 사이에 표시해 주세요.

② 표시한 점수들을 이어 주세요.

실현 정도 (1 ~5점)

1점 : 거의 실현되지 않음 → 나의 삶에 전혀 이루어지지 않고 있으며, 개선이 필요하다.

2점 : 다소 실현됨 → 나의 삶에 약간의 진전은 있지만 여전히 많은 발전이 필요하다.

3점 : 보통 → 어느 정도 목표가 이루어지고 있으며, 추가적인 노력이 필요하다.

4점 : 꽤 잘 실현됨 → 나의 삶에 목표가 대부분 달성되고 있으며, 지속적인 유지 및 개선이 필요하다.

5점 : 매우 잘 실현됨 → 나의 삶에서 목표가 완전히 달성되었고, 높은 수준을 꾸준히 유지하고 있다.

회복의 요소들 중 중요하다고 생각하지만 삶에서 실현되는 정도와 차이를 보이는 요소가 있나요? 차이는 보이지 않지만 계속해서 유지를 하기 위한 노력이 필요한 요소가 있나요? 가장 시급하게 변화가 필요한 회복의 요소가 무엇인가요? (가장 큰 차이)

활동 3.

삶에서 회복의 요소가 더 실현이 되거나, 실현된 것들이 유지 될 수 있도록 구체적인 계획을 적어보세요

출처 The Recovery Star: Outcomes Star [website]. Brighton: Triangle Consulting Social Enterprise Limited; 2009 - 2015.
Dickens, Geoff, et al. "Recovery star: validating user recovery." The Psychiatrist 36.2 (2012): 45-50.
Onifade, Yetunde. "The mental health recovery star." Mental Health and Social Inclusion 15.2 (2011): 78-87.

[ ] 님의 회복 계획

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

1단계. 꿈과 목표를 위한 계획

1. 나의 꿈/목표 탐색하기

나의 어린시절의 꿈 / 목표는 무엇이었나요?

나의 현재 꿈/목표는 무엇인가요?

* '꿈' 이라는 단어가 막연하게 느껴진다면, '장래희망'을 떠올려 보세요.

꿈이나 목표가 변한 이유

* 꿈이나 목표가 변하게 되었던 중요한 사건이나 현실적인 어려움이 있었다면 자유롭게 써보세요

2. 나의 선호 탐색하기

* 자신의 선호와 멋에 대하여 자유롭게 적어보세요. 많으면 많을수록 좋습니다.

내가 '좋아하는 것', '나를 행복하게 하는 것'들은 어떤 것들이 있는지 적어보세요.

내가 '멋있다' 혹은 '닮고 싶다'고 생각하는 사람 / 캐릭터를 이유와 함께 적어보세요.

3. 나의 강점 탐색하기

당사자 스스로 생각하는 자신의 강점은 무엇인가요?

지지자가 생각하는 당사자의 강점은 무엇인가요?

* 지지자가 발견한 강점의 경우, 당사자가 동의한다면 당사자 스스로 생각하는 자신의 강점에 추가해 주세요.

4. 단기/중기/장기 목표 세우기

* '자신의 꿈/목표' 와 '나의 선호' 그리고 '나의 강점'을 종합하여 목표를 세워보세요.

① 단기 목표 (1~3개월의 목표)

<table>
<tr><td>단기 목표</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>단기 목표를
정한 이유</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">구체적
실천 방안</td><td>필요 정보</td><td></td></tr>
<tr><td>정보 수집 방법</td><td></td></tr>
<tr><td>실천 방안</td><td></td></tr>
</table>

4. 단기/중기/장기 목표 세우기

* '자신의 꿈/목표' 와 '나의 선호' 그리고 '나의 강점'을 종합하여 목표를 세워보세요.

② 중기 목표 (4~6개월의 목표)

중기 목표		
중기 목표를 정한 이유		
구체적 실천 방안	**필요 정보**	
	정보 수집 방법	
	실천 방안	

4. 단기/중기/장기 목표 세우기

* '자신의 꿈/목표' 와 '나의 선호' 그리고 '나의 강점'을 종합하여 목표를 세워보세요.

③ 장기 목표 (4~6개월의 목표)

<table>
<tr><td>장기 목표</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>장기 목표를
정한 이유</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">구체적
실천 방안</td><td>필요 정보</td><td></td></tr>
<tr><td>정보 수집 방법</td><td></td></tr>
<tr><td>실천 방안</td><td></td></tr>
</table>

2단계. 건강한 나'를 유지하기 위한 계획

1. '건강한 나'를 유지하기 위한 계획

열정적인	신중한	사랑스러운	호기심 많은
사교적인	내성적인	친절한	모험심이 강한
외향적인	의심이 많은	따뜻한	진지한
충동적인	화를 쉽게 내는	부지런한	태평한
자신감 있는	운동을 잘하는	염세적인	직설적으로 말하는
혼자 지내는	빨리 배우는	힘을 북돋아주는	성실한
말하는 것을 좋아하는	낙천적인	책임감 있는	재미있는
조용한	행복한	지지적인	장난기가 많은

* 단어 예시는 참고용일 뿐이며, 예시 외의 단어를 사용할 수도 있습니다.

Q. '건강한 나' 와 '건강하지 못한 나' 는 어떻게 다른가요?

건강한 상태에서 나는 어떤 행동을 하나요?

1.

2.

3.

건강하지 못한 상태에서 나는 어떤 행동을 하나요?

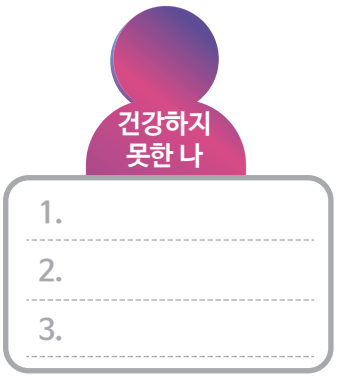
1.

2.

3.



지지자가 생각하는 '건강한 당사자'를 표현하는 단어



지지자가 생각하는 '건강하지 못한 당사자'를 표현하는 단어

2. 오르막과 내리막을 관리하기 위한 계획

① 초록불을 유지하기 위한 일상

* 초록불을 유지하기 위해 당신이 '규칙적으로' 할 수 있는 것들을 아래에 적어보세요.

초록불을 유지하기 위해 규칙적으로 할 것들

* 초록불을 유지하기 위해 '피하거나 중단해야'하는 것들을 아래에 적어보세요.

초록불을 유지하기 위해서 '피하거나 중단해야' 하는 것들

* 초록불을 유지하기 위한 시간표를 작성해 보세요.

	월	화	수	목	금	토	일
아 침							
오 후							
저 녁							

② 마음속 노란불과 빨간불 알아차리기

* 나의 기분신호등이 노란불이거나 빨간불인 상태와 그때 내가 할 수 있는 것들을 써보세요.

나의 경고 신호들	경고 신호를 경험할 때 내가 할 수 있는 조치들

③ 나의 마음상태를 노란불과 빨간불로 만드는 이유

* 촉발요인을 알아내는 것이 중요합니다. 촉발요인이란 당신을 불안하고, 두렵고, 비참하거나 낙담하게 만들 수 있는 내부/외부의 사건이나 상황을 말합니다.

* 촉발요인을 적고, 촉발요인이 발생했을 때, 어떻게 대처하는 것이 가장 건강한 방법일지 아래에 써보세요.

촉발요인	촉발요인이 발생했을 때 내가 할 수 있는 건강한 방법들

④ 종합하기

나의 경고 신호들	경고 신호를 불러오는 상황이나 자극 (촉발 요인들)	경고 신호를 경험할 때 내가 할 수 있는 조치들

3. 경고 신호가 나타날 때, 지지자들로부터 어떤 도움을 원하나요?

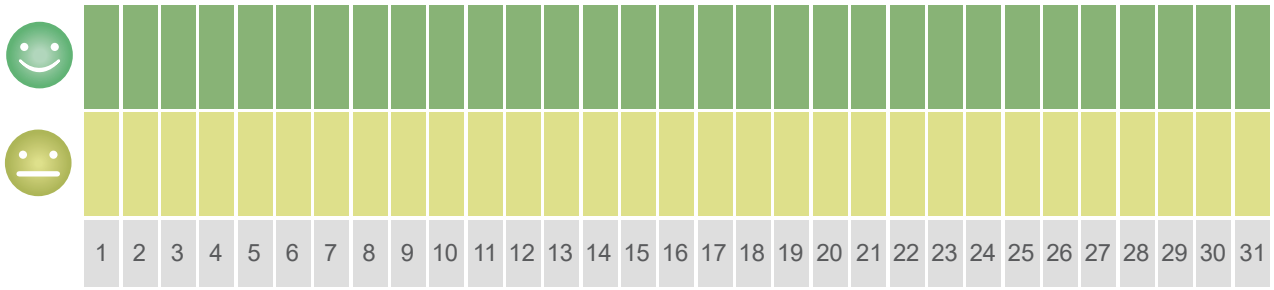
경고신호가 나타날 때, 지지자들에게 바라는 점 (보호자 [가족, 친척, 친구, 시설 관계자 등], 종사자)

내게 도움되지 않는다고 생각하는 것	도움이 되지 않는 이유

4. 기분 달력

* 하루하루의 기분과 기분 변화를 유발한 사건을 기록해 보세요. 기분 달력과 사건 기록은 당신의 촉발 요인을 더 잘 이해하는 데 도움을 줄 수 있으며, 이를 통해 안정된 상태를 유지하는 데 기여할 수 있습니다.

일일 기록 차트



참고 ① Nottinghamshire National Health Service (NHS) Trust. Personal Recovery Plan. Nottingham, United Kingdom: Nottinghamshire NHS Trust.
② Nottinghamshire National Health Service (NHS) Trust. Taking Back Control: A guide to planning your own recovery. Nottingham, United Kingdom: Nottinghamshire NHS Trust; 2008. ③ Nottinghamshire NHS Trust. Advance Statement [online publication]. United Kingdom; Nottinghamshire NHS Trust; 2008.
(Available from: https://www.nottinghamshirehealthcare.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n1799.pdf&ver=1845., accessed 9 February 2017).
④ Nottinghamshire NHS Trust. Advance Statement (page 32) [online publication]. United Kingdom; Nottinghamshire NHS Trust; 2008.
(Available from: https://www.nottinghamshirehealthcare.nhs.uk/download.cfm?doc=docm93jijm4n1799.pdf&ver=1845., accessed 9 February 2017).

[ ] 님의 회복 계획 2

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

1. 응급/위기 상황에서 연락할 사람

이름		이름	
관계 예 : 가족, 친척, 친구, 사례관리자 등		**관계**	
전화번호 개인 연락처 혹은 기관 연락처		**전화번호**	

2. 응급 / 위기 상황에서 지지자들이 해주었으면 하는 지지 / 행동

3. 응급 / 위기 상황에서 지지자들이 하지 않았으면 하는 행동

위기상황에서, 지지자들이 하지 않았으면 하는 행동	그 이유

4. 내가 받고 있는 치료와 서비스들 (정신건강 관련 이외의 것들도 포함)

병원 / 기관 / 공동체 이름	전화번호	주치의 / 담당자 이름

최근 약물 치료
(정신건강 관련 약물 외에 건강과 관련한 모든 약물을 나열한다)

약물명		용 량 (mg, 하루 복용 횟수)	
약물명		용 량	
약물명		용 량	
약물명		용 량	
약물명		용 량	
약물명		용 량	

5. 위기 상황에서 선호하는 약물, 피하고 싶은 약물, 알레르기(과민반응)이 있는 약물

위기 상황에서 선호하는 약물

약물 종류 / 투약 방법	내가 선호하는 이유

위기 상황에서 피하고 싶은 약물

약물 종류 / 투약 방법	내가 선호하는 이유

알레르기(과민반응)이 있는 약물

약물 이름	알레르기 종류(간지러움, 피부발진, 쇼크 등)

6. 만약, 내가 입원을 하게 된다면

회복에 도움이 되는 것들	
1	
2	
3	

내가 싫어하거나 피하고 싶은 것	
1	
2	
3	

입원 시, 병동에 가지고 가기를 원하는 물건 (예: 안경 등)	
1	
2	
3	

정신질환 당사자를 위한
<사전의료 및 돌봄 의향서>

작성자	
주민등록번호	
주소	
전화번호	

본인(_____)은 건전한 정신을 지닌 성인으로서 자발적으로, 정신 건강 치료에 대한 사전 의료 및 돌봄 의향서를 작성합니다. 본인이 정신 건강 치료에 관한 합리적인 결정을 내리거나 의사 소통을 할 수 없다고 두 명의 의사에 의해 판단될 때, 사전 의료 의향서의 지침이 준수되기를 원합니다.

본인은 본인의 정신 건강 치료에 관한 결정을 내릴 대리인으로 다음 사람을 임명합니다.

대리인 이름	
대리인 주소	
대리인 전화번호	

예비 대리인: 위에 명시된 사람이 본인을 대리하는 것을 거부하거나 대리할 수 없는 경우, 또는 본인이 그 사람의 대리인 권한을 취소하는 경우, 본인은 다음 사람에게 대리인 권한을 위임합니다.

예비 대리인 이름	
예비 대리인 주소	
예비 대리인 전화번호	

정신건강 치료에 대한 합리적인 결정을 내리거나 의사 소통을 할 수 없다고 두 명의 의사가 판단한 경우에만 대리인이 본인을 대신하여 결정을 내릴 수 있습니다.

대리인의 효력이 발생하기 앞서 대리인은 동의서에 서명해야 합니다.
대리인은 결정을 내릴 때 이 문서에 작성된 내용을 바탕으로 환자 본인의 의사를 따르도록 노력할 것입니다.

본인은 대리인에게 아래에 명시된 치료에 동의하거나 거부할 수 있는 권한을 부여하고 해당 서비스 비용을 본인의 자금으로 지불할 수 있는 권한을 부여합니다.

본인이 대리인에게 부여할 권한에 대해 (V) 표시하십시오.

본인의 기록에 대한 권한: 본인의 정신 건강 치료에 관한 정보를 받고 해당 치료와 관련된 의료 기록을 수령, 검토 및 공개에 동의합니다.	
약물 투여 동의에 대한 권한: 본인의 약물 투여에 대해 대리인의 결정에 동의합니다.	
입원에 대한 권한: 본인을 집중 치료 프로그램을 갖춘 병원에 입원시키는 것에 대해 대리인의 결정에 동의합니다.	
기타:_____	

본인(대리인)은 대리인으로 임명되는 것에 동의합니다.

작성일	년 월 일
대리인	서명 또는 인

본인(예비 대리인)은 예비 대리인으로 임명되는 것에 동의합니다.

작성일	년 월 일
예비 대리인	서명 또는 인

치료를 위한 지침

1. 본인은 다음과 같은 의학적 상태에 있으며, 증상은 다음과 같습니다

2. 정신 건강 관리 및 치료에 대한 저의 일반적인 견해와 바람은 다음과 같습니다

3. 현재 복용하는 약물			
약물명		용량	
약물명		용량	
약물명		용량	
약물명		용량	
약물명		용량	
약물명		용량	

4. 치료에 있어 선호하는 병원	
1순위	
2순위	
3순위	
4순위	

5. 치료에 있어 선호하지 않는 병원

6. 치료에 있어 선호하는 의사, 치료자	
이름	
전화 번호	

7. 선호하는 입원 형식(선호하는 순서대로 1-5로 표시)	
자의 입원	
동의 입원	
보호 입원	
행정 입원	
응급 입원	

병원 입원 중 치료 및 선호

1. 향정신성 약물에 대한 본인의 의사는 다음과 같습니다			
선호하는 약물		용량	
선호하는 약물		용량	
선호하지 않는 약물		용량	
선호하지 않는 이유			
선호하지 않는 약물		용량	
선호하지 않는 이유			

2. 사전 응급 상황에 대한 선호도 및 지침: 본인은 격리 또는 구속 등을 사용하기 전에 아래의 개입이 시도되거나, 고려되기를 원합니다. (해당되는 모든 항목에 표시)	
일대일 대화	
약물 추가 투여	
다른 곳으로 주의 전환	
본인의 행동에 대한 확고한 제한 설정	
감정을 토로/표출할 수 있도록 돕기	
감정을 토로/표출할 수 있도록 돕기	
자극 줄이기	
중립적인 사람이 분쟁을 해결하도록 제안하기	
기타(명시):	

3. 병원 입원 중 응급 개입: 본인은 정신과 병원에 입원하는 동안 본인의 행동이 본인 또는 타인에게 임박한 위험에 처할 경우 응급 상황에서 특정 개입이 승인될 수 있음을 이해합니다. 본인은 다음과 같은 방법으로 치료를 받으면 그러한 응급 상황을 피할 수 있다고 믿습니다.

4. 본인은 다음과 같은 행위로 인해 증상이 악화될 수 있다고 믿습니다

5. 본인은 본인 또는 타인의 보호를 위해 필요한 경우 응급 처치 절차에 대한 선호 사항을 명시할 수 있습니다. 본인은 응급 개입 절차에 대한 선호 사항을 고려하도록 요청하지만, 의료 시설은 이러한 선호 사항을 준수하지 않는 것에 대해 민사 책임을 지지 않는다는 것을 이해합니다. 본인은 본인 또는 타인에게 위험이 발생할 수 있는 경우, 의료 서비스 제공자 또는 의료 시설이 본인이 명시한 선호 사항을 준수하지 않는 절차를 사용해야 할 수 있음을 이해합니다.
입원 중 또는 의료 시설에 입원해 있는 동안 본인이 응급 개입이 필요한 행동에 관여하고 있다고 판단되는 경우, 응급 개입 시 사용되는 절차에 관한 나의 선호도는 다음과 같습니다.

개인	선호도(선호하는 순서부터 1~5로 표시)	이유
격리		
강박		
약물 (주사)		
약물 (경구)		
기타		

6-1. 본인은 정신 건강 치료 시설에 입원한 경우 다음 개인에게 즉시 알려주기를 원합니다

이름		이름	
관계		관계	
전화번호		전화번호	

6-2. 본인은 다음 개인의 방문을 금지하고, 치료에 개입하는 것을 원하지 않습니다

이름		이름	
관계		관계	
전화번호		전화번호	

7. 자녀 돌봄 준비

본인이 요양원이나 병원에 입원해야 하는 상황에 다른 방법으로 자녀를 돌볼 수 없는 경우, 사전에 자녀 돌봄 준비를 하지 않은 경우, 본인은 다음 개인에게 연락하여 자녀를 돌봐줄 것을 요청합니다.

이름	
관계	
전화번호	

8. 본인은 다음과 같은 행위로 인해 증상이 악화될 수 있다고 믿습니다

9. 기타 알리고 싶은 정보 (정신 또는 신체 건강 과거력, 식단, 반려동물, 종교 및 기타 중요한 사항 포함)

10. 본인은 입원 기간 동안 동료 지원가의 도움을 받는 절차보조서비스를 이용하고자 합니다. 절차보조서비스는 정신의료기관에 입원 중인 당사자가 본인이 원하는 정보를 얻고, 절차를 이해할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. (해당되는 경우 항목에 표시)
절차보조서비스 이용 동의 ☐
11. 본인은 퇴원 후 다음에 해당되는 도움을 받기를 원합니다

서 명

1. 본인은 위 내용을 본인이 직접 작성하였음을 확인합니다.	
작성일	년 월 일
작성자	서명 또는 인

2. 정신 사전 의료 의향서 등록기관 및 상담자:	
기관명칭	
상담자 성명	
소재지	
전화번호	

3. 증인 증인은 다음과 같은 사람은 될 수 없습니다 (1) 18세 미만, (2) 혈연, 입양 또는 결혼으로 본인과 친족 관계에 있는 사람, (3) 본인 재산 일부를 상속받을 자격이 있는 사람, (4) 이 문서에 서명할 당시 본인의 의료 서비스 제공에 관여한 사람	
작성일	년 월 일
증인 서명 또는 인	서명 또는 인
작성일	년 월 일
증인 서명 또는 인	서명 또는 인

4. 정신건강의학과 전문의 정신건강의학과 전문의의 판단 하에 환자 본인은 사전의료 및 돌봄 의향서를 작성할 능력이 있는 것으로 보이며, 작성 내용을 이해하였습니다.	
작성일	년 월 일
정신건강의학과 전문의	서명 또는 인

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램

수료식

나에게 **회복**이란

입니다.

연구참여자용 설명문 및 동의서

연구 과제명 :

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램 효과성 연구

연구책임자 및 공동연구자 :
연구책임자 : 000 (XXX 병원, 교수/원장/과장)
공동연구자 : 000 (XXX 병원, 교수/원장/과장)

이 연구는 지역사회 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에 참여한 참가자들을 대상으로, 연구를 통해 회복 중심 프로그램의 효과성을 확인하여 향후 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램 종사자 훈련도구의 방향성을 제시하고자 하는 연구입니다.

이 연구를 수행하는 연구책임자 혹은 공동연구자가 귀하에게 이 연구에 대해 설명해 줄 것입니다. 이 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 수행될 것이며, 귀하께서는 참여 의사를 결정하기 전에 본 연구가 왜 수행되는지 그리고 연구의 내용이 무엇과 관련 있는지 이해하는 것이 중요합니다. 다음 내용을 신중히 읽어 보신 후 참여 의사를 밝혀 주시기 바라며, 필요하다면 가족이나 친구들과 의논해 보십시오. 만일 어떠한 질문이 있다면 담당 연구원이 자세하게 설명해 줄 것입니다.

1. 이 연구는 왜 실시합니까?

이 연구의 목적은 세계보건기구의 퀄리티라이츠 가이드에 기반하여 발전시킨 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램의 효과성을 탐색하는 것입니다. 여러분들의 경험을 통해서 보다 치료적인 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램을 운영하기 위한 기초 자료로 활용될 것입니다.

2. 얼마나 많은 사람이 참여합니까?

본 연구는 당사자, 보호자, 종사자 포함 약 160여명의 성인을 대상으로 진행할 예정입니다.

3. 연구에 참여하면 어떤 과정이 진행됩니까?

이 연구에 참여해 주신다면 귀하께서는 지역사회 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에 참여하시는 중재군 또는 참여하지 않으시는 대조군에 배정되실 수 있습니다. 중재군에 배정되시면 퀄리티라이츠 리커버리 프로그램에 참여하시고, 프로그램 전후에 사전-사후 검사, 3개월 후 추적 검사를 진행하게 됩니다. 대조군에 배정되시면 프로그램에 참여는 하지 않으시나, 설문 평가는 동일하게 진행합니다. 평가는 대면하여 진행하는 것을 원칙으로 하나, 부득이한 상황에는 비대면으로 진행할 수 있습니다.

1) 퀄리티라이츠 프로그램 진행 방법

ⓐ 프로그램 개발 목적

세계보건기구(WHO)가 개발 및 보급하고 있는 퀄리티라이츠(QR) 계획의 일부로, 당사자의 회복과 존중받아야 할 인권을 최우선 가치로 하는 프로그램으로, 정신건강 및 관련된 분야에서 회복의 개념을 교육하고 당사자/보호자/종사자 모두의 삶에서 적용하기 위한 목적으로 개발됨

ⓑ 프로그램 목표

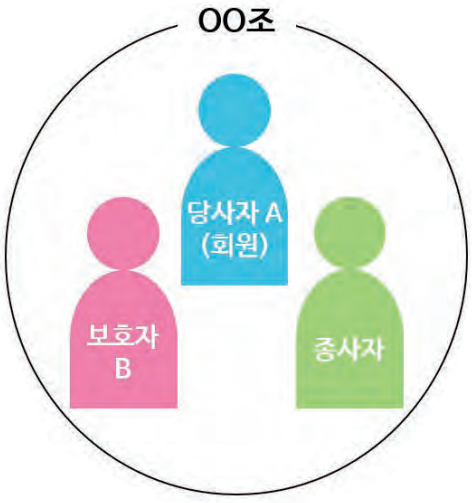
· 정신건강에서의 회복적 접근과 회복의 핵심 원칙/요소들에 대한 깊은 지식을 얻는다.
· 회복에 대한 당사자/보호자/종사자 간에 관계와 각자의 역할에 대해 이해하고 토론한다.
· 회복 지향적 원칙, 회복 지향적 의사소통기술을 어떻게 적용할지 배운다.
· 자신만의 유일하고, 대체 불가능한 회복 계획의 중요성을 배운다.
· 개인의 범주를 넘어, 사회에 긍정적 영향력을 행사한다.

ⓒ 프로그램 대상

· 당사자: 심리사회적 장애를 지닌 사람, 지적 장애, 치매를 포함한 인지적 장애, 조현병을 포함한 정신증 환자
· 보호자: 가족, 간병인 및 기타 당사자를 지지하는 사람들
· 종사자: 정신건강 및 관련 서비스 제공자 (정신과 의사, 정신과 간호사, 심리학자, 사회복지사, 작업치료사, 동료지원가, 자원봉사자)

ⓓ 활동 진행 방법: 조별 토론 및 발표 방식

· 당사자, 종사자, 보호자가 한 조가 되어, '회복'과 관련된 다양한 사람들의 의견을 자유롭게 이야기한다.
· 당사자/보호자/종사자 모두 수평적인 관계에서 의견을 주고받으며 모든 의견은 경청 되어진다.
· 특정 주제에 대한 합의된 내용을 발표함으로써 모두와 공유한다.



ⓔ 시행 장소: (각 시행 기관)
ⓕ 소요 시간: 예시) 매주 화요일 10-11:30 (1시간 30분)

2) 설문 진행 방법

ⓐ 사전설문(20~30분 소요됨)

① 연구 대상자 설명서 및 동의서 취득

② 인구학적 배경정보

· 성별, 연령, 학력, 주소, 결혼상태, 직업유무, 직업 지속기간, 취미유무, 진단명, 치료시기, 복용약물, 현치료상태, 입원횟수, 응급실 방문횟수, 응급실 방문이유 회복 프로그램 교육여부

③ 베이스라인 평가

· 국제신체활동설문 (7문항)
· 주관적 삶의 질 척도 (33문항)
· 심리적 임파워먼트 척도 (28문항)
· 정신건강 회복 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (29문항)
· 자기효능감 척도 (23문항)
· 변화동기척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (32문항)
· 기본심리욕구 척도 (14문항)
· 성격 5요인 척도 (10문항)
· 우울증 선별도구 (9문항)
· 간단 음성평가도구(정신건강서비스 당사자만 해당) (13문항)
· 간편정신상태 평정척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (18문항)
· 양성 및 음성증후군 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (44문항)
· 약물태도 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (10문항)
· 병식평가 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (30문항)

ⓑ 사후설문(20~30분 소요됨)

· 학력, 직업유무, 직업 지속기간, 취미유무, 응급실 방문횟수(당사자해당), 응급실 방문이유(당사자 해당)
· 국제신체활동설문 (7문항)
· 주관적 삶의 질 척도 (33문항)
· 심리적 임파워먼트 척도 (28문항)
· 정신건강 회복 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (29문항)
· 자기효능감 척도 (23문항)
· 변화동기척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (32문항)
· 기본심리욕구 척도 (14문항)
· 성격 5요인 척도 (10문항)
· 우울증 선별도구 (9문항)
· 간단 음성평가도구(정신건강서비스 당사자만 해당) (13문항)
· 간편정신상태 평정척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (18문항)

· 양성 및 음성증후군 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (44문항)
· 약물태도 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (10문항)
· 병식평가 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (30문항)
· 만족도 조사(6문항)

ⓒ 추후설문(20~30분 소요됨)

· 학력, 직업유무, 직업 지속기간, 취미유무, 응급실 방문횟수(당사자해당), 응급실 방문이유(당사자 해당)
· 국제신체활동설문 (7문항)
· 주관적 삶의 질 척도 (33문항)
· 심리적 임파워먼트 척도 (28문항)
· 정신건강 회복 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (29문항)
· 자기효능감 척도 (23문항)
· 변화동기척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (32문항)
· 기본심리욕구 척도 (14문항)
· 성격 5요인 척도 (10문항)
· 우울증 선별도구 (9문항)
· 간단 음성평가도구(정신건강서비스 당사자만 해당) (13문항)
· 간편정신상태 평정척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (18문항)
· 양성 및 음성증후군 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (44문항)
· 약물태도 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (10문항)
· 병식평가 척도(정신건강서비스 당사자만 해당) (30문항)

4. 연구 참여 기간은 얼마나 됩니까?

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램은 총 OT까지 포함하여 총 14회 진행됩니다. 연구참여자는 연구 시작 전과 후, 총 2회 설문을 진행합니다. 부득이하게 중재 참여 혹은 설문 실시에 어려움이 있을 경우에는 꼭 연구담당자에게 이 사실을 미리 알려야 합니다.

5. 참여 도중 그만두어도 됩니까?

예, 귀하는 언제든지 어떠한 불이익 없이 참여 도중에 그만둘 수 있습니다. 만일 귀하가 연구에 참여하는 것을 그만두고 싶다면 연구책임자에게 즉시 말씀해 주십시오. 그만두는 경우 수집된 자료의 폐기를 원하시면 생명윤리법 시행규칙 15조 4.2항에 의거하여 연구종료 후 최대 3년 보관한 이후에 적절히 폐기됩니다. 그러나 폐기를 원하시지 않는다면 중도 탈락 이전 자료는 연구 자료로 사용됩니다.

조기중단) 기저평가 이후, 연구 참여가 중단된 경우에는 조속하게 연구기관을 내원하여 종료평가에 시행하는 것으로 예정된 모든 평가들을 완료하는 것이 필요합니다.

6. 예상되는 위험요소나 불편사항은 없습니까?

연구 참여를 위해 설문지 작성에 1시간 가량 머물러야 하는 불편감이 있을 수 있습니다. 연구책임자에게 부작용이나 위험 요소에 대한 자세한 사항에 대해서 문의해주시면 자세하게 답변 드리겠습니다.

7. 이 연구에 참여시 참여자에게 이득이 있습니까?

귀하가 이 연구에 참석하는데 직접적인 이득은 없습니다. 그러나 본 연구는 보다 치료적인 지역사회 프로그램을 운영하는 매뉴얼 개발하기 위한 기초 자료로써 활용할 계획이며, 귀하의 참여가 정신건강의 치료적 발전에 기여할 것으로 예상합니다.

8. 만일 이 연구에 참여하지 않는다면 불이익이 있습니까?

귀하는 본 연구에 참여하지 않을 자유가 있습니다. 또한, 귀하가 본 연구에 참여하지 않아도 귀하에게는 어떠한 불이익도 없습니다.

9. 연구에서 얻은 모든 개인 정보의 비밀은 보장됩니까?

본 연구에서 수집되는 개인정보와 설문자료는 연구자에게만 접근이 허락되며, 연구 자료는 참여자의 정보를 알 수 없도록 코드화하여 USB 저장장치에 저장하고, USB 저장장치는 연구자의 연구실 내 잠금장치가 있는 보관함에 보관될 것입니다. 동의서는 관련 법령에 따라 3년을 보관한 후 보관기간이 종료되면 폐기할 예정입니다. 저희는 이 연구를 통해 얻은 모든 개인 정보의 비밀 보장을 위해 최선을 다할 것입니다. 이 연구에서 얻어진 개인 정보가 학회지나 학회에 공개될 때 귀하의 이름 및 기타 개인 정보는 사용되지 않을 것입니다. 그러나 만일 법이 요구하면 귀하의 개인정보는 제공될 수도 있습니다. 또한 모니터 요원, 점검 요원, 생명윤리위원회는 연구참여자의 개인 정보에 대한 비밀 보장을 침해하지 않고 관련규정이 정하는 범위 안에서 본 연구의 실시 절차와 자료의 신뢰성을 검증하기 위해 연구 결과를 직접 열람할 수 있습니다. 귀하가 본 동의서에 서명하는 것은, 이러한 사항에 대하여 사전에 알고 있었으며 이를 허용한다는 동의로 간주될 것입니다.

10. 연구에 대한 문의는 어떻게 해야 됩니까?

본 연구에 대해 질문이 있거나 연구 중간에 문제가 생길 시 다음 연구 담당자에게 연락하십시오.

연구책임자 : 000 전 화:

공동연구자: 000 전 화:
000 전 화:

만일 어느 때라도 연구참여자로서 귀하의 권리에 대한 질문이 있다면 아주대학교병원 임상연구윤리센터에 연락하십시오.

000병원 임상연구윤리센터 헬프데스크:

동 의 서

연구 과제명 :

퀄리티라이츠 리커버리 프로그램 효과성 연구

연구책임자 및 공동연구자 :
연구책임자 : 000 (XXX 병원, 교수/원장/과장)
공동연구자 : 000 (XXX 병원, 교수/원장/과장)

1. 본인은 연구에 대해 구두로 설명을 받고 상기 연구 설명문을 읽었으며 담당자 및 연구자와 이 연구에 대하여 충분히 의논하였습니다.
2. 본인은 연구의 위험과 이득에 관하여 들었으며 나의 질문에 만족할 만한 답변을 얻었습니다.
3. 본인은 이 연구에 참여하는 것에 대하여 자발적으로 동의합니다.
4. 본인은 이후의 치료에 영향을 받지 않고 언제든지 연구의 참여를 거부하거나 연구의 참여를 중도에 철회할 수 있고 이러한 결정이 나에게 어떠한 해가 되지 않을 것이라는 것을 알고 있습니다.
5. 본인은 담당 연구자나 위임받은 대리인이 연구를 진행하거나 결과 관리를 하는 경우와 법률이 규정한 국가 기관 및 아주대학교병원 기관연구윤리심의위원회가 실태 조사를 하는 경우에는 비밀로 유지되는 본인의 개인 신상 정보를 확인하는 것에 동의합니다.
6. 나는 언제라도 이 연구의 참여를 철회할 수 있고 이러한 결정이 나에게 어떠한 해도 되지 않을 것이라는 것을 압니다.
7. 나는 수집되는 자료가 본 연구의 목적으로 사용되는 것에 동의합니다.
8. 나의 서명은 이 동의서를 받았다는 것을 뜻하며 나와 동의 받는 연구원의 서명이 포함된 동의서를 보관하겠습니다.

	성 명	서 명	서명날짜
대상자			년 월 일
대상자의 대리인 (해당되는 경우)			년 월 일
	대상자와의 관계 : _____ 대리인 동의의 구체적인 사유 : _____		
책임연구자 (또는 위임 받은 연구자)			년 월 일

Topic 2. 회복 지향적 접근

유라 이야기

유라는 당사자로, 정신과에서
치료받고 있는 환자입니다.
다음은 유라에 대한 3가지 묘사입니다.

Q1. 당신이 유라라면,
위의 3가지 묘사들 중 어떤 것이 당신을
묘사하는데 쓰였으면 좋겠습니까?
그 이유는 무엇일까요?

1) 유라는 스스로를 위해 아무것도 하지 않는 치료에 비 순응적인 비만의 조현병 환자이다.

2) 유라는 조현병을 진단받은 환자로, 해당 질환과 체중에 대한 최적의 관리를 위해 전문적인 도움이 필요한 상태이다.

3) 유라는 두 살 여자아이의 자랑스러운 어머니이고, 그녀에게는 지지적인 가족들이 있다. 그녀는 대학에 진학하여 보육에 대해 공부하고자 하는 꿈이 있다. 그녀는 20살부터 조현병과 함께 살고 있다.

Topic 2. 회복 지향적 접근

근하 이야기

Q3. 각각의 접근으로 근하를 묘사해 보세요.

결손 기반 접근	자산/강점 기반 접근

Q4. 각각의 접근으로 근하에 대한 치료의 방향성과 목표를 정해보세요.

근하는 우울한 기분, 만성 피로, 그리고 알코올 문제 등을 겪어 왔으며 지난 1년간 배우자와 지속적으로 다투어 온 서른 살의 미술 교사이다.

근하는 과거에는 사람들과 어울리는 것을 좋아해서 함께 운동하는 것을 즐겼고, 직장에선 동료들을 격려하고 용기를 주던 분위기 메이커였다. 하지만 현재는 어울리는 친구가 없으며 종종 통제할 수 없는 불안감에 밤에 잠드는 것도 어렵게 되었고, 이럴 때마다 안정이 될 때까지 술을 마시곤 한다.





Topic 3. 회복 지향 정신건강 서비스와 희망의 증진



선지 이야기

**'얼마나 지나야 이 긴장감 속에서 벗어날 수 있을까?
정말 나에게 희망이 남아있을까?'**

선지 이야기



**" 선지씨, 이번이 벌써 4번째 입원이에요.
이번에 퇴원해서는 약을 빼먹으면 안돼요!"**

30대 후반의 조현병 환자인 선지는,
20대 초반에 조현병 진단을 받은 이후
벌써 4번째 입퇴원을 반복하고 있다.

매번 약물을 자의로 중단한 뒤, 자신을 비난하거나
위험한 행동을 명령하는 환청과
국가 비밀 요원들이 자신을 감시한다는
피해망상이 악화되어 입원을 했다.

선지 이야기

선지는 재발할 때 마다, 자신은 병이 없다고 주장했지만,
약물을 중단하면 누군가 자신을 해친다며
한 겨울에도 맨발로 집을 나가 실종이 되거나,
환청의 명령에 이끌려 옥상에서 뛰어내리려 하는 등
위험한 상황이 연출되곤 했다.

응급실에 도착하면, 선지는 입원을 강력히 거부하며
자신이 원하지 않는 치료는 치료가 아니라고 소리를 질렀고,
이전에도 자신이 원치 않는 입원을 시킨 가족과 주치의 때문에
자신의 인생이 망가졌다며 폭력적인 모습을 보이곤 했다.

이번 입원 때는 흥분한 선지가 폴대를 휘둘러
간호사 한명이 다치기도 했을 정도였다.

선지 이야기

우여곡절 끝에, 선지는 입원을 했다.
입원 초기에 선지는 강력히 약물을 거부했고, 여전히 폭력적인 모습을 보여
강제로 약물을 투약 받기도 하고 한 차례 강박을 당하기도 했다.

아무리 발버둥을 쳐도 치료를 거부할 수 없다는 사실을 알아차릴 즈음부터,
선지는 자포자기 하는 심정으로 약물을 복용하기 시작했다.
여전히 자신은 병이 없다고 생각하고, 아무것도 모르는 가족과 주치의가
자신을 감시하는 국가 비밀 요원의 존재를 모르는 것이 답답하기만 했다.

선지 이야기

그런데, 분명 자신에겐 병이 없는데,
입원하여 약물을 복용한 기간이 늘어나면서 더 이상 불안하지 않았고,
귓가에 울리던 도청장치 소리 또한 줄어들었다.

병동 프로그램에 참여하고 환우들과 어울려 지내다 보면
국가 비밀 요원에 대한 생각도 잊어버리곤 했다.

선지 이야기

3개월 정도가 지나고, 주치의로부터 퇴원을 하자는 이야기를 들었다.
드디어 퇴원을 한다는 생각에 기쁘기도 했지만,
마냥 기쁘지만은 않았다.



여전히 내가 정말 정신병이 있는 것인지,
정말로 국가 비밀 요원이 없는 것인지 혼란스럽기만 하다.

가족면담 후 가족들은 선지의 상태가 많이 좋아졌다며
주치의에게 연신 고맙다는 인사를 한다.

주치의는 선지가 입원치료를 성공적으로 잘 마친 덕분이라며
선지에게 고생했다는 말을 건넨다.

하지만, 막상 선지는 뭐가 좋아졌는지 잘 모르겠다는 눈치다.

선지 이야기

선지는 문득 주치의와 가족들이 원하는 상태로 살지 못하게 된다면,
또 다시 입원을 해야 하는 것인지 의문이 들었다.

막연히 입원 치료를 받고 좋아진 것 같지만,
여전히 강제로 입원을 한 것과 원치 않는 약을 먹고 강박을 당했던 것을 생각하면,

자신을 강제 입원 시킨 가족에게 화가 난다.

선지 이야기



퇴원 당일, 주치의는 선지에겐 희망이 있다며
선지와 가족들 앞에서 온갖 긍정적인 말을 쏟아낸다.
선지는 불쾌하다는 듯이 조용히 이야기를 시작한다.

**“ 선생님 저는 15년간 치료를 받았어요. 4번이나 입원을 했어요.
이제 저는 직업도 돈도 친구도 없어요…**

**저는 앞으로 뭘 해야 할지 모르겠어요.
제가 누구인지도 모르겠고, 제가 누구였는지도 잊었어요.
가슴이 너무 답답해요.**

희망이요? 선생님은 제가 얼마나 고통스러운지 알고 있나요?”

선지 이야기

선지는 가족들의 표정을 살핀다.
퇴원을 앞둔 아들을 보는 가족들의 표정이
마냥 밝지만은 않다는 것을 눈치챈다.

자신이 가족들의 눈치를 보는 만큼,
가족들도 자신의 눈치를 보고 있다는 긴장감이 느껴진다.

**'얼마나 지나야 이 긴장감 속에서 벗어날 수 있을까?
정말 나에게 희망이 남아있을까?'**

퇴원을 하는 선지의 발걸음도, 선지를 데리러 온 가족의 발걸음도,
그 광경을 지켜보는 치료진들의 마음도 가볍지 않다.

Topic 4. 회복의 여정에 함께 한다는 것



은성이와 은성이 아버지 이야기

**"은성아, 잘 모르겠으면 나서지 말고,
친구들이 먹고 싶은 거 있다고 하면 먼저 사주렴"**

은성이와
은성이 아버지
이야기

은성이는 20대 초반의 남성으로,
초등학생 시절 수업에 집중하는데 어려움을 겪었다.
친구들과는 달리 선생님이 가르쳐주는 내용이 쉽게 이해되지 않았다.

은성이의 모습을 유심히 관찰하던 담임 선생님은
그의 부모에게 지능검사를 권유했고
검사 후 은성이는 지적장애 진단을 받았다.

담임 선생님은 은성이에게 보다 적합한 학습 환경을 제공하기 위해
특수학교로 전학을 권유했다.

은성이와
은성이 아버지
이야기

하지만, 은성이 아버지는 은성이가 특수학교에 가는 것을 원하지 않았다.

대기업을 다니던 아버지는 은성이를 돌보겠다는 결심을 하고 직장을 그만두었고
비교적 시간을 자유롭게 쓸 수 있는 조그마한 가게를 시작했다.
그리고 은성이가 평범하게 학교 생활을 하는데 최선을 다하겠다고 다짐했다.

그렇게, 은성이는 아버지의 헌신적인 보살핌 속에 일반 중학교까지 졸업할 수 있었다.

은성이와
은성이 아버지
이야기



고등학생 시절, 은성이는 자신이 평범하지 않다는 사실이
드러날까 두려워 친구들의 눈치를 살피곤 했다.

아버지는 용돈을 넉넉하게 주면 아들이 조금 더 밝아질까 싶어,
친구들과 어울리는 데 사용하라며 매번 많은 용돈을 주었다.

하지만 은성이는 옷 한번 허투루 사지 않으며
절약을 하시는 아버지를
알기에 용돈을 쓰면서도 늘 마음이 불편했다.

은성이와
은성이 아버지
이야기



은성이는 아버지에게 이렇게 많은 용돈이 필요하지 않다고
말하기도 했지만, 그럴 때마다 아버지는 오히려
주머니에서 구겨진 지폐를 꺼내 주시며 온화한 목소리로
이렇게 말씀하곤 하셨다.

**“은성아, 잘 모르겠으면 나서지 말고,
친구들이 먹고 싶은 거 있다고 하면 먼저 사주렴”**

은성이와
은성이 아버지
이야기

그러던 어느 날 은성이는 친구들과 조별 과제를 하게 되어
일정부분을 맡게 되었다.
은성이는 늘 그랬듯이 아버지에게 도움을 부탁하려 했으나,
그날 따라 아버지는 유독 피곤해 보였다.
은성이는 스스로 숙제를 해보겠다는 결심을 했다.

은성이는 선생님이 가르쳐 주신 내용을 여러차례 읽어보았지만,
잘 이해되지 않았다. 몇시간 동안 숙제와 씨름했지만,
스스로의 힘으로 과제를 작성할 수 없었다.
결국 은성이는 자신이 맡은 부분을 마무리 하지 못했다

은성이와
은성이 아버지
이야기

다음 날, 친구들은 은성이에게 왜 맡은 부분을
해오지 못했냐고 날카롭게 따졌다.
당황한 은성이는 아무 말도 하지 못했다.
갑자기 심장이 빨리 뛰고, 숨이 쉬어지지 않았다.

시간이 느리게 가는 것 같았고
목이 졸려 죽을 것 같은 괴로움이 느껴졌다.
은성이는 그 자리에서 쓰러졌고, 응급실을 방문하게 되었다.
응급실에서 은성이는 공황장애가 의심된다는 이야기를 들었고,
이 때부터 정신과 치료를 받기 시작했다.

은성이와
은성이 아버지
이야기



은성이는 이 사건이 이후 학교에 가지 못했다.
전교생에게 자신에 대한 안 좋은 소문이 퍼져 있을 것이라는
두려움이 그의 마음을 괴롭혔다.

집 밖에 나가는 것조차 힘들었고,
비슷한 또래의 학생들과 마주칠 때면,
자신에 대한 소문을 들었을까 불안했다.
가끔 친하게 지내고 싶은 사람도 있었지만,
말을 하면 자신의 지능이 낮다는 것이 드러날까 두려워
최대한 말을 하지 않았다.

모든 것이 불안했고 우울했다.

은성이와
은성이 아버지
이야기

하지만, 아버지는 은성이를 포기할 수 없었다.
가게를 정리하고 집에서 할 수 있는 부업거리를 하면서 은성이를 돌보았다.
하루도 빠짐없이 은성이의 약물을 챙겨주고, 꼬박꼬박 외래도 데려갔다.

진료실에서 말을 하지 않는 은성이를 대신해서,
은성이의 일거수일투족을 적어 놓은 본인만의
'은성이 관찰 노트'를 주치의에게 건네며
은성이의 작은 변화까지도 주치의와 상의하곤 했다.

은성이와
은성이 아버지
이야기

주치의는 은성이에겐 약물뿐 아니라 비약물적 치료가 필요하다 판단했고,
조심스레 은성이에게 낮병원 방문을 권했다.
은성이도 수년간 만나온 주치의의 권유를 긍정적으로 생각했다.

사람들과 다시 어울리고 싶은 마음과 새로운 곳에서 또 다시 망신을 당하지 않을까
하는 걱정이 동시에 마음속에 떠올랐다.
하지만, 은성이의 고민이 무색하게, 은성이 아버지는 말했다.

" 선생님이 필요하다고 하신거면, 당연히 해야죠

은성이와
은성이 아버지
이야기

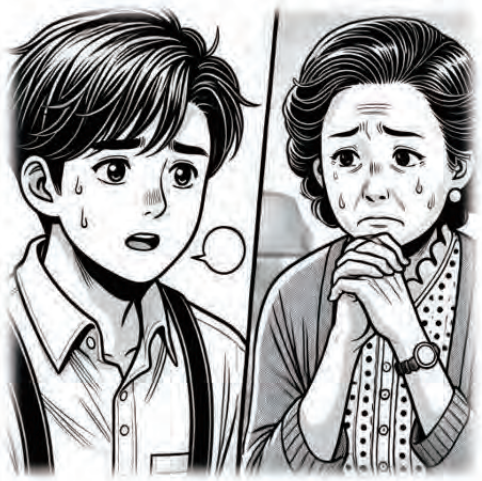


아버지는 당연하다는 듯이 낮병원 동의서의 서명란에 은성이의 이름을 적은 뒤,
동의서를 주치의에게 다시 건넸다.
고민해볼 틈도 없이 은성이는 낮병원에 다니기로 결정되었다.

낮병원에 처음 방문하는 날, 아버지는 은성이에게 새 옷을 입혔다.
아버지의 남루한 옷 때문에 은성이의 새 옷은 더욱 빛났다.
아버지는 새 옷을 입고 있는 은성이를 흐뭇하게 바라보며
온화한 목소리로 말했다.

**"은성아, 잘 모르겠으면 나서지 말고,
친구들이 먹고 싶은 거 있다고 하면 먼저 사주렴"**

Topic 5. 회복의 여정에서의 경계



홍기와 홍기 어머니 이야기

하지만, 어머니의 생각은 달랐다.

홍기와
홍기 어머니
이야기

홍기는 20대 초반에 양극성 장애 진단을 받았다.
지난 20년 동안 수 차례 재발을 경험하며 어려움도 있었지만,
현재는 안정적인 직장생활을 하고 있고 꾸준히 교회에도 출석하며
의지할 수 있는 친구들도 사귀었다.

홍기는 두 번째 입원치료 중 현재의 주치의를 만나게 되었고,
정신질환의 회복에 대한 이야기를 듣게 되었다.
주치의는 단순히 증상이 없어지고 '평범한 모습'에 강박적으로
집착하는 것이 아니라, 이 질병을 통해 성장하고 새로운 삶의 방향을
설정할 수 있다고 이야기했다. 홍기는 그 이야기가 무척 마음에 들었다

홍기와
홍기 어머니
이야기



30대 중반에는 지독한 우울증이 찾아왔으나
정신건강복지센터 사례관리자와 동료지원가의 도움을 받으며 회복했다.
이 후, 홍기는 자신도 동료지원가가 되겠다며 수련 과정에 도전했고
1년 후 자신의 꿈을 이룰 수 있었다.

홍기의 동료지원 활동은 당사자와 함께 외래를 방문하거나
원치 않는 입원 치료를 받고 있는 당사자들을 만나 그들을 안심시키고,
치료를 통해 꿈꿀 수 있는 희망을 구체화시키는 활동이었다.
많은 사람들이 홍기를 롤모델로 따랐고,
홍기 또한 자신의 역할에 자부심을 느꼈다.

홍기와
홍기 어머니
이야기

홍기의 어머니는 홍기가 대견스럽기도 했지만, 다시 재발할까 늘 노심초사했다.
마지막 입원 치료 후 5년이 지났으나 어머니는 홍기에게 약을 먹으라고 잔소리를 했고,
늦게까지 잠을 안 잘 때면, 재발한 것이 아니냐며 빨리 외래 예약을 잡자고 채근했다.

홍기는 동료지원활동이 마음에 들었지만, 어머니는 그 조차 무리가 되는 것 아니냐며
동료지원 활동을 그만두고, 집에서 쉬면 어떻겠냐고 부탁을 하기도 했다.

홍기는 이런 어머니가 너무나도 답답했다.
동료지원활동에서 받는 스트레스보다 어머니로부터 받는 스트레스가 더 컸다

홍기와
홍기 어머니
이야기

이러한 갈등은 집에서만 발생하는 일이 아니었다.
한 번은 주치의가 홍기에게 약물 부작용이 의심된다며 약물을 줄이자고 했지만,
어머니가 강하게 반대하여 약을 계속 유지하게 했다.

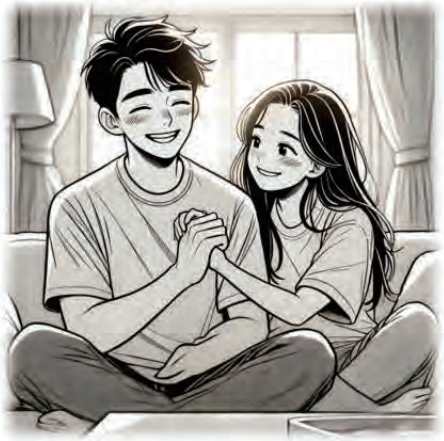
또 한 번은 정신건강 복지센터의 사례관리자가
홍기에게 취업 프로그램에 신청할 것을 권유했지만,
재발할 경우 책임질 것이냐는 어머니의 날카로운 질문에 눌려
더 이상 아무 말도 하지 못했다.

홍기와
홍기 어머니
이야기

이러한 일이 반복되자 어머니는
자신이 홍기의 회복을 방해하고 있는 것은 아닌가 걱정을 하기도 했지만,
결국 재발을 막는 것이 낫다고 생각했다.

수 차례 재발을 했고 그 때마다 강제로 입원을 시키는 과정에서
자신이 겪었던 일들이 떠오를 때면,
타들어가는 자신의 속도 모른 채 회복이나 희망 같은 이야기를 하는
주치의와 센터 사례관리자가 밉기도 했다.

홍기와
홍기 어머니
이야기



그렇게 지내던 중, 홍기는 여자친구를 만나게 되었다.
20대에 발병한 정신질환은 악화와 호전을 반복했고
자연스레 친구들과의 연락도 끊어졌다.
언젠가부터 홍기는 혼자지내는 것이 익숙했다.

여자친구가 생길 것이라는 생각은 하지도 못했다.
그러던 홍기에게 호감을 가지고
교제를 해보자는 여자친구가 생긴 것이다.

홍기와
홍기 어머니
이야기

홍기와 여자친구는 수 개월 째 별다른 문제 없이
관계를 이어 나가고 있었고 서로의 사랑은 깊어져 갔다.
관계가 깊어져 갈수록 홍기는 여자친구에게 자신이
정신질환이 있다는 사실을 알리고 싶지 않았다.

점차 밤 늦게까지 여자친구와 함께 있는 시간이 길어졌고,
홍기는 시간에 맞추어 약을 먹어야 한다는 사실은 알았지만
여자친구와 함께 있어야 했기에 약을 먹는 시간을 놓치곤 했다.

홍기와
홍기 어머니
이야기

홍기는 점차 잠이 적어지고, 매사에 과민한 반응을 보였다.
급기야 여자친구에게도 심하게 화를 내거나 폭언을 하기 시작했다.

몇일 후 홍기는 평소와 달리 하루 종일 말을 하며 새벽부터 부산히 움직이며
운동을 하기 시작했고 급기야 길거리에서
모르는 사람과 언쟁을 벌이다 폭행을 하여 경찰과 함께 응급실에 방문했고
또 다시 입원치료를 받게 되었다.

홍기와
홍기 어머니
이야기

다행히 홍기는 입원치료를 받으며 빠르게 회복해 나갔다.
홍기는 자신이 약물 복용이 소홀했다는 것을 후회하며 다시금 약물을 꾸준히 복용했다.

약물 부작용으로 하루 종일 졸리기도 하고, 발음이 어눌해 졌다는 것을 느꼈지만,
주치의와 침착하게 소통하며 문제를 해결해 나갔다.

홍기의 여자친구도 홍기에게 전화를 하거나 자주 면회를 오면서 입원치료를 격려했다

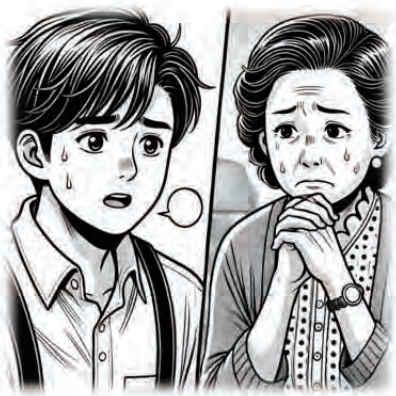
홍기와
홍기 어머니
이야기

한달 정도의 시간이 흐르고 퇴원 당일이 되었다.
주치의와 홍기 그리고 홍기의 부모님이 한자리에 모여 가족 면담을 했다.

홍기는 이번 입원치료를 통해 자신의 질병을 관리하는 것의 중요성을 다시금 깨달었다고 말하며,
자신이 이전보다 더 성장한 것 같다고 이야기 했다.

홍기와
홍기 어머니
이야기

홍기는 퇴원 후에도 입원하기 전처럼 자신이 약 관리를 할 것이고,
동료지원가 활동도 계속해서 할 것이며,
여자친구와의 교제도 이어가겠다고 이야기했다.



하지만, 어머니의 생각은 달랐다.
어머니는 앞으로는 자신이 약 관리를 했으면 좋겠다고 했고,
동료지원 활동을 그만두었으면 한다고 했다.

그리고 여자친구도 당분간은
만나지 않았으면 좋겠다고 이야기했다.

Topic 6. 회복을 위한 긍정적 위험감수



한나와 한나 어머니 이야기

"만약 재발이 되면, 그건 말리지 않은 선생님 탓이에요."

한나와
한나 어머니
이야기

한나는 지역사회 정신건강복지센터에 다니고 있는 30세 여성이다.

주요우울장애를 진단 받기 전,
동물과 함께 있는 것을 행복해 했던 한나는
동물 병원에서 근무했고 주말엔 유기견 센터에 봉사활동을 하며 지냈다.

한나와
한나 어머니
이야기

현재 회복 중인 한나의 목표 중 하나는
예전에 하던 일과 비슷한 일을 다시 구하는 것이다.
한나는 다시금 행복하게 일할 수 있는 직장을 원했고,
부모님으로부터 독립을 후 자취를 하기 위한 돈을 모으려 했다.

정신질환을 진단받고 치료를 받았던 약 2년의 시간 동안,
한나에겐 많은 변화가 있었다. 한나는 누구보다도 적극적으로
자신의 치료와 회복을 위해 노력을 했고 이제는 스스로
자신의 정신질환을 잘 관리할 수 있다는 자신감을 가졌다.

한나와
한나 어머니
이야기

정신질환을 진단받고 치료를 받았던
약 2년의 시간 동안, 한나에겐 많은 변화가 있었다.

한나는 누구보다도 적극적으로 자신의 치료와 회복을 위해 노력을 했고
이제는 스스로 자신의 정신질환을 잘 관리할 수 있다는 자신감을 가졌다.

한나와 한나 어머니 이야기



종종 막연히 자신이 없어지기도 하고
이유를 알 수 없는 불안감이 엄습할 때도 있었지만,
그럴 때 마다 한나는 스스로에게 이렇게 말했다.

"다시 2년 전으로 돌아갈 수 없다는 것은 알고 있어.
그래서 나는 최선을 다해서 앞으로 나갈 꺼야.
나는 새로운 도전을 할 자신이 있어!"

한나와 한나 어머니 이야기

한나는 등록되어 있는 정신건강복지센터 선생님께
구직을 위한 도움을 요청했다. 그러나, 한나의 부모님은
한나가 일을 하다 재발을 할까 걱정을 했다.
부모님은 한나가 일을 하지 않고 집에서 안정적으로 지내길 원했다.

만약 한나가 집에만 있는 것이 답답하다고 하면,
작은 카페를 열어주어 일하고 싶을 때 일하고,
힘이 들면 언제든 쉴 수 있는 환경을 만들어 주고 싶었다.
그리고 그럴만한 경제적 여유가 있었다.

한나와
한나 어머니
이야기

한나의 어머니가 조심스럽게 한나에게 말했다.

"꼭 일을 해야 하니?
엄마는 일보다 너가 안정적으로 지내는 것이 더 중요하다고 생각해.
만약에 정 일을 하고 싶으면 작은 카페를 하나 차려 줄테니
그곳에서 하고 싶은 만큼 일하고,
쉬고 싶을 땐 수익 상관 없이 쉬면 좀 어떠니?"

한나와
한나 어머니
이야기

그러나 한나는 어머니께 명확히 자신의 뜻을 밝혔다.

"저는 일을 하고 싶어요.
특별히 동물과 관련된 일을 하고 싶어요.
카페를 운영하는 것은 적성에도 안 맞고 흥미도 없어요"

한나와
한나 어머니
이야기



사실, 한나는 2년 전 동물병원에서 자신이 돌보던 강아지와 고양이가 한달 간격으로 죽게 되자 심한 죄책감을 느끼며 우울해 했고 결국 위험한 행동까지 해서 보호병동에 입원했었다.

한나의 어머니는 한나가 다시 동물과 관련된 일을 하다가 과거와 비슷한 일들로 인해 2년 가량 이루어 온 모든 노력이 물거품이 될까 염려하고 있었다.

한나와
한나 어머니
이야기

얼마 후, 한나의 어머니는 센터로 찾아가 한나의 담당자인 설희를 만났다.
한나의 어머니는 설희에게 한나가 2년만 더 있다가
구직활동을 하게끔 설득해 달라고 간곡히 부탁했다.

"선생님, 잘 아시잖아요. 한나도 한나지만,
저희도 얼마나 어렵게 여기까지 왔는지요...
선생님, 한나는 저희 말을 듣질 않아요. 선생님이 꼭 좀 잘 이야기 해주세요.
아직 충분히 회복되지 않았으니, 2년만 더 있다가 생각해보자고요..."

한나와 한나 어머니 이야기



설희는 어머니의 이야기가 단순한 부탁이 아니라는 것을 느꼈다.
직접적으로 말하진 않았지만, 마치 어머니가
'만약 재발이 되면, 그건 말리지 않은 선생님 탓이에요'라고
말하는 것만 같았다.

한나에겐 회복을 이야기 하면서,
어머니에게는 아무 말도 못하는 자신이 비겁하게 느껴졌다.
설희의 마음이 그 어느때 보다 무겁다.

Topic 7. 공동체로의 재연결



기원이 이야기

'친구가 없는 게 뭐가 나빠?
그냥 혼자 지내면서도 행복할 수 있잖아?'

기원이 이야기



기원이는 26세 남성이다.
기원이는 어릴 때부터 무척이나 활발한 성격이었다.

기원이는 공부나 운동에서 두각을 나타내진 않았지만,
사람들과 어울리는 것을 좋아했고,
주변에는 늘 많은 친구들이 있었다.

기원이 이야기

고등학교를 졸업한 후 기원이는 대학에 입학을 했는데,
그 곳에서도 특유의 친화력으로 금새 많은 친구들을 사귀었고
선후배들과 친하게 지내며 여러 동아리, 그룹 활동들의 핵심에 있었다.

그러던 기원이가 군대에 입대하게 되었다.
기원이는 특유의 친화력으로 군 생활 속에서도 친구를 만들고,
내무반이라는 공동체를 가꾸어 가길 원했지만
이번엔 이전과 달랐다.

기원이 이야기



선임 중 한명이 기원이의 모습을 보며 '나댄다', '깝친다' 등의
이야기를 시작으로 일거수일투족을 지적하기 시작했다.
점점 선임의 지적은 일상이 되어갔고,
어느새 내무반 전체의 분위기는 기원이가 눈치 없이
나대는 사람으로 인식하는 식으로 흘러갔다.

기원이는 자신은 똑같이 생활했을 뿐인데,
이전과는 너무도 다른 자신의 상황에 당황을 하게 되었고,
자신이 살아온 모든 삶이 혼란스러워졌다.
점차 기원이는 혼란속에서 잠을 못 자고 작은 소리에도
소스라치게 놀라는 모습을 보였다.

기원이 이야기

시간이 흐르면서 기원이는 더욱 혼란스럽고 초조해 졌으며,
사람들과 눈을 마주치는 것도 어려워졌다.
귀에서 들리는 소리인지 마음에서 들리는 소리인지
명확히 분간할 수는 없지만,
누군가 자신에게 말을 걸기 시작했다.

"그만 나대고 그냥 죽어, 이 쓸모 없는 새끼야"

기원이 이야기

기원이는 결국 의병제대를 했다.
제대 후 기원이는 정신과 의사를 만나 조현병 진단을 받았고 약물치료가 시작되었다.
다행히, 기원이는 약물에 효과가 좋았고 부작용도 거의 나타나지 않았다.

기원이는 치료를 시작한 지 3개월 만에 환청을 포함해서 불안, 불면 등
자신을 괴롭히던 대부분의 증상이 호전되었다.

기원이의 주치의는 종합심리검사 결과 인지기능에도 큰 문제가 없어서
다행이라고 했고 약물을 줄여보자고 먼저 제안을 할 정도였다.

기원이 이야기

하지만, 기원이는 더 이상 사람들을 만나지 않았다.
여전히 친구들에게 종종 연락이 왔으나 기원이는 연락을 받지 않았다.
기원이 또한 친구가 많을 때가 그립기도 했다.
하지만 기원이는 한편으론

'친구가 없는 게 뭐가 나빠? 그냥 혼자 지내면서도 행복할 수 있잖아?'

라는 생각을 하며 혼자 지내는 삶을 합리화 시키곤 했다.

기원이 이야기



그렇게 3년의 시간이 흘렀다.
기원이의 모습은 예전과 많이 달라졌다.
살도 많이 찌고, 잘 씻지도 않아 냄새가 나며
머리는 늘 기름져 떡진 상태였다.

표정은 늘 무표정으로 로보트를 보는 듯한 인상을 주었다.
부모님은 무슨 문제를 놓치고 있는 것이 아닐까 걱정을 했고,
기원이는 자신이 받을 수 있는 거의 대부분의 검사를 받으며 지냈다.

그러나 어떠한 검사에서도 특별한 이상 소견은 보이지 않았다.
다만, 이상할 정도로 사람을 만나지 않으려고 했던 것 뿐

기원이 이야기

기원이는 자신을 걱정하는 부모님이나 주치의, 상담 선생님에게
자신은 행복하다고 이야기 했지만, 사실 기원이는 늘 외로웠다.

행복하다고 이야기 할 수록 스스로를 속이는 것 같아서 마음이 불편했다.
그럴 수록 기원이는 타인과의 대화를 피했듯이
자신과의 대화마저 그만 두었다.

Topic 8. 회복 의사소통 기술 (1)



규성이 이야기

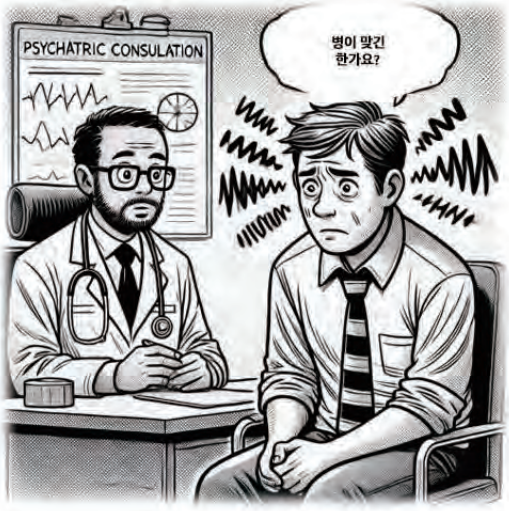
"얘는 또 쓸데없는 소리를 해! 선생님 바쁘셔…"

규성이 이야기

규성이는 40대 남성이다.
그는 20대부터 시작된 환청과 망상으로 수차례 보호병동에 입원하고 퇴원했다.

규성이는 꾸준한 약물 치료에도 불구하고 여전히 환청을 듣고 있으며,
누군가 자신을 해치려는 계획을 가지고 있다고 생각한다.

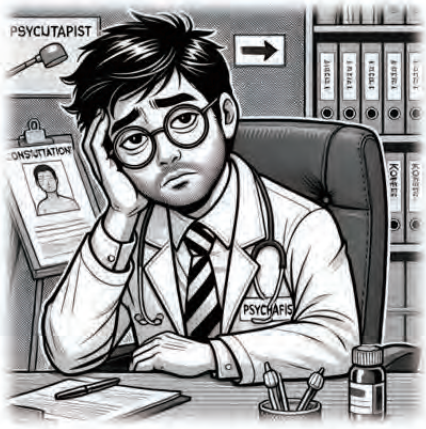
규성이 이야기



물론, 약을 먹지 않았을 때에는 이러한 생각이 더 심했고
하루 종일 두려움에 떨거나 시도 때도 없이 화를 내며
폭력적으로 변해 일상생활이 불가능한 정도였으니,
약이 아예 효과가 없는 것은 아니다.

하지만 규성이는 약 20년간의 치료에도 불구하고
만족할 만한 변화가 없자, 치료에 대한 불신이 생기고,
자신의 진단명과 자신이 경험하는 것들이
정말 주치의가 말하는 증상이 맞는지 의심이 들곤 한다.

규성이 이야기



규성이가 가장 싫어하는 시간은 주치의와의 면담 시간이다.
가족들의 성화에 못 이겨 마지못해 정신과 외래에 가고는 있지만,
면담 후엔 오히려 감정 조절이 잘 안 되고
한동안 환청이 더 크게 들리기도 한다.

규성이는 외래 진료실에 들어갈 때부터 짜증이 난다.
이미 얼굴은 상기되어 있고, 모든 것이 다 불만족스럽다.

대기 시간, 피곤해 보이는 주치의, 진료실의 온도,
마치 죄를 지은 것처럼 쭈뼛쭈뼛 들어오는 가족들의 모습까지.

규성이 이야기

규성이는 자신이 경험하는 환청에 대해
답답하고 말할 곳이 없어 종종 주치의에게 털어놓는다.

그런데 규성이가 끝까지 자신의 환청에 대해 말을 한 적은 없다.
말을 하는 도중 가족들이 환자의 말을 막기 때문이다.

"얘는 또 쓸데없는 소리를 해! 선생님 바쁘셔…"

규성이 이야기

그럴 때마다 주치의는 온화한 목소리지만
피곤하다는 듯한 표정으로 이야기했다.

**"그게 바로 증상입니다. 피해 망상이라고 하고,
그것이 언어화 되어 당신에게 들리는…"**

그럴 때마다 규성이는 화가 나고 답답했다.
가족과 주치의가 하는 말뿐만 아니라 표정, 태도까지
모든 것이 마치 자신의 화를 돋구는 것처럼 느껴졌다.

규성이 이야기

그리고 자신의 답답한 마음은 살피지도 않고,
질린 듯한 표정으로 말을 중간에 가로막거나 별거 아니라는 듯이
모니터만 본 채 피곤한 티를 내며 자신의 일을 해 나가는
주치의의 모습을 보면 화를 참을 수 없었다.

어느새, 규성이는 치료받겠다고 온 진료실에서,
자신의 모든 호소를 증상으로만 해석하는 주치의와 가족들에게
오히려 더욱 적극적으로 자신의 환청과 망상을 옹호하며
필요 이상으로 감정을 드러내고 있었다.

규성이 이야기



외래 진료를 마치고 돌아오는 차 안에서야 가족들은
규성의 표정을 살폈다. 그리고 이야기한다.

"다 너 잘되라고 하는 이야기잖니…"

Topic 9. 회복 의사소통 기술 (2)



규성이 어머니 이야기

'나는 누구였지?
내가 어떤 사람이었는지 기억이 나지 않아.
정신병에게 아들도, 그리고 나도 빼앗겼구나.'

규성이 어머니
이야기



규성이의 어머니는 주변으로부터 밝다는 이야기를 자주 들었다.
어머니는 학창 시절, 무엇인가를 배우는 데 열정적인 소녀였다.

어머니의 한 가지 한이 있다면, 공부를 하고 싶었지만
남자 형제만 가르치겠다는 아버지의 결정으로
대학에 진학하지 못했던 것이다.
그래서 하나밖에 없는 자식인 규성이는 마음껏 공부할 수 있도록
해주겠다고 다짐했다.

규성이 어머니 이야기

어머니는 자신이 입지 않고, 먹지 않아도 규성이의 공부에
부족함이 없게 하려 했고, 고액의 과외는 물론,
필요한 교재나 컴퓨터 등의 물품도 아끼지 않았다.
규성 또한 성실하고 착실하게 공부를 했고,
남부럽지 않은 대학에 입학할 수 있었다.

어머니는 규성이가 대학에 합격하던 날을 잊을 수가 없다.
자신이 입지 않고, 먹지 않아도 따뜻하고 배불렀던 그 시간을.

규성이 어머니 이야기



그러던 규성이가 대학 졸업을 앞두고 취업에 스트레스를 받더니,
어느 순간 도저히 이해하기 어려운 말을 하기 시작했다.

아버지가 자신을 죽이려 하고 있으며,
집 안에 온통 초소형 카메라가 있어 자신의 일거수일투족을
감시하고 그 정보를 비밀 정보기관에 넘긴다는 이야기였다.

어머니는 규성이의 입에서 나오는 말을 이해할 수가 없었다.
더구나, 당장 자신의 눈앞에서 벌어진 상황을 납득할 수가 없었다.
결국 어머니는 규성이에게 소리쳤다.

"규성아 정신차려! 지금 이게 무슨 말도 안되는 소리니!"

규성이 어머니 이야기

**"그딴 헛소리는 집어치워! 한번만 더 그런 헛소리 해봐!
하지 말라는데 왜 자꾸 그러는 거야!"**

시간이 갈수록 어머니는 낙담했다.
누군가의 도움을 받고 싶으면서도, 도움을 주려는
주변 사람들의 조언 하나하나가 듣고 싶지 않았다.
그 누가 뭐라고 해도 자신만이 아들을 본래대로
되돌릴 수 있다고 굳게 믿었다.

규성이 어머니 이야기



어머니는 언제부턴가 웃지 않았다.
어울리던 친구들 모임에도 나가지 않았다.
하루종일 가슴이 답답했고 종종은 숨이 잘 쉬어지지 않기도 했다. 꾸미는 것
을 좋아했던 어머니의 얼굴에서 화장기가 사라졌듯이,
어머니의 말 속에서 그 어떠한 온기도 찾아볼 수 없었다.

규성이 어머니 이야기

어머니는 계속해서 규성이를 설득하고
교정하려는 대화를 시도했다.
하지만 이런 식의 대화가 계속될수록
규성이는 점차 입을 닫기 시작했다.
그리고 혼잣말을 하거나 스스로의 생각에 갇혀
허공에 대고 혼자 웃거나 불안해하는 일이 지속되었다.
규성이는 집에만 있었지만 더 이상 가족들과 함께 있지 않았다.

규성이 어머니 이야기



한 달 만에 용기를 내어 찾아간 정신병원에서,
규성이가 조현병이 의심된다는 진단을 받았다.
어머니도 막연히 조현병 일 수도 있다는 생각은 했지만,
의사의 입에서 직접 그 단어를 들으니 자신도 모르게
감정이 섞인 말이 먼저 나왔다.

"아니에요. 얘가 취업 때문에 스트레스를 받았을 뿐이에요! 검사도 안 해보고 조현병이라니요!"

규성이 어머니 이야기

어머니는 도저히 규성이가 조현병에 걸렸다는 사실을
받아들일 수 없었다.
임신했던 시기부터 지금까지 규성을 양육하면서
실수하거나 후회했던 모든 일들이 떠올랐다.
문득 어린 시절 둘째 외삼촌이 정신병원에 입원했다는
이야기를 들었던 기억이 어렴풋이 났다.
등에 식은땀이 흘렀다. 갑자기 모든 것이
자신의 잘못인 것처럼 느껴졌다.

규성이 어머니 이야기

그럴 수록, 어머니는 더욱 절실하게 규성을 데리고
자신이 원하는 말을 해줄 의사를 만날 때까지
여러 병원을 떠돌았다.
그렇게 도착한 병원의 엘리베이터 안에서,
거울에 비친 자신과 아들의 모습을 발견했다.
벌써 두 달 째지만 불안한 듯이 힐끔거리는
아들의 모습이 여전히 낯설다

규성이 어머니 이야기



천천히 거울 속에서 불안해하는 아들의 시선을 따라가 보니,
거기에는 분노와 불안이 가득한 표정의 중년 여성이 서 있었다.
낯선 아들의 모습보다 더 낯선 자신의 모습을 보고,
어머니는 자신도 모르게 눈물을 흘렸다.

'나는 누구였지? 내가 어떤 사람이었는지 기억이 나지 않아.
정신병에게 아들도, 그리고 나도 빼앗겼구나.'

대표저자

조용혁 정신과전문의
아주의대 정신건강의학과 교수
수원시성인정신건강복지센터 센터장

공동저자

양명화 정신건강간호사 / 이음병원 / 연구원

유안나 심리학자
아주대학교병원 정신건강의학교실
연구원

김영희 정신건강간호사 / 이음병원 / 연구원

정수인 심리학자
아주대학교병원 정신건강의학교실
연구원

김　진 정신건강간호사 / 아주대학교병원

발 행 일 : 2025.03.28.
발 행 인 : 노재성, 정성권
디 자 인 : 신민하
발 행 처 : 한국보건산업진흥원
아주대학교병원
이음병원
홈페이지 : https://blog.naver.com/opendialoguekorea
대표메일 : mindtrek@hanmail.net

본 연구는 보건복지부의 재원으로 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업
지원에 의하여 이루어진 것임 (과제고유번호 : RS-2022-KH126432)

This research was supported by a grant of the Korea Health Technology R&D
Project through the Korea Health Industry Development Institute (KHIDI),
funded by the Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea
(grant number : RS-2022-KH126432).

KHIDI
한국보건산업진흥원

세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한 치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술개발